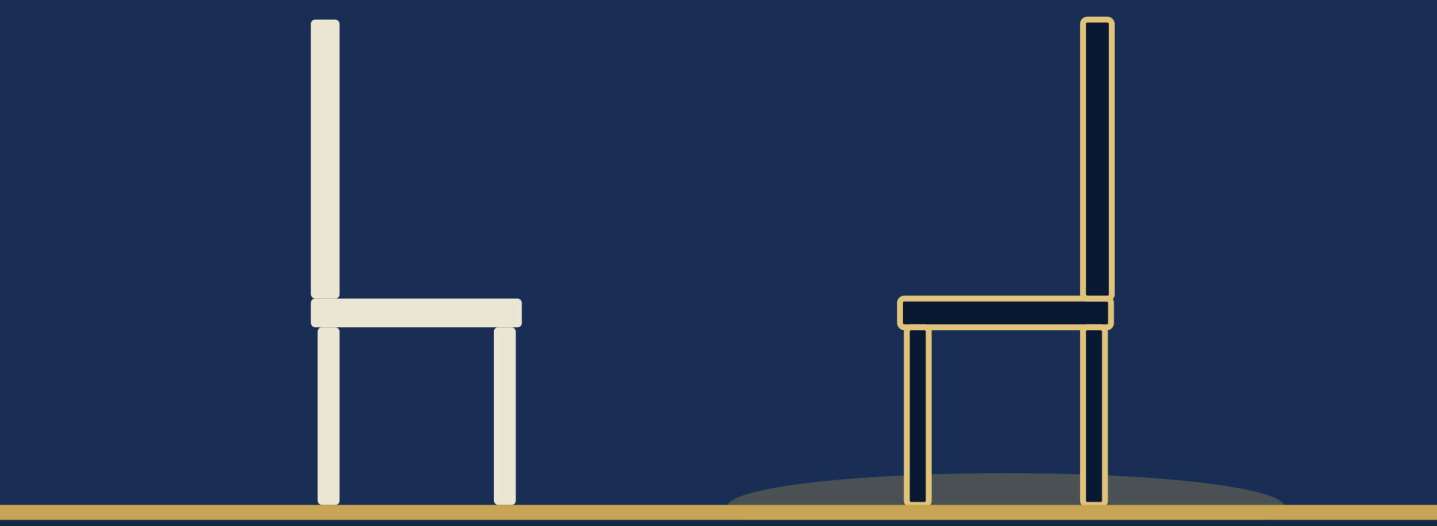
SDE UNIVERSES
德麦国际专著 · 第 591 号

都做对了，怎么还没变

心理治疗里被好意占住的那个位置



孔凡鹤　著

德麦国际出版社
Demai International Press

德麦国际专著 · 第 591 号

都做对了，怎么还没变

心理治疗里被好意占住的那个位置

孔凡鹤　著

德麦国际出版社
Demai International Press · Singapore

出　版　信　息

书名	《都做对了，怎么还没变》
副题	心理治疗里被好意占住的那个位置
英文书名	Done Right, Yet Unchanged: The Position Occupied by Goodwill in Psychotherapy
著者	孔凡鹤
指导	王德生
出版	德麦国际出版社（Demai International Press）· 新加坡
编号	德麦国际专著第 591 号
ISBN	979-8-90690-618-2
定价	US$22.00
开本	170 mm × 240 mm
字数	约 20 万字（前言、导读、导论、编首语、十二章与结语正文 196,878 个汉字；参考文献另计）
版次	2026 年 11 月第 1 版

成书说明：本书是学术专著初版，由作者在 SDE Universes 学员专栏发表的九篇心理治疗论文熔铸而成，另有六篇的材料并入。正文由 AI（Claude）协作重写，经统稿与三审，没有经过独立学术评审。

这是一部理论专著，不是临床指南。书中案例一律是说明性合成案例，不作证据。涉及自伤自杀风险或急性危机时，书里说的“撤”一概不适用，须走安全与转介流程。

版权所有　侵权必究

做得越对，越占住那个只有来访者能站的位置；改变在它空出时发生，却记不到任何人账上。

—全书母题

作者介绍

孔凡鹤，著者，SDE Universes 学员，长期在学员专栏写作，研究以照护、家庭、身体与心理治疗中的承认与在场为线索，此前著有德麦国际专著第 72 号《照护的智慧》、第 78 号《一直没出事》、第 86 号《停下来不算结束》、第 97 号《不是不爱了》。

王德生，博士，SIO 本体论与 SDE 发生学的创立者，新加坡德麦国际创始人，SDE Universes 平台主持人。本书由他指导。

成书说明

这是一本学术专著的初版，请按它实际做到的范围来读。

从哪里来。本书的底子是作者 2026 年夏天在学员专栏发表的心理治疗论文。全书以其中九篇为主料：改变的未发生、发生租借、共同进场、理解的不逾、那里可以不有、逼出动力学、从“撬动”到“发生”、场不是匹配、疗愈的归因敏感度；迷途的共鸣、悬而未决的守护、沉积性共在、能量侦探的诚实边界、技艺的肉身、批判者的间离六篇的材料也有并入。九篇写作时并没有打算合成一本书，全书母题是选篇之后归纳出来的。

谁写的。正文由十路 AI 执笔者按统一的章卡分章重写，统稿与三审也由 AI（Claude）完成。写作与审校用的是同一类底座，不能互作独立证据。成书时改动了原论文的一处核心用词：原文写治疗师“逼出”“制造”来访者的动作，本书裁定“逼”的主语只能是处境，第 10 章交代了这次改动和它的代价。

哪些做过检验，哪些没有。各章写明了读数与判错条款，全书有三条最承重的判错条款，都还没有检验。全书没有一项数据是本书自己跑出来的。引用的已发表研究以书末文献为准；同盟、共情与治疗师经验三组数字以及第 12 章的试验与研究已回到来源核对，其余文献的书目信息未逐条对照原件。

案例。全书案例一律第三人称，一律按说明性合成案例处理。原论文里部分案例写作第一人称亲历，本书不据此作任何主张，也不把它们当作证据。

正文字数。前言、导读、导论、编首语、十二章与结语的正文实计 196,878 个汉字；章题、节题与参考文献不计入。

前言

一本书的缘起，常常是一个说不太清楚的别扭。这本书的别扭来自治疗室里一种很常见的体验：治疗在进行，同盟良好，来访者按时到场，也愿意说，治疗师听得懂，也接得住，量表上的分数一路下行，结案时双方都觉得这一程走得不错。可是过了半年，来访者在电话里平静地说，日子大体又回到了从前的样子。没有人做错什么，没有哪一环可以拎出来责备，那种“都做对了，怎么还没变”的怔忡，却让许多认真做事的人心里不踏实。

本书的材料，是孔凡鹤围绕这个别扭写下的一组论文。它们最初各自成篇，各有一个命名：涵容性织体，发生租借，共同进场，不逾，零功能在场，裁决撤离，不可代偿的亲自动作，共构性转化场，归因敏感度。每篇都从一个具体的临床难处出发，试图替一种“看上去在变、其实没变”或者“变了、却说不清是谁做的”的现象立名。把九篇放在一起读，这九个名字就不再是九个平行的发现，它们在反复指向同一个位置：治疗室里有一个位置，只有来访者本人能够站上去，而治疗师的专业、善意与技术，恰恰在不经意间把它占满了。占住它的，往往正是治疗师做得好的那些部分，与失误无关。

这个判断需要一个清楚的限定，前言先把它说在前面。它并不主张共情无用、同盟无益。大规模元分析给出的图景是稳固的：治疗同盟与疗效的关联约为 r=.278（Flückiger et al., 2018），治疗师共情与疗效的关联约为 r=.28（Elliott et al., 2018），平均而言都是正的，而且不小。本书全部的论证，都建立在承认这两个数字的前提上。它所提出的是另一层问题：在平均正相关之下，是否存在某些阶段、某些位置，同样的好东西会变成阻碍？这是一个关于交互反转的问题，而不是对平均效应的翻案。

本书的九个来源篇目如下。第一，《改变的未发生：涵容性织体的发生学机制》，对应本书第1章。第二，《发生租借：心理治疗伪改变的一种动力学解释》，对应第2章。第三，《共同进场：为什么疗愈不是从“懂”开始的》，并参考《迷途的共鸣：当心理治疗抵达技术的尽头》，对应第3章。第四，《理解的不逾：论治疗性理解的生成条件、入侵性与伦理边界》，并参考《悬而未决的守护》，对应第4章。第五，《那里，可以不有：论零功能在场》，并参考《沉积性共在：临床在场的一种非帮助形态》，对应第5章。第六，《逼出动力学：人本疗法中裁决撤离的疗愈逻辑》，对应第6章。第七，《从“撬动”到“发生”：心理治疗中疗效的生成机制再探》，并以《能量侦探的诚实边界》为对手，对应第7章。第八，《场，不是匹配：治疗性改变何以只能发生在两人之间》，对应第8章。第九，《疗愈的归因敏感度：为什么最深的治愈进不了证据库》，对应第9章。第10章与第11章在九篇之外新写，分别处理这些判断之间的相互冲突，以及“让位”这件事自身的风险，并让《技艺的肉身》与《批判者的间离》两篇作为反方与自反的材料出场。第12章是外推与预测，讨论人工智能心理陪伴。

必须交代这本书是怎样写成的。它由孔凡鹤的论文熔铸而成，正文由 AI（Claude）协作重写。重写的含义是：九篇原文各有自己的语气、站内的分工说明和阶段性的深化记录，这些在成书时全部拿掉，论证被重新组织，案例被改写成统一体例，原文中过于强烈的动词被重新审查（第10章会专门交代其中最重要的一处改动）。重写并不等于替作者发明实证。全书没有任何一项数据是本书自己跑出来的，原文的预测一律保持“尚未检验”的地位。凡是引用外部研究，只引经过核实确有其文者，核不实的宁可舍去。读者若发现某处引文与原文献出入，请以原文献为准，并视为本书的疏失。

本书由王德生指导。九篇各自成篇，全书母题是成书时归纳出来的，这一点读者不妨记在心里。本书未经独立学术评审。一本讲“懂的人有问题”的书能否

不让自己成为新的“懂的人”，这一问留在结语，读者读到时会明白它为什么要被放在最后。

关于案例，需要先说一句。全书所有案例一律以第三人称叙述，一律是说明性合成案例：情节取自原文的讨论或在其基础上改写，人名为化名，细节是为了把一个结构讲清楚而拼合的，不应被读成对任何一位来访者的记录，也不应被当作临床证据。需要证据的地方，本书总是另行标明它是已有的研究，还是有待检验的预测。

最后是一句关于本书气质的提醒。这是一部理论专著，不是临床指南，里面没有步骤，没有“治疗师应当怎样做”的清单。书中凡写到治疗师可以做什么，写的都是事后可以记录的现象，并且全书反复提醒：连“不再填满”这件事本身，也可能失败，也可能变成另一种填满。如果读者合上书时觉得得到了一套新技术，那是读岔了；如果觉得对自己手里那些做得很好的事，多了一分犹豫和一分清醒，这本书就达到了它的用处。

书中的错误与过度，由作者与整理者共同承担。三条可以被打破的判断，已写在导论的末尾，也写在结语里。欢迎同行拿自己的数据来试它们，试垮了，就以数据为准。

导读

◆ 一、这本书回答什么问题

心理治疗研究的主流问题是“什么有效”：哪种疗法对哪种困扰有效，哪些因素在跨流派的意义上有效，哪类治疗师更有效。这些问题已经积累了大量扎实的证据，本书全部接受。本书追问的是证据的一个背面：已被证明有效的东西，在什么条件下会反过来挡路？具体地说，治疗师的理解、给予与判断，这三样治疗中最被珍视的东西，在来访者尚未亲自命名、亲自发起的那些地方，可能占住一个只有来访者本人能站的位置。位置被占时，治疗看上去一切顺利；位置空出时，改变才有机会发生，而且发生之后往往记不到任何人的账上，既不属于技术，也不属于关系，来访者自己也说不清。

读者在开始之前，最好先把一件事放在心里：本书是一次关于位置的论证，不是关于方法的推荐。书里会反复出现“椅子”这个意象，懂的椅子、给的椅子、判的椅子。它们是三个位置，每个位置上坐着的都不是坏人，坐上去的动作也大多没有错。问题出在坐得太稳、太久、太合适。读者如果带着“那我应该怎么做”的急切进入每一章，很可能会失望，因为书里给出的是对现象的分辨与对判断的约束，不给操作清单。这是有意为之，后面会讲理由。

◆ 二、全书怎样走

全书分导论、四编、合论与结语。导论把问题从“什么有效”改写成“好东西为何有时挡路”，立起三把椅子和一个记账问题，交代全书路线与三条判错条款。读者若时间有限，导论可以单独成篇阅读，它已经包含全书的骨架。

第一编“看上去都很好”包括两章。第1章处理一种治疗：没有失败，也没有卡住，一直在前进，进展却穿不过治疗室的墙。第2章处理另一种：期内的改变确实发生了，期后的退回也确实发生了，改变是借来的。两章讲的是同一类现象的两种发生方式，第10章会回头给出区分二者的判据。

第二编“三把被占住的椅子：懂、给、判”是全书的主体，包括四章。第3章从“懂的人”这个位置讲起，讨论治疗师与来访者各自的旧秩序怎样彼此咬合，以及一次共同进场如何发生。第4章讨论懂得太准为什么会成为闯入，这是全书第一条判错条款所在的一章，也是把平均正相关与阶段性反转放在一起讲透的地方。第5章讨论“给”：当各流派都在给，什么叫接下来访者的期待却不坐上去。第6章讨论“判”：接纳铺好之后，谁在推动，治疗师的评判性输出何时该撤。

第三编“椅子空了以后”包括两章。第7章问空出来的位置上发生的是什么，答案是一个无人能代做的亲自动作，这一章含全书第二条判错条款。第8章是全书的裁判席：卡住的东西是两个人共同做出来的，因此治疗师没有一个站在互动之上的高处，前面各章中任何暗示治疗师在导演过程的措辞，都在这一章受到审判。

第四编“这笔账记给谁”只有第9章，讨论为什么最深的治愈进不了证据库，也就是一次起了效的事件，在被写进病历、被归入某项技术、被收进某个疗法的名下的那一刻，会丢掉什么。这一章含全书第三条判错条款。

合论“三个难关”包括三章，是为本书新写的部分。第10章让九章中互相冲突的判断当面对质，并正式交代一次措辞上的全书裁定。第11章处理让位自身的风险：让位也能占位，有时不该让。第12章把全书的框架外推到人工智能心理陪伴，全章标明为外推与预测。结语追问这本书自己坐在哪把椅子上。

◆ 三、三种读法

对研究者，建议按顺序读，但可以把第4章、第7章、第9章三个含判错条款的章节当作骨架先读一遍，再回头补前后文。这三章的条款是本书愿意接受检验的地方，其余各章是在为条款提供前提和语境。研究者尤其应当留意各章“本章判错条款”里的“尚未检验”字样：本书没有任何一项自己跑出来的数据，凡是提到预测，都只是预测。

对临床工作者，可以从第3章起步。这一章的场景最贴近日常，读者容易认出自己的某些时刻。读完第3章与第5章，再读第11章，会更清楚这本书对治疗师的要求其实比通常的“要做什么”更克制：它要求的是对自己做得好的那些部分保持审查，同时记得有些时刻不该撤。第8章与第10章可以放在最后读，它们会把前面读到的各项判断收拢，并让读者发现自己最想抓住的那条“可操作结论”其实已被书自己拿走了。

对认真的求助者，本书不是为你写的入门读物，但并没有对你关门。你可以从导论的开头一节和第1章读起，那里的场景大概率会让你认出某些经历。需要特别提醒的是：如果你此刻正处于难以承受的痛苦中，请先阅读下一节关于不适用情形的说明，并且不要把本书当作评价你自己的治疗师是否“做错了”的尺子。书里讲的是一类结构性的难处，它存在于许多优秀的治疗师与认真的来访者之间，并不意味着谁亏欠了谁。

◆ 四、理论专著的边界与不适用情形

这部书是理论专著，不是临床指南。它不提供步骤清单，不写“治疗师应当”，也不推荐任何新技术。这一点出于论证的需要，与谨慎的客套无关：如果一本讲“位置被占”的书又给出一份“怎样让位”的操作手册，手册本身就会成为新的、更精致的占位。第11章会把这个悖论展开。书中凡是涉及治疗师能做的

事，写成的都是“事后可记录的现象”，也就是从来访者那一侧看，什么发生了，可以被怎样观察；而不是治疗师手里应当执行的动作。

更重要的是适用范围。本书的判断适用于来访者尚未亲自命名、亲自发起的那些地方，也就是说，适用于来访者本人有能力站上那个位置、只是位置被占的情形。它不适用于以下几类情形：自伤、自杀风险与急性危机；自我结构严重缺损；心理储备已经耗尽。在这些情形下，来访者需要的首先是结构化的帮助与安全流程，需要有人稳稳地替他撑住一些东西。此时的“不帮”算不得让位，那是逃避；此时的“不判”算不得尊重，那是缺席。读者无论从哪一章读到“撤”“空出”“不再填满”这类说法，都应当带着这条边界去读。书中每一章都有“失败或不适用的情形”一节，这是对边界的逐章重申，不是装饰。

若读者本人或身边的人处于危机之中，请不要把本书当作行动依据，而应当联系当地的危机热线、急诊或可信赖的专业机构。这是一句多余的话，也是一句必须写下的话。

◆ 五、案例：全部是说明性合成案例

书中的案例一律以第三人称叙述。它们的情节取自原论文的讨论，或在其基础上改写，人名为化名，细节为了把一个结构讲清楚而拼合。它们不对应任何一位真实的来访者，不构成临床证据，也不应当被引用为“某研究发现”。每一章第一次出现案例时，会在括号里标注“说明性合成案例”，这句话只标一次，但适用于全章。

选择这样处理，有两个理由。其一是保护：任何来自实际治疗室的细节，都可能辨认出具体的人。其二是诚实：一个为了说明而写的案例，只能说明概念的形状，不能证明概念为真。读者若看到某个案例特别贴合，也请记得它是为了贴合而被写成这样的。案例的功用是让抽象判断有一个可以对照的日常形象，每个关键判断后面几乎都会跟一个这样的形象，它们是梯子，不是地基。

◆ 六、读数与判错条款怎样用

每一章里有两个固定的部件，值得单独交代。“本章读数”是一个事后可以记录的现象。它既不属于操作，也不属于疗效指标，只是一个“若本章判断成立，通常会看到什么”的观察窗口。比如第1章的读数是：给织体补上外部反馈参照之后，互动是否松动。读数的用法是回头看，用来分辨两个相邻的解释哪一个更贴近实情，它不应被拿来当作实时评估来访者的工具，更不应作为治疗师的绩效标准。把读数当作操作，是本书明确反对的用法，因为读数一旦变成目标，被追求的现象就会被表演出来。

“本章判错条款”是一个条件句：若观察到什么，本章的判断撤回。每个条款都标明“尚未检验”。它们的功能是把本书的主张放到可以被打败的地方。全书最核心的三条分别在第4章、第7章和第9章，结语会再写死一遍。读者可以把条款当作研究设计的出发点，也可以当作自己的质询清单：读到一章时，先问一句“如果我在自己的工作中看到了与条款相反的事实，这一章还剩下什么”。条款的措辞尽量写得足够具体，以便同行用真实数据去试；若试出的结果与条款相反，被打中的部分就应当撤回，本书对此没有保留。

还有一点关于文献。每章文末列“本章文献”；正文用（作者，年份）夹注，外国作者首次出现时附中译名。凡是作者原文已有、而本书未能重新核实的文献，本书不予引用；凡是新增的引用，都经过核实。

◆ 七、几个固定命名

为了让读者在不同章节之间能认出同一个东西，全书保持一套固定的命名，在此先列在这里，读到时再看细节。

三把椅子：懂的椅子，给的椅子，判的椅子。“场”专指共构性转化场。保留的命名包括：涵容性织体，指体验上高度契合、与外部世界脱钩的互动织体；

发生租借，指治疗中的底气、工具或方向其实是从关系中借来的；双重互锁，指来访者与治疗师两套旧秩序对称地咬合；共同进场，指辨识动作本身被放到两人之间；不逾，指在理解凝结之前的撤回；零功能在场，指接下期待却不执行其所要求的功能；裁决撤离，指方向性、评判性的输出退出；逼临态，指处境把来访者推到必须自己面对的临界；不可代偿的亲自动作，是第7章原文中所说“发生性自我指涉”的改称，首次出现时会交代；前诠释性承受，指在解释形成之前的承受；归因敏感度，指治愈事件遭到归因时，其构成性信息保持的程度；无主，指一次有效的事件不属于任何一方的名下。书中称人，一律是“来访者”与“治疗师”。引用他人直接语句时，保留原文用词。

◆ 八、最后一个提醒

这本书的写法有一个潜在的悖论，读者读到一半时多半会自己发现：一本讲“懂的人”可能占位的书，它本身也在作出判断，也在替读者“懂”一些东西。作者没有回避这一点，结语会正面处理，但处理的方式拒绝用自陈谦逊来豁免，靠的是把三条判错条款交到同行手里。因此，请读者把这本书当作一份可以被试垮的主张，而不是一套值得信奉的立场。读完后最有价值的动作与赞同无关，是拿着其中一个条款，回到自己的材料里去核对。

导论

都做对了，怎么还没变

◆ 一、一个没有人做错的案例

周岚三十四岁，在一家事业单位做行政，来求助时的主诉是长期的疲惫和难以拒绝。她对母亲说不出“不”，对上司说不出“不”，对同事顺手推过来的活也说不出“不”，每一次答应之后，她都在心里默默记上一笔，攒到半夜再一笔一笔翻出来，恨自己，也恨那些不知情的人。（说明性合成案例）她的治疗师方立受过扎实的训练，治疗以每周一次的节奏进行了十个月。回头看这十个月，几乎找不出可以指摘的地方。第三次会谈，周岚第一次完整讲了她小学时母亲当众批评她的一件事，讲完之后沉默了很久。第七次会谈，方立说出了一句后来被周岚反复提起的话：“你一边答应，一边在心里记账，账记得越厚，越不敢去收。”周岚当场红了眼眶，说：“对，就是这样，从来没有人这样说过我。”那天她走出诊所时，脚步是轻的。

量表上的曲线也很好看。同盟问卷每次都在高位，焦虑和抑郁的分数一路缓慢下行，到第十个月，已经落在临床界值之下。督导会上，这个个案被当作一例顺畅的工作来讨论：诊断清楚，关系稳固，解释准确，来访者有洞察，有情绪的释放，有被理解的体验。督导者问了几个关于技术细节的问题，方立都答得从容。没有人觉得这个案例有什么需要改进的。

不过，周岚生活里发生的事，与会谈室里的这条上升曲线并不同步。她仍然会在母亲打来电话的时候先答应再后悔，仍然在上司安排周末加班时点头。她在会谈里把这些复述得越来越清楚，也越来越能说出其中的来龙去脉，说得方立频频点头，说完之后两人都有一种工作做得很扎实的踏实感。会谈室里的周岚和办

公室里的周岚，好像住在两个互相不渗透的房间里，中间的那堵墙，谁也没有注意到，因为每一次会谈都在顺利地进行。

第十个月，诊所因为房屋租约到期搬迁，会谈中断了五周。这是一个纯粹由处境造成的间隔，与任何治疗上的考虑无关。五周里周岚没有联系方立，方立也没有联系她。重新开始的那次会谈，周岚坐下以后有些迟疑，说：“这几周我什么也没想明白。就是有一天，我妈发来一条语音，我没回。”方立问：“没回，是什么感觉？”周岚说：“我也不知道。我把手机扣在桌上，去煮了碗面。两天后我才回的，什么理由也没找。”

方立听得很高兴。她几乎是立刻接上了一句：“这是你前十个月工作的成果。你开始能允许自己不立刻回应了，这正是我们一直在谈的边界。”这句话完全正确，在理论上无可挑剔，在关系里也是温暖的。周岚笑了一下，说：“也许吧。”然后就把话题转开了。那次会谈之后的几个月里，周岚在被问到那天的事时，总是说得含糊：“我也不知道算不算是我做的。”

这个案例里，没有一个环节可以被标成错误。同盟是好的，共情是准的，解释是及时的，肯定是诚恳的。但是读者若逐行重读，会发现一个微妙的现象：在整整十个月里，周岚最值得注意的变化，发生在方立不在场的五周，并且那个变化一旦被带回会谈室，就立刻被收进了一个有主的叙事：这是治疗的成果。周岚那一声沉默，那碗面，那两天不回应，在被命名的一瞬间就不再是她的了。她自己说不清它算不算是自己做的，因为在她听来，那件事已经被一个“更懂它的人”讲完了。

本书所要追问的，就在这里。如果一切都做对了，改变为什么仍然不在应当发生的地方发生？如果改变终于发生，为什么它偏偏发生在一个没人在场的空隙里，而且发生之后，又为什么如此容易被好意地认领，认领之后又如此容易失掉

主人？这些问题不是一个案例的偶然，也不指向方立的哪一次失误。它们指向的是一种结构：做得越对，越有可能占住一个只有来访者才能站的位置。

◆ 二、一百年的平局，以及它得到的三种解读

要看清这个结构，需要先回到心理治疗研究里最有名的一个发现，那个被称作“渡渡鸟判决”的平局。刘易斯·卡罗尔（Lewis Carroll）在《爱丽丝漫游奇境记》里写过一场没有起点、没有终点、没有裁判的赛跑，大家随意地跑，跑到不想跑了就停下，最后渡渡鸟郑重宣布：每个人都赢了，每个人都该得奖。罗森茨维格（Saul Rosenzweig）在1936年发表了一篇短文，题为《多种心理治疗方法中若干隐含的共同因素》，他注意到互相之间理论不相容的治疗方法似乎都有效，因此推想它们必定有一些共通的、没有被理论承认的起效成分，并借用了渡渡鸟的这句话（Rosenzweig, 1936）。四十年后，卢博尔斯基（Lester Luborsky）等人系统比较了各类心理治疗的疗效研究，用一个问句做了论文的标题：是否“人人都赢了，都该得奖”？（Luborsky et al., 1975）此后近半个世纪，这个比喻成了心理治疗结果研究的常用语。

平局的含义并不模糊。认知行为治疗、精神动力性治疗、人本取向治疗、人际治疗，它们对人性与疗愈的基本假设彼此排斥：一方认为症状来自功能失调的信念，一方认为来自被压抑的冲突，一方认为来自成长倾向受阻。可是在抑郁、焦虑这类常见困扰上，把它们放在一起比较，差异往往小到难以稳定地复现。被命名的取向数以百计，核心的实证事实却是一句“大家都差不多”。瓦姆波尔德（Bruce Wampold）把这一事实放在其代表作的核心位置，先后以《心理治疗的伟大论争》的两个版本做了系统论证（Wampold, 2001；Wampold & Imel, 2015）。

对这个平局，可以梳理出三种解读，前两种是学界的主流回答，第三种更像一种常被提起的态度，每一种都值得认真对待。下面依次摆出，先说清它们各自说了什么、贡献了什么，再看它们共同没有问什么。

第一种解读是共同因子。各流派之所以有效，是因为它们共享一套不属于任何特定技术的成分：温暖的治疗关系、治疗师的共情、来访者对好转的期望、一个让痛苦得以被命名的解释框架。这条思路从罗森茨维格出发，经过多位学者的系统化，成为最有影响的一支。它的贡献在于把注意力从“用什么技术”转到“在什么关系里用”，近百年的研究显示这个转向是有实证回报的。后文所要列出的两个相关系数，就是它最扎实的收成。

第二种解读是情境模型，由瓦姆波尔德与伊梅尔（Zac Imel）在共同因子传统上进一步推进。它把心理治疗理解为一种社会性的疗愈实践：治疗师与来访者之间有一种实在的关系，有一套对痛苦的解释和与之配套的仪式化行动，来访者对这套解释的相信与期望被激活，由此展开朝向健康的行动（Wampold & Imel, 2015）。情境模型的一个关键贡献，是不再把技术当作药丸，而是看作一个自洽的、能使人相信的行动框架中的组成部分。技术的特异性成分在这个模型中占比很小，关系与相信占比很大。这一判断符合大量元分析的总体图景，本书没有任何理由反对。

第三种解读最悲观，本书为完整起见把它补上，称为精致的虚无主义，未必有哪位学者完整持有：既然流派之间没有差别，理论建构不过是职业修辞，是给治疗师一套传递信心的叙事，谁来演并不重要，戏本身才重要。这一解读在某种意义上是对前两种的极端化。它的价值在于让人保持一份对理论自我吹捧的警惕，但它的代价是取消了对机制的追问：如果理论只是修辞，一切好转都是安慰剂式的信念效应，那么为什么不同来访者在同一种修辞下命运迥异？

三种解读都有实在的支撑，本书对它们没有任何轻慢。尤其是共同因子与情境模型，它们的结论构成了本书所有论证的前提：关系是起效的核心成分，技术的特异性贡献有限，治疗师的善意与专业是疗效的主要通道。本书要做的事，是在这个前提上再追问一步。三种解读，包括它们各自对渡渡鸟判决的回答，都共享一个从未被审视的底层预设：心理治疗的要义是提供某种好的东西。共同因子说，提供的是好的关系；情境模型说，提供的是好的情境与可信的原理；虚无主义说，提供的是好的叙事。它们争论的是“提供什么”，没有谁问过：提供，本身会不会成为问题？

◆ 三、两个相关系数和一个令人不安的研究

在继续追问之前，需要把平均意义上的证据完整地摆出来，因为没有这份证据，后面的一切论证都会滑向它所反对的东西。

先是治疗同盟。弗吕基格（Christoph Flückiger）、德雷（A. C. Del Re）、瓦姆波尔德与霍瓦思（Adam Horvath）在2018年发表的成人心理治疗同盟元分析，汇总了295个独立样本、三万余名来访者，得到同盟与治疗结果之间的总体相关为 r=.278，95% 置信区间 [.256, .299]（Flückiger et al., 2018）。这个效应在社会科学里不算小，更要紧的是它的稳健：在各类调节变量之下，它的方向都没有翻转。其次是共情。艾略特（Robert Elliott）、博哈特（Arthur Bohart）、沃森（Jeanne Watson）与墨菲（David Murphy）在2018年对治疗师共情与来访者结果所做的更新元分析，纳入82个样本、6,138名来访者，得到 r=.28，95% 置信区间 [.23, .33]（Elliott et al., 2018）。两个数字落在同一个位置上，彼此独立，讲的是同一件事：治疗师越是与来访者建立起良好的同盟、越是准确而深入地共情，平均而言，来访者就越有可能好转。

这两个数字是本书的地基，不是靶子。任何一章若读起来像是在说“共情有害”或“同盟无用”，那是误读，也应当被视作本书措辞上的失败。本书要主张

的，是平均正相关之下还存在一层结构：同一个治疗动作，在治疗的不同阶段、对来访者的不同位置，其作用可能反转。平均数只告诉我们大范围里的总方向，它不能告诉我们在某个具体的位置上，这一动作到底是在帮忙还是在占位。这里可以用一个并不复杂的类比来说明。一个人学骑自行车，父亲在后座扶着，平均而言，扶着的孩子摔得少、学得快、敢继续。这个结论无可争议。但存在一个时刻，扶着的手必须松开，那一刻孩子才第一次自己平衡；而这一刻谁也无法说，是松手的人让孩子学会了，还是孩子在某个时刻自己把握住了平衡。如果孩子永远等着有人扶，平均数里的那个“扶着更好”的结论，就恰好成了孩子学不会骑车的原因。平均正相关与阶段性反转并不矛盾，它们是同一幅图在不同尺度下的样子。

接下来是一项让人不安的研究。戈德堡（Simon Goldberg）等人在2016年发表了一项关于治疗师是否随着时间与经验而进步的研究，样本包括170位治疗师和他们服务的6,591名来访者，对治疗师个体随时间的结果轨迹做了纵向分析。结果与行业对“经验”的直觉相左：治疗师的疗效没有随着经验的增长而提升，平均而言还有小幅下降（Goldberg et al., 2016）。这个结果当然有它自己的限制：它的样本、它的结果测量、它对“经验”的操作化都可以被质疑，一项研究也不是定论。但它对本书的意义不在于证明什么，而在于撕开一个口子：如果更多的训练、更长的年资、更熟练的技艺并不自动地带来更好的结果，那么“做得更对”和“起效更多”之间，就不是一条笔直的线。

读者可以把这三个数字放在一起体会它们的奇特：关系与共情是有效的，而且稳定；治疗师越老练，却不一定越有效；各流派互不相同，疗效却差不多。三条结论没有一条错，也没有一条能单独解释另外两条。要让它们住在同一间屋里，需要一个关于“有效的东西在什么条件下不再有效”的设想。这就是下一节所要提出的问法。

◆ 四、把问题改一个方向

心理治疗研究的传统问法，是“什么有效”。这个问法催生了随机对照试验、元分析、共同因子清单和各类循证指南，它带来的成就是巨大的。但它隐含了一个前提：有效的东西，越多越好，越准越好，越及时越好。以此推下去，就会产生一种几乎无可反驳的临床直觉：既然共情有效，就应当更准地共情；既然解释有效，就应当更及时地解释；既然支持有效，就应当更充分地给予；既然评估有效，就应当更清楚地指出问题所在。每一个“更”字，都顺着证据的方向。

本书要改变的，是问题的朝向。它不再问“什么有效”，改问“好东西为何有时挡路”。这两个问法的区别很具体。前一个问法面对的是一个缺乏的世界：来访者缺少理解、缺少支持、缺少洞察，治疗师的职责是补上。后一个问法面对的是一个已经被补得很满的世界：理解已经到位，支持已经充分，洞察已经形成，来访者却还在原地。在这个世界里，再多补一份，不再是增加资源，而可能是挤占了某个仍待发生的东西的容身之处。

用一个日常的例子来说明。一位母亲辅导孩子做作业，孩子卡在一道应用题上。母亲识别得很快，一眼就看出孩子没有找到等量关系，于是提示：“你先想一想，总共有多少个？”孩子顺着提示往下写，答案对了，母亲满意，孩子也轻松。第二天遇到类似的题，孩子抬头看母亲。母亲没有做错任何事，提示是准确的，及时的，温和的。但孩子手里没有留下的，恰恰是那一刻他自己抓到等量关系的经验。那个经验的位置，被母亲的准确占住了。再往后，孩子有一个很自然的发展：他慢慢学会在题目卡住的瞬间转向母亲的脸，题目本身倒退到了视线之外。准确的提示越多，他越熟练地读母亲的表情。

这个例子里有三个值得单独标出的特征。第一，占位的是一个褒义的东西：准确、及时、温和。没有一项是缺点。第二，占位发生在“尚未由孩子自己做出的那一步”上，而不是在孩子已经能做的地方。如果孩子已经会做，提示就是多

余的；如果孩子根本够不到，提示就是必要的。占位发生在中间那条窄缝，孩子差一点点就够得到，而母亲的准确恰好早一步到达。第三，占位之后的结果是不可见的：作业得到了完成，孩子得到了表扬，亲子关系更融洽。任何一种常规的成效评估，在这个节点上都会给出正面的读数。

把这个例子换到治疗室里，结构是相同的，只是被占的位置换成了更深的东西：来访者对自己经验的命名，对自己困境的诠释，对下一步的发起。在这些地方，治疗师最强的资源，恰好是理解的准确、给予的及时、判断的成熟。本书的全部工作，就是把这一类现象分辨清楚，给它们立名，并且把每一个名字的适用范围、最近的邻居和被打败的条件写出来。

必须强调，这一问法不是对已有证据的反对。平均正相关是在大量来访者、大量治疗师、大量情境上汇总出的结果，位置被占的现象则是在平均数之下的一层结构，它可能只发生在一部分来访者、一部分阶段、一部分位置上，而这一部分在平均数里被其他大多数的正向贡献所淹没。若要检验本书的主张，需要做的与再算一次总体相关无关，要按阶段与位置分层，看同样的动作是否在不同层里方向相反。这一点，会在第4章里变成一条明确的、可以被打败的预测。

◆ 五、三把椅子

本书用“椅子”这个意象指称治疗室里三个具体的位置。它们都是治疗师最容易、也最应当坐上去的位置，在大多数时候坐上去是对的。本书讨论的只是那些坐上去反而不对的地方。

第一把是懂的椅子。治疗师是那个懂的人：他受过训练，听得出来访者话语背后的结构，辨识得出症状属于哪一类，说得出来访者自己一时说不出的东西。这把椅子的魅力，在于它几乎不需要辩护。来访者来求助，是因为他不懂自己为什么痛苦，治疗师的工作自然是帮他弄懂。可是请回到周岚。那句“你一边答应，一边在心里记账”，是十个月里最准的一句话，准到让周岚红了眼眶。准确

的理解有一个很少被谈论的侧面：它同时把周岚安放在一个位置上，那就是“被一个更懂我的人看着”的位置。这个位置对大多数走进治疗室的人并不陌生。从小被父母以“我们是为你好”的目光审视的孩子，被伴侣以“你怎么又这样”的口气评点的恋人，被上司以“你到底行不行”的神情打量的下属，他们最熟悉也最疲惫的人际处境，就是被一个看得比自己透彻的人看着。治疗师的目光再温暖，再专业，在这个位置上，它与那些旧目光共享一个结构。治疗师越准，来访者越配合；来访者越配合，治疗师越觉得应当继续辨识。第3章要论述的双重互锁，说的就是这样两套完整的旧秩序，一套是“我必须小心被审视”，一套是“我必须辨识并干预”，像两只齿轮一样严丝合缝地咬在一起，转得很顺，哪里也到不了。第4章则要追问另一件事：当理解准到、快到、早到、全到一定程度时，它不再是礼物，而成了闯入。

第二把是给的椅子。几乎所有流派都在给：认知行为治疗给出一种更客观的思考方式，精神分析给出一种更准确的关系解释，人本取向给出一份不评判的接纳。表面上，它们给的东西彼此不同。从来访者旧有的关系程序看过去，它们却有一个相同的位置：一个比以往那些人更好的回应者。来访者的旧程序预设了某个位置上必须有人，评判我的表现，决定我是否值得，需要我随时讨好。治疗师带着他的技术坐上去，做得比以前的人好得多，旧程序便把这一切登记为：这个位置上的人，这一回换成了更好的。旧程序没有被拆掉，它只是被优化了。第5章讨论的零功能在场，就是对这种“好人替代坏人”戏码的一个负性回答：接下来访者投射过来的期待，却不执行它所要求的那个功能，也不立刻递上一个新脚本。这个操作很难，在多数临床情境里也不应当使用，第5章会花不少篇幅讲清楚它在何处会失败，为什么“撤”也会被吸收为一种新的给。

第三把是判的椅子。治疗师当然会判断，这并不奇怪。他判断来访者的什么需要处理，什么可以放一放；判断此刻该继续倾听还是适当转向；判断一个想法是出路还是回避。这些判断在大部分时候是专业的核心，是它带来了安全与方

向。可是判断有一个特点，它们总是带着方向性与评判性。一位治疗师在接纳铺好之后，仍然会通过提问的角度、沉默的时机、表情里一点点的松弛或收紧，传递出“这样走是好的”“那边不太对”的信号。这些信号多半不是有意的，来访者却灵敏地接收了。他于是开始朝向被认可的方向走，走得越来越像一个“治疗中的好来访者”。想一想老师批阅作文：学生的文章还没写完，老师在旁边微微一皱眉，学生立刻改了方向。老师并没有说话，也没有要求，但判断已经完成了。在治疗里，这种无声的批阅有时是最强的塑形力。第6章用一个相当苛刻的区分来处理它：克制与撤离不是一回事。克制是知道自己想说，把话咽下去；撤离是方向性的输出本身退出，让来访者的下一步无人可以对照。

三把椅子并列，所指并非治疗师同时坐在三把椅子上，三个位置各自构成一个独立的占位机制，各有各的发生条件，各有各的失败方式。一位治疗师可能在懂的椅子上做得极好，却从未意识到自己在判的椅子上占了位置。更要紧的是，三把椅子的占位有一个共同之处：占住它的，从来都是治疗师的优点，缺点倒很少有这个力量。懂得准、给得足、判得稳，这是我们期望一位好治疗师具备的全部品质。

◆ 六、位置空出之后，这笔账记给谁

假设一个位置确实空出来了。并非治疗师做了什么使它空出，由处境所致，比如周岚那五周的中断；或者由于治疗师在某一刻没有来得及填，或在理解凝结之前停了手。空出来之后，会发生什么？

本书的第三编给出的回答是：在这个位置上，只有来访者自己能做的一个微小动作会发生，或者不发生。这个动作很小，不是顿悟，也不是宣言，周岚那碗面和两天的沉默就是一个样本。它的特点是与来访者既有的经验不可通约，也无人能够替他做。此刻若有人替他做，动作就不再是他的动作。第7章把这类动作命名为不可代偿的亲自动作，并在这个名字上做了一次交代：原文曾使用“发生

性自我指涉”这一说法，成书时改为现名，因为前一个名字更像对内部结构的描述，后一个名字更贴近从外部可以观察到的事实。

动作发生之后，随即出现的是记账问题。这个问题在治疗史上几乎从没有被正面处理过：既然改变发生了，它记在谁的名下？

对这个问题，存在三种常见的回答，各有其来源，也各自失败。第一种回答把账记给技术。认知重构做对了，暴露做足了，解释到位了，所以有效。这种回答在临床研究里最方便，它让治疗可以被手册化、被复制、被测评。它的失败在渡渡鸟判决里已经显露：不同技术的账，居然都能同样地入。第二种回答把账记给关系。同盟好，共情准，来访者感到被理解，所以有效。这是共同因子与情境模型的回答，有大量证据支持，也已经是本书承认的平均事实。它的难处在于，关系在这里同样被记成治疗师的产出，治疗师“建立了”同盟，“给出了”共情，功劳虽然从技术转到了关系，仍然登记在治疗师一侧。第三种回答把账记给来访者：是他自己的努力，是他自己的资源，治疗师只是陪伴者。这是人本取向的传统回答，在伦理上最为得体，却同样难以自洽：如果一切都是来访者自己的，那么为什么需要治疗师？为什么有些来访者没有治疗师就做不到？

周岚的案例暴露了记账过程自身的机制。方立那一句“这是你前十个月工作的成果”，是一次记账：她把周岚那个动作登记为治疗的成果。这个登记的善意毫无疑问，准确度也相当高，它让周岚的动作获得了意义，被放进一个有头有尾的叙事。可是记账这个动作本身，又构成了一次新的占位。动作刚刚在位置上发生，位置就被一句“这是治疗的成果”再次占满。周岚后来的含糊，“不知道算不算我做的”，是记账带来的后果，而且是一个很难被察觉的后果：账是记了，主人却丢了。

第9章要把这一现象推到更一般的层面，提出一个叫作归因敏感度的构念：一个治愈事件，在被归因的过程中，它的构成性信息还能保持到什么程度。有些

事件对归因几乎不敏感，把它们归给某项技术、某种关系或某个人，并不损害它们继续有效。另一些事件对归因高度敏感，一旦被归因、被命名、被收进某个疗法的方法学描述里，使它起效的那些细节，那一个特定的人在那一个特定时刻借用了那一个特定的缺口，就在归档中蒸发了。证据金字塔筛选出来的，恰恰是那些经得起归因的东西，也就是对归因不敏感的东西。这并非对科学的指责。它只是说，一种最深的治愈如果恰好对归因敏感，就会系统地缺席于证据库，缘由与它存在与否、有效与否都无关，只在于证据库收录的方式会把它改掉。

于是“这笔账记给谁”变成全书最后一个问题，也是前面所有问题的回声：做得越对，越占住那个位置；位置空出时改变发生，却记不到任何人的账上。读者在此可能感到一种不适，这种不适是正当的。记不到任何人账上的东西，既无法归功，也无法追责，更难以被写进培训手册。它在行业里没有名位。但是它如果确实存在，那么一门以改变为业的专业，就有必要承认自己账本上的这个空栏。

◆ 七、与几位近邻的界线

任何新立的说法，都要先回答它与已有说法有什么不同，否则只是换了一个名字。这里先以最粗的笔触划出本书与最近几位邻居的界线，每一章再各自展开更细的切割。

首先是共同因子与情境模型。本书不与它们争夺解释权，而是在它们的地基上追问一个它们未曾追问的方向：这些被确认为有效的成分，是否存在会反转的位置。它们的回答是平均意义上的，本书的追问是分层意义上的。两者的预测在多数地方重合，只在特定的阶段与位置上分叉。假如分层之后发现根本没有分叉，本书就败了，而共同因子与情境模型毫发无损。这是本书愿意承担的不对称。

其次是温尼科特（Donald Winnicott）一系的抱持和涵容传统，以及罗杰斯（Carl Rogers）的无条件积极关注（Rogers，1957；Winnicott，1965）。这些传统同样重视治疗师的在场与不评判，但它们把在场理解为一种供给：治疗师为来访者提供一个足够好的环境，来访者在这个环境里重新成长。本书并不否认这一点，大量的情境里这是对的。它追问的是供给结束于何处。当供给本身成了来访者旧程序所能识别和利用的一种资源时，供给越充分，旧程序越牢固。这一追问并不在抱持传统的视野里，因为抱持的概念预设了供给的方向总是朝向成长。

再次是各类关于治疗师自我节制与去专家化的主张，从弗洛伊德的节制原则，到叙事治疗的去专家化立场。这些主张与本书看上去最近，也最容易被混为一谈。区别在于：节制与去专家化讨论的是治疗师应当怎样自处，是一种面向治疗师的规范；本书讨论的是位置，是治疗室里一个只有来访者才能占据的地方，以及它在什么条件下被占、被空出。规范可以被遵守，也就可以被表演；位置的空出却无法被表演，只能在发生之后被事后记录。第11章会指出，一旦“撤”成了可教的规范，它就成了新的椅子。

最后是关于治疗师技艺的传统，认为治疗的精要在于治疗师经年累月熟成的直觉。本书对这一传统怀有敬意，并且第11章为它安排了一场正式的辩论，因为它的主张与“位置”说之间有实在的张力：如果精要就在治疗师熟成的身体里，那么位置说便不能作为精要的解释。本书不预先宣布谁赢。

这四处界线都是粗线，具体的切割要等到各章，在判断对判断的层面上展开。每一章会选出至少三家最近的邻居，把对方的主张原样摆出来，再说清两者在哪个预测上分道。

◆ 八、适用的范围，以及必须先承认的反面

任何一本讲“让位”的书，都有一个明显的危险：被读成一种关于撤退的伦理，被理解成治疗师可以因为“这是来访者自己的事”而心安理得地不管。因此，范围和边界必须在这里就写清楚。

本书的判断适用于来访者尚未亲自命名、亲自发起的那些地方。这是一个窄的范围。在来访者已经能够命名、已经能够发起的地方，治疗师的理解、给予和判断，就是单纯的协作，没有任何占位问题。在来访者根本无法站上那个位置的地方，也就是自伤自杀的风险、急性危机、自我结构的严重缺损、心理储备的耗尽，本书的判断不适用，治疗师需要提供结构化的帮助和安全流程。一位来访者在深夜里发来一条表示想结束生命的信息，此刻问“这是不是该给他空间自己面对”，是一个错误的问法；该问的是怎样让这个人活到天亮，并立即启动危机与安全流程：联系危机热线、急诊或可信赖的专业机构。第11章会把这条线写硬：安全优先，没有商量。

本书必须承认的反面，是平均的正相关。同盟与疗效、共情与疗效的关系是稳固的，这两个数字不会因为某个分层预测成立而作废。即使本书最激进的主张全部被证实，其含义也只是：在平均的正效应之下，某些阶段与位置里存在反转，需要治疗师在这些地方知道自己做得越好、越可能占位；它不会推出“那就少共情一点”这样的结论。因为在大多数地方，少共情就是少帮助。

还有一个必须承认的反面是治疗师的善意。读者在全书中会看到许多治疗师占位的场景，它们很容易被读成对治疗师的批评。实情相反：占位总是发生在治疗师做得最好的那些部分。方立没有做错，她的解释是准的，肯定是暖的，督导者对她的工作也是满意的。本书对治疗师的要求，不是要求他们变得更差，更不是要求他们假装不懂、假装不在。本书只要求一件事，在判断力之外保留一种自知：知道自己的好，在某些地方可能是别人的路障，而且这种自知本身是靠不住

的，第8章会说明为什么治疗师没有一个能够站在互动之上、从高处看清自己的位置。

◆ 九、全书的路线

全书分为四编和一个合论。第一编“看上去都很好”处理两个看上去没有问题的现象：第1章，治疗一直在前进，进展却穿不过治疗室的墙，这是涵容性织体；第2章，期内的改变是借来的，期后便被收回，这是发生租借。这两章讲的是同一个难处在时间维度上的两种形态，一个是“没有出门”，一个是“出门之后找不到主人”。

第二编“三把被占住的椅子：懂、给、判”依次展开三个占位机制。第3章讨论懂的椅子上的双重互锁与共同进场，第4章讨论理解如何由礼物变成闯入，以及“不逾”这个概念，第5章讨论给的椅子与零功能在场，第6章讨论判的椅子与裁决撤离。读者在这四章里会看到，三个机制各自有不同的发生条件，同时又彼此缠绕：在懂的椅子上卡住的人，往往也在给的椅子上被旧程序吸收。

第三编“椅子空了以后”讨论位置空出之后发生什么。第7章是全书的正面主张所在：那个微小的、无人可代的动作。第8章是裁判席。它要说的是，前面所有关于“占位”和“空出”的措辞，都容易给人一种治疗师在高处调度的印象，而事实上卡住的东西本来就是两个人共同做出来的，治疗师没有站在互动之外的位置。这一章会对前面各章中任何带导演腔的措辞进行审判。

第四编“这笔账记给谁”只有第9章，把记账问题推到证据库：为什么最深的治愈偏偏最难入库，一次起了效的事件在被写进病历、归入某项技术之后，究竟丢掉了什么。

合论“三个难关”由三章组成。第10章是三场自撞。九章的判断彼此不是并列关系，有些会冲突：第9章把深层治愈判为成立，第2章把期内改变判为借

来，二者怎样不矛盾？第3章撤的是解释权，第5章撤的是关系功能，二者撤的是同一样东西吗？第六、七章原文里治疗师“逼出”“制造”来访者的动作，与第8章的“没有高处”如何相容？第10章会逐一对质，并正式交代一次措辞上的全书裁定。第11章讨论“让位”自己的危险：让位也能占位，有时根本不该让；这一章为技艺传统安排反方，为安全优先写下硬线。第12章是外推：人工智能心理陪伴，一个永不离席的“懂的人”，把三把椅子再过一遍。全章被明确标注为外推与预测。结语追问本书自己坐在哪把椅子上。

◆ 十、三条判错条款

一本理论专著的诚实，最终要看它愿意让自己被什么打败。本书全部主张中，有三条被选作最硬的判错条款，分别落在第4章、第7章和第9章。它们都是尚未检验的预测，都没有数据，都等着同行去试。

第一条出现在第4章。把来访者按自我概念的清晰程度分为稳固组与萌芽组。治疗师给出一次精准的共情之后，预期两组来访者的同盟评分都会上升，这是平均效应的体现，本书予以承认。然后看四周后的自主行动，要求由第三方核实，不依赖来访者自己或治疗师的报告。本书的预测是：自主行动只在稳固组上升，萌芽组不但不升，还会下降。如果萌芽组与稳固组同样上升，本书关于“懂得太准就是闯入”的判断便告失败。条款尚未检验。

第二条出现在第7章。取两种情境：一种是来访者本人做出某个微小动作，另一种是治疗师在势能充足的情况下替来访者完成同一个动作，比如替他拨出那个迟迟拨不出去的电话。观察三个月后的行为模式。本书预测两者有差异：本人做的，模式松动，代做的则不然。如果三个月后两者没有差异，本书关于“不可代偿的亲自动作”的判断便告失败。条款尚未检验。

第三条出现在第9章。如果一个被指认为转折点的治愈瞬间，经过标准化之后，仍然能稳定地保留它的效力，也就是它对归因并不敏感，那么本书关于“最深的治愈进不了证据库”的判断便告失败。条款尚未检验。

读者可以看出，三条条款的朝向是一致的：它们都问，当把治疗师的好东西做足、做准、做标准化之后，结果是否如平均数所预示的那样继续向好。如果是，本书败；如果不是，才有继续追问的余地。三条条款在结语里会被再写一遍，并附上被打中时哪些部分应当撤回的清单。

每一章另有它自己的读数和判错条款。读数是事后可以记录的现象，用来分辨本章判断与最近邻的解释何者更贴近事实；判错条款则界定本章何时撤回。导论的读数只有一个：读者读完本章后，回到自己最顺利的一个案例上，看看那个案例里有没有一个“动作已经发生、但没有人能说出它是谁的”的瞬间。如果有，不必急着下结论，把它记下来，带着它读下去。

目 录

作者介绍 iv

成书说明 v

前言 vi

导读 ix

导论　都做对了，怎么还没变 xv

第一编　看上去都很好 **1**

第1章　越投契，越不动 2

第2章　变了，但不是他的 22

第二编　三把被占住的椅子 **49**

第3章　懂的椅子：谁是懂的人 50

第4章　懂得太准，就是闯入 75

第5章　给的椅子：接下来，不坐上去 103

第6章　判的椅子：接纳铺好之后 127

第三编　椅子空了以后 **147**

第7章　那个动作只能他自己做 148

第8章　卡住的东西是两个人做出来的 169

第四编　这笔账记给谁 **197**

第9章　最深的治愈进不了证据库 198

第五编　合论：三个难关 **219**

第10章　三场自撞 220

第11章　让位也能占位，有时不该让 240

第12章　永不离席的懂的人 260

结语　这本书自己坐在哪把椅子上 276

参考文献 287

版本说明　本版字数、版本与交付 296



第　一　编

看上去都很好

编　序

从两种最难被认出的停滞开始。治疗没有失败，同盟很好，量表在降，所有人都觉得这一程走得不错。第1章看的是一种一直在前进、却穿不过治疗室墙壁的治疗；第2章看的是确实变了、结案后又退回去的人。

这一编不谈谁错了。它要先把一件事摆出来：好局面本身可能就是问题的一部分。

01

第1章

越投契，越不动

周四下午四点，常远准时坐进那把熟悉的椅子。他三十五岁，在一家互联网公司做技术负责人，治疗已经进行到第六次。他先说了几分钟这一周怎么过的，然后停顿了一下，用一种近乎顿悟的语气开口：上周约好要去找那位长期不履行职责的同事把话讲明白，他没有去。他说自己反复想了很久，想明白了，自己不敢开口，原因倒与冲突无关，内心深处一直觉得自己不配为自己站出来，这和父亲从小让他觉得“你的感受不重要”是同一个模式。“昨天晚上想到这一点，突然就通了。”（说明性合成案例）

他说这话的时候是诚恳的，眼眶是湿的，那一刻他体验到的东西没有半点作假。治疗师点了点头，身体微微前倾，说：“这确实是非常重要的发现。”会谈在一种温暖而饱满的气氛里结束。治疗师在笔记里写下“来访者取得重要洞察，同盟进一步巩固”。常远走出诊室，在电梯里觉得自己比上周更接近好转了一步。第二天上午，他在走廊里远远看见那位同事，绕了一条路。

这样的场景在临床上并不陌生，难处在于它没有任何一处可以指出来说“错在这里”。来访者没有迟到，没有沉默，没有对解释表示怀疑，没有在会谈里与治疗师对抗；治疗师没有失误，没有越界，没有说出一句不恰当的话。以今天通行的任何一把尺子去量，这都是一段进展顺利的治疗。同盟量表会给出高分，过程笔记会写满“洞察”，督导会点头称许。唯一没有改变的，是走廊里那条绕开的路。

本章讨论的就是这种治疗：它没有失败，也没有卡住，它一直在前进，只是前进的方向不经过治疗室的门。本章的承重判断是：在特定条件下，治疗师与来访者之间会织成一种体验上高度契合、与来访者外部生活的结构脱钩的互动质地，本书称之为涵容性织体。织体越致密，改变所需要的能量越是被引入这条闭合的回路里消耗掉，双方都在回路中得到稳定的回报，因此谁也没有理由去拆它。

◆ 一、没有卡住的治疗

心理治疗的理论对“为什么没有改变”并不缺少解释。阻抗理论说，来访者的无意识冲突会以抵抗进程的方式表达自己，沉默、回避、遗忘关键材料、对解释做持续的理智化反驳都是它的面貌。破裂与修复的研究（Safran & Muran, 2000）说，同盟的裂缝若不及时识别，治疗就会停滞。阶段模型（Prochaska, Norcross, & DiClemente, 1994）说，来访者可能停在沉思前期或准备期，行动的动力还没有积攒够。共同因素的立场则从另一个方向补充：共情、同盟、积极期望若建设不足，改变便难以发生。

这些解释各有精到之处，把它们并排放在一起，却会露出一个共同的轮廓：它们都在寻找一块拦路的石头。阻抗表现为拒绝，破裂表现为关系中的张力，阶段性停滞表现为动力缺乏，共同因素的缺失表现为关系冷淡。而常远这一类治疗的特征，恰恰是这些形态的集体缺席。没有拒绝，没有张力，没有冷淡，也没有动力不足。治疗不是被什么东西挡住的，它沿着一条从一开始就不通向外部的小径，平滑地滑了下去。诊断拦路石的工具，面对一条看上去平坦却不知通往何处的路，无从下手。

同盟研究内部其实早就留下过线索。同盟与疗效的平均关联为正，Flückiger、Del Re、Wampold 与 Horvath（2018）汇总 295 个独立样本，

得到 r = .278，这是被反复验证的发现之一，本书从头到尾不会否认它。但平均数之下总有离开平均数的个案，临床讨论里常把其中一部分看作“高同盟、低改变”的异常。对这些异常的常规处理，是归因于来访者的特征（人格病理的严重程度、对拒绝的敏感）或测量的误差。这样处理本身没有错，只是它始终把异常当作需要外生变量解释的离群值，而没有追问另一种可能：高质量的合作关系，在某些条件下本身就是改变被搁置的原因。

对阶段模型的异议值得单独回答，因为它是最顺手的一个现成解释。有人会说，常远这样的来访者不过是在沉思期停得太久。回答在于停留的动力来自哪里。阶段模型把停滞归于来访者内部的权衡尚未完成，治疗关系的功能是为权衡提供信息和支持，它自己不是停滞的成因。涵容性织体的判断则相反：来访者长期停在“想明白”，利弊权衡有没有做完倒在其次，要紧的是“想明白”这个动作在治疗关系里得到了别处得不到的回报：被精准理解的体验，被认作“有深度”的满足，与治疗师之间无缝的默契。回报持续供给，进入行动便不仅多余，还可能有危险，因为行动带来的外部后果，随时可能撕开这份默契。阶段模型描述的是停留的现象，本章要追问的是停留由什么供能。

再往下追一层，会碰到所有这些解释共同依赖的一块地基。它可以这样表述：治疗师已经知道改变应当如何发生，他的任务是识别来访者在哪一环偏离了这条已知的路径，并加以校正。阻抗理论里，被压抑材料的浮现是路径，阻抗是路障。同盟研究里，高同盟促进改变是已知的规律，低同盟是需要修复的偏差。阶段模型里，阶段的序列是已知的，停滞意味着某一阶段尚未走完。这块地基并不是某一流派的偏见。每一种理论都是在回答自己面对的临床困惑时被锻造出来的：阻抗来自弗洛伊德在自由联想中遇到的沉默与转移话题，同盟来自疗效研究对跨流派共同因素的需要，阶段来自对戒烟与减重等自发行为改变的纵向观察。它们各自的来历不同，却在各自成熟的过程中，把同一个前提反复加固，直到它

成为培训手册、督导评价乃至保险公司“医疗必要性”审核的共同底座：存在一条可以事先规定、事后审查的正确改变过程。

这一底座的后果，在常远的案例里看得最清楚。只要来访者持续产出洞察、情感表达与合作，那张“改变应当如何发生”的地图就会显示：进展良好。地图允许这条路存在，因为这条路上铺满了地图上标着“好”的东西。治疗师手里的标尺越是忠实，他越难发觉来访者已经走上另一条路：一条同样铺设着洞察、共情与同盟回报的、自成闭环的路。

◆ 二、涵容性织体

撤开那块地基，治疗现场就不再是一张“正确的改变流程”与“来访者的执行偏差”之间的对照表，而是两个人之间正在被共同织出的一片质地。每一次回应、每一次认可、每一次对沉默的填充，都在推进或偏离改变之外，同时织着关系本身的密度、弹性与闭合程度。这种密度不从任何一方的意愿或技术里生长出来，而是在具体的互动回合里被双方联手织成。从这个角度重看“治疗顺利而生活不动”的个案，一个结构显出轮廓：它既出不了来访者单方面制造的假象，也算不得治疗师一方的失察，它是两个人在特定条件下共同织出的一种极其舒适、高度自洽、却与外部世界脱钩的联系形态。本书称之为涵容性织体。

这个命名里的两个词都需要交代。“涵容”取自比昂（Bion, 1962）：母亲或治疗师接收婴儿或来访者无法承受的原始焦虑，在自身内部消化，再以可以承受的形式交还。它是一个主动的、带转化功能的过程，而不是被动的接纳。本书保留这个直觉的全部分量：治疗师为痛苦提供一个可以被承受的关系空间，是深度信任得以建立的前提，对此没有半点否定的意思。本书多走的一步，是追踪这个直觉的一个逻辑后果。当涵容的空间变得过于致密、与外部世界过于隔绝时，它不再只是痛苦被消化的场所，它自己成了一个取代外部世界的、自足的替代现

实。后一半才是“涵容性织体”这个概念独立的内核，它标示的是涵容理论一个未被命名的边界，而非对涵容理论的反对。

“织体”一词借自音乐。复调音乐里，多条旋律线在同一段时间里交错、应和、彼此成就又彼此限制，织体指的是这种实时编成的质地，而不是静止的容器。成功的治疗里，这片质地是柔韧而透气的：它能承住来访者的混乱，却不把混乱全部包住；它有裂缝，有不完美，有没来得及回应的沉默，而这些不完美正是外部世界得以渗进来的孔隙。织体趋于致密的时候，情形相反：它越来越擅长消化一切张力，从任何方向施压都能优雅地回弹，那个需要被带进来的生活世界，被这层质地挡在了外面。

因此本书避免把“闭锁”写成织体的一种固定属性，更愿意说织体“趋于致密”、处于“闭合的过程”里。这种措辞上的克制有它的用意：要持续追问的是，在每一个具体回合里，是什么在给致密化供能。答案不在某一方的性格或技术里，而在双方需求逐步同构、彼此加固的那条微观回路里，下文第四节会逐帧展开它。

拿一段对照来看会更具体。设想另一位来访者林舟，同样三十多岁，同样在第六次会谈里报告上周约好的那次沟通没有去做。他同样很快讲起这与小时候的某种感觉有关，讲了半分钟，治疗师没有立刻接这个话头，只是说：“所以那天你没去。”林舟停住了，屋里安静了几秒，他有点不耐烦地说：“对，没去。我也不知道为什么，就是到了门口脚不动。”这句话比前面半分钟的分析都粗糙，却是整段会谈里第一次有一件发生在生活里的事进入了房间。后面的谈话未必更漂亮，笔记里也许没有“重要洞察”，治疗师甚至可能在那几秒里感到一阵坐立不安。两位来访者的区别不在聪明、动机或配合程度，只在于房间里有没有一个位置，容得下一句不成形的、与分析无关的话。透气的织体和致密的织体，在录音转写稿上往往只差这样一个位置。

致密与透气不能只停留在比喻上，否则这个概念无法被任何人检验。可以在会谈记录里读到的指标有六条，分作两组。透气的织体，通常至少带有其中一条：来访者报告某个行动计划没有完成之后，治疗师的至少一次回应没有立即把它转写成心理洞察的材料；来访者说出“我没做到，我也不知道为什么”之后，出现过一段三秒以上、没有被马上填满的沉默；来访者对治疗师的某次解释表达过异议或感到不被理解，这个表达本身没有被当场解释为“对权威的投射”。致密的织体则有如下特征：来访者每一次“没有行动”的报告，都在十秒之内被他本人转写成关于童年模式、内在冲突或移情关系的分析；治疗师对每一次自我分析都给予确认（点头、前倾、“这是很重要的发现”），没有例外；连续三次以上的会谈里，没有一次由治疗师主动发起的、针对具体行为计划执行情况的追问。这六条是事后可以逐条数出来的现象，本书把它们当作描述织体状态的读数，不当作操作的指令，原因将在第五节说明。

织体的形成需要两个条件的耦合。其一是双向的契合：治疗师与来访者在认知风格、情感表达的节律、对“什么叫深度”的默契判断上高度同频。契合本身是好东西，许多成功的治疗正是以它为基石，它让治疗师能准确接收来访者情感信号的频率，也让来访者能把治疗师的语言收为自己的叙事工具。它同时是一个阈值：当治疗师几乎总能预测来访者下一句话，来访者几乎总能预判哪种自我分析会引来治疗师深沉的回应，系统里的摩擦源就所剩无几。没有摩擦的系统没有孔隙。契合还会自己强化自己，每一次成功的相互预测都为下一次更精准的预测铺好轨道，契合没有谁“找到”它的那一天，它是被一回合一回合“做密”的。

其二是外部反馈参照的缺位。来访者在治疗之外，缺少可以独立于治疗师评价、实际检验其行为变化的处境：工作环境不提供关于他人际模式的反馈，或者他学会了屏蔽这些反馈；亲密关系里要么缺少坦率的渠道，要么对方早已放弃期待；也没有一个既了解他又愿意说实话的人，能对他说一句“你在治疗里讲的那

些，在生活里好像没什么变化”。这个条件同样不是织体之外的静态背景。织体越致密，就越擅长把来自外部的负反馈重新编码，把它读成“仍然不被理解的证明”或“需要更深分析的材料”。织体自己在制造外部参照的缺位。两个条件缺一，织体都不会滑向闭合：契合高而外部参照充分，治疗仍然可以保持透气；参照缺位而契合有限，也缺少让它致密的材料。这一点同时是本章后面要写明的一条判错条款的来源。

◆ 三、与近邻的切割

一个新概念要立得住，必须在最危险的近邻面前划出自己的地界。划界的办法不是列一张定义对照表，那样只是给每个概念分配一个格子。更有效的办法是设想各家的代表人物与我们一同坐在同一段会谈录像前，在关键的回合发生时，各自会说什么，他的概念让他看见什么，又让他漏掉什么。

同盟研究者会首先发言。他看到的是合作程度极高、情感联结紧密、目标共识明确，这是一份漂亮的高分答卷。他的框架允许他说：同盟很强而改变未至，也许是来访者的人格病理在起作用，也许是一个有待研究的异常值。同盟与疗效的平均关联确实为正，r = .278，汇总的是三万余人的数据（Flückiger et al., 2018），共情与疗效的平均关联同样为正，r = .28，汇总了 82 个样本、6,138 人（Elliott, Bohart, Watson, & Murphy, 2018）。本书认可这两个数字，也不打算对它们提出异议。平均数描述的是一群人的大致走向，涵容性织体讨论的是平均数下面那条没被问过的曲线：同盟的强度之外，同盟的质地，即它与外部世界联结的透气程度。可以把它写成一张两栏的表：横向是同盟的强弱，纵向是织体的透气或致密。高同盟而透气，是大多数成功治疗的现场，同盟研究在报告“高同盟促进改变”时，捕捉到的正是这一格。高同盟而致密，是本章讨论的位置。同盟量表问的是合作的质量，它的理论承诺把“高质量的合作必然促进改变”当作前提，因此从没有人用它去问“合作本身何时翻转成了改变的阻碍”。

量表并无疏忽，这是它的构念边界。把这个问题抛给量表，是在要求一把尺子去量它没有刻度的东西。涵容性织体所补充的，是这条连续谱上一个调节变量：透气性。

人本主义的治疗师会指出共情的贡献。罗杰斯（Rogers， 1957）把共情定义为进入来访者的内部参照框架，如同成为对方，同时不丢失“如同”的品质。织体的形成里共情是必需的原料，持续而精准的共情回应给了织体密度与韧性。但这位人本主义者看到录像里的精微进入，会得出另一个结论：共情的深度还不够，需要更多时间。他的框架允许他持续加大剂量。恰恰是这个“加大剂量”的操作，在给织体的致密化供能。来访者每一次“没能行动”的体验，都被共情精准接住，转写成“更深的自我理解”的材料，行动的外部性所带来的羞耻、挫败、不确定，以及必须独自面对世界的孤绝，被一个没有接缝的涵容回路豁免了。共情在这里不再是通向外部的桥，它成了一层阻断外部进入的缓冲垫。这不是说共情有错。共情传统预设了一个并不总成立的前提：共情本身是自足的善，越多越深。织体是这一预设的反例条件，也是第4章要用另一种证据继续追问的位置。

最锋利的近邻在温尼科特那里。他的过渡性空间（Winnicott，1953）介于内在现实与外在世界之间，让孩子或成年人安全地试验尚未经受现实裁决的冲动与可能的自己，它的价值在于它是一座桥。织体与它的分别很清楚：过渡性空间通向外部，织体把自己建成了一个与外部世界平行运转的替代现实，里面的体验是实在的，却不向外溢出。更难切的是客体关联与客体使用的区分（Winnicott，1971）。客体关联中，客体仍然运作在主体的全能感之内，是投射的接收者；客体使用则要求主体把客体放到外部去，承认它不受自己控制，并承受它可能拒绝、令人失望的事实，这一步依赖客体在被攻击时幸存，不报复，不撤回。一位温尼科特主义者看常远的录像，会给出一个几乎覆盖全部现象的诊

断：来访者停在客体关联里，从未抵达客体使用，治疗师是那个总在恰当时机给出确认的理想客体，没有人为他提供“幸存”的经验。这个分析为什么还不够？因为它把失败的供能全部记在来访者的恐惧上：他不敢攻击，所以治疗师无从幸存。涵容性织体的观察是，治疗师在持续向来访者供应一种让攻击变得不必要的互动质地。精准的共情、及时的确认、对“没做到”的迅速接住，合力把攻击的必要性提前消解了。来访者不用挑战治疗师，因为治疗师从未给他一个值得挑战的阻力面；治疗师也从未被置于“可能被摧毁”的处境里，因而无从幸存。温尼科特的语言只能把它读成分析师没有促成客体使用的过渡。织体的说法是，这份失败有人在为它持续消除摩擦，而且这个人在其中得到了自己的回报。

戈夫曼的拟剧论给出的是一个让人立即获得满足感的解释：来访者在扮演“好病人”，治疗师在配合演出（Goffman, 1956）。他的答案轻易覆盖了现象，随后合上笔记本。追问从这里才开始：剧本是谁写的？为什么“一个持续进展、深刻内省的好病人”这个剧本，在这间屋里比“一个笨拙尝试新行为又反复失败的病人”“一个对治疗师不满而不敢说的病人”“一个承认自己不知道在做什么的病人”都更稳固，更难被替代？拟剧论解释了人们为什么表演，没有解释某个特定的剧本为何在某段特定的关系里有这样强的韧性。要回答它，分析的单位必须从个人的印象管理移到两个人联手维持的互动织体上。戈夫曼是必须踏过的一级台阶，他把现象推到了台前，也挡住了台后。

卢曼的社会系统论是敌意最大的近邻。治疗互动是一个操作上封闭、自我指涉的沟通系统，以“理解/不理解”为符码，靠沟通对前序沟通的衔接来再生产自己，外部世界只能以被系统编码过的形式进入（Luhmann，1995）。来访者交付洞察，治疗师以认可回应，来访者再深入，治疗师再确认，这个回路无需外部验证即可运转。在卢曼看来，这是系统成功建立了操作封闭，是正常表现。他的描述在逻辑上几乎无懈可击。织体概念靠两样东西与它分开。其一是能量。系

统论追问“下一个沟通如何可能”，不追问人们为什么向这个系统持续投入。织体里的双方都在从中取得情感满足：来访者得到被准确接住的稀缺体验，治疗师得到“我是个有效的治疗师”的专业确证。这些是有血肉的需要，不是沟通符码。其二是可裁决的辨别格。卢曼会预测所有治疗系统都会走向操作封闭，织体的判断则是不会：闭合需要契合与外部参照缺位两个条件同时在场，缺一则封闭可以是良性的，保留着对外部的透气孔。在他的语言里，一切操作封闭的系统结构同构，切不开“普通的封闭”和“由双方情感需要驱动的超额闭锁”，织体切开了。

最后一个大家族是精神分析内部的精神退缩传统，罗森菲尔德（Rosenfeld, 1964）关于自恋组织的研究与斯坦纳（Steiner, 1993）关于精神退缩的论述，描写病人撤进一个自洽的内部世界，保护自己免受被害焦虑与湮灭感，同时切断与分析师的实际接触。一位克莱因学派的分析师看录像，会说这是典型的精神退缩。区别在于位置：他们分析的是来访者一个人的内部病态组织，治疗师是被拒斥的外部在场；织体位于两个人之间，治疗师恰恰是织体得以致密的必要条件，他持续提供的涵容、共情与认可是织体最重要的纬线。治疗师若不配合织入这些纬线，闭合不会被现场发生出来；反过来，来访者若不具备高度内省与语言化的能力，这张织体也织不出隔绝外界所需要的质地。理论的单位因此从“一个人”换成“一个互动场”。

还有三家在临床督导里最常被用来命名同一现象，距离更近，需要逐一说明。治疗性共谋指二人组心照不宣地避开某个危险区域。分离线在于有没有一个被回避的对象：共谋的结构是回避，织体不需要任何回避，来访者可以把最痛的材料完整交出，治疗师可以准确诠释，双方什么都没躲，改变照样不发生。比昂的 −K 联结（Bion, 1962）指两人联结在一起而使双方更贫乏，理解被剥去意义只剩形式。分离线在于意义是否被掏空：−K 的话越说越像话，内容越来越薄；

织体里的洞察可以是深刻的、经得起任何独立评审的，问题出在去向，而不是质量。拉克尔的互补性认同与同盟研究里的“假性同盟”（Racker, 1968；Safran & Muran, 2000）指向的是一个看上去良好的同盟其实是阻抗的形态，分离线在单向还是双向：互补性认同描述治疗师被推入某个角色的单向过程，织体的核心是双向的回报，治疗师同样得到专业胜任的确证，所以同样没有动机去松动它。三条分离线都已写成可以执行的判据，会在本章末列入判错条款。

每一个近邻都握住了拼图的一块，没有一个能单独看见整幅图。织体所做的工作，无意用新词否认它们各自握着的东西，只指认它们各自看不见、却共同围出来的那条缝：二人联手、在互动回合里持续织造、由双方的情感需要供能的闭合过程。

◆ 四、织体怎样被织密

对织体最根本的误解，是把它看成来访者单方面的策略：他在表演，治疗师被蒙在鼓里。这条解释路线走不通，因为织体能够建立，是由于它同时满足了双方各自的需要，而这些需要本身没有一样在道德上可疑。它们恰是治疗得以建立深度信任的前提。织体不是阴谋的产物，它是两个人各自的正当需要在无人察觉的条件下长出的一个超出任何一方本意的结构。

一个问题不能跳过。被理解、被认可、被确证有效，这样的满足在日常关系里并不稀罕，为什么在织体里它们会有这么强的“替代”效应，足以长期顶替外部世界的复杂反馈？答案不在满足的内容，而在供给的结构。外部世界给的确认几乎总是间歇的、有条件的、夹杂着误解与拒绝的：一周里上司肯定一次，无声地忽视五次；亲密关系里刚有片刻深谈，随即吵起来。织体给的确认在这几个维度上形成极端的反差：每一节准时开始，每一次深入的自我分析都有回应，持续；无论来访者在外面表现如何，他的内在工作总被认作有价值，无条件；他不

用担心因“做得不够”而失去这份关系，不夹杂惩罚。持续、无条件、不带惩罚的确认，在任何人际情境里都极其稀缺，当它恰好落在一个因外部挫败而耗竭的生命阶段，几乎无法抗拒。

来访者一侧，织体提供的是痛苦第一次被准确接住的体验，没有被仓促矫正，没有被轻浮安慰，也没有被防御性地推开。他把“被接住”与“我在变好”联系起来，这个联系也不全是错觉，能够承受痛苦而不崩溃，本身就是一种变化。于是赴约的动机悄悄从“我需要被接住”滑向“我需要持续感到自己在进步”，而后者在织体内部比前者更容易被满足：每一段精美的自我分析，每一次被认可的情感表达，都在实时递来“进展”的证据，他无需穿过治疗室的墙去验证。治疗师一侧，织体提供的同样是稀缺品：一位投入的、善于内省的、能用自己的语言复现治疗师所看重的深层模式的来访者。“这节做得很好”的感觉每一节都稳定到来，督导时报告“来访者正在取得重要进展”，所依据的全部材料，恰恰是织体内部自洽的证据回路，这些材料从来没有离开过那间屋子。治疗师一侧的力量比来访者一侧更难识别，它披着专业判断的外衣。当治疗师感到与来访者形成了深度默契，能预测下一句话，能为叙述赋予结构，这些体验在大多数治疗理论里都是深化的标志，正因为是标志，很少有人在这种时刻问一个扫兴的问题：这份越来越流畅的相互理解，是在把世界拉近，还是在把世界推远？

织体为什么难以从内部被看见，还有制度上的原因。治疗师判断自己的工作是否有效，依据的几乎都是会谈里发生的事：来访者的洞察、情感的流动、同盟量表上的分数、对治疗的积极反馈。这些东西在织体里全是实在的，它们构成了治疗师评估自己的几乎全部可见材料。督导会议上，被督导者报告的也是这些，“来访者正在取得重要进展”，督导者点头，因为他拿到的同样是这份材料。保险机构对“医疗必要性”的审核看的是病历里的进展记录，常见的胜任力清单里有建立同盟、识别模式、引导情感探索、传达共情，没有一项要求治疗师

检查这些东西有没有离开过诊室。经验也不会自动补上这块缺口。Goldberg 等人（2016）追踪了 170 位治疗师、6,591 名来访者，平均而言，治疗师的疗效没有随经验增长而改善，反而有小幅下降。这个发现不能直接拿来为织体作证，本书也没有这个打算，它只说明一件事：多年的从业时间不保证一个人学会看见自己所处的位置，而织体恰恰是一种位于“自己所处的位置”上的东西。

改变的能量去了哪里，值得单独说明。穿出治疗室墙壁的改变，涉及行为、关系与存在方式的重组，需要来访者调动相当可观的心智与情感能量：忍受旧模式解体的不适，承担尝试新行为之后可能失败的羞耻，放弃熟悉的自我叙事所带来的迷失。人们回避改变，往往看得到好处，只是不愿或暂时无力支付这笔费用。织体不取消这些能量，它为这些能量提供一条更轻易、更即时、更能得到认可的去处：精美圆融的自我分析要耗能，情感在治疗室内的唤起与代谢要耗能，对童年创伤再追溯一遍、再理解一遍也要耗能。它们都是高强度的心智劳动，共同点是耗完之后不留下需要带回生活的未竟冲动，在一个封闭的回路里完成了自己的循环。“这一周我做了很好的内在工作”，成了可以顶替“这一周我做了不同的外在行动”的结算方式，在体验上奖赏的力度同样足，甚至更稳。来访者离开诊室时可能精疲力竭，但那是内在工作之后的疲惫，里面装着“我懂了”的满足，而不是行动之后那种“我做了”的充实。前者改变的是世界的某个状态，后者改变的是他对自己的某种解释。

回到常远，看织体在一个回合里怎样被系上第一个结。这一节的分析单位取互动事件之间的衔接压力，不取个人的意图。

第一帧发生在他开口之前的几秒。他要交代一件事：约好的沟通没有做。这件事在对话里有不止一种方式被衔接。可以只说“我没做”，然后停下，让这件未完成的事作为开放的事件落进对话，由对方决定往哪里接。也可以在说“我没做”的同时，立刻给它一个意义的框架，用一个自足的认知产品填满那段可能令

人难受的空白。进入对话的是第二种。这里无需假设他在算计，只需看二人的互动史：第二种方式已被反复验证为能让对话顺滑衔接的路径，第一种携带一段不可预测的空白，可能被接住，也可能不被接住。衔接的压力，倾向于选择已被验证的路径。

第二帧在治疗师一侧。听完这段话，两个衔接选项几乎在一秒内同时升起。其一是停在未完成的行动上：“上次那个计划，发生了什么让你没能去做？”其二是接住来访者已开启的探索：“这个发现很重要，这个模式在别的情境里出现过吗？”两个选项并不中性。前者携带一个微小的互动风险：可能打断来访者刚建立起的、把失败转成洞察的流畅感，在关系里制造一个短暂的不契合，他期待的是对洞察的认可，得到的却是对行动细节的追问。后者是平滑的路径，延续此前五次会谈建立的深度共情的节律，不会在对话流里留下毛刺。衔接的压力倾向于选更平滑的一条。还要补一笔临床现实：治疗师在这一刻常常伴有一丝不到一秒的迟疑，“追问行动会不会破坏刚才那段分析的质地？”这丝迟疑事后多半不被记得，它说明回应没有被干净利落地“选择”，它在已织成的节律的压力下，被挤到了更平滑的那条路上。织体的致密，就是在无数次这种迟疑被压下的时刻里，一针一线织起来的。

第三帧是沉积。顺利的衔接留下两层东西。对话下一轮的方向被锁定了：来访者接到的信号是“洞察是受欢迎的衔接材料”，于是顺着认知探索继续深入，谈这个模式在其他情境里的表现，行动的未完成没有成为被搁置、等待返回的未竟事件，而是被无缝地转成了一轮成功衔接的起点。二人的互动史也被更新了：交付高阶的认知产品，得到确认性回应，对话继续平滑推进，这条路径被验证为高效而低风险，进入二人共有的模式库，将在类似的情境里被优先调用。

第四帧是闭合。此后每当行动失败，或者压根没有发生任何行动，“未行动”这件事倾向于迅速被来访者本人重写成心理洞察，因为互动史反复证明这是

最可靠的顺滑衔接方式；治疗师的回应倾向于接住这些材料，因为这是维持深度感与契合感的最平滑路径。双方衔接得越契合，这条“把未行动转成洞察”的路径就越被加固；路径越稳，行动的外部性本应携带的挫败、沉默，以及对关系契合度的挑战，就越难在对话里找到一个没被填满的窗口。没有人在这里“学会”了什么。是互动事件的衔接压力，选了那条最不容易断的路。

织体的韧性，在一次失败的松动中最为清楚。设想第十次会谈前后，治疗师在督导里第一次接触到织体这个概念，开始怀疑自己和常远之间也在形成类似的结构，决定下一次在来访者再把未完成的行动转成洞察时，先不确认，留一段没被填满的沉默，再把话题引回行动本身。这一刻在第十二次会谈到来。常远在前一周许诺过要与伴侣坦率谈一次，没有实施，这一次他花了三分钟，把它与童年时在父亲面前无法表达真实感受的记忆联系起来，语调平稳，分析精到，一看就是酝酿了一周的。他说完之后，治疗师没有点头，也没有说“这很重要”，沉默了大约三秒，然后说：“我想先回到上周那个计划。那个时候，是什么让你觉得最难迈出那一步？”

这个衔接选项在对话里造成了一个小小的断裂。常远的叙事节奏被打断，身体微微后靠，视线从治疗师脸上移到自己交叉的双手上。他没有回答，约五秒的沉默之后，说出一句此前从未在这段治疗里出现过的话：“我其实不确定你今天想听到什么。”几乎没有停顿，他自己接了下去：“可能是我自己太着急了。我做内在工作的方式，大概也给你们做治疗的带来困扰。我上周做了个梦，梦见自己在一个房间里，四面墙都是玻璃，我能看见外面的人，他们听不见我说话。我觉得这个梦可能和我爸有关，也可能和我们现在做的事有关。”

治疗师被打动了。那个梦的意象如此精准，如此有心理深度，他的专业直觉告诉他，不接住这份材料，就是辜负治疗的深度。他回应了那个梦，对话重新变

得顺滑。当天的笔记里写着：“来访者呈现极具深度的玻璃房之梦，可能表达了对治疗关系本身的无意识感知。”

这次松动失败了，失败的方式恰好是织体的特征：它没有僵硬地断开，而是用一份更深、更难以拒绝的心理材料，把治疗师从制造断裂的追问轨道上拉回双方都更熟悉的深度分析轨道。修复所用的材料，那个梦，转身成了织体新的纬线，织体比扰动之前更致密。要指出这一幕里没有谁在耍花招。常远的梦是他做的梦，说出“我不确定你想听什么”是他在这段治疗里头一回说了一句近乎异议的话，那句话也可能正是一个外部世界挤进来的孔隙。孔隙出现了，被一份有深度的材料接住，这份接住对双方来说都自然而且正当。从这个意义上，织体的自愈没有主谋。

◆ 五、庇护所、重新定义与可以被判错的地方

上一节的最后一幕，会诱使读者得出一个实践结论：既然织体会吸收一切温和的扰动，治疗师就该做得更坚决，更有意地制造不契合。本书拒绝这个结论，这个拒绝出自对第十二次会谈的认真阅读，与谨慎无关。在那一幕里，“保留三秒沉默再转向行动”本身是一次出于良好意图的、有技术含量的操作，它也被织体吸了进去：沉默成了一次可被梦境接住的停顿，转向行动的追问成了“治疗师这一节又很敏锐”的新证据。任何一套被治疗师单方面持有的、用来“处理”织体的技术，都在把治疗师重新放回织体控制者的位置上，而这个位置正是织体得以致密的条件之一。因此本章不收关于“松动”的各种操作性设想，一律改写为可以事后读到的现象，不以处方的形式出现。需要写明的只有一个方向性的判断：织体的觉察属于治疗师对自己位置的认识，它不等于一个可以执行的步骤。比如，“这节做得很好”的满足感一涌上来，说明治疗师仍在用一把内在的尺子丈量来访者的产出，并用高分兑换自己的专业效能感，这是读数，不是要治疗师去压制它的命令。再比如，面对一个把同一个模式分析得无懈可击却毫无行动上

微扰的来访者，治疗师心里那一丝难以言明的烦躁，往往被很快加工成“我需要更好地涵容他”的专业反思，安全地收进治疗师自己的内部。这丝烦躁是外部世界的行动紧迫感能够在治疗现场出现的唯一的微弱信号。它被改写成反思之后，信号就没有了去处。这些都是对现象的描写，本书无意把它们写成“治疗师应当”。

织体的边界必须写得硬。当来访者的外部世界极其严酷，处在无法安全离开的虐待性亲密关系里，工作中任何坦率的表达都可能导致失业而又没有替代的经济来源，维系最低限度心理功能的唯一资源就是每周那一节被深深涵容的会谈，这时的织体是他此刻能找到的唯一的庇护所，不是一个需要被松掉的病灶。把它强行撕开，不等于把外部世界请进来，而等于把一个没有替代住处的人推回暴风雨里，再告诉他这才是现实。织体作为临时庇护所是否正当，取决于来访者在外部世界里可供选择的庇护所有多少，这个数目为零的时候，织体是生存的办法，不是症状。这条边界同时也限定了本章所有判断的适用范围：它们适用于来访者本人对“没有行动”感到冲突或痛苦，带着“我明明懂了为什么还是动不了”的不自洽感的情形。自伤自杀风险与急性危机、自我结构严重缺损、心理储备耗尽的情形，不在此列，这些情形里需要的是结构化的帮助与安全流程，织体的概念对它们没有指导意义。

一个最深的反驳也要正面回答。设想另一位来访者，在织体里“顺利”了两年，获得很大的内在宁静与自我接纳，期间辞去了那份让他痛苦的高压工作，去做园艺师，收入不高而内心满足；与伴侣的关系依然淡薄，但两人把期待调到了更低的平衡；拖延也“好了”，因为他不再做那些让他拖延的复杂工作。他说：“我学会了接受真实的自己。”痛苦减轻了，生活也确实发生了变化，穿出了治疗室的墙。这算不算“改变没有发生”？如果判为没有，岂不是在撤掉“治

疗师已知改变图式”的前提之后，又悄悄立起一条更隐蔽的新标准，偏爱“进取的、世界性的、在压力中成长”的改变，用它去审判来访者的人生选择?

这个反驳无法在逻辑上推翻织体，它的力量在于逼织体为自己的伦理位置负全责。回答有四层。第一，织体概念不对“什么是好的改变”做实质的价值裁定，它指认的是一种结构上的差异：改变经过外部世界的摩擦与检验而发生，还是在没有外部摩擦的闭合回路里被自己确认。第二，必须承认一个风险：这一判断可能低估内在工作本身的疗效。有一类来访者，最主要的变化确实发生在内部，自我的重新叙述，意义的重新编织，对旧创伤的重新理解，在他自己的人生评价里这些变化是足够的，不再需要转成可被外部观察的行为。只要他不再为“不行动”感到冲突和痛苦，织体的框架就不应该把他判作“改变没有发生”。第三，织体概念的伦理位置落在“不代替”：它不替来访者决定什么是好的变化，只指出，如果他是在一个无缝的、被润滑过的回路上滑向那条唯一预留的路，他就没有机会知道自己的选择究竟是发自内部的自主决定，还是织体内部最省力的出口。若他在充分接触了外部摩擦之后，仍选择当园艺师，仍与伴侣保持淡而平和的相处，织体概念对此没有任何反对。第四，最锋利的一刀留给自己：在闭合回路里养成的高度自洽的“接纳叙事”，若已经是个体抵御外部残酷的最强甚至唯一的武器，撕开织体就可能瓦解他本就脆弱的存在方式。对这一点的回答，就是上一段划出的边界。

至此可以把本章与那个平均意义上的正相关放在一起说清楚。同盟与共情对疗效的正向关联，是汇总了大量个案之后得到的平均走向，本章不对它提出任何折扣。织体的判断落在平均数的内部：在同盟高、共情深、契合紧的那一端，存在一类个案，认可与理解的继续增加不再带来外部改变，甚至与外部改变反向相关。这个判断如果成立，平均数仍然为正，因为织体并不普遍，它需要两个条件同时在场；只是在条件同时在场的那个格子里，“更多”和“更好”之间的线会

弯下去。弯到哪里、弯多少，本书没有数据，倒 U 型是一个尚未检验的预测，它的证伪方式见下文第三条判错条款。这里先把话说死：任何把本章读成“同盟无用”“共情有害”的读法，都与本章的文字相悖。

以下三项是本章的读数。读数不是指令，是事后可以在记录里数出来、写进个案回顾的现象。第一，来访者报告某个行动计划未完成之后，十秒以内他本人是否已将其转写为分析性叙述，以及此后连续三次会谈里，是否有一次由治疗师发起的、针对具体行为计划的追问；记录下来的是这个数字，不预设它应当是多少。第二，补上外部反馈参照之后是否松动。例如把第三方观察者对来访者在生活中的实际行为的报告（来自同事、伴侣、督导之外的知情者）引入个案的回顾，看会谈里的“进展”叙述与外部报告之间的落差是否开始出现，织体的判断预测落差会显现，会谈的质地也随之变化。第三，治疗师事后能否报告当时有过那一丝迟疑或烦躁，以及它在哪个回合被压下。这三项读数都不要求谁去做什么，只要求有人在事后翻开记录。

本章的判错条款共四条，均为尚未检验的预测，一条也没有被本书跑出过数据。其一，条件缺失而织体仍成：在外部反馈参照充分、治疗互动里仍保有裂缝的情形下，如果仍可靠地观察到与上述六条指标不可分辨的致密织体，那么本章关于织体发生条件的判断就是错的。其二，指标的区分度：对“成功改变”的个案与“织体闭合”的个案做过程编码，若两组在上述三类微观指标（洞察方向的首次回应、转写延迟、未被填充的沉默频次）上没有可分辨的差异，织体就不应被主张为一种独立的状态，而应被还原为改变过程里的一个普通阶段，相关现象退回阶段模型的解释。其三，剂量关系：以每次会谈中“认可性回应”的占比为自变量，三个月后可由第三方核实的外部行为变化为因变量，织体的判断预测二者呈倒 U 型，认可过少与过多都对应较差的结果。如果在现成的同盟与结果数据上，二者呈单调正相关，认可越多结果越好，本章最硬的主张被推翻。其四，

近邻的吸收：对“无进展、高契合”个案做主题覆盖度编码，若系统性地存在主题空白，共谋的说法足以解释；把这些个案里的洞察材料交给不知情的第三方评分，若普遍被评为空洞，比昂的 −K 足以解释；若治疗师会谈后的自评满意度并不高于其常规个案，双向回报的主张失去支撑。这几条分别对应前文三条分离线，哪一条成立，织体的相应部分就应当撤回。

最后是织体不适用或会失败的几种情形，在此集中交代。织体概念不解释一切治疗的停滞：因技术失当、同盟破裂、生活遭受重创而停滞的治疗，不在它的范围之内。它不是一个流派的诊断，与治疗师的理论归属无关。它的透气状态也不是一个可以抵达并永久占有的理想：治疗师可能在某个阶段保持着透气，而在自己生活承受巨大压力、专业自我怀疑被触发、或经济压力迫使他向来访者证明治疗有效的阶段，不自觉地滑回致密。所以不能把“从致密回到透气”写成又一个“回归正确治疗”的叙事，两种形态都在特定条件下发生，没有哪一种是终点。本章在证据上的限度同样明确：原型案例是对共性结构的构造性重述，不是实证抽样；“双向回报”目前靠论证与临床直觉支撑，尚无治疗师一侧的过程数据；“教育里的包覆”“组织里创新的致密化”之类的类比，只能算本章判断在别处的投影，在本书里不另做论证。

织体所描述的，是治疗做得好的时候，进展穿不过治疗室的墙。下一章要讨论的是另一种看起来相近的情形：墙是被穿过了的，来访者在治疗期里确实变了，期内的变化和期后的退回都是确凿的，可是回头去问这变化是谁的，答案变得不那么好说。两种情形在结案时刻几乎不可分辨，区别要到治疗关系断开之后才露出来：织体的来访者回到原状，不再有任何动静；另一种来访者则会去找下一个人。

◆

02

第2章

变了，但不是他的

丁立的邮件是在结案十个月之后到的，只有几行。“医生您好。不知道您还记不记得我。一直没联系您，是因为实在没什么可说。那段时间的治疗对我很重要，我一直很感激。大概从半年前开始，好像那个劲儿没了。没出什么事，就是慢慢的，我又变回以前的样子了。妻子说我又走了。我也不知道怎么跟她解释。我想问问您，我是不是就是那种人，好不了的那种？”（说明性合成案例）

收信的治疗师有十五年的临床经验，在同行里口碑很好。他把这封信读了不止五遍。丁立的治疗他记得很清楚：十三个月，每周一次，动力学取向；进步笔记里写着情感表达范围扩大、防御减轻；结案评估里量表总分从临床临界降到了正常范围；结案前丁立还讲了一次与妻子的争吵，说自己没有像从前那样退缩，“就站在那里，一句一句吵”，吵完两个人反而说了很久没说的话。那一刻治疗师是真心高兴的。现在，他面对的既非治疗没起作用的来访者，也非中途脱落的来访者，是一个确实变过、也确实退回去了的人，连这个人自己也说不清那个“劲儿”是什么时候过掉的。

这样的情形最麻烦的地方在于，两头的事实都成立。期内的变化有笔记、有量表、有妻子当时的反馈为证，不能因为后来的退回就说它是假的；期后的退回也有来访者自己的陈述和妻子的观察为证，不能因为期内的好就说它没有发生。要容纳这两件看上去相互妨碍的事，需要一个把“改变”和“改变是谁的”分开来问的概念。本章的承重判断是：治疗期内产生的情感底气、操作工具、方向感，有一部分其发起、供能与纠错的位置始终在治疗关系那边，来访者是在使用

它们，没有拥有它们；这种安置随治疗关系的存在而存在，随它的结束而终止。本书把这种状态叫作发生租借。

◆ 一、两头都成立的事实

心理治疗领域对“为什么不同流派都有效”这件事的讨论，已经有半个世纪。Luborsky、Singer 与 Luborsky（1975）对当时的对照研究做了系统回顾，借《爱丽丝梦游仙境》里的话作结：所有人都赢了，所有人都该得奖。理论前提互相冲突的流派，在帮助来访者走出痛苦上没有谁能压倒谁。从这里分出两条路。一条是共同因素的路：从 Rosenzweig（1936）最早的直觉，经 Lambert（1992）把疗效归于治疗外因素、关系、期望与技术四类因素，到 Wampold（2001）用元分析论证关系因素的贡献远大于技术因素。另一条是向机制走的路：Grawe（2007）从神经科学出发提出跨流派的通用改变原理，Rosa（2016）则把深层的疗愈理解为一种不可物化、只能被遭遇的双向关系质态，他叫它共鸣。两条路的积累都很重要，本书的每一章都在使用它们。

可是在这些讨论的背面，一直有一个很少被正面提起的问题：成功之后的事。治疗结束后症状复发是被认真研究过的题目，抑郁的复发与再发就是一个例子（比如 Vittengl, Clark, Dunn, & Jarrett, 2007 对认知行为治疗降低复发的比较元分析）。通行的解释有两种。一种是治疗无效，这对本章讨论的个案不适用，因为期内的变化有可核查的记录。另一种解释本书称为排异型退回：治疗室里诞生了一件确实属于来访者的新东西，一份新的底气，一项新的技能，一种新的方向感；来访者把它带回生活，旧环境像免疫系统一样攻击它，他撑不住，它被淘汰了。这是一颗种子在室外夭折的逻辑，种子曾经是活的，是环境杀死了它。

发生租借提出的是第三种可能：温室里那一片长得枝繁叶茂的东西，从头到尾没有长过属于自己的根。它在温室里与扎了根的植物没有任何外观上的区别，温室一拆，连一天也撑不住，因为它不曾有过自己的根。来访者在这里并非新东西的主人，而是租客。租来的情感底气，租来的认知工具，租来的方向感，住在里面的时候，一切都像是自己的，租约一到期就什么都不是了。

说“租”，就必须说清“所有”。本书对所有权的定义是功能性的：一种心理功能（情感底气、认知操作、方向确认），能够在没有某个特定他人（包括他的内化参照）共同在场的条件下，由来访者独立启动、维持并完成，并且在遭遇挫折之后不依赖外部确认就能自行修复。这里的关键是执行的指令、供能的来源与纠错的判断是否位于来访者内部。所有权因此不是一种主观感受，“我觉得这是我自己做到的”这句话无法证明什么。丁立可以全心全意地这样觉得，而功能的架构仍然是借来的。把所有权定义成功能上的独立性，有一个好处：它可以被观察。治疗师能在来访者的语言结构里，在功能表现的波动里，在支撑减弱之后还剩下什么的情形里，逼近这个变量。

要弄清租借可以租在哪里，需要先看治疗在做什么。本书不把心理治疗理解为修理，更愿意把它看作一次重新启动。被启动的，是一个人内在的一套动态循环：把经验消化为新结构的循环。循环停转的时候，一个人不只是“有症状”，症状是结果，他是不再能把自己的经验变成新的结构。停转可以发生在不同的环节，三大流派积累的技术储备恰好各自对应一种。第一种发生在供应的环节。童年反复遭遇忽视、拒绝或惩罚的人，往往发展出一套生存技能，能工作，能社交，能应付日常，但每一次人际交往对他只是消耗，无法转化为支撑后续行动的内在燃料。他“知道”自己应当被善待，身体里却没有积存过“被善待”的记忆。第二种发生在消化的环节。他有过足够的好体验，却被早年严苛的环境训练出一套自动化程序：痛苦的情绪一涌上来，他不能停下来、命名、让它穿过身

体，而是立刻启动下一个任务去盖住上一个。第三种发生在方向的环节。他的供应和消化都在运转，可是“朝什么用力”被外部过度占用，每个决定都是从家庭、社会、职场的期待里原样搬来的，“我想要什么”那点微弱的信号被“应该成为谁”的声音压没了。

这三种停转不是三个诊断箱。一个人可以同时在供应与消化两处塌陷，也可以前半生困在供应、后半生转入方向的过载，治疗师每一次要问的，是“这一次，他最要紧的停转落在哪一环”，而不是“他属于哪一型”。精神动力学的长程治疗擅长在供应处起手，它提供一段可以被内化的关系；认知行为的工序擅长在消化处起手，它在情绪与行动之间强插一个可以呼吸的暂停；人本与存在取向擅长在方向处起手，它撑出一个让内部信号重新被听见的安全空间。三种入口各自都有一个最容易失败的环节，那就是内化：关系被内化，工序被内化，那个重新被听见的声音被确认是自己的。租借就租在这个环节上。

◆ 二、燃料、工具、方向：三个岔口

租借不是一个静止的标签，不是“这位来访者依赖性强，所以租了治疗师的功能”。它是一串在特定互动条件下反复发生的小事件，单看每一件都微不足道，甚至像是好的治疗，串起来却指向同一条生成的链。下面三段互动是依概念结构构拟的理想型（同为说明性合成案例），每段对应上文一个环节上的岔口：同一个瞬间，治疗师的两种回应，通向两种完全不同的所有权归属。

先看燃料。苏晴三十一岁，因长期弥漫的无价值感做了八个月的动力学治疗。童年的情感忽视让她缺少内化的安全感，她从关系里汲取不出燃料。治疗师给了她一段稳定、可预期、有情感回应的关系，她逐渐敢于表达愤怒、失望和被冷落的感受。有一次，她与一位长期忽视她感受的朋友争执，没有像往常那样默默忍下，说了一句“你这样安排，我不舒服”，朋友愣了一下，敷衍了一句“下

次再说吧”，话题到此为止。她觉得又痛快又发虚。下一次会谈，她对治疗师说：“我按你说的，就跟她说了我不舒服。”

岔口的第一条路上，治疗师说：“你做到了，这太不容易了，我为你感到骄傲。”苏晴笑了，有点不好意思，说没想到自己真的说了，现在觉得“好像也没那么难”。这一轮回应无可挑剔，共情，强化，确认进步。需要看的是里面藏着的结构：“我按你说的”，苏晴把自己的行动定为实施治疗师的建议；治疗师不但没有调整这个框架，还接住它，用“我为你感到骄傲”加固了它。行动的发起者成了治疗师，来访者是执行者，成就感回送的对象也是治疗师，“让你骄傲”成了这个行动的情感回报。一份小小的租约在这里被签署，没有人觉察到它是租约。她体验到了勇气，但这份勇气的所有权在对面。

第二条路上，治疗师问：“你当时是怎么决定要说那句话的？说出口之前那几秒，你脑子里闪过什么？”苏晴沉默了一会儿，说自己也不知道，只觉得再不说就又咽下去了，然后就不想再咽了。治疗师重复了她的话，“不想再咽了”，问这个“不想”对她意味着什么。长久的沉默之后，苏晴说：“……意味着我觉得我应该说。不是我应该，是……我就是不想再忍了。”治疗师没有接住“我按你说的”，用一个提问把它轻轻推开，邀请她回到行动发生的瞬间，自己去找那个把她从“想忍”推到“不想再忍”的力量。这个提问没有给她任何新内容，它只在已有的行动里挖出一条通向所有权的隧道。

不要把第二条路读成治疗师“一念之间做对了”的魔法。苏晴从“我按你说的”走到“我就是不想再忍了”，中间隔着一段很长的沉默，沉默里发生了一场没有被说出口的微小的战争。她得允许自己对治疗师的期待落空：说出“我按你说的”时，她多半隐隐盼着一个熟悉的点头，一个习惯了的正面回音，而治疗师只是看着她，她得独自消化那个“没要到糖”的失落。她还得在这个空白里忍受“我不知道答案”的不适：她习惯了治疗师帮她命名、帮她总结，做完一件勇

敢的事，听到自己值得被肯定的回音。现在回音断了，她只能在寂静里听见自己。“我就是不想再忍了”是在所有外部回响消失之后，从她内部浮上来的，它的所有权从一开始就刻着她的名字。但这段沉默同样可能失败：她可能跌下去，在空白里感到被抛弃，下一次会谈不再来。第二条路并不比第一条安全，本章后面还要回到这一点。

再看工具。魏阳二十八岁，因广泛性焦虑和反复的自我批评做认知行为治疗。他的自动化负性思维又快又密，几乎不给理性反驳留缝。他学会了思维记录表：焦虑涌上来时，写下自动化思维，评估信念强度，列出支持与反对的证据，写出一条新的平衡信念。在治疗室里他和治疗师一起填表，填得熟练到位，症状评分一路下降。第一次独自在办公室填表，是在部门会议发言之后。他觉得自己讲得很差，脸发烫，脑子里反复回放几个“失误”。自动化思维那一栏写得很顺，“我说的都是废话”“每个人都觉得我无能”，轮到“支持与反对的证据”，他停住了。他努力回忆治疗师怎么问的，“有什么客观证据支持这个想法”，脑子却是空的。他对着那张表格坐了很久，觉得自己可笑，胡乱填了几条，更焦虑了。下一次会谈，他报告说：“我试了，但没用。做到一半脑子就空了。”

第一条路上，治疗师说，我们来看看卡在哪里，然后带着他把那张表当场再填了一遍。填完，魏阳说：“跟你一起做的时候就觉得还行。”治疗师说：“你看，你是有这个能力的，我们一起做的时候你能做到。下次再卡住，就想象我们在治疗室里，刚才这个流程，一步一步来。”这个回应看上去几乎可以放进教科书：没有批评他的失败，用行动帮他演练了一遍，还给了一个视觉化的应对办法。可是这恰恰是租借被加固的一刻。他独自操作时脑子空了，这个最重要的信息没有被当作信息处理，“我们一起做”的成功把它盖过去了，然后递给他一根拐杖：“想象我们在治疗室里。”工具的使用权没有交到他手里，他得到的是准

许：在想象中继续借用治疗师的在场来操作这个工具。工具箱没有被拆开，只是在他脑子里被打了包，贴上了“使用时请调取治疗师形象”的标签。

第二条路上，治疗师没有帮他填表，而是问：“脑子空了，是什么感觉？在身体哪里？”魏阳说是发蒙，好像什么都想不起来。治疗师问他发蒙之前最后记得在想什么。他说在想“你要找证据”，然后就想不起要找什么证据了。治疗师问：“你要找证据，你听到这句话的时候，是谁在说？”魏阳愣了一下，说是治疗师，是平时问他的那个声音。治疗师没有说话，他自己接了下去：“所以我其实没在找证据，我是在找你说的话。”治疗师请他看看，那个声音断了之后，自己心里还有什么冒出来，哪怕没用。魏阳沉默了很久，说：“我就觉得，我肯定又搞砸了。不管找什么证据，都搞砸了。”治疗师说，这个想法不用找我，它自己就在那儿。魏阳说：“嗯，它确实在。”

这一幕里，治疗师做的是帮魏阳去看“脑子空了”这件事本身。空，不是能力缺席，是脑子里那盘治疗师的录音带断了：他试图调用一条存放在外部的指令，而不是在自己内部生成一个探索的动作。治疗师没有给新的指令，而邀请他看，指令断裂之后，自己还剩什么。剩下的是“我肯定又搞砸了”，这个原生的自动化思维，它不需要被找，它一直在，而这才是认知工具要处理的原料。当他能直接接触到这个原料，他就不必想象治疗师会怎么问，他自己可以开始问：这是真的吗？

最后是方向。何岚三十五岁，因“我活成了所有人期待的样子，但我不快乐”做存在取向的治疗。她的职业、婚姻、生育，每个重大决定都是照搬家庭的期待，从来没有属于自己的方向感。治疗里，她慢慢辨认出内心一个微弱而持续的声音：她不想当管理者，她想去读一个艺术相关的学位。在治疗师的在场与确认下，这个声音越来越清晰。治疗临近尾声时她向家人透露了辞职读书的念头，遭到父母激烈反对：“你疯了？都做到这个位置了，现在去读什么艺术？你考虑

过家里吗？”她被压力裹住，开始怀疑自己。下一次会谈她说：“我妈说我被人洗脑了。我现在也不知道了。会不会真的是我太自私了？”

第一条路上，治疗师说，家人不理解你，不等于你的选择是错的，我们在这里讨论过很多次，你自己也看到现在这条路对你越来越窄，你想走的那条路是认真想过的，你有权利为自己的人生做决定。何岚说，这些我都知道，可是一面对他们，我说的那些就好像不算数了。治疗师说，这很正常，你需要给他们时间，你不需要用你的决定去交换他们的认可，我们之前说过什么，“我必须为自己活一次”，你记得吗？何岚说记得。这些回应每一句都是支持，每一句都对，但恰是这种支持在最深处加固了租借。她的怀疑被治疗中积累的共识盖住了，治疗师没有让她去接触那个动摇的具体质地，而是用一个更稳固的外部声音压住它。她用不着自己消化家人的反对并重新确认方向，只需回到治疗师这里，给方向感的电池重新充电。“为自己活一次”她记得，可它已经成了一句需要治疗师调取才能激活的存储语句，而不是一个独处时可以自己生成的、活着的方向。

第二条路上，治疗师问：“自私，你妈妈用这个词的时候，你心里什么地方动了一下？”何岚说，是那种觉得自己做错了的感觉，像小时候。小时候每次她想要点什么，都被说“你怎么这么不听话”，然后她就觉得自己是错的，现在也是，想要的就是错的。治疗师问她觉得去读艺术是错的吗。她说，在这里的时候不觉得，回去就觉得是错的。治疗师问：“在这里不觉得，那你在这里是怎么确认这一点的？”她说：“因为你在听。你说我值得。”治疗师说：“我说你值得。但有没有那么一个时刻，不需要我点头，你自己就觉得，是的，这个我就是想要的？”何岚沉默了很久，轻声说，有一天晚上她自己在网上看那所学校的课程视频，看到他们做的一个装置，反复看了好几遍，那一刻她想，不管别人怎么说，这个东西，我就是想搞懂它是怎么做出来的。“那时候你没在。”治疗师说：“我没在。”何岚说：“你确实没在。那会儿是我自己。”

这一问需要治疗师承担一个风险，因为来访者可能在追问中发现“离了你，我就不确定了”，那正是她害怕的东西。但这一问也找到了一个她独处时自行确认的瞬间。治疗师最后那句“我没在”，不是承认失控，是帮她命名并拥有一个事实：这份方向感曾有一刻完全由她独立生成，不是治疗师给了她、她再拿走的。治疗师在这个时刻做的，是从方向感的共同生产者的位置上向后退了一步，把主权还给那个深夜里独自看视频的人。需要提醒的是，这三条第二路的描写，是对已发生过程的事后描述，本书无意把它们抽成“遇到这种情形应当这样问”的话术。一模一样的问句在另一个来访者面前，完全可能被听成冷漠，或被当作又一个需要完成的任务。

把三个岔口放在一起，租借的生成方式清楚了。每一次来访者把进步归给治疗师，每一次治疗师接过进步的所有权并给予正向确认，每一次来访者调用治疗师的声音去代替自己的探索，租借就被加固一层。这些事件单看哪一件，放到临床督导面前都挑不出毛病。可是几百次会谈累积下来，来访者学到的并非“我有这个能力”，所学的是“治疗师在场的时候，我能表现得好像有这个能力”。

◆ 三、三种形态、共有的骨架与结构性温床

三个岔口说明了租借怎样生成，三种形态各自在压力下露出什么，则需要另外交代。

燃料型的租借，露出在来访者面对一个冷淡的人时。一个拥有自己燃料的人，遇到冷淡的上司，会受挫，但他的内部有能力做一个区分：“这个人的反应，不说明我有问题。”他不需要对方改变，他的安全感不被外部的反应轻易摧毁。租借了燃料的人遇到同样的情境，反应截然不同：他没有去辨别外部的反应，转身在内部搜寻那个能给他安全感的人，而那个人不在。他储存下来的，是“这个特定的人理解我”的经验，不是“我可以被理解”这条通用的经验，二

者在日常交谈里几乎看不出差别，在压力下的后果却大相径庭。他对自己说的是“她会理解我”，不是“我值得被理解”。他的情感系统中某个关键模块其实没有修好，它被一根从治疗师那边拉过来的外接电线暂时供了电。

工具型的租借，露出在新情境里。会用一件工具有两种。一种是掌握了原理和一套步骤，能在不同情境里灵活重组，操作者是他自己。另一种是记住了治疗师做过的示范，试着在自己的情境里重现，对工具的了解是例程式的，不是原理式的。他记得焦虑涌上来时治疗师会问“你在想什么”，于是也问自己“我在想什么”，可是走到“我找到了自动化思维，但不知道该找什么证据”这个拐点时，操作就卡住了，因为他的工具是一组依赖外部调试的脚本，脚本跑到没有预写的分支，就中断，而能即兴续写的那个人不在。魏阳脑子里空掉的那一下，恰是脚本的断裂。他以为自己在使用工具，实际上运行的是一个需要远程服务器支持的瘦客户端程序，服务器连不上，客户端就白屏。

方向型的租借最难看出，因为方向感的形成天然需要另一个人在场。人是通过被倾听学会倾听自己，通过被提问学会向自己提问。问题只在于，这位第二人在方向感成立之后，是可以被撤掉的，还是一直被需要。一个从自己内部长出方向的人，决定被周围质疑，他也会动摇会痛苦，但他的动摇不触及“这个决定是不是根本就是假的”这一层。他会说：“我知道他们不理解，但这确实是我想要的。”能说这话，原因与固执无关，是他曾在某个时刻，没有第二人点头的情况下，独自与这件事面对面，确认过。租借了方向的人在相似的压力下，内心的对话是另一种样子：他想的不是“我为什么做这个决定”，想的是“她当时是怎么说的”“她会怎么看我现在的处境”，甚至会疑心：“是不是我被她带偏了？”治疗师的在场对他来说算不上可有可无的脚手架，它是构件的受力结构，撤走它，构件就塌。这种租借被包在“终于开始为自己活”的叙事里，连当事人

自己也相信，只有在遭遇足够有力、直指内核的外部打击时，所有权才会暴露，而这样的打击，往往发生在治疗已经结束之后。

三种形态共有一副骨架，可以用三个词说清。第一是来源错置：一项心理功能的来源，在治疗关系共同维持的外部支撑里，没有位于来访者内部重新启动的循环中。这个来源是在实际的互动里发生的体验，只是它所处的结构，只能在一个特定他人在场时被激活。第二是功能分离：这项功能在治疗师在场时可以被充分执行，甚至执行得比许多已经把它内化了的人更好，因为它接着外部电源，比靠自身燃油运转的更猛；治疗师的在场（物理的或内化参照的）一旦撤除，同一功能便无法独立执行，或只能磕磕绊绊地模仿。峰值表现与独立表现之间，隔着一条断裂的沟。这条沟需要一个解释：为什么一个在治疗室里高到足以被当作“痊愈”的功能，结案后连普通水平都维持不住？解释不在“所有权没转移”这个比喻里，而在学习的机制里。每一次功能的执行，都有治疗师（物理的或内化的）在后台同步供能，接住情绪，命名意义，确认方向，来访者的神经系统反复走通的是“在外部共同调节下完成”的通路，不是“独自完成”的通路。高频的外部调节强化了对外部调节信号的依赖，同时弱化了内部自我调节回路独自承重的能力。每一次成功的“联合执行”都在告诉他的大脑：放心，不会摔，有人垫着。垫子抽走时，这些从未单独承过重的回路，没有被训练出独自支撑的力量。租借构件为什么断崖式下跌，不是缓慢磨损，原因就在这里：电路本身从第一天起，就是按“有外部供电”的规格铺设的。第三是所有权的错觉：来访者与治疗师双方，都把租来的功能在治疗室内的峰值表现，当作功能已经落位于来访者内部的证据。治疗师据此判断治疗可以结束，来访者据此相信自己好了。这个错觉没有人制造，它是“在治疗关系里看上去功能完好”这一事实的自然推论，只是推论错了：功能没有在来访者内部重建，是一条外部供能的通道建立起来并稳定运行。通道看起来像修复，只因为它一直有电。

三种形态加上共有的骨架，还没有回答一个问题：为什么偏偏是好治疗在生产它。如果租借只是个别治疗师的技术失误，它就不必占一章。理由在于，最容易生产租借的治疗，往往恰是最接近成功的治疗：关系最稳，技术最细，来访者投入最深，改善最明显。这是由心理治疗的制度构造决定的，需要三层条件相互嵌套，才能让这种伪改变长期隐身。

第一层是单边供能的结构。日常生活里，一个人的情感能力是在双向互动里培育出来的：向对方表达愤怒，对方有反应，可能道歉，可能受伤，也可能反击，两个人在这个来回里合作消化这场冲突。一个人在其中长出来的核心素养，与“表达”关系不大，要紧的是表达之后接住对方的反应并继续往下走的能力。治疗室里的情感互动被另一套规则改写：来访者可以愤怒，治疗师接住、理解、命名，但不还手；来访者可以依赖，治疗师提供安全基地，却不在自己的生活里向对方索取依赖。这是一个事先计划好的不对称，治疗师系统地、长期地照看另一个人的情感需要，而自己不在这段关系里寻求自己的需要被满足。它是治疗成立的伦理装置，没有这个不对称，治疗会变成一场讨价还价，一方诉说受伤，另一方辩称自己也受伤。同一个装置也改变了被培育出的情感能力的生态：一个人在专门为他构造的、单向供能的世界里学到的功能，不管看上去多么强健，进到双向的、互相供能也互相反击的日常世界里，需要从头再验证一遍。这个差距不是治疗的失败，是治疗结构的必然产物。

第二层是进步叙事的共同生产。治疗师天然有动机相信自己在帮人往前走，来访者天然有强烈的动机相信自己在好转，这谈不上批评，是人性。两种合理的动机叠在一起，在三个条件同时具备时，会产生系统性的高估。一是治疗师的回应习惯倾向于替位：来访者卡住时帮他说出他可能想说的话，来访者不确定自己的进步时主动用治疗的框架解释进步的意义。这种习惯在某些阶段甚至是必要的，只是当它成了唯一的回应方式，缺少“让来访者自己去发现”的互补能力

时，那份小小的租约就被反复续签。二是来访者有很强的适应他人期待的能力。童年里学过“让大人高兴我才能活得好”的人，不论现在看上去多么自信独立，在治疗关系里都能极快地捕捉治疗师的期待并拿出相应的进步。他不是在装好，他是一位高度敏感的关系学习者，学会了“在治疗室里变得更好”需要什么样的表现，并诚实地做到了。他报告的情绪改善是实在的，展示的新技能是实在的，却都运行在“让治疗师满意”这个操作系统上。治疗一结束，这个系统失去了服务对象，功能的执行就失去了内在的启动指令。三是治疗走到收尾，却没有出现任何一次支撑被撤减之后的检验。结案本是一个协商的过程：总结收获，处理分离，讨论日后的应对。很少有哪段治疗在结案前，让治疗师把某些隐性的支撑收回去几次（对进步的回应不那么热烈，对困惑不再立即澄清），看来访者在支撑减弱时功能还剩多少。没有这个观察，“看起来好了”就是一份被污染了的证据，因为它是在支撑还在的时候取得的。

这三个条件叠加，就解释了为什么高度成功的治疗，恰是租借风险最高的治疗：成功意味着治疗师做对了所有的事，关系稳固，技术精准，来访者改善明显，而这些“对”恰好满足了租借发生的全部条件。租借不是治疗的副产品，它是某种完美治疗内在的风险。

第三层是行业评价体系的盲区。关于“什么样的治疗师是有效的”，行业已经有了相当成熟的、基于实证的胜任力模型：建立同盟，识别来访者的模式，引导情感探索，传达共情，管理进程。这些条目里几乎没有一项教治疗师去看，自己的治疗正在不在制造租借。要看见租借，治疗师需要的监控，问的不是“我做得对不对”，问的是“我替他做的这些事，有没有正在妨碍他自己长出做这件事的能力”。在技术上，替位完全可以被评为“共情到位”，所以这份警觉的缺位无关个别人的疏忽，是评价体系把它遗漏在了识别范围之外。

最后需要补上发展心理学里那个老概念，才能把“替位”与“所有权转移失败”连接起来：恰到好处的挫折。孩子能把外部的抚育功能内化为自己的心理结构，每一次需要都得到完美满足并非原因，原因是在某些安全的、可以承受的时刻，抚育者“不在”了：母亲没有立刻回应，父亲没有替他解决那道难题。这一点微小的断裂带来可以承受的张力，孩子被张力推着，动用自己的资源去补那个缺口，每补成一次，内部结构就添一块砖。治疗里持续的、完美的替位，恰好在每一个这样的断裂即将发生的当口，用治疗师的回应先把它填平了。来访者每次刚要面对“我一个人行不行”的不适，治疗师已经先一步替他命名了情绪、解释了意义、给了方向。他从未走到“撑不住”的临界状态，内部结构因此没有接收到“必须自己长出来”的信号。租借的发生，不在于替位本身有错，在于替位太密、太久，密到剥夺了内化所需的那点微小的挫折。

◆ 四、与近邻的切割

任何一个新概念，都必须经受同一道检验：它能不能被某个现成的概念原样替换？能，就只是新瓶装了旧酒。下面各家的分离线统一落在同一个辨别面上：在治疗室内，新功能的执行者是谁。

矫正性情绪体验是最危险的近邻。Alexander 与 French（1946）的主张是，来访者在治疗关系里经历到与过去创伤模式相反的新情感内容，本能地预期被惩罚，得到的却是接纳，这个新体验本身就有矫正效力。发生租借并不否认这样的体验是实在的。它切开的是体验的所有权：来访者反复得到了被接纳的体验，可他在情感系统里存下来的，少有“被接纳”这个通用经验，多是“被这个特定的人接纳”的特定经验。矫正性体验的理论没有区分这两种存储方式，它默认体验一旦发生，就自动成了来访者内部结构的一部分。体验的发生等于体验的内化，这个乐观的默认并不总成立。内化需要一个额外的加工过程，在某些关系条件下它会被系统性地跳过，而恰恰在矫正性体验质量最高、最深切、最令双方

感动的关系里，内化的“被跳过”最容易被双方当成内化的“完成”。可观察的判别是这样的：如果来访者结案后在自己的关系里仍然“知道”自己曾被治疗师接纳过，却“用不上”这份被接纳，用起来像在调取一条需要刻意提取的知识，而没有自然涌起的底气，那么问题便不在体验不够深，在它从一开始就没有被装进他自己的情感系统，而是存在了另一个分区，一个只有在那段特定关系里、在治疗师共同在场时才能稳定访问的分区。

移情性治愈是精神分析对同一现象最早的名字。症状在治疗关系里迅速缓解，缓解却依附于分析师的在场，关系一结束，症状复归（Fenichel, 1945）。它的机制是情感依附：来访者为了保住分析师的爱或认可，压抑了病理性的冲突表现，改变是一份献礼，单位是动机。租借的机制是功能占位：来访者不为取悦任何人，只是把“发起、判断、承担”这整套动作的执行位暂时安放在了治疗师身上，单位是能力的所在地。两种情形里来访者在结案后的境况也不同。移情性治愈的来访者如果不再想取悦治疗师，可以完全抛弃那些被强化的“健康行为”，回到旧症状里，他是在做回他自己，退的是动机。租借的来访者想维持那些健康行为，却发现自己无力独立执行，他想做回那个“只有在撑还在时才成立的自己”，做不到了，缺的是能力。判据在情感投注上分层：移情性治愈预测来访者对治疗师有明显的投注，理想化，取悦，害怕让对方失望；租借则可以发生在情感投注很低、甚至对治疗师有所保留的个案上。如果所有被判为租借的个案都伴随高投注，租借可以被移情性治愈吸收。这是一条在现成的移情量表数据上就能分层检验的预测，尚未检验。

同盟的过度依赖是第三个顺手的解释。有人会说，所谓租借，不就是来访者过度依赖治疗师、把同盟当成唯一的安全基地，结案后功能垮掉吗？这个说法混淆了依赖的强度与功能执行者的位置。强度是量的问题，租借是质的问题。一个来访者可以与治疗师关系极好、同盟极其牢固，仍能在没有治疗师的场合独立使

用治疗中得到的新工具，因为他把工具当工具学会了，感激治疗师，却不需要治疗师在场替他操作。另一个来访者可能在意识层面相当独立，从不显出强烈的依赖，他的新工具却是“跟治疗师一起完成的联合操作”，一个人就无法启动。同盟研究内部本身也在追问同盟的治疗作用有多少来自个体之间稳定的差异，有多少来自同一个人在治疗过程中的变化（Zilcha-Mano，2017），这条线索提示依赖感受与功能结构是两个层面。依恋理论的“内部工作模型”（鲍尔比）更精细：安全的新依恋应逐步更新早年“他人不可靠，我不值得被爱”的内部模型。表面上租借可以被“工作模型更新失败”覆盖。差别在于，工作模型的更新关心的是预期有没有变，从“他人会拒绝我”变成“他人可能接纳我”，租借关心的是情感操作功能的执行者在哪里。一个来访者可能在认知层面已经更新了预期，“我知道我值得被接纳，治疗师教会了我”，可在情感操作层面，没有这位治疗师的共同调节，他仍然无法独自消化被拒绝的体验。他知道预期变了，他的情感消化系统里供应燃料的那一环，结构上仍是一根要外接电源的线路。“我知道”和“没有你的时候我也能做到”之间的鸿沟，工作模型的更新捕捉不到，租借命名的正是这条鸿沟。

排异型退回是本书自己的框架内最近的一个。它的判定条件是：新东西确已诞生，结案时刻来访者已能在没有治疗师（含隐性内化参照）支持的新情境里独立使用它；日后的消退，发生在旧环境持续的磨损之后。租借的判定条件是：结案时刻，这个构件已无法独立使用，它在治疗室内的表现从头到尾依赖治疗师的共同在场，它不是被环境磨坏的，是从一开始就没有独立活过。可以设计一个鉴别：治疗结束之后，选一个来访者从未与治疗师共同处理过、性质与治疗中处理的问题相近的全新情境，如果他能独立调取相当的能力，那是内化已成（后来的退回属于排异型），如果他在这个新情境里就启动不了，内化从未发生，那是租借。另有一个线索可作旁证：排异型退回的来访者，通常能指出一个转折，哪怕

事后追溯，“就是从那次老板当众羞辱我之后，我再也不敢在会议上发言了”；租借的来访者说不出转折，因为没有哪一击打垮了他，一直在暗中撑着他的东西，随着时间无声地蒸发了。

罗萨的共鸣理论（Rosa， 2016）与租借的关系更有意思，因为在租借发生的场景里，共鸣恰恰发生得非常好。治疗师的回应是真诚的、双向的、有质量的；来访者感到被理解，被接住，被允许发出自己的声音，这些罗萨毫无保留地叫作共鸣。来访者遇到的并非异化的治疗师，他遇到了一位与他建立深度共鸣的治疗师，租借照样发生。罗萨的推导里，从共鸣到结构改变之间有一个几乎自动化的桥接：深度共鸣，被体验为“我在世界里被回应了”，这改变了他与世界的关系，结构因此改变。每一个箭头在他那里近乎现象学的必然。本书的观察是，这条链中间有一道所有权的关卡：共鸣可以被接收，被体验，被感激，却仍不被拥有。一个人可以在音乐会上被深深打动，记住一生中最好的旋律，他不会因此成为作曲家。作曲的能力，即自己生成新的底气与方向的能力，不会随着“被打动”而自动传递。共鸣理论只问共鸣有没有发生，租借问共鸣被接收之后存进了哪个系统。

经典内化理论及其近亲是最后一大家族：科胡特的转变性内化（Kohut, 1971），温尼科特的过渡性现象（Winnicott， 1953），斯特恩的相遇时刻（Stern， 2004），都在处理外部的抚育功能如何被内化为自己的心理结构。既然这些概念早已承认内化可能失败，租借是不是只是“内化失败”的另一种说法？精神分析文献里也有对“似内化而非内化”现象的零散讨论，“as-if”人格，对治疗师诠释的“吞入而未消化”。这些讨论抓到了一部分表面特征，却没有把问题推到“执行者位置”这个维度，停在“这个内化是真的还是假的”的二元判断上，也没有追问另一件事：来访者为什么能“假”得这样像扎了根，那个虚假的构件为什么在功能上与扎了根的构件毫无二致。经典的内化失败通常被描

述为功能的缺席，来访者没有得到某种能力；租借则是功能看上去在场而且完好，因为它被直接挂在外部对象上。能力没有缺席，它被外部执行了，执行的全过程被双方误读为已经内化。单凭事后失效去反推的“假性内化”只是一个事后的标签，租借的辨别面则可以被事前探知，通过观察来访者进步语言里的引述结构、功能表现的超高波动，以及支撑被减弱时的功能残存度。

科胡特的模型值得单独拎出来，因为它与本章现象几乎逐点对应：治疗师一段时间里承担来访者所缺的心理功能（自体客体的功能），借助恰到好处的挫折，功能被一点一点转变性地内化；内化未完成，则结构缺陷持续。“借来，使用，归还失败”这条线，他写了一本书。分离线在失败的位置：科胡特那里，失败是内化未完成，过程启动了却没有走完，来访者仍在试探独立，并反复受挫；租借是另一种事态，内化从未被启动，这一状态还被双方共同奖赏，功能用得很稳很顺，没有人在试探独立，也没有人盼它结束。科胡特的失败带着痛苦，租借不带痛苦，这正是它长期不被发现的原因。判据在独立试探的频次随治疗时长的变化：科胡特的模型预测来访者会自发试探独立，哪怕反复失败，频次不应随时长下降；租借型个案的独立试探频次不随时长上升，甚至下降。如果所有长程个案的独立试探都随时长上升，租借所指的那一类个案就不存在，它被自体客体完全吸收。

脚手架是教育学里的成熟版本：教学者先承担学习者尚不能承担的部分，再逐步撤除支持（Wood，Bruner，& Ross，1976；Vygotsky，1978）。撤除失败，学习者便持续依赖。这与租借几乎相同，分离线在于有没有人计划过撤除。脚手架的撤除是教学设计的一部分，被计划，被排期，撤除失败是执行不力；租借里没有任何人计划过撤除，撤除这个话题被双方共同回避，议程从未上过桌。判据是查督导记录与治疗计划，看有没有出现过明确的撤除安排。若租借型个案

普遍有被写下而未执行的撤除计划，脚手架足够解释；若普遍连计划都不存在，租借成立。

最后是温尼科特的假自体（Winnicott，　1960）：它是长期的人格组织形态，在治疗开始之前已存在数十年，是个体为了顺应环境而发展的虚假外壳；租借是治疗期内的临时安置，由治疗期内的互动生出。判据是起点：租借型的功能占位应当在治疗开始之后才出现，在过程测量上可以看到起点，若同类表现在治疗前的生活史里早已长期存在，那是假自体。

这些切割合起来，可以收束成一个让租借与最危险的几家近邻做出相反预测的判别格。设想一位来访者：同盟质量高，结案时症状显著缓解，进步叙事里长期有大量引述结构（“我按你说的做了”“你教我的那个工具我用了”）。结案六个月内，他被要求独立处理一个与治疗中处理过的问题性质相近、具体情境却全新的挑战，比如治疗里练习的是与配偶沟通，结案后遇到的是一次同样触发旧模式、但从未在治疗里讨论过的职场冲突。矫正性情绪体验与经典内化理论预测：体验若够深，同盟若够好，构件应已内化，他能独立应对。移情性治愈预测：症状缓解是讨好的产物，讨好动机消失，功能全盘回退。发生租借预测的是另一种曲线：功能高波动、快衰减，在间歇调取治疗师的内化参照时尚可，在完全独立的新情境里塌陷，而且谷底不随时间抬升。如果实证上这类来访者的衰减曲线完全符合移情性治愈或内化失败的预测，没有新情境的挑战就稳定，只在环境磨损下缓慢衰减，租借就可以被更简单的现成解释覆盖。这条判别尚未检验。

◆ 五、丁立的十三个月，与一个必须回答的审问

回到开头的邮件，把丁立的治疗从头走一遍。他初诊时三十三岁，已婚，有一个年幼的女儿，在一家建筑设计事务所做项目组长。主诉是不快乐，但不是抑郁：能吃饭，能上班，能和朋友说笑，他形容自己的人生“像隔着一层毛玻璃在

看别人活”。工作业绩稳定而无热情；婚姻里他尽责不出错，却总觉得妻子看他的眼神里有一种“你不在场”的失望；做父亲，他爱女儿，却说不出那个“爱”字。他每天都在做“正确的事”，每一件正确的事都在消耗他。童年极干涸，父母常年在外务工，他轮流寄宿在不同的亲戚家，学会了不给人添麻烦。他最早内化的声音不是“你值得被爱”，那声音说的是“只要你不麻烦别人，你就可以待下去”。他后来精准的共情、对情绪的快速识别、很强的社交适应力，都是这条生存策略的延伸，让他在任何环境里都能安全地待下去，代价是他从来没有学过怎样接收。评估把他的停转定在供应的环节。治疗是每周一次的动力学取向。

前六个月，丁立后来形容那像“在冻土里装地暖”。他不会谈感受，治疗师问“你现在身体有什么感觉”，他常常发呆几十秒，然后说“没什么感觉”。慢慢地，这个空间不再奇怪了，他开始报告一些细小的变化：他会对妻子说“我今天很累，不想说话”，而不是沉默着继续履行丈夫的义务；会议上被领导打断，他感到一阵被堵住的愤怒，以往他会立刻把它消化掉，告诉自己“领导说得也有道理”，这一次他让愤怒在身体里多待了一会儿，发现它自己过去了。进步笔记里写着：情感表达范围扩大，防御减轻，在最近一次会谈中首次表达了对治疗师“总是这么安静”的不满，可视为负性移情开始浮出，关系更趋于互动的信号。

第九个月，他有一次情感的爆发。他讲了一段从未对任何人说过的经历：十三岁那年，在亲戚家被冤枉偷了钱，没有人相信他。他在治疗室里哭了，说自己一直以为早已忘了，边哭边说，他从来没有被任何人相信过。治疗师那一次没有说话，只是坐在那里看着他。随后一个月，丁立报告自己的状态有一次跳升，心里“轻了一块”，更愿意主动和妻子沟通，在一次和女儿的游戏里，第一次觉得“我是在玩，而不只是在陪玩”。两个人都认为，治疗到了转折点。

第十三个月，丁立自己提出结案，理由是学到了很多，知道怎么处理情绪，和妻子的关系好了许多。他特别提到最近和妻子吵了一架，吵得很凶，他没有退缩，“我就站在那里，跟她一句一句吵，吵完了我们反而说了很多很久没说的话”。结案评估结合了常规临床访谈与自评量表，总分已从临床临界降到正常范围，三个维度均有改善。结案笔记写着：早年情感供应中断的创伤，经由矫正性的关系体验得到实质性修复，来访者已能把治疗中获得的新情感能力迁移到家庭与职场。三个月后的随访里，他说状态稳定，“没有太大的起伏，是一种好的平静”。

事后，治疗师带着两位同行，把这段治疗从头回看了一遍。他们翻出进步笔记、结案评估和能回忆起的关键对话，要弄明白的是那十三个月里发生或没有发生什么，没有追责的意图。回看找出了三个入口。

第一个入口，是所有权的回引不足。丁立在整个治疗中多次用“因为你在”“多亏你说了”这类句式报告进步，治疗师通常以共情的确认和温和的鼓励回应：他说过“你能做到很难得”，说过“我很高兴看到你为自己争取”，说过“你有这个权利”。几乎没有一次，他像第二节里的第二条路那样，往回推一句：“你决定开口的那一瞬间，是怎么发生的？”他接受了来访者递来的所有小小的合同，把功劳签在自己名下，再用善意把它们装订成册。第二个入口，是支撑从未被撤减过的测试。整个结案阶段，他们讨论的是“你学到了什么”“你准备怎么用”“遇到什么情况要警惕”，都是标准的好问题。但没有哪一次，在丁立于治疗室里描述一次成功时，治疗师收敛过自己的情感回应，他仍以与过去同样的强度共情、确认、表示欣慰。丁立在治疗室里报告成功时，得到的仍是同样的外部供能。治疗室作为测试环境，条件从没有变过。一个在支撑还在时表现良好的系统，不能当作支撑撤去之后仍然良好的证据，他们却把它当成了证据。

第三个入口最深，就是第九个月的那次爆发。督导者问了治疗师一个让他愣住的问题：“你在那个时刻，有没有意识到，你就是那个第一次相信他的人？”治疗师说，当然意识到了。督导者接着问：“那他有没有意识到，你相信他，和他能相信他自己，还不是一回事？”在那一刻，治疗师以全然的临在成了丁立生命里第一个相信他的人，这是一次质量很高的矫正性体验。矫正性体验的经典模型假定，体验一经发生，就会成为“世界上是可能有人相信我的”这条新知识，慢慢变成一种内在的能力，他开始相信自己。事情未必这样运作。丁立记下来的，也许并非“被相信的感觉”，是“这个人相信我的感觉”。此后每当他需要被相信，他的内部唤起的并非一种自我确认的默认感，他调取的是一张脸：治疗室里看着他哭的那个人的脸。那张脸能给他的情感系统临时注入底气。时间一长，那张脸在他心里的清晰度往下掉，底气也跟着往下掉。十个月后，当他再也看不清那张脸时，他被打回了原形。按这一读法，邮件里为什么没有问“我该怎么办”，问的是“我是不是就是那种人，好不了的那种”。他不知道问题出在哪里，只感觉到一件事：治疗室里曾经有过的那个劲儿，不是他自己的，所以会蒸发。他的绝望不在于“劲儿没了”，在于劲儿没了，他不知道去哪里把它找回来，因为当初它就不是他自己找到的。

一个敏锐的读者，尤其是一位老练的督导者，此刻必然提出质疑：丁立的退回，有没有更简单的解释？也许在结案后的十个月里，他遭遇了足以击穿一个尚不稳固的新构件的生活变故，职场上的重挫，婚姻里的突发危机，家人的变故。若是这样，他的退回就不是租借的证据，属于排异型退回，一颗种子被意料之外的霜冻打蔫了。

这个替代解释值得认真对待。回看的人去核对了丁立这十个月的生活。邮件里他自己的话是：“没出什么事，就是慢慢的，我又变回以前的样子了。”后来一次以关怀为目的的电话里，治疗师问起这段时间有没有重大变动，丁立提到两

件事：公司调整结构，他的项目组被合并，他不再当组长，回到了普通设计师的岗位；父亲查出高血压，需要长期服药，对日常生活没有剧烈冲击。他用“烦心”形容这两件事，随后说，跟以前让他崩掉的事比，这些不算什么，他也没觉得自己被击垮，“我就是慢慢地、不知不觉地，就又那样了”。

这段自陈带着来访者自己的诠释，但它给出了几条线索。生活压力在他自己的体验里并非极端事件；他把退回归于内部的、过程性的“劲儿过了”；他描述退回时没有任何具体事件的叙事，没有说“某个月因为什么事，我开始又退缩了”，说的是“慢慢的”“不知不觉”。无时间性、无事件性的退化叙事，与有明确触发事件的排异型退回不同。当然，这个替代解释不能被彻底排除，任何个案的事后追溯都有它的限度。严格地说，只有在一项定期、密集随访的前瞻性研究里，让事件在发生时就被记录而不是事后被重构，才能裁决“环境打击”与“构件空心”之争。就现有的回顾性信息而言，“新打击说”的解释力并不比“租借说”更强，因为打击的客观强度与功能塌陷的幅度之间，存在不成比例的落差。这是一个未决的判断，本书标为尚未检验。

对这个案例还有一个更深的追问。如果连一位有十五年经验的治疗师，也要靠事后的督导与回看才能认出那些被遗漏的岔口，这个概念的实时价值何在？它是不是只能当一个事后诸葛亮式的解释框架？回答分两层。其一，承认这里的张力：丁立的案例是事后回溯，带着事后合理化的视角优势，它演示的是一次失败分析，没有演示租借被实时识别、当场修复，“如果重来，哪些时刻本该被认出”。这两种知识之间有差距，这个差距暴露了当前培训体系里一个实在的盲区。其二，这个盲区至少可以通过下一节的读数被缩小，因为那些读数不需要翻遍全部笔记才能得到的上帝视角。至于它们能不能在实时里被用，本书不做保证。

◆ 六、读数、判错与不适用的地方

这个概念最初的表述附有一整套“识别与修复”：三种信号，三组操作，其中包括抗租借的提问句式、撤回而不修补、结案前几周的系统减撑。本书不收这些作为处方。一则，这是一本理论专著，不开步骤清单；再则，上一节三个入口的回看已经显示，这些动作一旦被写成清单，就成了治疗师手里又一件替位的工具。撤回如果由治疗师单方面决定并执行，它本身就是一种替位，替来访者决定他该在何时跌落、跌落多深。下面只保留可以在事后从记录里读到的现象。

第一项读数，是进步句的主语。来访者报告进步时，句子里行动的发起者占据什么位置。独立陈述的样子是“我做了某件事，因为我想做”，“我也不知道为什么，那天就是觉得不能忍了”；引述结构的样子是“我按我们讨论的去做了”，“你之前说过我应该这样，我就试了试”，“你说这个可以试试，我就试了”。在后一类句子里，“我”表面上是行动者，句法深处的主语是治疗师，因为“你说”，所以“我做”。这不是来访者故意谦虚或讨好，是构件的启动指令存放在外部时，陈述必然指向那个外部。读数的做法是在连续若干次会谈的转写里，数出两类句式各占多大比例，同时看有没有不带“她说过”这一类前缀、完全由自己演进的段落。需要提醒一点：丁立结案前那句“我就站在那里，跟她一句一句吵”，单看是一句主语是“我”的独立陈述，可是它是对治疗师讲的。治疗师在场的情境本身，就是这个构件的隐性支撑，他在给那个曾与他一起撑起这个新功能的人讲这个功能的运用。他讲得越顺，治疗师听得越欣慰，租约就越容易被双方读成产权证书。所以读这一项时必须同时记录，这句话是在谁面前说的。

第二项读数，是功能表现的跨时段形状。内化已成的构件，其表现是有波动但谷底逐步抬升的波浪；租借的构件，峰值很高，甚至高过内化者的平均水平，因为它有外部供能，谷底却更深，而且不随时间抬升。一旦外部供能因任何原因

中断，如会谈间隔拉长，生活里出现别的压力，来访者对治疗师产生了尚未处理的负面感受，表现就会断崖式回落，供能恢复时再次拉高。这种高波动通常被读作“不稳定的进步”，本书给它一个更具体的读法：它可能是租借的示踪信号。要读的是进步曲线的摆幅与生活事件的变动是否成比例。

第三项读数，是支撑在减弱时功能还剩多少。这一项往往没有，因为多数治疗根本不曾改变过对来访者进步的回应强度。如果碰巧有这样的记录，治疗师的回应由饱满的共情确认收敛为简短的承接，来访者的进步叙述和情感质量是否随之下降，变得更不确定、更急于寻求确认，是读数；如果没有这样的记录，那本身就是读数，说明“看上去好了”这个证据，是在支撑完好时取得的。三项读数不能单独使用，需要在至少连续三次会谈里相互核对，这是一个对读数本身的限制，不是一条操作规程。

第四项读数，连着上一章，是治疗关系断开之后的去向。断开后，织体型的来访者回到原状，治疗室里的契合没有向外溢出过，所以也就没有什么需要寻找；租借型的来访者则会去找下一个出借人，新的伴侣、新的督导、新的团体，在一个有人在场的地方，同样的动作重新出现。这两种走向，可以在随访里直接区分。这条判据同时是两章之间的合并条款：如果在断开之后，两类来访者的行为轨迹无法区分，第1章与本章就应当合并为一个概念。需要诚实指出的是，丁立这个案例本身没有给出清晰的答案：他退回了原状，这像织体型；他给治疗师写了信，这又像在回找出借人。一封邮件不足以裁决，这是理论预期的一次边缘性接触，不是证据。

关于“必要的支撑”与“替位”，一位务实的督导者会问：我撑住他，是为了让他将来不靠我，在这过程中，哪些是必要的过渡，哪些是在制造租借？回答不能落在支撑的内容上，二者的内容可以完全相同，都是接住情绪，确认方向，提供安全。区别落在两个事后可记的现象上。其一是时间的方向：必要的支撑朝

向一个将来，在那里它逐渐被内化、最终被拆除，它的痕迹是每一次支撑之后或同时，有一个把所有权往回推的动作，一个沉默，一个问题，一次不急着替他说出答案的等待，节奏像“撑一把，松一点，看他自己能不能多稳一点，再撑一把”。替位则是持续的高水平供能，没有给来访者留出独自摇晃的空间。其二是功劳的去向：来访者以“多亏你”“按你说的”归因进步时，治疗师是把功劳往回递，还是接过来用于强化同盟。可以做的读法是：连续三次会谈里，治疗师对来访者进步的回应是否全部是正向确认，没有一次附带所有权回推的动作。这只是一种可以数的现象，不是对哪位治疗师的评判。

本章的判错条款，一律尚未检验。其一，所有权转移的长期追踪：结案后 6 个月与 12 个月两个时点，记录来访者在新情境中的同类动作是否需要一位在场的出借人，若租借型与非租借型的个案在这个指标上没有差异，核心区分不成立。其二，衰减曲线的形状：随访至少 12 个月、每月至少一次采样的纵向研究里，若被判为租借的来访者与被判为内化的来访者在功能波动的形状上没有系统差异，租借者也呈现谷底持续抬升，“发生租借”就被“治疗效果不持久”这种更简单的解释取代。其三，增量于依赖：结案时同时测量来访者对治疗师的关系依赖（同盟量表）与支撑减弱时的功能残存度，对结案后一年内功能滑回的预测，若残存度的解释力可以完全被依赖变量吸收，租借只是关系依赖的复杂重述。其四，情感投注的分层：按移情量表分层后，若租借只出现在高投注组，它与移情性治愈无法区分。其五，构念效度：功能使用平稳、独立试探不增、结束的议题被双方回避，这三条租借的标记应当共现，若在临床样本里它们经常分离，例如大量个案功能使用平稳而独立试探照常上升，那么“租借”就不是一个结构，只是三个互不相干的现象被一个词捆在一起。其六，三种形态的判别效度：两位独立编码者对同一批个案做燃料、工具、方向的三分类，若一致性低于

随机水平，或三类在预后上无差异，这个分类就是描述性的修辞，不是有判别力的结构。

最后交代失败与不适用。租借的概念不主张所有疗效不持久的个案都是租借，任何一个个案都可以被多种理论解读，它只主张存在一类，其不可被现成概念吸收的预测需要接受检验。它也不主张撤回是普遍的良药：撤回只在同盟已足够稳固、来访者不会把治疗师暂时的撤回读成关系破裂时才谈得上；对已经以独立陈述为主的来访者，撤回没有诊断价值，只徒增同盟的风险；来访者在撤回之后可能出现剧烈的恐慌、无助、愤怒，这一幕如果发生，说明租借的深度比此前被替位掩盖的更深，它同时也可能伤到人。对处于自伤自杀风险、急性危机，或心理储备已经耗尽的来访者，任何形式的减撑都不在本章的讨论范围之内，那些情形里需要的是支撑，是结构化的帮助与安全流程。还有一点必须写明：租借与第9章将要讨论的另一类现象，使用的是同一个动作，借用治疗师的在场完成一次自我的重启，两章却给出了相反的判决，那一边判作治愈，这一边判作伪改变。两者不能同时为真。裁决的办法是治疗结束后六到十二个月，在治疗师完全缺席、也没有替代性依赖对象的新情境里，来访者能否自行发起同类动作；借用之后是否发生所有权的转移，是同一个现象分岔为两种结局的那个变量。这个张力留给第10章正面处理。

前两章处理的都是治疗做得“对”的时候：对到织体不透气，对到改变是借来的。两种情形都把问题引向同一个位置，那个位置一直被默认属于治疗师：知道发生了什么，知道该如何应对，知道此刻来访者需要什么。第二编的第一把椅子就是它。下一章要追问的是，当治疗师、来访者与研究者三方都认领同一次痊愈，说“他懂”的那个人，是怎样被所有人默认为不需要质疑的。

◆



第　二　编

三把被占住的椅子

编　序

那个只有来访者能站的位置，是被什么占住的？这一编拆成三把椅子：懂、给、判。第3、4章是懂的椅子，一章看“懂的人”这个站位怎样与来访者锁成一对，一章看懂得太准为什么会成为闯入。第5章是给的椅子，第6章是判的椅子。

三把椅子上坐着的都不是做错事的人。读这一编时请记住：平均而言同盟和共情都是好东西，这里问的是平均之下的那些阶段和位置。

03

第3章

懂的椅子：谁是懂的人

一场跨流派的个案研讨会上，主持人放出一份结案报告。来访者受广泛性焦虑困扰六年，治疗八个月，症状明显退去，工作里开始主动提方案，与伴侣争执之后也不再靠沉默收场（说明性合成案例）。会场里坐着三位治疗师，轮到各自点评时，每个人都认出了这份报告里自己熟悉的东西。认知行为取向的那位说，这是核心信念被重建的结果，持续的认知重构加上暴露练习，终于松动了“世界危险、我无能”的图式。精神分析取向的那位说，这是无意识冲突得到修通的明证，来访者与苛刻父亲之间的权力争夺在移情里被重新点燃，又被解释，最后化开。人本取向的那位则说，在长期不带评判的接纳里，来访者第一次放下防御，自我实现的倾向便顺势生长。

三种说法都有道理，三种说法也都无法被另外两位驳倒。这样的场面在心理治疗的行业里并不罕见，而它的背后站着一个近一个世纪未曾平息的老问题：各流派的前提互不相容，疗效却长期分不出高下（Rosenzweig, 1936；Luborsky et al., 1975；Wampold & Imel, 2015）。本书导论已经讲过，这个所谓“渡渡鸟判决”并没有被共同因素研究和情境模型简单地消化掉，它留下的追问仍然是：好东西为什么有时会挡路。本章要在这个追问里切入第一把椅子。

三位治疗师的点评之间有一处无人提起的共同点。三个人都默认，来访者的痛苦里有一个卡点，治疗的功夫在于辨识出这个卡点，再施以与之相配的干预。他们对卡点的命名各不相同，叫功能失调信念，叫未修通的冲突，叫受阻的成长倾向，可是“有一个人看得见卡点”这件事，三个人的叙述里都原样保留。这个

人坐在治疗室里最显眼的那把椅子上，本书称之为懂的椅子。本章的承重判断由此而来：在某些长程而平稳的治疗里，懂的椅子本身就是僵局的一半，因为它让来访者继续坐在被看的位置上，而来访者最熟悉也最疲惫的生存经验，恰是被一个更懂自己的人看着。

◆ 一、同一次痊愈，三家认领，第四者无人质疑

整合运动是对渡渡鸟判决最体面的回应。技术折衷主义把多套辨识语法收在一处，治疗师不必只懂一种语言，他要懂的是什么情形下用哪把钥匙开哪把锁。共同因素理论整合的是有效成分，治疗师未必要懂深层的心理结构，却要懂什么是好的同盟、什么是准确的共情、什么是能点燃希望的共享叙事。过程取向的疗法整合的是加工模式，治疗师要懂来访者的认知、情绪与行为在哪一环固化，又用什么体验性的办法去柔化它。这些努力各有扎实的贡献，本书不打算贬低其中任何一条。

细看这条整合之路，会发现被整合的始终是“懂的内容”。精神分析师懂无意识冲突，认知行为治疗师懂信念与行为的链条，来访者中心的治疗师懂尚未触及的感受，折衷者懂何时换哪套懂法。内容在换，换的是治疗师懂什么，没有一种整合去追问他凭什么坐在懂的位置上。治疗师是那个拥有专业辨识能力、站在审视位、负责诊断并干预的人，这个站位从未被撼动。它如此自然，以至于看起来不像一个预设，而像治疗这件事本身：来访者来，是因为他不懂自己为什么痛苦、为什么走不出来，治疗师的工作就是帮他弄懂，再修通。

这个叙事顺得过分，顺到听不见内部的裂缝。当治疗师把自己安放在懂的位置上，他同时把来访者安放在了另一个位置，被看的位置。这里的“被看”有很具体的来历。一个从小被父母用“我们是为你好”的目光检视的孩子，一个在亲密关系里被伴侣用“你怎么又这样”打量的恋人，一个在职场被上司用“你到底

行不行”掂量的下属，他们走进治疗室时，身上带着的正是这种“一个更懂我的人在看着我”的体验。对大量求助者来说，它一点也不陌生，恰是他们最熟练、也最累人的人际剧本。治疗为他们提供的第一件东西，常常是一套更精致的审视，目光更温暖，更专业，也更“为他好”。

经验增长也没有让这把椅子更好用。Goldberg 等人（2016）追踪了170位治疗师和6,591名来访者，发现治疗师的疗效平均并没有随着执业年限而提升，反而有小幅下降。这个数字不能直接拿来证明本章的任何一句话，因为它没有检验懂的位置，只检验了经验。可它至少提醒我们，“懂得越多，帮得越好”这条直觉没有它看上去那样稳固。

懂的椅子占住的是什么，需要说得更精确一点。它占住的不是治疗师的技术，技术当然可以继续用；它占住的是关于“谁有资格知道卡点在哪里”的那个裁决权。只要这个裁决权在治疗师手里，来访者再配合、再有悟性，也只是在一个被安排好的位置上做一个好学生。三家流派在“谁懂”这一点上长得一模一样，各自的理论差别因此全部落在懂法的内容上，落不到椅子本身。这也许是渡渡鸟判决里最少被讨论的一层：流派们之所以分不出高下，一部分原因是它们共同拥有一个没有人去碰的支点。

这个判断需要立即加上限定。本章不主张治疗师不该辨识，也不主张懂得越深越有害。大量来访者在从未被看见过的荒野里走了很久，一次准确的辨识对他们是救命的。本章要处理的是更窄的一块地方：关系平稳、同盟良好、来访者勤勉配合、治疗师工作有序，进展却迟迟停在表层的那一类治疗。这类治疗里没有任何明显的错误可供指认，错误因此无处下手，只有结构。

◆ 二、双重互锁：两套完整的秩序

懂的椅子的另一半，通常被忽略。人们习惯把“懂的人”理解成治疗师施加给来访者的一种权力结构，这个理解不错，却漏掉了同样被锁在那把椅子里的人，治疗师自己。

“不被允许不辨识”这件事，并不只是写在教科书里的职业要求。经过多年训练，它已经内化成临床每个微小时刻里近乎自动的身体紧迫感。来访者沉默了，治疗师心里升起的第一反应通常想不到陪着这段沉默，涌上来的是一串追问：这沉默意味着什么，是阻抗，是情绪在积聚，还是在酝酿什么，我是不是该说点什么，不说会不会让对方觉得我无能。来访者落泪了，治疗师的下意识往往也顾不上让眼泪待在那里，先开始分辨它背后是悲伤、委屈、释放还是操纵。来访者说出一句含混的话，“我就是觉得活着很累”，治疗师还来不及掂量这句话的分量，后台已经开始检索概念目录：抑郁，存在性空虚，耗竭，关系里的慢性透支。

这些反应并不是治疗师的过错，是训练刻下的痕迹。麻烦出在它与来访者那边的另一种紧迫感恰好互补。来访者在沉默里想的是“他在等我说话，我得说点什么”，治疗师在同一段沉默里想的是“她不说了，我得弄清这意味着什么”。来访者用旧剧本应对被审视的焦虑，“我得表现好一点”，治疗师用旧剧本应对“我必须胜任”的压力，“我得辨识得准一点”。两个人各自被自己的旧秩序推着走，不断向对方输送对方习惯接收的东西。来访者的顺从喂养治疗师的辨识惯性，治疗师的辨识惯性又在来访者那里重新生产那套熟悉的台词：看，他又在分析我了，我得配合。双方都觉得关系很好，来访者感到被理解，治疗师感到自己在做事，最深的那个东西却始终没有动。

本书把这种结构称为双重互锁。它的单位是两套完整的秩序，各自从身体感受一路排到行为输出。来访者一侧的秩序，是在长期现实的人际威胁中打磨出来

的生存模块：肩膀绷紧、呼吸变浅，认知上预判“他马上要不满意了”，行为上先点头、先顺从、先不添麻烦。治疗师一侧的秩序，由专业训练、职业伦理、机构制度和自我身份共同托着：微时刻里的紧迫，认知上的“这是防御，要等面质的时机”，行为上的“以温和而坚定的语调给出探索性回应”。两套秩序像两只齿轮，齿与齿对上了，任何一方单独改变转速，都会被对方的齿推回来。

互锁最难察觉的地方，在它的张力极低。它不是激烈的对峙，也既无剧烈的移情与反移情的活现，只有双方都觉得舒适、能在长程治疗里延续数月乃至数年的温和停滞。来访者没有在施压，他恰恰在努力做一个好来访者；治疗师没有被逼入什么角色，他恰恰感到自己有效地工作，同盟稳固。一般情形下，临床上的出事总会带着信号，互锁里信号的缺席就是信号。

这里必须把互锁与精神分析传统里的邻居切开，因为那条传统已经系统处理过治疗师与来访者之间的相互塑造，若切不开，互锁只是旧概念换了新衣。

投射性认同（Klein，1946；Bion，1962）的动力源在来访者：他把无法承受的内在部分投进治疗师，经人际压力诱导对方感受、思考乃至行动得像那个被投射的部分，治疗师是被拉入的一方。互锁的动力是对称的，两套秩序各自完整，哪一方都不是原初的发动者。互补性反移情（Sandler，1976）更看重双方的实际行为，指来访者以角色压力把治疗师逼向其内部客体剧本中的某个位置，治疗师可能无意识地接过这个角色，但这里依然是一方施压、一方回应。共谋（Langs，1976）倒是对称的，描述双方在无意识里默契地回避会引发焦虑的议题，可它的分析单位是动机，解释的是双方为什么回避，回答不了两套秩序在结构上怎样彼此依赖。主体间系统理论（Stolorow & Atwood，1992）最接近对称的要求，明确拒绝把任何一方当作原初动力源，但它在临床上的典型动作仍是治疗师去识别并命名场里发生的事，说者与听者在命名的瞬间并不对等。

于是互锁这一概念切出的辨别面有三层。第一，分析单位是两套秩序的结构性咬合，不是单方的投射或认同，也不是共享的回避动机。第二，它特指一种低张力、两相舒适的临床状态，前面几个概念的本义大多预设了某种张力作为信号，互锁却要在张力缺席的地方被认出来。第三，它的破解条件写在定义里。投射性认同靠治疗师的涵容和解释，互补性反移情靠自我分析与节制，共谋靠揭示，这些路径有同一个立足点：治疗师以更强的洞察、更深的觉察、更稳的节制去单方面完成破解。互锁恰恰不能这样破解，因为任何一方加大自己的“辨识”或“涵容”的力度，都是在给对方的齿轮提供更趁手的动力。

由此可以把这一节的判断凝成一句：互锁是两套完整秩序之间的低张力对称咬合，它的松动需要两端同时松开，而治疗师若始终站在“我是那个能松手的人”的位置上，自己就还在咬合里。

◆ 三、失手的那一次：廖郁青

要看互锁怎样松开，先要看它怎样长成。廖郁青，三十四岁，出版社编辑，硕士学历。她为“工作倦怠”来求助：每天早晨难以起床，工作时无法专注，下班后瘫在沙发上刷手机。申请表上没写的另一件事，是她与相恋六年的男友之间的感觉也在同步淡下去，她知道对方可靠温和，心里却有一个越来越大的声音在问，难道这辈子就这样了。

头几次会谈里，她的叙述有两个特点。其一是极其概括，很少讲具体事件和具体情绪，而是拿一整套反复想过的解释覆盖所有问题：“可能就是职业瓶颈期吧”，“大概每段感情到这个年头都会淡”，“我是个挺无趣的人”。语调平稳，表情疏离，像在讲一个与自己不太相干的人。其二是礼貌地配合治疗师的每一次探索邀请，短暂停顿之后，却总滑回那条平稳的自我分析轨道。治疗师的笔

记里反复出现类似的句子：今天她又提到母亲，很快收住；我试着追问那个情绪，她滑到了认知分析上。

这个状态不能简单归到某个核心议题。它不是认知扭曲，不是无意识冲突，也不是行为失能，而要追溯到她在家里占据的位置。她是长女，父母之间长年低度紧张，不见剧烈争吵，只有渗进每件日常琐事的相互不满。父亲沉默易怒，母亲隐忍委屈，她被放在中间。饭桌上，一察觉父亲的眉头开始皱，她就得把此刻的害怕、委屈、“为什么又是这样”全部放下，去做那个不让事情变得更糟的人：岔开话题，讲一件学校里的趣事，做任何能松动空气的小动作。她学会的是“别人在怎么看我”，没有学会“我的感受是什么”；学会的是“别人期待我是什么样”，没有学会“我想要什么”。每次那顿饭平安吃完，她就得到一次负强化，没有爆发，没有冷战，没有碗砸在地上。她的弟弟是那个敢在饭桌上发脾气的孩子，后果她亲眼见过。她并非没有愤怒，只是在那个环境里做出了最不坏的选择，这个选择让她活了下来。

这套生存策略的顽固，正在于它不是一条可以被认知重构优雅替换掉的错误信念。它一层一层压实，每次“成功”都再加固一层，每个环节都盖着同一枚古老的钢印：我当时这么做，是对的。要动它，光在理性层面指出“现在不适用了”是不够的，她在认知上多半早知道这一点。它需要在体验层面发生一件它没有预案的事，一件生存手册里查不到对应条款的事。

治疗室恰恰为她的旧秩序提供了熟悉的养料。这里有一个在制度上被授权、在伦理上被要求密切关注她、评估她、做出专业判断的人。旧秩序一踏进这个房间，就认出了那个需要小心应对的人，而她最擅长的应对，就是做一个懂事的、配合的、不添麻烦的好来访者。于是她在前四次会谈里表现得极好，准时到，礼貌答，主动配合每一次探索。她用“好好配合治疗”防御着被审视的恐惧，把一出被审视的旧戏，演成了模范来访者的戏。治疗师在另一端也舒适地照着自己的

旧剧本演出：辨识，干预，进展，巩固。两个人各自运转良好，这种良好并非疗愈的土壤，倒更像疗愈的替代品。

第五次会谈，治疗师出了一个差错。他记错了时间，晚到几分钟，廖郁青推门进来时，他正匆忙收起上一场的笔记，神色里有一点慌张。这是整个治疗过程中第一次出现治疗师一方的时间失误。她后来回忆，门外等了大约七分钟，反复看手机确认不是自己弄错了，隐约听到里面有说话声，脑子里冒出两个念头，一个是要不要打电话问问，另一个是算了，大概有什么事。

治疗师没有掩饰。坐定之后，他坦率地说：“廖小姐，抱歉，我今天的时间安排出了问题。你进门的时候，我还在接上一场的尾。这可能让你有一种‘我不是你今天第一个想到的人’的感觉。我们先不急着开始，你愿不愿意说一下，刚才在外面等的那几分钟是什么感受？”

廖郁青沉默了几秒，说出一句前四次会谈里从未出现过的话：“我刚才在外面等的时候，其实在想，是不是我的时间改了，你们没有通知我。”治疗师回应：“嗯，你担心的是自己被忘记了。”她点点头，又补了一句：“不过我想应该是你有你想说的，所以就没有打电话问。”

这句话是个绝佳的入口。它包含两样东西：她的生存性警惕一直在场，几分钟的等待里，第一反应并未指向“治疗师可能搞错了时间”，指向的是“我是不是被忘了”；她的旧秩序在念头冒出的同时就启动了，她“没有打电话问”，因为懂事的人不用问题打扰别人。治疗师当然辨识得出这两层，他受过训练。他也就这样做了：“廖小姐，你说‘没有打电话问’的时候，我注意到语调变得很轻。我不确定这个‘没有问’，你想把它当成一个习惯，还是一个遗憾？”

她没有回答。她盯着茶几，手指在搓沙发垫。空气骤然变紧。治疗师感觉有什么东西从两人之间被抽走了，说不清是什么。他只知道刚才那个“习惯还是遗

憾”的提问可能太快，也太聪明了一点。它听起来像审视，把她从“两个人一起在经历这次迟到”的共享感受里，拉回了“治疗师又开始分析我”的老路。

几秒钟的停顿里，治疗师心里升起的不止挫败感。还有一丝不那么体面的东西，一点慌乱。他意识到，问出“习惯还是遗憾”的时候，自己是想回到熟悉的节奏里去，方向由他掌握，精准的提问由他给出，确切的答案由她交出。那个节奏让他安心，而此刻节奏断了。他一时不知道下一句该说什么，并且清楚地感到，自己刚刚用一件熟练的工具，把两个人好不容易走到的那一小段路又推了回去。

接下来的一句话，没有哪本手册里写过。“我刚才那句话，”他停了一下，像在找措辞，“可能说得不太对。我问‘习惯还是遗憾’的时候，好像又回到老路上去了，很想帮你分析‘不打电话’这件事。但这可能是我自己的惯性。我好像……还在试图当一个‘懂你的人’。”他又停了停，语调不再是解释性的，带着坦率和一点不确定。“其实我想让你知道的只有一件事：你今天按时来了，被晾在门外，你没有做错任何事。那几分钟的不确定，可能还有一点不安或失落，是实在的，跟你有没有打电话没有关系，跟我的失误有关系。”

廖郁青听完，没有说话，但这次沉默的质地与此前不同。先前的沉默伴着搓沙发垫的小动作和低垂的目光，是在把自己收起来。此刻她不再搓沙发垫，看着茶几，眼神也不再是在搜寻一个“正确的回答”，像是在往回翻找什么。然后她说：“其实……被晾在门外那几分钟，我想的不是‘我是不是被忘了’。我第一个念头是，‘是我自己没搞清楚时间’。”她抿了一下嘴唇，像在确认这句话对不对，接着说：“我到现在有时候还会这样，只要出问题，我第一反应就是‘大概是我弄错了’。不是别人在责怪我，别人还没开口，是我自己先怪我自己。”

这段互动值得放慢来看。它不是一次成功的共情，不是一次精湛的反移情运用，也不是对“真实关系”的一次温暖示范，它是一个结构性的动作。先看治疗

师一侧的转折。问出“习惯还是遗憾”之后，他立刻感到空气变了。这种感觉并不依赖什么高深推论，是身体性的前反思觉察：心跳可能快了一拍，肩膀可能紧了，脑子短暂空白。这个反应本身就是互锁的产物。来访者没有回应探索性的提问，触发的是他作为专业辨识者的焦虑，“我是不是不够敏锐”，“我是不是错过了什么”，他在那一刻成了自己旧秩序的囚徒。

接下来发生的才是区分性的。他没有用一个更精妙的追随式提问去修正前一个提问的偏差，那依旧是在辨识与干预的循环里自我修复，用更准的辨识力遮盖刚才的失准。他也没有在心里默念“这是她的防御，要等更好的时机”，那同样把辨识留在自己手里，只待时机成熟再发射。他把刚才发生的事，包括对自己那个动作的觉察、他的不确定、他对自己惯性的怀疑，一并放进了两人之间。

这个动作在结构上同时松开了互锁的两端。来访者那端，她熟悉的剧本“治疗师在分析我，我得配合”失去了对手戏：治疗师没有继续分析，他拿自己的动作开刀。在她的旧秩序里，没有哪位权威会这么做。治疗师这端，他熟悉的剧本“我要辨识出防御，等待时机面质”也在同一刻塌了，他不再靠精准的辨识给自己制造方向感，和她一样被悬在半空。本书把这个时刻称为共同进场。

它描述的是两套旧秩序在同一个临界点上彼此暴露、彼此失效的时刻，不描述治疗师运用高级技能单方面去松动来访者的秩序。治疗师所揭开的，与个人的脆弱无关，不涉及他的童年、情感或私生活，涉及的是他的专业角色所携带的惯性，那种习惯于“用分析来接管”的惯性。这个揭示有效的原因，不在于感动了对方，而在于它从结构上撤掉了咬合中对面的那只齿轮：辨识与干预停止转动，旧循环失去动力，两个人站在一片谁也没有预演过的空地上。

有必要特别留意主语。叙述至此，行文几乎处处在写治疗师做了什么，容易让人以为共同进场是治疗师设计的一步棋。倘若如此，它立刻就沦为一种新的懂：治疗师懂得此刻该把自己的惯性亮出来。回到现场，事情的顺序恰好相反。

这一步的前面站着一次差错，以及差错之后一个工具的当场失灵。治疗师说出那段话时，处境已经替他拆掉了台子：他已经晚到，已经问砸，已经慌乱，已经不知道下一句往哪里走。他开口，是因为没有别的话可说，不是因为选中了一种修复策略。本书因此始终把共同进场写作一个发生在两人之间的事件，而把治疗师的那句话看作事件的一部分，不看作事件的发动机。

在这之后，治疗并没有立刻变好。接下来的几周甚至更不稳定。廖郁青在会谈里更频繁地沉默，有时突然截断自己的话，说“我不知道这么说是不是在浪费时间”。有一次治疗师给了一个反馈，她没有像从前那样点头说“嗯，可能是吧”，而是摇了摇头：“你说的这个，逻辑上我懂，但我感觉不太对。”这是一句前四次会谈里绝无可能从她嘴里出来的话。原因不在于过去的她更顺从，而在于过去的她没有余地容纳“治疗师说的话可能不对”这个念头，那个余地被被审视的恐惧占满了。

第六到第十二次会谈之间，她仍会在某些时刻滑回配合模式，旧策略照常运转，只是出现了缝隙，那些她以前不敢给任何人看的缝隙。治疗师在这段时期没有刻意重复“亮出惯性”的动作，那样做只会把它变成套路，他保持的是一种不急于辨识、不急于修复的在场。变化很小，既不是顿悟，也不是症状消失，更不是核心信念的重建，但它做到了此前所有互动都做不到的一件事：让她能在依赖治疗师的同时，保有一个自己的感受空间。她可以在他面前摇头，可以说“我感觉不太对”。她说这些话时没有叛逆，没有防御，也不是移情，只是在用自己的判断。这个能力，在她过去的生活里从未被允许存活。

结案前不久，她在一次会谈里无意说起了那件事：“我后来有一次回去想……大概是几个月以前吧，那次你迟到了，然后你跟我说了些话……说实话我不太记得你到底是怎么说的了。但我记得你给我的感觉，就是你好像不是在帮自

己圆场，也不是在帮我分析我当时怎么了。你说那个话的时候，也有一点不确定自己该不该说。就是那个感觉，我在别的地方从来没有碰到过。”

她的记忆值得细看。治疗师在第五次会谈里说过的具体措辞，“这是我自己的惯性”，“我还在试图当一个懂你的人”，在她的回忆中已经模糊。她没有逐字记住对方说了什么，却记住了一个位置：在这个人面前，自己被允许不是那个“有问题的人”。她用自己的方式，把这个位置收进了自己的叙事。

◆ 四、没有选择的那一次：被迫失效与它的边界

廖郁青的故事有一个容易被误读的地方：治疗师的那段话读起来太像一种姿态，一种可以学来的谦逊。要防止这一点，需要另一个案例作对照，那里面连开口的选择都几乎不存在。

艾敏，四十岁，被弥散性的羞耻感缠绕，工作里社交里都被排山倒海的自我批评淹没。她主动要求认知行为治疗，又读过不少相关书籍，几乎是个自学成才的来访者。最初几次会谈，治疗师严格依照这一取向的规程推进：识别自动思维，挑战背后的不合理信念，设计检验现实的行为实验。她每一步都配合得无可挑剔，聪明得很，总能在治疗师说出认知歪曲的名称之前就先认出“读心术”和“灾难化”。治疗关系堪称典范，她多次表达对会谈的期待。

信号却在完美配合的缝隙里一点点积累。到第三、四次，她的配合已变成流畅的、近乎自动的反应，像出色的学生交作业，交完就等着被肯定。别的细节也在累积：回应越来越短，治疗师说“很好”时目光偶尔飘向窗外，每次认知重建作业之后那句迅速而没有温度的“我明白”。治疗师的每一次正确干预，都像一张制作精良却写错地址的请柬，被完美地投递进一个无人签收的信箱。

第四次会谈，治疗师想为她的“社交实验”布置更精细的步骤。她停顿了很久，说：“这太难了。”脸上是疲惫，不是阻抗。治疗师在那个停顿里忽然看清

了整个循环怎样运转：他全部的努力，识别，挑战，重建，实验，都在向她反复宣告同一件事，“你的痛苦是个可以被技术步骤拆解的问题”；她每一次精准的配合，则在疲惫地回答，“是，你的方法没错，可我的痛苦不在你的方法能碰到的地方”。

那一刻，治疗师的工具箱已经空了。焦虑层级的拆解，对话的角色预演，证据清单的苏格拉底式检验，这一取向能做的事都做到了尽头。他没有在选择“不知道”，他确实不知道了。他问出了一个不在任何指南上的问题：“如果你去做了这个实验，当场证明了确实没人觉得你蠢，那一刻你会失去什么？”这句话不是训练出来的干预，是一个不再拥有地图的人，朝着唯一的同行者在迷雾里抛出的不解。

她崩溃了。她说：“如果……如果证明了他们没这么想，那我就不能再怪他们了。那就只剩下我自己了……我必须去恨我的母亲，而我做不到。”治疗师后来回忆，那一刻不只她的旧世界裂开，他那个以认知重建修补痛苦的专业世界，也同时塌了一角。她的痛苦由忠诚、恐惧和自我憎恨织成，是一个必须“活在里面”的存在处境，不是一个能从外部命名、再交给某种技术去匹配的“错误”。认知行为取向的语法要求一个操作的主体去处理一个被操作的客体，而这种痛苦的要害，恰在于它不能被客体化。

会谈室里随后发生的事，不再属于任何一方的计划。治疗师的呼吸在几秒里停了，手指扣紧椅子扶手，与她脸上的泪水同时发生，事后他无法在叙述里把两个人的体验分开。她的目光穿过眼泪直视他，里面没有求安慰的依赖，是一个确认：你是不是也听见了，你是不是也被这个东西重重撞了一下。治疗师没有退回专业的镇静里，几乎出于本能地说了一句：“说出来了……这么重的话，被放在我们中间了。”这句话不是安抚，不是共情，也不是诠释，只是把刚发生的事交还到两个人之间，作为一件共同经历的事。

沉默大约不到一分钟，她先开口了，声音不再崩溃，带着一种低沉的、似乎从身体深处长出来的、此前不被允许的愤怒：“她也是个可怜人，她必须贬低我，才能让自己好过一点……但这太不公平了。这不公平。”在旧秩序里，她是母亲价值的证明，只被允许羞耻，不被允许愤怒，因为愤怒等于对母亲说“你伤害了我”，在忠诚的结构里这又等于说“我是个忘恩负义的人”。此刻愤怒自己浮了上来，没有谁把它引导出来，没有哪项空椅子技术把它提取出来。后来她对治疗师说：当那个“我很蠢”的声音再出现，她不再跟它辩论，只是对自己说，不，这是我母亲的声音，我不用再替她说话了。认知重建的工具仍在使用，使用它们的人换成了她自己。

把两个案例并排，可以抽出一个更细的区分。廖郁青的治疗师在“习惯还是遗憾”之后，工具并未用尽，他是被一次可以回溯的差错和一个当场的慌乱推到了开口之前；艾敏的治疗师则是在一整套规程跑完全程、纹丝不动之后，才被推到了没有话可说的地方。两者的共同点是，开口的那个人事先并没有打算这样做。本书据此补一个概念：迷途的共鸣，指治疗师的专业框架被来访者具体的困境耗空，并且这份耗空被放在两人之间、被对方以可辨认的形式接住的那一段治疗互动。三个条件须同时成立。

第一，技术库存的耗尽是被来访者的具体处境逼出来的，不是治疗师选择的。判据是该时刻之前，治疗师已在本次或此前几次会谈里实际执行过框架内的主要干预路径，而这些路径在来访者的自述与行为上均未产生位移。这一条把“策略性地摆出不知道的姿态”排除在外。第二，角色的瓦解是双向且同时的：治疗师失去“知道下一步”的位置，来访者也失去“等待被指出下一步”的位置。只有一方松动，另一方仍在原位等待，事件就不成立，那只是治疗师的自我暴露。第三，这一共同处境被显式地放进两人之间，至少有一方用对方听得见

的语言说出“我们此刻都不知道”，另一方以可辨认的形式确认，言语也好，点头也好，沉默中的对视或随后的情绪释放也好。各自心里承认的迷失不计。

三条缺任何一条，剩下的都能被已有概念覆盖：缺第一条是治疗师的技术性谦逊，缺第二条是自我暴露，缺第三条是双方各自的私人困惑。这三条还有一个好处，它们都写成了第三方可以在逐字稿与录像上判定的形态，不必全凭当事人的内省报告。

两个案例并起来，还能排出一条主动性的梯度，标明治疗师一侧撤走的东西在多大程度上出于自己的意愿。最靠近自觉的一端，治疗师觉察到自己的辨识动作成了互锁的一环，有意识地放下，这是共同进场的理想形态，也是最容易被误会成技术的一端（廖郁青的案例处在这一端的边缘，因为其中同样夹着一次差错）。中间一档，治疗师有意识地不去执行来访者所要求的那个角色动作，本书第5章会专门处理，名为零功能在场。另一端，则是被处境砸中，别无选择，艾敏的案例属于这里。三档之间最容易检验的区分，是治疗师事后能否说出“我当时是打算这么做的”：前两档能，最后一档不能。一旦把共同进场写成一个“治疗师应当学会的动作”，丢掉的正是最后这一档，而艾敏的案例说明，这一档恰恰最难被技术顶替。

任何一个只讲成功的概念，都值得怀疑。迷途的共鸣有一个同样实在的反例。吕明，三十二岁，因无法维持长期亲密关系来求助。他的母亲在他七岁时因精神疾病长期住院，此后几乎没有参与过他的成长。父亲把他送进寄宿学校，周末来接他，几乎没有深入的情感对话。他很早学会了自己照顾自己，用一种非常礼貌、擅长道谢的方式，与所有人保持一段安全的距离。头三次会谈里，治疗双方建立了一种温和流畅的合作关系。治疗师尝试了几个入口：探讨亲密关系里的安全感需求，辨认他对被抛弃的恐惧，用依恋理论为他绘制情感模式的图谱。每一次吕明都礼貌点头，下一次再问时说：“我想了很多，但好像还是那样。”

第四次会谈，治疗师熟悉的挫败感又来了，技术库存超额工作而收效甚微。他决定坦白。他以为第三次会谈建立的同盟已足够稳固，便说：“我感觉我带来的这些工具，在你这里好像都派不上用场。也许我之前一直没有真正听懂你在经历什么。你能不能帮我，看看我漏掉了什么？”这不是一次草率的坦白，他评估过关系的厚度，也控制了语气，希望传递的是诚恳，不是失败。

吕明沉默了。不是艾敏那种被触动的沉默，是一种迅速冷却、向后退的沉默。他点点头，说“没关系”，语调比刚认识时更平整、更正式，然后提前结束了会谈。一周后，治疗师收到一封邮件，他决定暂停一段时间。

事后的复盘慢慢显出缘由。“我没有真正听懂”这句话，在治疗师自己是诚恳的脆弱，在吕明的生命史里却撞上了另一道更深的伤口：又一个男人说他不懂自己。七岁时，没有人懂母亲的病意味着什么；在寄宿学校的那些夜晚，没有人懂他为什么在枕头下藏一只手电筒；周末礼貌地探访父亲的新家庭时，没有人懂他为什么从不问一句“我可以留下来吗”。这句话在邀请的意图之外，被他的接收器听成了一声旧门被撞开的巨响。

这个反例划出了概念的一道严酷边界：迷途的共鸣无法由治疗师单方面触发，也不是一种可以随手取用的万能手段，它对来访者的内在结构有要求。艾敏那里，误读的风险低，母亲的贬低与控制是她问题的核心，一个愿意当面承认无力的人，对她来说是母亲的对照，与母亲的翻版相去甚远。吕明身边遍布的是让他无比熟悉的失望者的轮廓，在他长出足够的觉察、能把“此刻的治疗师”和“当年的父亲”分开之前，同一句话成了旧创伤的再次确认。

由此可以说出三个最低的前提，缺一，治疗师的坦白就不是迷失，是失职。其一，关系储备的厚度：坦白之前，双方须已有足够稳固的联结，让来访者确信治疗师可靠、不会走。吕明的治疗师把礼貌合作误读成了情感信任，错就错在这里。其二，来访者具备最低限度的观察性自我：坦白邀请的是共同观察“我们之

间正在发生什么”，若来访者已濒临解离，或被闪回完全吞没，这样的邀请是残忍的，此时该做的是提供结构、保障安全、等观察性自我恢复。其三，坦白的内容必须是对治疗困境的命名，不能是自我感受的宣泄。“我所有的工具好像都失效了，我们好像一起撞上了一堵墙”，这句话面向两个人的处境；“我为这个案例很挫败，我可能不是个够好的治疗师”，这句话面向治疗师自己的自尊，要求来访者反过来安慰他。前一句邀请共同面对，后一句是情感泄洪。

◆ 五、近邻切割：谁已经走到了这把椅子旁边

一个概念要站得住，靠的不是听起来新鲜，要看它与最相似的邻居能否一一划清。共同进场与迷途的共鸣周围，至少坐着八位邻居，其中几位几乎要把它整个收走。

情境模型区分了工作同盟与“真实关系”，后者指治疗师与来访者作为两个具体的人超出角色之外的诚恳互动，被认为是疗效的重要成分（Wampold & Imel, 2015）。它与共同进场的分歧在动作的方向。真实关系从治疗师的内在态度流出：治疗师诚恳，来访者因此感到被一个实在的人接纳。这条逻辑没有错，可它没有碰到互锁，因为一位诚恳的治疗师完全可以全程诚恳，同时稳稳坐在“我懂你发生了什么”的位置上，诚恳地共情，诚恳地回应，诚恳地解释，永远是给的那一方，来访者永远是收的那一方，两套秩序照旧咬合，只是关系质量很高。共同进场要求的是情境模型无须要求的一个额外动作，治疗师拆掉自己作为全知辨识者的站位。这件事与诚恳不在同一个维度上，它不关乎“这个人是否实在”，关乎“这个角色以及它锁死的互动模式能否被角色的持有者自己悬置”。

叙事疗法的“去专家化”与共同进场共享着悬置专家权威的意图。区别在于前者靠一套技术序列完成：外化问题的语言，系统地寻找被主流叙事掩盖的独特

结果，引导来访者长出更丰厚的替代故事（White，2007）。步骤清晰，可手册化，可评估忠实度。运用这套技术的人，也就是决定何时外化、如何寻找独特结果的人，依旧占着专业判断者的位置，这是一场由专家操作的去专家化。共同进场没有步骤。一位叙事治疗师可以全程不做这件事，外化技术用得精准，替代故事帮来访者找到了，一次完整的叙事治疗做完，却从未在来访者面前对自己手里的叙事工具本身起过公开的怀疑。共同进场的实质，是治疗师把手里的工具，包括那些去专家化的工具，一同放到了两人中间的台面上。一个是技术立场，另一个是站位的撤离。

Anderson 与 Goolishian（1992）的“不知道的姿态”比叙事疗法更近，几乎用着同一批词：来访者是自身经验的权威，治疗师从不知道的位置进入对话。分离线在于，那是一种持续的伦理姿态，要求自始至终保持，与有没有僵局无关；共同进场以互锁为前提，只在治疗师本来正在辨识、并且辨识失灵之后才可能发生，没有先前的懂，就没有可撤的站位。这里有一条可裁决的相反预测：一位从第一次会谈起就恪守不知道姿态的治疗师，按后现代取向应当持续有效，按本章则不会产生共同进场，因为没有互锁可拆。若取两组长程僵局个案，一组由严格训练过不知道姿态的治疗师承接，另一组由先辨识后撤位的治疗师承接，前一组的僵局松动率不低于后一组，本章所说的“站位剥离”就多余了，Anderson 与 Goolishian 已经足够。

比昂（Bion, 1967）要求分析师在每次会谈中悬置记忆与欲望，以接收尚未被认识的东西，动作上与放下懂的站位极近。分离线是谁必须知情。比昂的操作完全在分析师内部完成，来访者原则上不必知道；共同进场则要求来访者看见治疗师也不知道，廖郁青的案例之所以起作用，正因为迟到的失手是看得见的。这是一条关于“谁必须知情”的硬区分，也带着一条可检验的预测：设一组会谈，治疗师内部清空、外表照常，不流露任何不确定；再设一组，不确定明明白白被

来访者看见。若前一组产生等量的松动，“共同”二字便是冗余的修饰，比昂的单方版本已经足够；只有后一组松动，可见性就是必要条件。

Safran 与 Muran（2000）的破裂修复研究，以及 Stern 等人（1998）的“相遇时刻”，是与迷途的共鸣最近的实证脉络。破裂修复里的元沟通，是治疗师识别出破裂、发起公开谈论、邀请来访者共同修复的过程，目的是回到一段有功能的关系，角色结构不变。共同进场与迷途的共鸣所做的元沟通，表面上可以几乎一模一样，用词也相近，行动的目的却相反：前者修关系，后者宣布旧关系的剧本暂时演不下去。更重要的是时机。破裂修复处理“关系坏了，怎么修”，共同进场处理的是“关系太好了，深层不动了，怎么打破”。前者是修复的闭环，后者是对一个运转良好的闭环的打破，打破的后果可能是短期内关系更不稳，廖郁青此后几周的沉默与质疑便是一例。“相遇时刻”描述旧程序失效、双方须共同即兴出一个新的互动方式，同样是旧程序失效的时刻。区别落在抵达的方式上。在波士顿小组的描述里，治疗师有足够的临在与敏感，才识别得出这个时刻，它依然是专业框架内部的事件。迷途的共鸣发生在识别之前，治疗师还没能识别出任何东西，先被来访者的处境摔出了识别能力。一个是专业框架的深度运用，另一个是专业框架的暂时崩塌。

“刻意练习”取向主张，治疗师之间疗效的差异，相当程度上取决于他们识别关系破裂并及时修复的具体技能，这些技能可以通过回看会谈录像、编码关键行为、获得即时反馈而提升（Miller et al., 2020）。它对共同进场的质询最尖锐：你所谓的共同进场，无非是一位高技能治疗师识别到关系破裂，运用了一种高级的修复技巧，换了个漂亮的名字。这一质询并不否认现象，它把现象还原成技能的一种亚型，所以必须回应。无论修复工具多精妙，包括“坦率交代自己刚才的分析惯性”这件工具，操作者在执行修复的时刻依然站在一个特定的立足点上：我辨识出问题，我选择策略，我执行，我评估。这是一个完整的辨识与干预

的闭环，修复权单方面属于治疗师。共同进场的临界时刻发生在治疗师从这个立足点上退下来的瞬间，他放弃的是对关系的单方修复权。两者的差别无关技能等级，在于立足点不同。刻意练习能让人成为更好的修复者，却训练不了那个让人不再是唯一修复者的动作。两者在逻辑上并不互斥，一位治疗师当然可以先练习如何精准地放下工具，可那个“放下”之所以有效，靠的是取消了自己作为精准操作者的垄断，与做得多精准无关。

关系精神分析里的“第三方”（Ogden，1994；Benjamin，2004）同样接近。Ogden 的分析的第三方，仍是等待分析师解读的场域；Bion 的涵容，仍是分析师单方面完成的消化；Stolorow 与 Atwood 的共同建构，仍由治疗师来命名；Benjamin 的第三方空间，仍由治疗师创建并守护。共同进场把解读权连同守护权一起交出，治疗师承认自己此刻无法提供那个被妥善看护的位置，由此生出的共享空间，任何一方都没有创建或守护它，它在双方都承认“不全知”的缝隙里自己长出来。

最后两家来自治疗之外。列维纳斯（Levinas，1969）主张他者的面容并非被我认识的对象，它打断我的认识、质疑我的自发性，治疗师让来访者的他异性打断自己的辨识，读起来就是这套伦理学的临床版。分离线是对称还是不对称：列维纳斯的伦理关系结构上不可逆，我对他者无限负责，他者不对我负责，反对总体化的全部力量就在这种非对称里。共同进场要求对称，治疗师也把自己的不知道交出去，让自己同样处在可被看见、可被质疑的位置。若做成不对称的无限承担，得到的是又一种“更高级的懂”，也就是第二节所说互锁的升级版。医学里的共同决策（Elwyn et al.，2012）已是成熟的制度，医生把选项、证据和不确定性交给病人，共同做出选择，也是一次专家权威的自我限制。分离线是共享选项，还是共享“没有选项集”这件事。共同决策的前提是专家仍掌握选项集，正因为掌握，才谈得上交出；共同进场发生在选项集本身不存在的地方，长程僵

局里并没有一张现成的选项表，治疗师不知道往哪走，并非隐瞒了什么。共同决策在专家知识充分时最有效，共同进场只在专家知识失效时才启动。

还有一条常被问到的邻居，治疗师自我表露的实证传统。让来访者看见治疗师的不确定，操作上就是一种自我表露，这个领域已有元分析结论：适度表露与结果弱正相关，且高度依赖时机（Hill & Knox, 2001；Henretty et al., 2014）。分离线在内容。既有研究测量的多是治疗师的个人信息与情感反应，如“我也经历过”“我此刻感到”，这类表露可以在保持专家位置的同时进行；共同进场暴露的是专业能力的边界，“我不知道你该往哪里去”，它以放弃那个位置为内容。判据很具体：把表露按“是否含有对自身解释权的撤回”二分，重做元分析，若两类表露的效应量没有差异，这条区分就不做功。

◆ 六、只能在对面确认的事

共同进场最容易遭遇的质疑，来自它自己。本章批评叙事疗法的去专家化仍是专家操作的技术立场，那么这个概念本身，会不会也在传播中迅速被手册化，变成治疗师在适当时候说一句“我可能又在试图当一个懂你的人了”的沟通技巧，操作者依旧站在“我用这个技术更好地帮你”的立足点上？这个风险是实在的，任何能写成文字的理论都有被教条化的可能。

可以给出的回答，围绕开口之前的那一刻展开。话语本身完全能被模仿和复制，话语之前的状态却不能：廖郁青的治疗师开口，是因为他赖以站立多年的那套东西在这一刻用不上了，他不知道怎么走。这种跌落是身体性的、前反思的，不是一个认知判断，“我应该显得谦逊一些”，与它没有关系。技术化的“自我交代”则不同，说这句话时，操作者心里想的是“看看这个技术的效果如何”，注意力的焦点仍是来访者传回的反馈信号，立足点没有动，只是换了一份新剧本。实际发生的那一回，立足点本身被悬空了，换剧本是一回事，失去剧本是另

一回事，这里发生的是后者。两种状态落在来访者那里，会被编码成不同的东西：前一种是“他用了某种新的沟通方式”，后一种是“他刚才确实不知道该怎么办”。

所以关于共同进场的任何确认，只有一个地方有资格给出，来访者那一边。治疗师不能自我宣称发生过共同进场，督导和研究者也不能单凭录像判定。在廖郁青的案例里，确认来自她结案前无意中的回忆：措辞已经忘了，位置还在。倘若来访者事后的回忆里，没有任何关于“这个人不是全知的”“他当时也不太确定”“他把自己也放进来了”的体验变化，那么无论治疗师怎样自认为做过，这个动作都没有兑现。他的谦逊可能只是旧循环的一个新变奏。

本章读数。 可记录的现象有两项。其一，结案后或随访中，来访者在不被提示的情况下，是否自发提到过某个“治疗师也不确定”的时刻，并把它记作一次此前没有过的经验，提到的是位置与感觉，不要求措辞；若来访者的叙述里完全没有这类内容，当次会谈便不能计作共同进场。其二，在互锁期的逐字稿上，来访者顺从性应答的频次与治疗师解释性发言的频次，应当呈同步升高的耦合，并在松动发生的那次会谈之后消失。这第二项是对第二节整个结构的检验：若两者在僵局期并无相关，或松动之后相关照旧，双重互锁就是一个虚构。

本章判错条款（均尚未检验）。 第一，若严格的对照研究能让治疗师在不做任何可被编码为“站位剥离”的操作的前提下，仅凭更精准的同盟建立、更系统的共情训练或更精熟的特定技术，包括向来访者解释互锁的精神分析式干预，使一组长程僵局个案产生与共同进场组等量的松动，那么共同进场作为独有增量的主张即被判错。第二，若把共同进场写成可培训的话术，包括“我也不知道”这类句式，交给一组治疗师执行，其僵局松动率与自发组无差异，那么本章关于共同进场不能被技术化模仿的主张被证伪；若显著更低，本章成立，低出的部分正是句式带不走的那一部分。第三，若测量治疗师暴露自身不确定的量与疗

效的关系，二者呈单调正相关，暴露越多、越早、越频繁，效果越好，那么本章把它说成一个时机性事件的主张失败，它退化为一种风格偏好，可以直接并入自我表露的传统。本章预测的是倒U：在僵局形成之前过早、过频的暴露，反会加固互锁。第四，随机分派两种督导训练，一种训练治疗师单向承担（更深的共情，更少的诠释，不暴露自身），一种训练对称暴露，若两组在长程僵局个案上的松动率无差异，“共同”二字便失去经验支撑。

不适用与失败的情形。 这个概念的适用范围窄，需要逐条交代。第一类是旧秩序的核心信念并非“我必须配合权威”，而是“所有权威都不可信”的来访者。多年的欺骗与辜负，让他把任何可被觉察的不确定都编码成“这个人即将伤害我”的预警。治疗师坦率地承认惯性，不会被体验为站位的撤离，会被体验为“看，他果然也不可靠”。第二类是急性危机，来访者有自伤风险、需要清晰明确的保护性框架，此时悬置“懂得情况、能做判断的人”的站位，只会加剧不安全感，并且有违伦理，本书开篇交代的适用范围在这里同样生效：自伤自杀风险、虐待与其他急性危机，一律先走安全评估与危机处置的流程。第三类是失败的尝试本身。设想一位治疗师感到自己陷在“分析与配合”的循环里，决定试一次，对来访者说：“我刚才那些分析，可能更多是我自己的习惯，我好像又在试图当一个什么都懂的人了。”来访者沉默片刻，冷冷地答：“所以你是说，你其实也不知道自己在干什么？那我付这个费用是为了什么？”这句反击不是毫无道理的，来访者带着对专家权威的期待而来，这份期待在这一刻被打破，而他的旧秩序又恰好以“找一个可靠的全能权威来保护我”为核心。这时若治疗师更用力地“共同进场”，只会越陷越深。他需要的是先接住对方的恐慌：“你说得对，这一点上我确实不够确定，但这并不意味着我不再是你可以依靠的人。我只是希望我们之间，不是我一个人在想你怎么了。”共同进场的内核没有放弃，时机的

判断则得到了校准。共同进场并不拿掉权威，它把权威从一种地位变成一个可以被谈论的东西，倘若来访者此时承受不了权威的可谈论性，时机就是错的。

新手的处境同样要老实交代。专业身份在现行的训练体制里，本就是靠辨识能力的养成建构的，新手首先要学会从模糊的材料中认出模式、形成个案概念化、做出有理据的干预。基本功未稳就要求悬置辨识位，只会得到一种空洞的“假装不懂”，那不是共同进场，只是用谦逊的姿态遮蔽技术上的无能为力。另一个方向的风险同样存在：若把“先学辨识，再学放下”当作刚性的序列，先花几年把自己修炼成合格的“全知者”，辨识位就会在时间里固化为治疗师的自我身份。资深者的障碍往往不在技术，他们理智上完全能懂这套逻辑，难处在于放下工具的那一刻，意味着放下“我一直赖以成为我”的那个身份。这个张力不能靠先后顺序化解。本书能给的只是一个并置的习惯：在每一次个案报告里，除了报告“我辨识出了什么”，也问一句，这个辨识带给我的准确感和掌控感，是不是我维持“我是治疗师”所需要的东西。对于职业身份本身还不稳固的治疗师，共同进场所要求的内在工作可能超出现阶段的心理容量，这是理论在现实里的诚实边界。

还要给出一条与后文的接口。本章的判据是治疗师自觉地、让来访者看见地放下解释权。设想治疗师因病缺席，或因语言不通而无法回应，旧的投射同样落空，第5章要讨论的零功能在场，其“不执行旧功能”的一半条件成立了，“接收”与“确认”却缺位，所以至多成立一半（第10章据此作裁定）；共同进场的条件则完全不成立，因为它需要被看见的自觉。若在这类非自觉的落空里也观察到与共同进场等量的松动，两个概念就应当合并为零功能在场一个，解释权的撤走与关系功能的撤走也就不必分开写。这是第3章与第5章之间一条可以裁决的分工线。

本章从一个会议室里的三种点评开始，三位治疗师认领了同一次痊愈，并且没有人去质疑那把共同的椅子。回头看，懂的椅子的难处在于它几乎不可能被一个人单独离开：来访者在椅子的另一侧，以顺从和配合维持着对称，治疗师稍一松手，对面的齿轮便把他推回原位。这也说明为何本章谈论的几次松动，没有一次出自深思熟虑的设计，它们都伴随着差错、耗尽和无计可施。然而，懂的椅子上最难处理的还不是“懂不到”，“懂得太准”才更棘手：当治疗师的辨识没有失灵，反而精确得无可挑剔，对面那个人为什么会在这一刻关上了门？下一章转向这种更隐蔽的情形。

◆

04

第4章

懂得太准，就是闯入

来访者用了十五分钟讲一件事：和母亲在电话里吵了一架，讲着讲着沉默下来，转去说昨晚做的梦，说着说着又绕回母亲上周发来的一条微信。她自己也不知道在说什么（说明性合成案例）。治疗师坐在对面，听出一条清晰的线索：她想要母亲的认可，每次靠近都撞上对方的不置可否，于是学会了用疏远保护自己不被落空所伤。这条线在他心里已经成形。他挑了她刚泄出一口气的那个节点，用她自己的词，包着温和的语调，把它递了过去。

递得很准，准到他自己都有些感动。几乎就在话音落地的同时，他看见来访者合上了。身体没有离开，话也没有停，脸上还挂着礼貌的专注，可那个刚才还在一层层摊开自己的人，已经把东西重新叠好，收进了他够不到的地方。治疗师追问自己做错了什么，一无所获。回应在技术上无懈可击，没有评判，没有建议，没有把话题引向不该去的方向。他只是说出了一句让自己都动容的、对她的深刻理解。偏偏是这份精准，触到了她尚未打算被触碰的位置。

这类场景在从业者的记忆里并不稀罕，却几乎没有进过培训课程。培训教共情的维度、层次和评分标准，复述内容是初级，捕捉言外之意是较高一级，在来访者自己还不知道自己感受到什么之前帮他说出来，则是最高一级。整套训练背后有一个从未被质疑的前提：理解得越深、越准、越及时，就越好。全部的技能都在把人造就成更精准的抵达者，更快，更深，更不露痕迹。很少有人在耳边提醒过：有时，不抵达才是治疗。

上一章讨论的是懂的椅子上“懂不下去”的时刻，治疗师的辨识失灵，反而让两个人落进同一片空地。本章转向反面：辨识毫无差错，甚至好得出奇，椅子仍然占住了不该占的地方。本章的承重判断是，治疗性的理解不是价值中立的信息传递。它落在什么人身上、什么时刻、以什么姿态落下，决定了它是一口氧气，还是一次闯入。当来访者正在尝试对自己的某一部分经验建立第一人称的所有权时，任何外来的、抢先的、封闭的命名，哪怕再准再善意，都在那一刻取走了他独自完成命名的机会。

这个判断需要立刻同另一句话分开。它不是“理解总是入侵，所以不要理解”。对大量来访者而言，尤其那些从未被任何人看见、长期在情感荒野里独自行走的人，一次精准而及时、被温柔递出的理解是生命线，是“我终于存在了”的确认。本章要论证的是更有限也更尖的一点：理解在一些条件下发生为资源，在另一些条件下发生为闯入，一套完整的治疗伦理必须同时容纳两种可能，并为防止后者留出一个被理论化的反向动作。本书称这个动作为不逾。

◆ 一、太准、太快、太早、太全

先把临床上反复感到、却一直被现成术语遮住的几种现象讲清。移情、防御、阻抗、投射性认同这些词，都默认问题出在来访者那一边，帮不了人把拳头对准自己。因此这里暂时停用它们，从现象本身出发，看理解怎样在特定的张力里被推成一次闯入。下面四种动态不应当读成治疗师常犯的四种错误。那样读，是把发生的过程降格成了问题分类。它们是同一个动作，在权力、时机与主权状态交错的不同位置上，生成闯入的四条路径。一位治疗师可能二十年从未落进其中任何一条，那并非他掌握了某种正确的共情技术，只是在关键时刻碰巧选择了不逾，尽管他可能从未给这个动作起过名字。

第一种是太准。回到本章开头的那位来访者。她讲述时的混乱，碎片化，时断时续，在治疗师听来是一团需要澄清的线，对她却是一项正在运转的心理功能：这层混乱让她安全，使她不必直接面对那条疼痛的内核，可以暂时拖延与痛苦的正面遭遇。治疗师的精准理解，在那一刻没有解除她的困境，却拆掉了她唯一的防御工事。准确在她这里被体验为一次越界，因为她还没准备好让自己的这一部分被看到，被谁看到都不行，首先是被她自己。于是她被提前带到了那条疼痛的正面。这个动态要同时满足三个条件才会形成：来访者处在主动摸索、尚未准备言说内核的阶段；治疗师的理解精准到足以跳过她的摸索，直接命中内核；理解以封闭的陈述句交付，没有给她留下修正的余地。

第二种是太快。一位来访者刚开始触碰一件从未对人启齿的事，羞耻的，内疚的，让她觉得自己很不堪。她的第一波表达往往是试探性的：轻描淡写地提一句，绕着正题兜个大圈，说到一半忽然笑一下，仿佛没什么大不了。治疗师几乎抑制不住地想对她说：“这不是你的错。”这句话是对的，它的功能却是合上她刚鼓起勇气撬开的那条缝。治疗师太快站到她这一边，她也就没有机会自己走完“从认为自己有错，到发现自己没错”的路程。那一段路是她在这个话题上重建自我理解必须做的内部工作，治疗师替她把转化完成了，她跟着失去了亲手完成的机会。把她从羞耻里拉出来的时候，也把她从只有穿越羞耻才能抵达的那片主体性里拉了出来。这个动态的核心不在“快”，在“替代”：治疗师善意的回应，替代了来访者自己需要完成的那个伦理与情感的判断，“我究竟是不是错的”。这个判断一旦被别人抢先给出，她就不必再自己去做，而恰恰是自己去做的过程，才是她找回心理主权的唯一路径。

第三种是太早的命名。一位来访者对自己身体的某种烦躁、对妻子某句话挥之不去的不舒服，都说不出到底是什么。这正是他的核心困难：内在混沌的东西，他翻译不成可以辨认的情感。成长中从来没有人在他身边做这件事，没有人

告诉过他“你现在的感觉叫委屈”“你刚才的反应很可能是羞耻”。他此刻需要的，与一个权威替他完成翻译无关，是有个人在旁边，陪着他从黏稠的感受里一点一点挤出词来。这个挤词的过程本身就是治疗，和他一起挤的人的存在，是他从未得到过的成长条件。治疗师出于训练和善意，在他还在摸索时说了一句：“听起来，那可能是一种被轻视的感觉。”说对了，他自己也知道说对了。但这个“对了”不是帮助，是撤资：他自己挤词的机会被撤走了，他需要的是缓慢的过程，拿到的是成品。理解在这里变成闯入，原因不在于错，而在于它剥夺了来访者亲自做这件事的机会，机会本身恰是治疗。

第四种是太全的解释。有些来访者带着高度自洽的自我叙述来：他们知道自己为什么是这个样子，童年发生了什么，谁伤害了自己，怎样一步步走到今天。这段话对朋友讲过，对伴侣讲过，对上一位治疗师讲过。信号在于叙述太光滑，严丝合缝，没有裂缝，没有犹豫，没有任何一处会让他停下来说一句“其实我也不那么确定”。熟练的治疗师能感到这套叙述本身就是一个防御结构，第一反应是想拆开它，去问被光滑盖住的更深的东西。可这个防御结构，恰是这个人走到今天所依赖的心理支架，他没有别的支架了。太快地拆，他不会感谢治疗师帮他看清了什么，他会在心理上塌下去，或者更常见地，不动声色地脱落，隐约觉得对方对他用了一种他不理解、让他感到威胁的力。理解在认知上精准，在关系时机上却是破坏性的：拆掉了他唯一的脚手架，而新的脚手架还没有开始搭。

四种动态的名字，太准，太快，太早，太全，都是褒义词。它们描述的不是缺陷，是优点的过量形态。没有一处能被指认为失误，伤害因此出现在技术成功之后。所以这类现象在传统的错误清单里无处安放：清单上的项目，是不够准、不够快、不够深、不够全。当全部错误都被排除之后伤害依然发生，伤害就不能来自执行，只能来自那个动作本身在特定条件下的存在方式。

四种动态共同指向一件事：理解的深度、时机与呈现方式不是价值中立的变量。在来访者那一端，特定的心理主权状态（本书用这个词指一个人对自身内在经验的定义权与控制权，只在心理层面使用，与政治或法律上的主权无涉）与关系权力条件下，它们会被体验为一种入侵性的动作，因为“被人理解”有时意味着“被人占领”。一个人的内在经验一旦被另一个人准确说出，他就不再是这片经验唯一的主人了，对自己经验的定义权被分走一份。日常生活和学校教育里，这份定义权通常无人看重，大家习惯认为被理解是幸福，被误解才是痛苦。可对那些从小就没有拥有过完整定义权的人来说，他们的感受总被别人纠正：“你其实不是那么想的”，“你太敏感了”，“你应该感恩而不是生气”。对这样的人，把他的感受精准地说出来，这件事本身就在重演他一生的创伤结构，又一个更善意、更温和、更聪明的人在告诉他，他对自己经验的判断终究是不够的。他的主权又一次被善意取走了。

◆ 二、三个瞬间：一句准话落地之后

上一节的四种动态，若只停在现象描述，仍会留下一个质疑：来访者合上，究竟是因为“主权被取走”这样高度理论化的原因，还是仅仅因为羞耻，一个他没准备好面对的东西被外人看到了？前者是领土被占，后者是暴露的痛苦，两者的体验显然不同。这需要一座桥。

桥可以这样搭。羞耻在相当一部分来访者那里，不止是“暴露了不好的东西”，更深一层是“我暴露了，而我不是这场暴露的主人”。回到上一节第二种动态里的那位来访者：她用轻描淡写的语气谈那件羞耻的事时，其实正在做一件极具主权意味的工作，自己调节暴露的速度与剂量。“好像没什么大不了”的语气给她搭了一个缓冲区，在缓冲区里，她可以先把这件事往外放一点，看外界的反应，再决定要不要放更多。治疗师一句“这不是你的错”，等于一脚踢翻了缓冲区。她失去的是对暴露的控制，让她在对方面前关上门的，是“失去控制”的

感觉，那件事本身的羞耻反倒在其次。羞耻与主权丧失在这里是同一枚硬币的两面：主权，就在于她能控制自己何时羞耻、对谁羞耻、以何种方式羞耻。控制被取走，羞耻便从可控的内部私事，变成了被人当面揭开的现场事件。主权被剥夺是刺痛的内核，羞耻是这层内核的情感质地。需要说明，这是本书对临床现象的一个解读，没有现成的实证量表支持它，它是否成立，由本章末的判错条款去接受检验。

这个过程可以拆得更细。当治疗师说出一句精准的共情，比如“你等这句话等了很久，它终于来了，但你不敢接”，来访者内部会发生一串连续的、往往没有被她本人意识到的操作。第一个瞬间是认知匹配：她听到这句话，认知系统几乎自动地比对，是的，这正是我的感受。匹配在一瞬间完成，带来一种被理解的、温暖而熟悉的快感。紧随其后的第二个瞬间是边界检测：她的心理系统极快地扫了一遍这个理解的来源，它不出自我，它来自另一个人。这意味着那条她隐隐感到、却始终无法或不愿说出的心理内容，已经被另一个人用比自己更清晰、更凝练的语言掌握了。在这个瞬间，那条内容不再完全属于她，她与它之间那种直接的、没被外人染指的占有关系被打破。第三个瞬间是主权判断，她几乎无意识地评估自己此刻的状态：“我正在自己摸索这个，我还没准备好让任何人替我把它说清楚，我还没准备好让它变得这么清晰，我还没准备好在这个房间里暴露它。”三个瞬间叠加起来，若被体验为一种失控，防御动作就被触发：关门，转移话题，或礼貌地说一句“你说得对”，随后在情感上撤退。这个三瞬间的拆解是本书的模型性描述，各瞬间是否真如此分立、先后，尚未经任何测量检验。

这条序列不会在每个人身上走完。对心理主权稳固、能把外来理解转成可供自己使用和修改的材料的来访者，第二、第三个瞬间可能根本不出现，即便出现，也是馈赠，不是入侵：“谢谢你帮我把这个说清楚了。”分岔点就在第三个瞬间的判断，此刻我是否正在做自己的命名工作。答案若是“是”，外来的理解

便是入侵；答案若是“不是，我此刻没有在做自己的命名，我正需要一个人帮我想清楚”，外来的理解便是氧料。这里起决定作用的变量，是来访者当下主权的功能状态，理解的精准度倒在其次。

用一个案例看看这三个瞬间。孟女士，二十八岁，因长期低自尊和亲密关系中的反复受挫来谈，这是第七次会谈。她的母亲强势、能干，童年时频繁用“我为你牺牲了那么多”要求顺从，孟女士学会了在母亲面前不表达任何可能引发冲突的负面情绪。前几次会谈中，她已经模糊触碰过“我不知道我到底在愤怒什么”这个主题，每次将要靠近就绕开。这一次，她用轻松的语调说起昨天和母亲的一通普通电话：母亲问工作怎么样，她说还行吧，母亲说你每次都这么说，你能不能具体点。她就讲了最近一个有点烦的项目。母亲又说了句什么，“她也说不上什么不对，反正就是那个样子”，然后挂了电话，她去楼下买了一大袋薯片，“很蠢的那种感觉”。接着她说，不是薯片的问题，挂完电话她也不生气，就是觉得没劲，什么也不想干，原打算去健身房也没去，躺了一个下午。

治疗师先说了一句：“听起来那通电话之后，你身体上感觉到的是一种往下沉的东西，不是往上窜的愤怒。”她立刻应：“对对对，就是沉，特别沉，像被裹在一个湿被子里，别人看不出来，但你就是动不了。”治疗师问母亲有没有说什么听着不舒服的话。她说没有，真的没有，她就是那个语气，“你每次都这么说”，她也不骂我，就是让你觉得你很没劲。

此刻治疗师心里已经形成了一个清晰的整合：母亲用隐性的否定语气持续传递“你不够好”，而孟女士无法对此产生合法的愤怒，因为她没有“被骂”，愤怒只好转向内部，变成弥漫的麻木与沉坠。这个理解很准。他犹豫了两秒，选择说出来：“我在想，你没办法生气，可能是因为你妈妈从没给过你一个‘可以生气’的理由。她没有骂你，没有指责你，只是用一个语气让你觉得自己不够好，

然后你连生气都觉得自己没有资格。那个气发不出去，就沉到身体里去了。就变成那个湿被子。”

孟女士沉默了十秒。身体从向前微倾变成靠回沙发背，一只手开始反复捻衣服的下摆。“嗯。可能是吧。”治疗师觉出气氛变了，问：“你觉得我说得对吗？”她说：“对。你说得挺对的。”笑了一下，眼眶有一点湿。“其实就是这样。我觉得我可能就是这样的。”治疗师想要重新连接：“我是不是说快了？”她说：“没有没有，你真的说得挺对的，我就是需要消化一下。”看了一眼墙上的钟，“我们今天是不是快到时间了？”还有五分钟。她说，那我们可以停在这里吗，我回去想想，下周见。此后三次会谈，她每次都以“这周没什么特别的事”“工作上的小事”开场，情感深度退回最初几次的水平，“湿被子”的意象再也没有被她主动提起。

这个案例要面对一个现成的竞争解释，必须正面回答。孟女士之后的回撤，也许只是正常的治疗性重组：一次深刻的共情往往引起来访者的内省与短暂退缩，这是她的心理系统在消化新信息。杀死这一段进展的，也许并非那句精准的话，是治疗师感到她“关上”之后的不安与跟进不当，一连串追问“你觉得我说得对吗”“我是不是说快了”，在沉默里流露焦虑，这些后续动作才是断裂的真正原因。

这个解释无法被完全排除，任何单个案例里，都不可能用实验控制把“理解本身”从“理解之后的互动序列”中干净地分开。孟女士是说明性合成案例，下面三点不构成对竞争解释的证据，只示范在真实个案的逐字稿与录像上该去核对什么。其一，非言语的变化出现在那句话落地的当下：后靠，捻衣摆，十秒沉默，都发生在治疗师追问“你觉得我说得对吗”之前，气氛在追问之前就变了，这是对那句话本身的回应。后续追问可能加深了断裂，触发点仍在那句话上。其二，“你说得挺对的”在临床上是一种典型的投降式确认，她用认同来关闭对

话，不是用认同来深化对话。治疗性的内省，其口头回应通常带着不确定、探索性的沉默、“但我还不完全确定”这类给自己留空间的话，孟女士的“挺对的”带着收尾的意味，认知上的“对”被确认之后，情感上的门随即关上。其三，退一步接受竞争解释的部分合理，也不能推翻本章的核心判断，因为本章只主张理解可以在特定条件下发生为入侵。即使那句精准的话只是“触发了一个正常的重组”，它触发的方式，恰是击穿了孟女士用碎片叙述、笑声和“很蠢的”这类降调语言搭起来的保护层。那个缓冲区是她当下主权运作的一部分，被精准地穿透，无论随后被跟进不当恶化，还是被跟进得当修复，穿透本身的性质不变：它是一个在主权脆弱的时刻发生的、未经邀请的认知穿透。穿透可以修复，修复却抹不掉穿透发生过的事实，在某些情形下，修复的代价也许还不如一开始就不穿透。

◆ 三、同一句话，什么时候是氧气

理解并非天生携带“入侵”的标签。一把刀的结构是刀刃、刀柄和钢材，“伤人”是刀在某些用法下的关系后果。理解也是一样，它只是一个认知动作，使它成为氧料或暴力的，是它嵌入的权力、主权状态与姿态构成的三角。这一节先把另一侧讲到同等的深度，再回来收紧入侵这一侧的条件。

治疗性理解的发生条件，可以沿两条轴来问。第一条轴是来访者的心理主权状态。长期处在“被定义”位置上的人，经验不断被父母、老师、伴侣、上司命名、归类、评判，自己从无机会对内在经验行使完整的定义权，他接收理解的姿态便处在一种结构性的警惕里，任何外来的理解，哪怕精准而善意，都先被他的心理免疫系统当作潜在的入侵信号。反之，一个主权内核足够稳固的来访者，被理解时仍保有一块内部空间：我知道自己的感受，你说的可能对，也可能不全对，由我来判断。他可以接过一个精妙的诠释，放在心里掂量，收下一部分，放下一部分。此时理解是被使用的资源，不是占领。

第二条轴是治疗师的诠释姿态。以试探的、可被修正的方式给出理解，“我听到的是X，但我不确定是不是你的意思”，与以权威的、封闭的方式给出，“你感到的是X”，在来访者那里引发的体验截然不同。前者保留了来访者对这个命名的主权，他可以改，可以拒，可以说“不，更像是Y”；后者几乎以陈述句的形式关闭了修改的空间，来访者要做的心理操作变成了“推翻一个权威的判断”，对很多人来说，这需要额外的心理力气。试探性的姿态给来访者留了一个出口，让他在内部完成“你说得对”或“你说得不对”的判断，而这个判断本身就是对自己经验定义权的锻炼。

然而，必须立即补上一个临床事实，防止本章自己变成教条。有些时刻，恰是坚定而准确、不容置疑的诠释，才让一个濒临崩溃的自体感到被稳稳托住。当来访者的内在经验已混沌到无法被他自己思考，比昂所描述的那种无法被命名的恐惧淹没了他（Bion, 1962），治疗师若这时以试探的、可被修正的姿态说“我听到的可能是……”，非但保护不了他的主权，反而添了焦虑：连你也确定不了，那我还能相信什么？这类时刻，治疗师以陈述句给出的坚定命名，“你感到的是恐惧”，起的是容器的作用，替来访者承担了他暂时无法承担的思维工作，这是生命线。它之所以是资源，要紧处在权威性被用在了正确的地方，去承担来访者暂时没有的心理功能。等来访者的思维功能一点点恢复，这份权威可以逐步缴回。

所以治疗性理解的发生条件，绝不能压缩成“主权稳固加试探姿态”这一对搭配。完整的图景有两端：来访者主权极度脆弱、自我功能濒临崩溃时，坚定、权威、不容置疑的理解，可能正是重建主权的第一个锚点；来访者主权刚刚萌芽、正在尝试独立完成某个心理操作时，试探的、留有修正余地的理解，才能保护那个刚发出的芽。两者怎么选，取决于治疗师对来访者当下主权状态的即时判

断。这种判断是一种要在临床里反复磨练的感知能力，不是写得进操作手册的规则。

主权“从未建立”的来访者，需要单独讲。有一批人，主权谈不上被剥夺，从来没有人给过他们定义权。他们来治疗，核心的请求正是“请理解我”。对这批人，治疗师的不理解，哪怕是有意的不逾，很可能被体验为又一次被无视、被抛弃。他们需要的恰是稳定的、相对高频的理解输出，借此形成“我的经验可以被另一个人理解”这个最基本的信念。因此，早期阶段过多使用不逾，是失当的。几类来访者之间的关系，更像一个时序（这是本书的临床推测，尚未检验）：早期，被理解是氧料；中期，被理解有时是入侵，因为它挤占了来访者刚萌芽的理解能力；后期，被理解与不逾可以在同一次会谈里交替，治疗师先给出一个坚定的、容器式的理解，帮他稳住濒临崩溃的边界，几分钟后他重新站住，再撤回来，剩下的路由他自己走。不逾对应的是中后期的临床需要，用在早期，它是冷漠，用过了期而不知停止，它会从保护变成撤离。

这条时序在同一个人身上有一个更尖的表述，可以拿来与人本取向的经典预期对照。罗杰斯（Rogers，　1957）的条件论预期，治疗师的准确共情理解越高，治疗进展越好。本章预测的是一个阶段性反转：在来访者的困境尚未被他本人命名的阶段，共情的准确度与他后续的自主决断能力呈负相关；一旦困境已被他本人命名，二者转为正相关。这是本章最尖锐、也最容易检验的一条预测，尚未检验，后文会再把它放进判错条款。

下面两个场景发生在治疗室之外：一位母亲，一位研究生导师。它们不是治疗，也不是证据，同样是说明性合成案例，借来只为看同一个结构（助人者的知道先于对方的不知道）在别处是什么样子，类比到治疗室时须自己打折扣。方宁，大三学生，正在为是否换专业挣扎。她对父母为她选定的经济管理毫无热情，又说不清自己想学什么，向母亲反复说的一句话是：“我每天早上走到教学

楼门口都想吐。”母亲李敏是中学教师，有十五年教育经验，深谙倾听与共情。女儿说“想吐”时，她没有批评，没有否定，只说：“你听起来真的很痛苦。”方宁哭了，感到被理解。随后几周，李敏做了她认为最负责任的事：查职业倾向测评，联系大学心理中心的朋友，请几位在不同行业工作的朋友来和方宁聊，“看看别人在做什么，也许能找到方向”，每次聊完都和女儿复盘：“你看，你和人打交道好像比和数字打交道更自在”，“你从小画画，可能说明你的思维更偏视觉和直觉”，“你说到那位姐姐做策展时眼睛是亮的，我觉得这是个信号”。

李敏的每一个观察都准确。方宁确实对人比对数字自在，说到策展时眼睛确实亮了。每次复盘后，她会短暂地觉得“妈妈说得对”，接着陷入几天更深的茫然。后来她对朋友说过一句连自己也不太明白的话：“我妈对我太好太准了，好到我都没法生她的气。但有时候我宁可她说一句‘我也不知道你该怎么办’，然后别那么快就知道我该干什么了。”她最终转去艺术管理，这个选择本身并不差。一年后，同样的危机回来了，她对辅导员说：“我转了专业之后，有时候分不清这个专业是我喜欢的，还是我妈让我觉得我喜欢的。”

这句话无法再追溯。那颗种子究竟是方宁自己的，还是李敏种下后被方宁的自我说服当成了自己的，没有人分得清，包括她自己。李敏没有替她做决定，只是在“帮她梳理”。问题在于一段被跳过的区间：方宁从没在没有外部框架的情形下，在“我也不知道自己到底喜欢什么”里泡足够久，久到自己的判断冲动从内部升起。她的“不知道”被母亲的共情理解翻译得太快，快到她来不及感受那个“不知道”的底部是什么。底部不是恐惧，恐惧只是中层，底部是一个她需要亲自经历的过程：在多少个百无聊赖的下午，多少次看到某条信息时的无名心悸，多少次对自己说“这个好像不对”的微小否定之后，自己捞起一个轮廓。她从母亲那里继承了一个正确的判断，缺的是这个判断所需要的那段发生史。一只

瓷胚，最怕的不是被撞碎，撞碎了还有泥可以重来，最怕的是被一个等不及的人提前推进了窑。出来的是一件形状优美的瓷器，它永远失去了成为另一种形状的可能。

陈屿则处在另一种位置上。陈屿，哲学系研究生，硕士三年级，在是否继续读博之间挣扎。他在连续三次与导师张清的谈话里说过：“我应该读博，本科就是为这个考的研”，随即停顿，“但我说不清为什么一想到读博就胸闷”；说过：“我师兄说我就是太矫情了”，随即发怒，“不对，跟他没关系，我自己的事我自己清楚”；第三次一个小时里说了十几次“我也不知道”，其中三次沉默超过四十秒。张清从事哲学教育二十年，脑子里几乎自动生成三个分析框架：学术倦怠的躯体化，家庭期待内化引起的动机异化，对学术市场的隐性焦虑。每一个都足够写一篇漂亮的指导笔记，他知道，无论把哪一个用多温和的提问喂给陈屿，陈屿都会点头，思考，下次带着对这个框架的回应回来，但那将是张清的种子在陈屿的地里长出的庄稼，不是陈屿自己的根。

四十秒的沉默里，张清意识到自己的冲动。他说的是：“胸闷这个说法，你自己也还在琢磨它是什么意思吧。”陈屿抬头看了他一眼，沉默的质地变了，不再是堵塞的沉默，是被允许继续堵塞的沉默。第二次谈话，陈屿怒气冲冲地说“我自己的事我自己清楚”，张清忍住了三个选项：共情他的愤怒，温和地纠正他的自我评价，用专业框架承接。他沉默几秒，把那团试探轻轻放回陈屿面前：“你刚才说‘我自己的事我自己清楚’的时候，好像同时也在对谁说‘不准进来’，是对我，还是对那个说你矫情的朋友？”陈屿愣住，接下来二十分钟里第一次说出了从未对人说过的话：他最怕的不是选错，是不管选哪条路，都能听见父亲说“早就跟你说过”，跟父亲选的一样，是“你看最后还是听我的”，不一样，是“你就是想跟我反着来”，“我怎么选都在他的嘴里”。

第三次谈话，陈屿说他可能不读博了，但不确定这个决定是不是因为怕，“怕之后发现自己真的不适合学术，到那时候就没有借口了”。张清问：“‘借口’这个词，你是在替谁说？”陈屿几乎立刻答：“替我自己吧。读博这件事，从一开始就有一个我不用负责的好处，我把赌注压在学术这条路上，走不下去了，那不是我的失败，是这个专业太卷，是学术圈有问题，是我爸当年非让我学这个。但如果我选了别的路，走得不好，那就是我自己的事了。所以我现在不读博，最重要的不是我怕学术，是我发现我一直在用一个‘被安排’的人生，来避免一个‘我自己选’的人生被证实为失败。”这段话是他在第十分钟说出来的，说完他第一次坐直了。张清这时只做了一件事：承受住一个诱惑，把这段话翻译成更优雅的哲学命题，作为漂亮的总结还给对方。他只问了一句：“这段话你自己说出来，跟别人替你说出来，是不是不一样？”陈屿点头，笑了，那种笑不是“我被理解了”的感激，是“我理解了我自己”的释然。

把两个场景并起来，差别不在谁更善良，也不在谁的判断更准，李敏的判断甚至比张清更准，张清从头到尾也不知道陈屿该不该读博。差别在于，一个人让自己的不知道成了空间，另一个人用自己的知道，哪怕是共情的、准确无误的知道，填掉了那个空间。方宁的生成过程被关上了，因为有人做了“对”的事，而那个“对”，恰是本章要悬置的东西。陈屿半年后给张清写过一封邮件，几乎没提导师，只讲创业第一年里好几次“当时觉得完全不知道该怎么办”的时刻，每回都会想起研三那阵子“自己从一团浆糊里慢慢把线头抽出来的感觉”，然后就知道该怎么做了。他不记得张清做过什么，在他的记忆里，生成的过程属于他一个人。需要补一句：张清的几个提问本身并非全无引导，按第五节对叙事疗法的切割，它们仍算短短的跑道；这个场景说明的是不抢先交出整套框架，算不得不逾的完整形态。

◆ 四、不逾：理解走到边界，不越过去

前面几节如果成立，它推出的实践问题就不再是“怎样更谨慎地共情”，更根本的一问摆了出来：什么时刻、以什么为界，理解应当被主动地悬置。本书给这个悬置动作起名为不逾，取“走到边界，不越过去”之意。

不逾是这样一个动作：治疗师有能力也有条件，对来访者的经验形成一次精准的理解，在这个理解即将凝结为可表达的形式的末梢，他停下了这个认知动作。他没有在“理解了但忍住不说”，那叫节制。他在自己的认知内部，在那句“我明白了”的自我确认将要成形的瞬间，没有让它成形。他对自己说：我还没有明白。这句话并不意味着再想一会儿就能想清楚，意味着他选择不把一个完整的理解放出去，因为此刻这个完整的理解对来访者不是帮助，是侵占。

一个尖锐的操作性质疑马上就来：一个人怎样在内部“撤回”一个已经形成的理解？撤回之后，他的认知状态是什么，是“我知道，但假装不知道”，还是“命令自己忘掉”？这个问题讲不清，不逾就只是把“忍住不说”这个外在动作翻译成一套听上去更深的内在话语，仍可以被“高级节制的内化训练”吸收。

回答需要把三种在外部看起来一模一样、都表现为“治疗师没有开口”的状态拆开。第一种是认知能力的上限：治疗师还没想清楚来访者在经历什么，他处在混沌里，所以没有给出理解，这是“没懂”。第二种是冲动抑制：他想清楚了，也生出了把理解说出去的冲动，靠意志力把它压住，就像到嘴边的话咽回去，喉咙还是会动一下，这是传统的节制。这时那个理解命题已经完整，带着交付的冲动，只是被额外的力气按下。第三种是认知撤回：他在理解命题将成未成之处，主动中止了它的完成，让它没有成为一件带着“可交付”标记的完整认知产品。他看见的东西仍在，是线索，是方向感，是随时可以再调用的材料；被撤回的是那句自我确认和交付的资格。这像医生写好了处方，没有递出，折好放进

白大褂的口袋，继续听病人讲。处方还在，没有被撕掉，也没有被忘记，只是不交付。

节制与撤回，外表相同，内部的路径不同，这种不同在长期临床里会留下可辨认的差异。习惯节制的治疗师会在某些时刻感到“我忍住了，但我知道我在忍”；完成了撤回的治疗师，在那个瞬间不会产生“我在忍”的体验，因为他没有走完最后一步。应该申明，这一区分目前只有描述，没有测量。

不逾的边界，没有谁能事先划好。它只能在每一次具体的互动里，由治疗师一边跟随来访者的话，一边追问自己“此刻如果我完成这个理解并说出来，它会被接收成合作，还是入侵”，从经验的伤痕里重新辨认。两个片段说明边界会在两个方向上被越过。

第一个片段，撤回不够。周女士，三十五岁，教师，与母亲有长达二十年的情感纠葛。第四次会谈的后半段，她用从未有过的柔软语气讲起一件小事：上周母亲在电话里说了一句“你小时候我确实对你太严了”。讲完这句，她沉默了很久。治疗师在这段沉默里清楚地看见一条从未被明说的情感线：她等这句话等了二十年，现在既想相信，又怕一相信就再受伤。这个结构可以被说得很漂亮。他没有撤回，用温和的语调说：“你等这句话等了很久，它终于来了，但你不敢接。”周女士抬头，勉强笑了一下：“嗯，大概是吧。”随即换了个无关紧要的话题，这一次会谈剩下的时间没有再触碰任何情感性内容。下一次，她取消了预约，理由含糊。理解走完了从形成到交付的全程，刚刚在对方面前展开的脆弱叙事被重新折叠。

第二个片段，撤回太过。罗先生，四十岁，企业主，为婚姻里反复出现的暴怒来谈。他语速极快，情感高度外化，从不在会谈中示弱。第十二次，他讲一次与妻子的争吵时第一次停了下来，说了两个字：“其实……”然后陷入长久的沉默。治疗师在沉默里准确感到了即将浮出的东西，很可能是某种恐惧，怕自己得

不到妻子的尊重，更深一层是怕在亲密关系里毫无价值。她记起了“不逾”的训诫，没有用任何语言去碰那个“其实……”，只是安静地等。沉默持续将近一分钟，罗先生忽然站起来，说“算了，也没什么”，用剩下的时间聊了些无关紧要的工作。他没有脱落，之后又来了好几个月，却再也没在这间屋子里推开过那扇门。后来一次较放松的谈话里，他轻描淡写地提了一句：“你那时候要是拉我一把，可能我就进去了。”“其实……”和随后刻意的沉默，本身就是一次试探性的邀请，他在用沉默朝治疗师探出了一步。他的主权此刻需要的已不再是保护，是一个被命名的容器。治疗师把“不在对方准备好之前命名”理解得过于刻板，撤回的时机错了。

两个片段指向同一件事：边界不在任何理论里，在来访者沉默的质地里，在每一声“其实……”后面的停顿长度里，在每一次脱口而出的共情之后的关门声里。不逾这个概念的用处，不在提供一份“A条件下不逾、B条件下给出”的新手册，在于为那层随时发生的判断提供一个被理论化的存在理由：它告诉治疗师，“我不说”并非操作失误，可以是一种被命名的能力。他可以在督导里说“我在这里选择了不逾”，事后回看逐字稿，与督导一起辨认，这一次不逾是保护了对方的主权，还是关上了对方递出的门。它的对错，不由某条事先存在的准绳裁决，而由它在具体关系事件里引出的后果来回溯地审判：来访者是更敞开了，还是更关闭了。

再看一个撤回成功的片段。蒋先生，四十四岁，企业高管，因长期失眠和与青春期女儿近乎断裂的关系来谈。第十六次会谈，他已经用十五次建立了对治疗师的基本信任，但有一个牢不可破的模式：谈情绪时总用第二或第三人称隔开，“你会觉得”，“一个人会想”，从没用“我”描述过任何脆弱。治疗师早已有了一条线索：蒋先生不敢承认自己需要女儿的爱，因为在他的成长史

里，“需要别人”等于“软弱”，而软弱是他不许自己成为的样子。这条线索，治疗师从第八次起就握在手里，一直没有把它做成一句要对他说的话。

这一次蒋先生说，女儿上周说要去她妈那边住一个暑假，他当时说“行啊随你”，拦也没用，她从来不听我的，她跟她妈更亲。她妈带她逛街、陪她追星，他做不来，“我只会给她打钱”。治疗师沉默三秒，用几乎像自言自语的轻声说：“你做你会做的。”蒋先生说：“对。我做我会做的，也就只会做那些。她小时候我还能带她去游乐园，现在她什么都不要我参与。我的功能就是一个ATM。不对，ATM只是取款。我是自动转账，连取都不用取，每个月自动转过去，都不用见面。”

这里有一个清晰的可干预节点：蒋先生正借“ATM”和“自动转账”触碰一种没有直接命名的情感，他觉得自己在女儿的生命里不再是一个人，只是一个功能。治疗师本可以用一句共情把它说出来，他停留在蒋先生的意象里，没有替他完成从意象到情感的翻译，只说：“自动转账……那就连面都不用见了。”蒋先生沉默二十秒，看向窗外，声音忽然轻了很多：“其实我不是不在乎。我是……我怕我去了她也还是不理我。就还不如不见。见了她不理我，我更那个。”治疗师知道“那个”里面是他等了很久的东西，他可以说“你是不是怕自己受伤”，他只回了最小、最空的一句：“嗯。更那个。”蒋先生又沉默，深吸一口气，对着面前的空气说：“我就觉得我特别没用。在她面前，我就是没用。”停了一下，“我。我觉得我没用。一个爸爸觉得自己在女儿面前没用，你能想象吗。”治疗师沉默五秒，轻轻说：“嗯，我听得到。”

这是十六次会谈里蒋先生第一次用“我”说自己的脆弱。在“我。我觉得我没用”出现之前，治疗师做了也许是十六次中最要紧的一件事：什么也没说。他看见了全部，那个“怕受伤”的结构，“ATM”下面对被抛弃的恐惧，那份用愤怒包着的对女儿的深切需要，一样也没有交付。从意象到情感的翻译权，完整

地留在蒋先生自己手里。他从“自动转账”走到“没用”，又从“一个爸爸在女儿面前没用”走到“我。我觉得我没用”，那个“我”是他在没被染指的沉默里自己挤出来的。这样得来的命名，没有像孟女士那里那样，在会谈结束后悄悄倒退（这是合成案例里设定的走向，用来示意读数，不作证据）。

这个片段自带一个张力，需要老实交代。按上面的定义，撤回发生在理解凝结之前，治疗师在这里却似乎握着一个早已完成的理解整整八次会谈。合理的读法是，他握着的是一条线索，他一直没有让这条线索长成“这就是你”的断语，也没有给它加上可交付的标记；他每次只是在蒋先生的话语旁放一个“足印”，让对方知道旁边有人。但这个读法仍然只能由治疗师自述来支撑，旁人无从核验，本章第六节会把它写成一条可以被检验的预测，不让它停留在叙事里。

◆ 五、近邻切割：谁已经说过“不要急着懂”

不逾乍听之下和一长串既有概念重叠，每一个背后都有庞大的传统。切不开，它只是旧知识换了一个说法。下面逐家来切，并尽量写成判断对判断。

现象学的悬搁（胡塞尔），把对外部世界是否实存、价值判断是否成立的自然态度放进括号，以便纯粹描述意识中被给予的东西。临床上，它常被理解成治疗师暂置理论预设和价值判断，以现象学的态度面对来访者。悬搁处理的是判断：我搁置自己的诊断、病理归类和好坏评判。不逾处理的是理解本身：我已走到那一步，我完全可以把它说出来，而且这是纯粹的现象学描述，不带判断，我仍然不说，因为此刻连这份纯粹的描述也是闯入。悬搁之后的理想是更纯粹的抵达，不逾的理想恰是一次有意的未抵达。悬搁守在入口，阻止评价和诊断闯进来；不逾守在出口，阻止已完成的理解交出去。两道门开在认知的不同位置。

精神分析的节制（弗洛伊德），要求分析师克制满足来访者愿望的冲动：不直接建议，不满足移情中的爱欲要求，不过度自我表露，好让被压抑的冲突在移

情关系中重新激活、得到修通。它与不逾共享一个“不做什么”的表面，对象却不同。节制管行动、情感与欲望，是治疗师作为一个有需求的人的那一部分，防的是欲望越界；不逾管认知，是治疗师作为一个有能力理解的人的那一部分，防的是认知越界。这里暴露出精神分析传统几乎没有正面看过的缝隙：一位完全节制、对自己的反移情高度警觉的分析师，仍然可以在他认为合适的时机，精准地给出一个诠释，而这个诠释的给出本身，已经完成了对来访者经验主权的取走。节制止住了欲望，没有止住认知。更进一步，节制发生在冲动已经生成之后，靠意志压制；不逾发生在冲动生成之前，是对“这是一个可交付的理解”这最后一步的中止。前者是欲望与抑制的二人博弈，后者是理解与撤回的单人中止。

比昂的“无记忆、无欲望”，后来被称作负能力，要求分析师容忍不确定，不被急于求解的焦虑驱动，清空记忆和欲望，让尚未被任何形式捕获的东西有可能到来（Bion, 1970）。共振是实在的，分歧在认知序列的两端。负能力处理理解尚未发生的状态，分析师的认知是空的，他悬置的是“知道的需要”；不逾处理理解已经发生之后，认知是满的，悬置的是“告诉的需要”。一个在入口处刹车，一个在出口处刹车。教学的含义因此截然不同：比昂传统教分析师，不懂来访者时别急着编造一个理解，等待到来；不逾要教的是，已经懂了，而且懂的很可能是对的，仍然可以在某个具体的时刻不把它交出去。前者防止的是虚假理解的闯入，后者防止的是属实理解的闯入，后一类闯入在既有理论里没有单独的名字。

列维纳斯主张，他者的面容不可被我的认识总体化，认识他者的企图本身就带着占有（Levinas, 1969）。这与不逾在方向上相通，却在根基上不同。列维纳斯的论断是形而上的，他者对认知绝对地不可逾越；不逾的伦理依据是实际的权力分析，某些时刻撤回理解，是因为看到自己即将在关系里占据“做者”的位置，对方即将被迫占据“被做者”的位置。这就让不逾免于一个后果：如果他者

绝对不可知，理解永远是暴力，那“早期的来访者需要被理解”这件事就无处安放。本章的立场是条件性的，同一个理解，在这个阶段是氧料，在那个阶段是入侵，列维纳斯式的绝对命题给不出这种区分。

叙事疗法的去专家化，是与不逾距离最近、也必须切得最深的一家。叙事疗法把治疗的核心操作从“给问题命名”扭转为“邀请来访者自己命名问题”（White & Epston, 1990），治疗师不告诉来访者“你这是抑郁”，而是用一串结构化的问题：“如果给这件事取个名字，你会叫它什么”，“它什么时候最强，什么时候最弱”。一个现成的质疑是，不逾是不是叙事疗法在操作层面早已实现的东西。承认两者确有高度相似的时刻：治疗师内心已有一个专家版的理解，没有直接交付，转成一个提问。用两个场景对看。

场景一：来访者零碎地讲述与父亲的长期冲突，治疗师心里已经形成一个专家版的理解，他正被一种自己尚未认作“愧疚”的情感缠住。治疗师没有说“你在感到愧疚”，问：“如果给这个让你不舒服的东西取个名字，你会叫它什么？”来访者想了想：“像是欠了什么东西，欠了债。”治疗师追问：“这个‘欠债’的感觉，什么时候最重？”一问一答，来访者自己从“欠债”走到了“愧疚”，终于说出了那个词。专家理解没有以专家理解的形式交付，转了个弯，以提问的形式交付。

场景二：同样的来访者，同样的叙述，治疗师也完成了那个专家理解。他没有把它转成任何形式的问题或言语干预，来访者说完后，他沉默片刻，安静在场。来访者在沉默里自己说了下去，自己找到了那个词：“我好像一直在愧疚。”

差别在哪里？场景一里的提问依然是一种认知脚手架。它不像直接诠释那样抢占命名的位置，却仍搭了一条认知路径：“叫什么名字”“什么时候最强”这样的提问方向，为来访者的思绪划定了方向、速度和组织方式。来访者确实是自

己命名的，但他是在一条已被设计好的跑道上跑。跑道不是命名，跑道规定了跑的方向。场景二连跑道也没有提供，来访者在没被结构化的沉默里，自己完成了最终的命名，也自己铺好了通往命名的全部认知路径，从哪里进入，用多快的速度，在哪个节点停顿。叙事疗法放弃了命名的内容权，保留了认知过程的引导权；不逾在更强的意义上，连引导权也一起放下，把自己降到最低限度的在场。这不是高低优劣的判断。提问式引导在大量情境里是必要的、有效的，来访者完全缺乏自我命名能力、需要外部脚手架时，几乎是唯一可行的办法。不逾针对的是一个窄得多的临界时刻：来访者恰恰快要靠自己的力量走到那一点，任何外部引导，哪怕是提问，都会挤占他将要完成的最后一步，那一刻，连跑道也是闯入。叙事疗法保护的是内容的归属权，“这个名字是你取的”；不逾保护的是认知过程的完整所有权，“你不仅取了名字，通往它的整条路也是你铺的”。窗口更窄，时机更微妙，也就更难进入标准化培训。

科胡特把共情视为精神分析的观察模式，分析师通过替代性内省进入来访者的主观世界，共情失败不可避免，治疗的核心动力是破裂之后的修复（Kohut, 1984）。这与不逾交叉在一个有张力的位置：有些时刻，不是治疗师掉了线，是他一直在线，在得过了头，精准的共情本身造成了断裂。这种断裂是“我太理解你”，不是“我不理解你”。科胡特式的修复，承认错误、重新校准，在这里无处着力，没有一个错误可以承认，“抱歉我说得太准了”，逻辑上自毁，关系上诡异。需要公道地说，科胡特的框架可以吸收这个事件：精准得过于超前的共情，会被体验成“非神入的断裂”，分析师可以问“我刚才是不是说得太满，让你感觉被看透了”，把它纳入破裂与修复的循环。但吸收的方式是把它定性为破裂，事后修复；不逾处理的恰是破裂之前那个节点，治疗师凭经验预判，此刻说这句话极大概率造成破裂，而且即便事后修复，也会踩断来访者刚开始的某个内在探索。不逾是破裂发生之前的预防，不是之后的修复，它通过主动不同频，保

护一根还没接通的导线不被拉断。科胡特的传统关心如何更好地进入，没有系统讨论过“何时进入本身就是错的”。

本杰明的“做者与被做者”关系（Benjamin，2004），把问题引向权力。当分析的一方占据“做者”的位置，主动诠释、定义、组织，另一方被迫占据“被做者”的位置，主体性的不对称就被固定下来，这种固定不由具体意图决定，由关系结构本身生产。不逾处理的临床事件，恰是这一结构在认知层面的微观发生：治疗师交付一个精准的共情时，意识里往往只是在“反映”来访者已表达的情绪，在来访者的接收端，尤其对那些从未享有过完整主权的人，这个动作的结构位置是：你做了关于我的经验的认知工作，我接收了你的成果，不管同意与否，我都先被放在了接收者的位置上。你定义，我确认；你做，我被做。于是不逾在关系结构上是一个反互补的操作：治疗师在自己内部中止“完成一个可交付理解”，拒绝占据做者的位置，退回一个不完整的、尚未完成的认知状态，为来访者腾出“自己命名自己”的位置。这一步在权力层面是做得更少，在认知层面并不做得更好。关系精神分析对权力不对称有许多精彩的诊断，却没有给这个具体的认知撤退动作命名。

还有三家需要点名。精神分析的过早诠释与时机学说（Greenson，1967），从费伦茨到格林森，早有训诫：诠释须等材料接近意识表层，给得过早无效甚至有害。这与不逾几乎同义，分离线在判据：过早诠释的判据是来访者接不接得住，接不住就等，接得住就给；不逾的判据是来访者是否正在自己做命名工作，他完全接得住，正因为接得住，才必须不给。两条戒律在“来访者尚未准备好”时重合，在“来访者已经准备好、但正在自行命名”时方向相反，时机学说要求此刻给出，本章要求此刻撤回。治疗性在场（Geller & Greenberg，2012）把治疗师的全然在场本身视为疗效因子，且有了可测量的量表。在场是个单调递增的善，越投入越不分心，评分越高；不逾指认的是在场充分之后的输

出截断，一个非单调的量，在量表的计分逻辑里，这个动作要么记录不了，要么被记成分神。第三家出自同一作者的相邻研究，也是最微妙的一家：把“帮”从“知”里松开的悬而未决的守护。它主张守护者连“知道”本身都不允许自己拥有，“我也不知道你需要什么，而且我不打算让自己知道，同时我留在这里不走”；不逾则承认治疗师可能已经看见，被撤回的是那份看见变成可交付命题的资格。这是两种不同的内部状态，同一段沉默可能同时对应两种说法。本章不替两者裁决，只记下它们对同一事件的预测略有分歧，其一预测治疗师在沉默里处于不知，其二预测处于已看见而未凝结，这个分歧要由第六节的替身测量去试，而不由概念的优美程度去判。

◆ 六、平均数之下：r=.28 与这一章的关系

任何对共情的批评，都必须先面对那组数字。Flückiger 等人（2018）综合295个独立样本、三万余名来访者，得出同盟与疗效的相关为 r=.278；Elliott 等人（2018）综合82个样本、6,138名来访者，得出治疗师共情与疗效的相关为 r=.28。两个数字都是正的，都是稳定的，二者合起来是这个领域里相当稳定的发现。本章不质疑它们，也不会说共情有害、同盟无用。相关系数0.28换算成解释的变异，大约是百分之八，正向，稳定，同时也意味着另外九成多的差异不在这里。

本章主张的东西落在这个平均数的下面。一个跨来访者、跨阶段合并起来的平均相关，回答的问题是“平均而言，共情做得越好，结局是否越好”，它不回答“这句话落在什么人身上、什么时刻”。若来访者的内部状态有分岔，同一个动作在两个子群里方向相反，只要多数处在“理解就是氧料”的一侧，合并出来的相关依然是正的，反向的那一小块被稀释进去，看不见了。反过来也要说清：反向子群若很小，它在人群层面的分量也相应有限。本章能主张的重要性，取决于这个子群在长程而平稳的治疗里占多大比例，这个比例今天无人知道。本章的

判断因此与这两个数字并不冲突，也不能被它们支持：它们所测的结局多是症状与综合疗效，本章所问的是四周之后第三方可核实的自主行动，量的是另一种东西。两者之间能说的只有这一句：平均数之下，可能藏着一个阶段乘以位置的交互反转，这件事要靠专门的设计去看，无法从合并系数里读出来。若本章成立，同盟分数在这个子群里就是一个会误导的指示器：它上升的时候，自主行动没有跟上，甚至在下降。下面的判错条款特意要求两组“即时同盟都升”，缘故在此。

本章读数。 事后可记录的现象有两项。其一，一次精准的理解落地之后，来访者礼貌地说“你说得对”，随后话题明显变浅，持续数分钟乃至数次会谈，且这一变浅发生在治疗师任何追问之前。把这类时点按会谈记下来，是对四种动态最低成本的记录。其二，不逾的可观察替身：要求治疗师在会谈结束后30秒内，标出“我当时知道但没有说”的时段，再由不知情的第三方编码者，从录音里标出这些时段的沉默时长，以及其后90秒内来访者自发使用新的情感词的频次。这一读数同时回答了前文蒋先生片段里的悬念：那份“已看见而未交付”的状态，能不能在行为上留下痕迹。

本章判错条款（全书第一条，尚未检验）。 以自我概念清晰度量表（Campbell et al., 1996）的低分组为“主权萌芽组”，高分组为“主权稳固组”。预测是，一次精准共情之后，两组的即时工作同盟评分都上升；但四周后由第三方核实的自主行动指标只在稳固组上升，在萌芽组不升反降。若萌芽组同样上升，本章的核心判断即告失败。这里的“即时同盟都升”不可省略：它保证了本章不是在说萌芽组不喜欢共情，同盟的分数与自主的分数走的是两条路。这条预测在设计上有几处须先写明，否则容易被别的东西解释掉。第一，要有对照：同一批人随机接受精准共情与常规共情（或同内容的试探式表述），判断落在分组与条件的交互项上，单看萌芽组四周内自主行动下降，可能只是均值回归

或病程的自然波动。第二，两个分组在症状严重度上多半不同，须把基线症状与自我功能作协变量，并排除急性危机与自我结构严重缺损者。第三，自我概念清晰度只是主权状态的粗略替身，低分组里也有第三节所说主权从未建立的人，按本章自己的判断，他们在早期更需要充分的理解，所以最低分一端应当单列；预测是它不同于萌芽组，若最低端与萌芽组表现相同，第三节关于时序的说法就要修改。第四，“自主行动”的指标须在施测前写定，并由不知晓分组与条件的第三方核实。

另有几条随之而来的判错条款，各自独立，均尚未检验。一，姿态的分离效应：在标准化来访者范式下，把同一条诠释随机分派为封闭陈述句和试探句，预测萌芽组对试探句的“被理解感”更低、“主权感”更高，两周后复述该内容时第一人称的比例更高；若“被理解感”与“主权感”始终同向变动，两者的区分不成立。二，阶段性反转：在困境尚未被本人命名的阶段，共情准确度与后续自主决断能力负相关，已被命名后转为正相关；若全程正相关，罗杰斯的框架就足够。三，不交付理解时更好（限于本章适用范围内的来访者）：帮助者最终不向对方交付一套理解时结果更好，交付越早、损害越大；若交付带来更好的结果，本章应并入比昂的容纳与转化路径。四，上述替身测量若显示被标记时段之后来访者自发命名的概率与对照时段无差异，则不逾即便存在，也不产生本章声称的临床后果，应当退回为一种关于治疗师内心状态的描写，不再算一个临床机制。

不适用与失败的情形。 先划出本章自己的边界。来访者自我功能濒临崩溃、被无法命名的恐惧淹没时，坚定而权威的命名就是容器，此刻谈不逾，是把本章用在了它最不该去的地方。自我结构严重缺损、心理储备耗尽、有自伤自杀风险的来访者，以及正在遭受或实施虐待、亲密关系暴力的情形（罗先生那样的暴怒一旦伴有对妻子的暴力，也属此类），需要结构化的帮助与安全流程，不逾

在这里不是技术选项。主权从未建立、核心请求就是“请理解我”的来访者，早期该给的是稳定而充分的理解。

再看对不逾自身的三条反驳。第一条，它会不会成为懒惰或无能的治疗师的保护伞：一位治疗师因经验不足根本没能形成可交付的理解，事后完全可以说“我不是没懂，我是在践行不逾”。单一时刻的行为上，“我懂了但不说”与“我没有懂”毫无分别，这一点无法反驳。区别只在序列里。一位偶尔选择性使用不逾的治疗师，他在其他时刻展示的理解精度，是这一次声称的信誉基础；督导里还可以追问，那个时刻你在内部形成了什么理解，又凭哪些具体的信号判断来访者正处于主权脆弱状态。说得出这两点，且事后来访者朝自主性增长的方向发展，这个声称才值得认真对待；说不出任何信号，只有“直觉告诉我不该说”，事后来访者因这份沉默而脱落或恶化，更像能力不足的伪装。这个回溯性检验谈不上实验级别的可靠，只是把不逾从无法检验的神秘直觉，挪到了事后可以追问和核对的临床判断上。培训也不能把它当成拿来即用的技巧，若要涉及，大概只能先谈识别什么时刻理解可能成为入侵，再谈不逾，并且诚实地交代，它是一种会反复失败的能力：撤得太早，来访者在那里等，治疗师不伸手；撤得太晚，理解已经递出，才看见对方在面前合上。

第二条，对渴望被理解的人，不逾本身是不是新的伤害。前文已经答过：对主权从未建立的人，它是失当的，对中后期的来访者才是资源。第三条最致命：所有人与人之间的理解都不可避免地包含误读与占用，企图以一个内隐的撤回动作根除这种风险，是对完美关系的幻想，而且可能阻止治疗师去做该做的事，冒险理解，被拒绝时承受那份不适，让来访者体验到“关系可以承受误伤而不断裂”，而这个“冒险与修复”的循环，才是改变发生的地方。这条反驳必须认真对待，本章的回答是撤回理解并不比理解高一级，也不更纯净、更道德：理解是资源，在特定条件下，撤回理解也是资源，各适其时。当来访者急需一个外部容

器承担他无法独自承担的思维工作，坚定的理解是资源；当来访者正在独立完成某个心理操作、任何外部干预都会挤占他即将完成的最后一步，撤回才是资源。本章的最终结论因此不会是“不要理解，用不逾代替”，它是：不要在理解成为惯性的时候，忘了自己还可以选择不逾。这份选择权，不能被标准化地训练出来，它在反复辨认临床张力之中，随着一次次判断失误，慢慢长成一种临床感。

本章没有实验室数据，不逾的全部操作发生在不可观察的认知层面，所以证伪条件只能写成方向和替身：在同盟良好、来访者心智化能力健全、治疗师不处在反移情压力下的对照条件里，被有意悬置了理解的会谈，若与同样条件下及时给出精准共情的会谈相比，并不能更多提升来访者的自主性成长指标和深层改变的维持时间，本章即应被推翻。这个实验在今天不好做。至少它标出了一个方向：本章若错，应当在那个方向上被证明为错，不要在掌声或沉默里被忘掉。

到这里，懂的椅子上的两种情形已经摆出来了：辨识失灵时，两个人落进同一片空地；辨识精准时，准确本身也可能占住来访者的位置。两种情形有一个共同的前提，治疗师手里有东西可以给，给什么，给得对不对，才成为问题。下一章转向第二把椅子，“给”的椅子：各流派都在给，给理解，给接纳，给结构，给一个更好的关系。如果连不给也能被吸收成另一种给，那么治疗师究竟还能怎样不坐上去？

◆

05

第5章

给的椅子：接下来，不坐上去

一个在严厉父亲面前长大的人，进了公司，遇到一位脾气温和的上司。上司从不挑剔，每次看完他的周报都说“很好，辛苦了”。按常理，这个人应该慢慢松下来。可他的周报写得越来越细，格式越来越齐整，星期五的晚上总要再检查两遍，才敢点发送。上司的温和没有拆掉他心里那张评审席，只是让评审席上换了一位更体面的评审，也让他更确信：这个位置上必须有人，我必须让那个人满意。上司越是善意，这套安排越是稳固。多年以后他换了工作，新上司不看周报，他反而坐立不安，到处打听“领导是不是对我有意见”。

这个例子里没有任何一个人做错了什么。上司的温和毫无虚假，他的周报也写得认真。出问题的地方在于，两个人的好意恰好都落在同一把椅子上：一把早就摆在那里的、等人来评判的椅子。本章要讨论的就是这样一把椅子。心理治疗室里的治疗师，几乎总要面对来访者带进来的这类椅子，而各个流派的做法，如果拆到最细处，有一个共同的动作：坐上去，并且坐得比前面的人好。

本章把这把椅子称为给的椅子。它与前两章的懂的椅子、也与下一章的判的椅子相邻，但位置不同。懂的椅子上坐着解释权，谁是那个知道来访者怎么回事的人；判的椅子上坐着方向，谁来说这样对、那样不对；给的椅子上坐着的是功能，来访者向对面发出一个请求，请对方扮演某个角色，对方就去扮演。本章的承重判断可以先说出来：对一类特定的来访者，治疗里起作用的部分，有可能不在治疗师给了什么，而在旧关系里一直有人应声的那个位置，这一回没有人应声；治疗师接下了请求，没有执行它所要求的功能，也没有拿一个新的功能补上

去。本书把这个现象叫作零功能在场。这个名字容易被读成“什么都不做”，下文会一点一点拆开，它要窄得多，也难得多。

◆ 一、所有流派都在给，而且给得很好

先要把话说公道。给是治疗里最古老也最可靠的动作，不能因为本章要讨论它的反面，就把它写成一个错误。在大样本的元分析里，治疗同盟与疗效的相关约为.278（Flückiger et al., 2018），治疗师共情与疗效的相关约为.28（Elliott et al., 2018），两个数字都是正的，也都相当稳定。这些数字说的是平均，说的是绝大多数来访者在绝大多数时候，被好好地给了，于是好了一些。本书要主张的东西落在这个平均之下，落在某一类来访者、某一个阶段、某一个位置的交互里，不触动平均本身。

对多数来访者，给是拆解的第一锤。一个从来没有被好好听过的人，第一次发现自己的话被接住了，那个“我是不重要的”旧剧本会晃一下。这样的人需要先被给足，给到他敢从“必须讨好才能安全”的恐惧里探出头来，之后才谈得上承受别的东西。主流技术面向的主要就是他们，这一类来访者不是本章的对象。

本章的对象是另一类人。他们已经被给撑坏了。这样的人往往认知层发达，对自己的困境讲得头头是道，学会了用治疗的语言谈论自己的情绪，同时在关系层极其熟练地把任何人的回应识别为某种功能的履行。对他们来说，每一口好回应都被一套高度自洽的旧系统转成了证据：治疗师的接纳成了“我表现得足够好”的奖杯，治疗师的解释成了“我又把体验变成了可讨论的文本”。他不是在从治疗里吃东西，他是在咀嚼别人咀嚼过的东西。把这两类人混在一起谈，是关于“给”的争论总也吵不清的原因之一：一方举出大量被给救起来的人，另一方举出少数被给困住的人，两边的证据都对，只是说的不是同一群人。

三种主要的治疗原型在这里可以逐一看。认知行为取向的治疗师，把自己放在“比你更客观的思维教练”的位置上。来访者说“上周的汇报糟透了”，她不去安抚，她问：你注意到谁露出了轻蔑的表情？除了那个表情，他们还有别的反应吗？这个追问拒绝了来访者递过来的审判者剧本，是一个干净的撤。可是接下来，来访者做完行为实验，回来说“他们没有笑我”，治疗师几乎必然会接一句“这个新证据，你怎么看”。旧脚本刚刚失灵，裂缝刚刚张开，一个更好的思考方式就递了进去。裂缝被盖住了，来访者从边缘被轻轻带回“有人教我什么是正确”的熟悉地带。

精神分析取向的分析师，不靠填补推进。他通过移情解释，让来访者看见自己把旧关系的模板投到了他身上。他接住了愤怒，没有报复；接住了讨好，没有利用。到这里为止，旧预测在分析关系里失效了。接着是第二步：这个失效要被命名，“你对我生气，就像你对你父亲那样”。命名在分析传统里是修通的关键，而本章要指出的是，命名之前，有一个短暂的、没有被解释的间隙，来访者独自面对了一个不符合旧规则的现实，没有人告诉他这意味着什么。解释的到来，不管多精准，都是一次给：给一个理解的框架。对于早就学会把一切关系变成可分析文本的人，这套更高级的词汇只会让他的位置更稳。分析于是成了移情最后的避难所。

人本取向最接近“不执行功能”。罗杰斯列出的三个条件，真诚、无条件积极关注、共情理解（Rogers, 1957），都不分析、不建议、不解释，似乎只是陪着把感受走完。但它仍是一种给，给出的是一个不按旧脚本惩罚你、也不推开你的人。来访者说“我觉得自己很糟糕”，回应是“你觉得自己很糟糕”，这个复述在传递：这个感觉可以存在。对过程层长期被压抑的人，被允许拥有感觉本身就是强大的新经验。对另一类人，它还是一场交易，治疗师用接纳换取我

的“如实表达”，他越被鼓励“做你自己”，那个“必须用被认可的方式做自己”的旧脚本就藏得越深。

把三种做法并排放，它们坐的位置各不相同：教练、见证者、不评判的接纳者。可是它们做了同一件事，都替换了来访者生命里原来那个坏位置上的人，把自己变成了更好的版本。治疗的戏剧仍是好人替代坏人。来访者得到了一个新经验，原来世界上有人可以这样对我。问题不在好坏，在“替代”这个结构本身：演员换了，位置还在。旧关系结构是一个功能性的空位，需要一个评判我表现的人，一个决定我值不值得被爱的人，一个我要一直讨好的人。无论谁坐上去，来访者都会对他自动执行同一套攻略。治疗师带着最好的技术坐上去，第一件被完成的事，就是被来访者的系统登记为这个空位的新的合法占用者。此后每一次正确的回应，都在向旧程序汇报：这个人比以前的好。旧程序没有被拆掉，它被优化了。

这一节的判断要保持克制。本书并不说这三种原型的有效性是假象，各自的技术在大量个案里确实做了它们声称做的事。被混在一起的是两种机制：一种是“提供了更好的回应”，另一种是“没有回应旧脚本”。每个流派都同时在做这两件事，训练体系只给前者命了名，后者留在资深从业者“说不上来、但知道它在那里”的沉默知识里。下一节用一个案例，把后者从沉默里请出来。

◆ 二、做对了的地方打滑：一个案例与第四层错配

魏先生，三十五岁，工程师，因社交焦虑前来治疗（说明性合成案例）。接诊时的评估几乎无可挑剔：诊断与认知行为取向的适应症吻合，他自己也愿意合作。头几周，他完美地完成了每一张思维记录表，行为实验照单执行，每周带着填得整整齐齐的表格走进治疗室，一度报告“有效”。从第六周到第十周，出现了一种隐蔽的打滑。他开始用极其完整的自我分析覆盖刚刚冒头的感受；完成作

业本身变成了另一种讨好，而他讨好的对象是治疗师的认可。联合访谈那一次，他的妻子一语中的：他在家里“像个做错了事的小孩”，一遇到冲突，就用道歉加分析绕开，从来没有把任何一点改变带出治疗室。

这里的难处在于，按常见的错配排查逐层检查，找不出毛病。技术匹配没有问题，社交焦虑本来就是这套技术的适应症；过程匹配没有问题，前几周推进得很顺；关系匹配也没有问题，治疗师没有冷淡，没有越界，同盟的评分也好看。三层都对了，改变却锁住了。这种“操作正确但无效”的情形，说明这类排查少了一个层级：它多半只问技术、节奏、关系供给这三件事对不对，没有问第四件事，即治疗师做的每一个动作，在来访者的旧程序里被解码成了哪一种关系动作。

魏先生的旧程序把思维记录表、行为实验、治疗师的进步反馈，统统放进了同一个槽位：有人在评判我。每次提交作业，是一次“我做得对吗”的提问；每句正向反馈，是一次“他认可我了”的证据；每两周一次的会谈，是检查与汇报的循环。认知行为治疗的标准操作，在他那里被翻译成一出古老剧本的新台词：我按你的规则表现了，请给我预期的回应。治疗师给出的一切，哪怕再温和、再不带评判意图，在功能上都完成了这个剧本的一个回合。这个模式有明确的来路。他长在一个对成就期待很高的家庭，父亲的认可总以“你做得对不对”为前提；他在学校用完美的成绩换老师的赏识，在工作里把同一套办法搬到所有权威面前。带着这套程序走进认知行为治疗，是他一生里做得最顺手的一件事。他的高效、他的配合、他的完美记录表，正是三十五年来同一件事的延续，一点也不是阻抗。

本书把这种失效叫作第四层错配：技术、节奏、关系供给都对，失效发生在技术执行被旧程序重新解码为关系功能执行的地方，而且发生在执行得最正确、

最无可挑剔的地方。它是最难诊断的一种，因为它长得像进步。来访者自觉越来越好，记录表越来越漂亮，旧结构的硬度却有增无减。

打滑被看出来以后，治疗师放下了结构化的框架，转入结构较低、更贴近过程层体验的姿态。松动发生在一个很小的时刻。那次会谈里，魏先生做完又一轮自我分析，忽然停下来说：“分析完之后，那个空的感觉反而更大了。”治疗师当时察觉到自己心里升起三个熟悉的冲动。一个是精神分析式的：说“这个空可能跟你早年的匮乏有关”。一个是认知行为式的：说“你能注意到这个空，这本身就是进步”。一个是人本式的：只是把“更大了”复述一遍。三个回应各不相同，却落在同一个功能位置上，都是对她的来访者说一句旧程序认得出的“回应”。

她一句也没有说。她点了点头，说：“是。这本身就很苦。”然后停在那里。没有解释那个空，没有把它重新框成成长的信号，没有鼓励他继续探索。她接住了他的话，确认了那个苦的分量，然后留在空白里。沉默持续了十来秒。这十来秒里她承受着自己的焦虑：他会不会觉得我被击倒了？他会不会把沉默读成漠然？她的身体微微前倾，视线没有离开他的脸，她没有走，只是不准备做任何事。

然后魏先生开口了。他说了一句此前从未说过的话：“我其实一直不确定，你让我做这些，是因为我需要做，还是因为你想看到我做。”这句话的分量在于，他第一次不是以“好病人”的身份问“我做得对吗”，而是以一个在检验这段关系的人的身份问“你到底要我什么”。旧程序在这里没有收到它预期的反馈，完美的自我分析没有被奖励，功能性的提问没有得到功能性的回答，那个没有被填上的缝，把他带到了一个他没到过的地方。此后几周，一连串小事发生了：一次激烈的争吵里，他第一次没有先道歉，而是对妻子说“你这样说，我很难受”；公司会议上，他第一次因为对问题本身好奇而举手，而不是因为举手是

正确的社交行为。后来被问到是什么帮了他，他自己也有些意外地说：“它只是让我第一次觉得，我不用修理，也可以先活着。”

如果按现成的理论去解释，这段经历会被放进同盟深化、移情修通、矫正性情绪体验这些框里。这些解释都漏掉了最细也最要紧的一点：转折发生的那一刻，治疗师并没有给出任何可以被这些概念描述的东西。她没有纠正认知，没有解释移情，没有提供深度共情。她只是在来访者的旧程序发出一个功能请求，即“请在我的自我分析成果上打个钩”的那个精确时刻，接下了这个请求，确认了其中情绪的分量，没有执行被请求的功能。

这里需要把一层再说清楚。认知行为取向的治疗师当然可以共情。如果她说“是。这本身就很苦。你能感觉到这种苦，这很重要”，她就是在共情，这个共情是好的，但它的结构仍是“治疗师认可了你的感受”。对魏先生这样把“好病人”做到极致的人，这句话会立刻被他的表现系统收下：我表达了脆弱，治疗师认可了，我又做对了一次。那句“是。这本身就很苦”之所以裂开了什么，不是因为它比标准共情句式更聪明，而是它在句法上缺了后半截，没有“所以你很好”，没有“这很重要”，于是被接收与被评价这两件在他一生里始终焊在一起的事，当场松开了。

对这个案例有两层保留要交代。其一，一个案例里的十秒沉默，永远可以有别的解释：那个星期他刚好累了，妻子的话刚好起了作用，治疗关系积累到了某个点。本书不宣称这里有因果证明，案例只用来让读者看清所说的是哪一种现象。其二，转折之后发生的事，没有任何一件可以记在治疗师账上。不论是争吵里不先道歉，还是会议上因好奇而举手，都是魏先生自己做的，她事先不知道，事后也无从安排。这一点在后面各章会反复回到：位置空出来以后，发生了什么，不由治疗师决定。

◆ 三、接下，不执行，不补新的

魏先生的案例里，治疗师同时完成了三件互相拉扯的事，本书把这个组合叫作零功能在场。接收：来访者朝她投来旧关系里的那个位置，她没有把它挡在门外，眼神、点头、微微前倾都在说“我听到了”；确认：把对方话里的分量原样放回他面前，一句话，不加解释；不执行：被请求的那个功能，也就是评判、安抚、解释、指引，她不去履行，也不拿另一个更好的功能来顶替。

三者缺一，结果都不同。缺了接收，沉默会被读成“他没听见我”，投射连被识别的资格都没有，这是来访者早就熟悉的被忽略的旧伤。缺了确认，来访者会觉得自己白说了。缺了第三件，便退回到常规的好回应，旧程序又得了一次满分。这三件事的并存，在日常关系里几乎没有先例：日常的逻辑是，收到别人投来的需求，就该做点什么，否则就是冷漠。零功能在场要求落在“做点什么”和“冷漠”之间一条极窄的、几乎没有人走过的地带。冷漠也是旧程序认得的一种回应，它的内容是“我不在乎你”；无回应的另一种常见读法是“他没听见我”，同样是旧程序现成的解码。接收了、确认了、却不执行，这件事旧程序既不能归入冷漠，也不能归入没听见。

为什么非要这个“零”，不能用一个更好的回应来替代？理由在于这类困扰的维持结构有一个奇特的共性：它是一套自我维护的识别系统。一个长期被忽视的孩子长大以后，“我是不被重视的”这个旧结构会主动做几件事：把切实重视他的信号读成客气，把看似冷淡的信号放大成证据（“她没回消息，一定是烦我了”），甚至引出符合自己预测的反应，他用疏远去“测试”朋友，朋友被推开，果然远了，于是他又拿到一批新证据。这套结构绑在自我认同上。承认“我其实一直被重视着”，意味着承认自己用三十年的力气搭起来的整个世界理解是错的，错误的理解还伤过自己和所爱的人，这比“有病”更难承受，因为它触到了自我感的底。所以这套结构必须消化一切回应，不能被反驳，反驳它就是反驳

我本人。无论治疗师给出共情、接纳、温暖还是理解，它都能把这一回应读成：规则又被遵守了，我值得被爱，是因为我此刻符合被爱的条件。

在这个逻辑里，旧程序最需要的燃料，是“有一个人回应我”这件事本身。回应的内容是好是坏，对它是次要的，因为每完成一次“请求，回应”的回合，“这里有一个能回应我的人”这条规则就被自证一次。更好的回应与更坏的回应，是同一个二元系统内部的变异，两者承认同一个规则。只有一种情形不属于这个规则：请求被听到，分量被确认，功能没有被执行。旧程序在这里被启动了，却跑不下去，它第一次没有从一次完整的运行里得到加固。后面可能发生的一切，都从这个“没有加固”开始，本书称它为位置的落空。

这里要把主语问清楚，全书对这个问题的态度在这里第一次表露。原论文把这个空白写成“被主动制造的空”，仿佛治疗师是那个造空的人。本书不这样写，第10章会专门交代这处写法为何改动。魏先生的案例里，治疗师做的事很少，也很窄：她没有填。空是在她没有填的地方出现的，出现与否并不由她决定。她如果在那十几秒里绷着神经等待，身体的紧张会被来访者捕获，读成另一种形式的回应，“他在等我做点什么”，空就没有出现，旧程序又完成了一个回合。这一点后面讲元功能悖论时还要回来，这里先记下：能够写进“治疗师做了什么”的，只是不再填满，而且这一点本身可能失败。

空白出现以后会发生什么，这里需要一段很重要的克制。它不承诺治愈，只承诺拆掉旧程序的自动执行。拆掉以后，来访者被放到一个没有脚本、没有参照、没有惯性应对的新地带。在那里，他可能发现没有旧脚本也能活，这是最有创造力的一刻；他也可能掉进更深的恐慌，因为什么也没有接住他；他可能暴怒，因为眼前这个人看上去就是那个漠然的、见死不救的旧角色；他也可能把沉默读成冷漠拒绝，然后离开。这些结果取决于一个变量：旧程序被停住的那一刻，把“无回应”解码成了什么。对旧结构高度关系化、已经有一点安全基底的

人，“无回应”更可能被体验成“旧程序失灵”，先是困惑，再是好奇，然后从那个空里长出一点新东西。对自我强度较低、创伤史以遗弃为主的人，同样的沉默会被读成“他终于像我父母一样不在乎我了”。所以这个操作没有“安全”的版本，它不像共情，对大多数人几乎无害，对少数人无效；它对一部分人可能有害，必须在这部分人身上被排除。排除的办法在第六节讲。

◆ 四、与最近邻的切割

零功能在场落在一堆现成概念的缝里，越像它的概念，越要把线划硬。若不划，它很容易被读成一个旧词的新名字，那样本章就没有增量。以下按近邻逐一判断，每一条都写成判断对判断。文中凡写到“预测”之处，均尚未检验。

对抱持。温尼科特的抱持（Winnicott，1965）要求治疗师为来访者维持一个安全的情感环境，使其能在其中体验感受而不被侵入。即便把抱持推到最消极的版本，只是克制自己不去侵入，它的操作锚点仍是“环境”这个功能位置：来访者的投射以“这里应该有一个让我安全的人”为期待句式，治疗师接下来，执行它。零功能在场与抱持的分界不在给不给，而在对“环境承担者”这个位置本身的态度。来访者把治疗师投射成一个提供安全环境的人，零功能在场不把自己定义为这个关系里的环境承担者。须赶紧补一句：这不等于治疗室不安全。接收、边界、人类的温度都在，被搁下的只是那一个被点名的功能。

对无条件积极关注。罗杰斯的这一条件是一把利刃，它挑战的是来访者内化的价值条件，“我只有表现好才值得被爱”。可是推到“存在方式”这一最深处，它依然含有一个肯定性的结构：治疗师整个人在向来访者传递一个无条件的“可以”。零功能在场在这个肯定场的中心插入一道分岔：当旧程序发出功能请求，它既不肯定，也不否定，连那个最宽广的、无条件的“可以”也不执行。前者让评判者失效，没有人在评判你了；后者让评判者的位置失效，无论好坏。

对自体客体功能。科胡特的镜映、理想化、孪生（Kohut，1984），核心都是补：来访者早年缺了某种发展性的体验，治疗师现在提供。来访者要镜映，“我做得好吗”，治疗师就执行镜映。零功能在场不镜映，不是不给好评，而是不进入评价功能的任何一个版本，包括积极版。

对比昂的涵容，需要多花些笔墨，因为在极限处它们外观相同。比昂（Bion，1962，1970）描述的涵容是一个循环：分析师接收来访者投射的、无法被思考的原始体验，用自己的心灵把它转化为可思考的经验，再归还。顶尖的实践者把这个循环推到极限，涵容至深时分析师只剩沉默，这沉默本身就是归还，因为来访者体验到一个能承受一切而不崩解的心灵。此时比昂式的沉默与零功能在场的沉默，在外部看去几乎没有差别：都不说话，都不解释，都不退场。

差别在沉默中的内在活动。涵容的沉默里，分析师的心灵在工作，承受、转化、准备归还，即使归还从不以可感知的形式完成。这种“正在工作”的姿态，有可能经由表情、肌肉张力被来访者的身体捕获：他在那里做着某件我看不见的事，那便仍是一次功能的执行，只是执行得极其隐微。零功能在场要求的是把“转化”的意图清空，不试图消化，不试图让投射变得可承受，不试图为它们赋予意义，甚至不做承受这件工作。这不是把回应的冲动压了下去，而是回应根本没有被当作选项摆在那里。如果差别确实存在，下游的结果也该不同：涵容成功，来访者心里多了一个能消化原始体验的内部涵容者，功能从分析师搬进了来访者，这是功能的内化与迁移；零功能在场成功，来访者体验到的是那个功能位置可以是空的，而他没有因此崩解，他的收获不是“我现在能自己涵容了”，而是“不一定非要有人涵容”。前者是功能的转移，后者是位置的解体。

这条分界可以落成两个相反方向的预测。第一种情形：来访者投射的要求是“你必须帮我想通它”，并有多年用自我分析躲开体验的历史。极限形态的涵容预测，沉默促成他内化承受体验的能力，学会自己想通；零功能在场预测，多

次“投射没有被承接”之后，“必须有人帮我想”这个期待本身松动，他不一定需要学会想通才能活。第二种情形：来访者处在严重的自我崩解边缘，急需外部的心灵兜住碎片化的体验。涵容预测，沉默提供“被兜住”，是重建边界的必要脚手架；零功能在场则明确不应被调用，此时撤空有造成二次创伤的高风险，旧程序需要的不是一块空白，而是一个确实可用的功能。第二种情形里两个概念指向相反的做法，这一点是本章不让步的地方。

需要承认的是，第一种情形里两者的区别，在外部观察者眼中仍有一块无法消除的晦暗：沉默就是沉默，录像看不见沉默里的心灵。这一点属于全书的高墙，第8章会正面回到它，这里只把它当作本章判断的一处弱点标出来。

对节制原则。这是精神分析技术规则里最危险的近邻。弗洛伊德早就要求分析师不满足病人在移情中提出的要求（Freud，1915），理由是满足会使移情失去成为分析材料的机会。这条规则的内容，接下投射而不执行它要求的功能，几乎与零功能在场逐字重合。分界在不给的理由和归宿：节制是为了让移情显形、以便被诠释，所以它必然以随后的诠释为归宿，不诠释的节制在古典技术里没有意义；零功能在场以不诠释为条件，一旦治疗师把“你在期待我扮演某个角色”说出口，投射就被重新纳入了一个由治疗师提供的意义框架，位置又被填上了，填的是解释而不是回应。这里有一条相反方向的预测，而且不需要新数据：取两组同样不执行功能的会谈，一组随后给出移情诠释，一组不给。按节制原则，前者更有效；按本章，后者才是被空出的位置。过程研究可以按诠释频次分层，把现成的材料重新分析一遍。

对恰到好处的挫折，也对格式塔的“熟练的挫折”。科胡特认为自体客体适度的不回应，会促成变形性的内化（Kohut，1971，1977）；皮尔斯主张治疗师拒绝提供来访者索取的支持，让他动用自己的资源（Perls，1969）。两者都是有意识的不给，也都给出了剂量学。分界在不给是否以内化为目的：科胡特的挫

折必须适度，因为它的功能是让功能搬进来访者内部，挫折过量则内化失败。本章的撤空没有目的，也不预设正确剂量，它没有要把治疗师的功能转交给来访者，而是让旧对象找不到承载物，来访者与旧结构的关系因此失去支点。成功的标志也因此不同：按科胡特，来访者日后能自我安抚，功能已经内化；按本章，来访者不再需要那个功能被执行，原本唤起需求的情境，唤起的力量本身减弱。随访六个月分别测自我安抚的频次，与情境唤起需求的程度，两个概念会给出不同的曲线。

对拉康的“分析家的欲望”。拉康派的核心操作，是拒绝占据被要求的位置：分析家不回应要求（demande），好让欲望在要求落空的地方显形（Lacan，2006）。这与零功能在场在动作上高度相近，比节制更彻底，因为它连“谁在给”这个位置也不认领。分界在落空之后有没有必然的产物。拉康的操作是目的论的，要求落空是为了让欲望的真理显形，落空之处必有所出；本章不预设任何应当显形的东西，撤空以后那个位置可以什么也不长出来，这被列为一种正常的结局，不算失败。这个差别决定了落空之后治疗师要不要说话：按拉康的路，随后要把落空引向“那你想要的是什么”；本章的判断是，若有效的个案里普遍没有这类引导，而效果仍然出现，拉康的理论就覆盖不了。

对空白屏幕。弗洛伊德要求分析师像一面镜子，只映出被给予的东西，不透露自己（Freud，1912），后世把它固化为一种设置。它是“不提供功能”最古老的形态。分界在恒定设置与定点动作：空白屏幕贯穿全程，治疗师在所有位置上都保持低回应；零功能在场针对的是某一个具体的投射，其余位置照常在场。如果把它做成全局的低回应，本章预测的不是有效，而是遗弃性的重新解码。同一位治疗师在同一个个案中的功能回应密度分布，就是一个可看的指标：有效的个案若表现为单点密度骤降、其余不变，本章成立；若表现为整体偏低，空白屏幕足以解释。

最后是阻抗。精神分析传统会把魏先生这类现象诊断为阻抗：来访者的旧防御以伪装的形式渗进了治疗，阻碍了修通。这个诊断预设治疗的框架没有问题，问题是来访者把防御带进了框架。本章的判断是反过来的：旧程序不是在攻击治疗框架，框架里“好回应”的结构，反而给旧程序提供了寄生的地方。若治疗师持续在那个功能位置上给回应，哪怕是以移情解释的形式，寄生就得到养分；把这种情形诊断为阻抗，治疗师接着用自己的理论去解释来访者的防御，这正是旧程序求之不得的更高阶的好回应，你又给了他一个可以被理解、被讨论的位置。本书并不因此否认对防御的分析在大量个案里是修通的关键步骤，只是主张，对旧程序已经高度关系化、高度认知化的那一小类来访者，阻抗分析本身就是一次给，而且给的恰好是他用来躲开那个唯一可能松动他的瞬间的东西。

◆ 五、撤也会被吸收：元功能悖论与沉积性共在

前几节写下来的东西，有一个绕不开的漏洞，必须由本章自己先捅破。如果治疗师有意识地维持一个“能被投射、自身却不执行功能”的空位，这件事不就是在执行一项名为“撤空”的精密功能吗？对来访者的旧系统而言，这是一种负性功能，但负性的功能仍然是功能。来访者一旦察觉到规律，“每次我问这个，他就不答”，他完全可以把撤空本身重新识别为一个更高阶的旧程序变体：治疗师在用沉默操作我。旧程序没有被废止，只是被复制到了更高一层的位置上。更糟的情形也不难设想：来访者学会了在沉默里表现得更痛苦，指望换来治疗师更多的“认可式沉默”，空白于是成了新的表演舞台。

本书不试图用一个补丁把这个悖论消掉。它的存在恰好说明，零功能在场只能是一个理想的极限，没有任何一次具体的沉默可以保证达到它。每一次成功的撤空都带着被重新吸收的种子，每一次识别出这种吸收，都要求更高一阶的应对，这是一架走不到头的梯子。能够设想的二阶情形，只能是描述性的：当治疗师察觉来访者已经把“不回应”当作可操纵的规律，她可能打破沉默，把两个人

正在做的这件事本身放到两人中间，“我注意到你问我那个问题，我没有回答，你好像在等我继续不回答，我们之间现在在发生什么”。这句话既不执行旧功能，也不继续撤空，它把棋盘上正在下的棋摆出来，邀请对方一起看。这等于是撤空撤到了自己头上：治疗师从“给空白的人”这个台座上下来。可是一个足够顽固的旧程序，可以把“邀请共同观看”也译解成一个可执行的新程序。梯子没有顶。

这个悖论决定了本章与全书其他部分的一种关系。第3章讲的是治疗师把“懂的人”的位置放下，本章讲的是把“功能执行者”的位置放下，两者各自都会遇到“放下本身变成新的位置”的问题。第11章将专门处理这件事：当“撤”可以被教、被练、被写进督导清单，它就成了一把新的椅子。在那里，本章的判断会受到最严厉的审查。

悖论的存在还带来一个直接的后果：零功能在场不能当作技术来教。技术意味着可以被意图直接启动，而它的成败恰恰取决于启动者有没有在心里等着看效果。能够教的，至多是它得以发生的条件，以及它什么时候不该被调用。本书的体例也是照此处理的，不列步骤，只写事后可以记录的现象，下文第七节给出读数。

沉积性共在是与零功能在场相邻的另一个概念，出自同一作者的另一项研究，它从另一个方向碰到了同一堵墙。它的起点是人本取向，要问的是一个比“非指导”是否变质更深的问题：假如非指导被运用得无可挑剔，它为什么在某一类痛苦面前仍然擦肩而过？批评人本疗法的人，通常指向它的变质，马森（Masson，1988）认为付费、权力不对等的结构本身就让“平等”成了修辞，施密德（Schmid，2000）看到三个核心条件在培训和认证的过程中沉降为一份可评估的技术清单。这两脉批评战壕相反，却都在批评“非指导”这个动作的不纯。它往更下面打了一口井：即使它是纯的，治疗关系本身也是从“我来帮

你”这四个字立起来的。弗洛伊德要帮来访者把无意识变成意识，贝克要帮来访者纠正认知扭曲，罗杰斯要帮来访者重新接触机体智慧，帮的方式相去甚远，“帮”这个动作，是整个行业的出厂设置。

穆女士四十出头，在一家文化机构做中层，没有失业，没有离婚，没有严重的躯体疾病，前几次会谈里治疗师也已核对过，她没有自伤的念头。她第一次会谈说的话是：“每天早上醒来，都觉得没有什么值得起床的事。不是累，也不是睡不好，只是做这些事的人，好像早就退场了。”接下来的几个月，治疗师像任何受过扎实训练的人本取向者那样工作。穆女士敏感，语言能力强，能准确指出哪一次共情打中了她，哪一次漏掉了。每次结束她都会说一句熨帖的“谢谢，今天很有收获”，治疗师越来越听出里面一种熟练的、像结束一场得体的工作会议的礼貌。她已经在这间屋子里找到了一个位置，一个聪明、善于自我分析的来访者的位置，而且坐得毫不费力。治疗师每一次觉得快要碰到什么，那件东西就像水从指缝里流走。

转折发生在一个她们谁也没有预先安排的晚上。穆女士照常谈这一周的另一个类似处境，边讲边自己分析，语调平稳，逻辑自洽。治疗师试了几次回应，每一个都落在她事先铺好的一张海绵垫上，不反弹，也不消失，被无声地吸收了。治疗师发觉自己胸闷，像在没有阻力的空气里挥拳。她张口，又闭上。这一次的沉默与以往不同，以前的某些沉默里，其实挂着一个隐微的期待，期待穆女士会因为没人说话而触到什么；这一回，她确实不知道往哪里走了。那个撑着她做了几个月治疗师的东西，“我必须帮她，必须把这场对话带到某个有价值的终点”，在那个瞬间像断了电。穆女士抬起头，眼神里有困惑，不焦虑。治疗师说了一句不是事先排练、也不是从任何理论里来的话：“我这会儿不说话，不是在想怎么回应你。我好像一直在用力帮你，那个力总打不到你要的地方，我也不知道怎么打了。所以就这么坐着，你继续讲。”

穆女士看着自己的手，沉默了一会儿，开始讲一件此前从未提起的事。不是重大创伤，不是压抑的童年，是她周末在家洗了一条旧围巾。她把围巾铺平晾干的时候，发现它已经磨得很薄，有几处线松了。她站在那里看了一会儿，忽然觉得："我好像还活着。我也不知道为什么是洗围巾的时候。"她的语气和以往讲任何事都不一样。不是更有情绪，而是少了那种"我在对你叙述"的自觉，她好像忘了有人在听。此后她又几次滑回倦怠的、事不关己的叙述方式，治疗师也又几次笨拙地试图"做点什么"。那一晚没有治愈任何东西。

这个片段值得做的读法，是看那个"不说话"由什么引起。它不是治疗师选择的一项姿态。沉积性共在被定义为：治疗师不再以"解决问题"的意图在场，也不要求此刻的对话产生疗效；它不能由意图直接启动，只能在治疗师遭遇了帮助姿态的结构性失效、被迫允许自己搁置帮助意图之后，作为在场质地的转移出现。"沉积"二字取自地质学的意象，沉积岩不是被堆砌的，是物质在时间里一层一层静静落下、密实起来。这个说法与前面对主语的交代一致：治疗师没有"撤"出什么，是撑着她的那根弦断了，处境替她空出了位置。从这个角度看，穆女士的旧世界之所以一时没能解析治疗师，是因为治疗师那一刻不再是一个以用途为底色的在场者，而这不是因为她更高明，只是因为她那根必须证明自己有用的弦，在那几分钟里恰好断了。

这个概念与零功能在场并不重合。零功能在场针对的是一个具体的功能请求：魏先生递出"请打钩"，治疗师接下了，没有执行。沉积性共在发生的地方没有这样的请求，穆女士什么也没有请求，墙立在整个关系的出厂设置上：她在治疗师的所有姿态里嗅到了"用途"的气味，每一句共情都被收进一个无声的括号，括号的标题是"我在做我的工作，我的工作是帮你"。她的旧结构里有一条根深蒂固的认识：所有指向我的关注，都捆着某种用途，成绩、品行、情感供给、绩效、服从。治疗师越真诚越精准，这条认识被验证得越彻底，"连声称无

条件接纳我的人，也不过是在履行职责”。因此两个概念在同一个意义上汇合：旧结构要的是一个有用的人，而这一回，对面的位置上没有人在履行用途。它们又在两个层面上分开：一个撤的是对一个具体请求的回应，一个撤的是整段关系的目的。

沉积性共在需要同它的近邻切开，才站得住。与治疗性在场（Geller & Greenberg, 2012）：后者同样强调“不为了做什么而在那里”，同样反对技术化，同样可溯源到罗杰斯，但它的量表以疗效为效标，在场之所以有价值，是因为它带来更好的结果；沉积性共在的构成条件是从疗效意图里撤出，治疗师心里只要保留一句“这样做他会好起来”，所说的形态就没有发生。这是可裁决的：在存在性失重（像穆女士那样，日子没有坏，只是没有了分量）的个案中同时施测在场量表和“意图悬置”自评，二者若显著正相关，沉积性共在只是治疗性在场的一个子集。与治疗联盟（Bordin, 1979）：联盟之所以是好的联盟，是因为它促成疗效，是工具性的；一个联盟可以很强，而治疗师心里一次也没有离开过“帮”，而沉积性共在甚至可以出现在一场没有任何目标的短暂接触中。与无知立场（Anderson & Goolishian, 1992）：它悬置专家知识，是为了给替代的故事留出空间，动力来自对新意义生成的投入，仍站在帮助的地基上，只是把帮助改写成了“生成新意义”；沉积性共在的特异处，是连“新意义必须被生成”这个期待也一并搁下。与亚隆的旅行同伴（Yalom, 2002）：两个人仍然共享一个方向，朝着更好；这里不需要方向，两个人可以各自停在自己的雾里，恰好坐进了同一间屋子。与温尼科特和比昂的消极姿态：它们都由一整套理论驱动，沉默是为了让更深的东西发生。与布伯的“我与你”（Buber, 1923）：后者是人类存在的普遍结构，可以发生在恋人、师生，乃至街头对视的两个陌生人之间，沉积性共在则是一个有起止、有失效边界、可以在录音里定位的临床时段，一个会失效的东西不是范畴，是形态。

还有一个与罗杰斯本人有关的限定。罗杰斯晚年有一段自述（Rogers, 1977），本书见到的只是二手转述，未能逐字核对原书，因此只取大意：他越来越不愿意担任“帮助者”，因为这个词似乎总在暗中重复一个他一生都想打破的叙事，一个人是有能力的，另一个人是需要被扶助的。本书不把它当作罗杰斯已经走到了这个位置的证据，他晚年转向群体对话与冲突调解，完全也可以读成“帮助”在更大尺度上的延续。这段自述的价值恰在于它含混：罗杰斯碰到了一道他自己也未必消化完的裂缝，本章是沿着这道裂缝往下掘，没有宣称他已经站在底下。

◆ 六、不该用的地方，以及失败的样子

先写三条前提，它们不是可有可无的伦理附注。第一，知情：治疗开始时，来访者就应当知道治疗师不保证每次都满足他对回应的期待，也知道这些时刻可以被讨论、被质疑、被拒绝，这是进入之前先留下的一条退路。第二，次序：在没有充分提供过好的回应之前，谈不上空出，支持性的基础要先建立，只有好的回应已经被旧程序消化成燃料时，这个问题才出现。第三，督导：每一次这样的不回应都要在督导和同行面前如实讲出来，成功和失败的都讲，否则“零功能在场”很容易变成治疗师掩盖自己无力的名目。治疗师心里若是“我不知道接下来怎么办”，那就是无力，应当承认无力，不该用这个名字盖住它。来访者说“请不要这样”的时候，这件事就停止了。

一个新概念值多少，要看它能不能说清自己什么时候不该出场。本章的判断带着三道明确的界线，每一道都出自它自己的逻辑，不是附加的免责声明。

第一道界线由一个失败的片段划出。温女士，三十二岁，长期抑郁，旧程序的核心是“只要我表现出需要，别人就会嫌我麻烦，然后离开”。治疗进行到第十次，她用很小的声音说：“我最近一直睡不好，但我怕跟你说这些，你会觉得

我没进步。”治疗师在这一刻认出了一个功能请求，“请你确认你不会因为我没进步而失望”，并且做了前面描述的那一套：身体微微前倾，复述一句“你怕说这些会让我失望”，然后停住。沉默持续了大约十五秒。温女士在这十五秒里急速地坏了下去。她后来在回顾这次会谈的反馈里写道：“你沉默了，我就知道我果然太麻烦了，你不想理我了。”

这十五秒没有留出任何松动，它造成了一次创伤的重演；对长期抑郁的来访者，这样的重演还可能抬高风险，不是可以事后一笑带过的小失误。失败的原因不在技术执行，接收、确认、停住，每一步都做到了。原因在于这个位置不该被空出来。温女士旧程序的解码锚点是被遗弃：在她的生命史里，沉默一直被读成放弃，说完话没人回应一直是拒绝的开始。同样的沉默，对魏先生是旧程序失灵，对她是旧程序最熟悉、最害怕的那份证据，那个人接住了我的需求，然后什么也没做，他和他们一样要走了。同一个动作，因旧程序的解码不同，一个是裂缝，一个是创伤。所以本章从头就说，零功能在场不是一种通用的技术，也不是一种安全的技术：对解码锚点是“关系中的功能执行”的人，它可能是松动；对解码锚点是“被遗弃”的人，它是危险。

这个片段之后发生的事也要写出来。治疗师为那次沉默向温女士道了歉，解释了自己当时的内在过程，邀请她一起理解那一刻对她意味着什么。几个月里，治疗缓慢地重新推进，治疗师再也没有对她调用过这种做法。后来一次会谈里，温女士因为那次沉默对治疗师发了火，治疗师没有辩解，接受了指责。温女士说了一句话：“那次之后，我好像没那么怕你也会走了。”这个转折不能记在零功能在场名下。它是承认错误、不辩解这件朴素的给的工作的结果。温女士需要的不是空，是给：给足，给够，给到她相信为止。至于有一天她是否还要面对那块空，那是以后的临床判断，不是此刻的。

第二道界线来自沉积性共在，与前一道同向，但指向更硬的情形。急性自杀风险、物质戒断期、即时的家庭暴力，这些场合里治疗师的第一责任是安全，而不是悬置帮助的意图。此时任何“不干预”，任何对疗效关切的搁置，都是在来访者坠落的过程中把沉默误认成深度。自我结构严重缺损的人，在情绪风暴里失去对自身连续性的感觉，此刻他需要的恰恰是一个稳定的、有边界的、能提供清晰结构的专业身份在场：明确告诉他“下次你感到要伤害自己，先打这个电话”，耐心帮他把身体里那团说不清的灼烧命名为屈辱，再区分屈辱和饥饿在胃里的不同。在这些场合里，“不帮”不是临床智慧，是逃避责任。本书的适用范围声明因此写得很死：这里讨论的位置，只涉及来访者尚未亲自命名、亲自发起的那些地方；危机、自我结构缺损、心理储备耗尽的情形，不在其内，那里需要结构化的帮助和安全流程。

第三道界线是依赖。有一类来访者对“被看见”本身形成了依赖，每周来把一周的痛苦细细叙述一遍，享受五十分钟被全然关注的温暖，然后回到生活里，什么也不改变。对他，治疗室成了一个无限量供应共情的取暖器。在这类个案里，治疗师不推进、不挑战的在场，恰好被他的防御系统收编为一个新的零件，他可以继续不动，因为连治疗师都“只是在这里”，没有人要求他动。此时沉积性共在不是治疗，是共谋。这是对本章判断的一个必要的收窄：一个“不坐上去”的治疗师，有可能只是又一个在场的观众。在这类个案里，“我在这里”若不带上另一半，即“我在这里，但我不会陪你一起假装这不是一个问题”，就只剩陪衬。这与前面所有的内容并不矛盾，它说的是，什么时候不该用，本身是使用这个判断的一部分。

另有一种失败不来自来访者，来自治疗师。治疗师心里如果有一个很轻的声音在说“我不知道接下来该怎么办”，那一刻的沉默便不是撤空，是无力。零功能在场的名字不能被拿去掩护这种无力。两者的区别，是前者的沉默被接收和确

认前置，被持续的注意包着，留在那里的人不离开，他和来访者一起待在那个空位旁边，承受空位带来的不确定；后者的沉默里没有人在。冷漠则是另一种东西，它没有接收，没有确认，也没有注意，在场的只有一个躯体。这三种沉默在录像里很难分，这仍属于第8章要面对的高墙。来访者的权利也要写明：如果来访者在某次具体的沉默里明确说“请不要这样”“我需要你说话”，那件事就应当停下，而且不应当再加一句“你看，这正是你的旧程序在起作用”。来访者说“不”的时候，任何理论的正确都排在后面。

本章与第3章之间还留着一个判据，需要在这里钉上。第3章讲的共同进场，要求治疗师自觉地、并让来访者看见地放下解释权；本章讲的零功能，撤走的是关系功能位。设想一位治疗师因病缺席，或因语言不通而无法回应：旧对象同样落空，没有承载物，所以零功能这一半的条件成立；而共同进场的条件不成立，因为没有任何人在自觉地放下什么。这个设想同时暴露了本章的一个未决之处。缺席只满足了“不执行”，没有“接收”，也没有“确认”，而本章把这两件事当作零功能在场的必要部分，缺了它们，来访者体验到的是被忽略的旧伤。所以缺席的情形，至多是零功能的一半成立；这一半有没有独立的效力，本书没有数据，只把它当作两章分工线的判据，不当作疗效的主张。

◆ 七、读数、判错条款与交接

本章的判断不开处方，所以也不列步骤。能写下来的，只是事后可以记录、可以由旁人核对的现象，这里一律称为读数；它不告诉任何人该做什么，只告诉读者，在翻看一段治疗的记录时，可以去找什么。

本章读数：在一次功能请求的精确时刻之后，随后几次会谈里，来访者是否出现了以下两类现象中的任何一种，并且由第三方（比如家人、同事，或治疗以外的记录）独立核实。第一类，来访者不再朝治疗师索取同一类功能回应，同时

向关系本身发起了一次检验，魏先生那句“你到底要我什么”就是一个例子；第二类，来访者在治疗以外做出了一件治疗师事先不知情、事后无法布置的小行动，魏先生不先道歉、因好奇而举手之类。读数的要点是“没有被预告”。如果一件行动在会谈里被反复演练、被治疗师称赞、被写进作业，它就不能算读数，因为那恰是旧程序最熟悉的燃料。此外还要同时记录三种看上去相似、实际不是读数的现象：来访者变得更痛苦，来访者学会了在沉默里表现，来访者离开了治疗。这三种现象都可能出现在撤空以后，它们本身不证明本章对，也不证明本章错，只提示这个位置有没有被正确地读出。

本章判错条款，共三条，均尚未检验。第一条，是主条款：在安全基底已经建立、旧程序以关系功能的执行为锚点的来访者身上，如果治疗师在功能请求的精确时刻系统性地以合宜的回应填补那个位置，其长期人际功能的改善不低于“撤空不填”的做法，本章对这类来访者的判断撤回。第二条，针对与节制原则的分界：把撤空后的会谈按“随后是否给出移情诠释”二分，若给出诠释的一组效果不低于不给的一组，说明“不诠释”这个条件多余，节制原则足以覆盖本章。第三条，针对“定点”这一主张：本章认为撤的必须是旧结构正在投射的那一个功能位，若把撤空的点位随机化，随机撤与定点撤的效果没有差异，本章关于“定点”的全部主张作废，退回空白屏幕即可解释一切。三条之外，还有一条属于沉积性共在的：在存在性失重的个案里，若悬置帮助意图的会谈，与同等时长、同等联盟强度却保持帮助意图的会谈相比，来访者在随后五到六周里自主发起的重组性行为没有差别，沉积性共在的主张退回到一种关于治疗姿态的文学描述。

与前面各章的承接，以及这章与全书母题的一个距离，也值得写明。上述预测都以一个窄的前提为条件：安全基底已立，旧程序以关系功能执行为锚点。在这个前提之外，本章不对任何人作主张，更不触动同盟、共情与疗效之间那两个

稳固的正相关。此外还可以设想一条回顾性的预测：长期人际功能的改善，对那些事后把治疗师“不说话的瞬间”评为转折点的来访者，应优于把共情时刻评为转折点的来访者。这一条的难处在于，“不说话”要作为独立变量被提取，而不被归入“分析师的节制”这类笼统的名目，现有的研究几乎没有这样做。它同样尚未检验。Barber 与 Muenz（1996）在抑郁症协作研究的重新分析中发现，回避型来访者在认知治疗里优于人际治疗，强迫型相反，这种反转说明匹配确实存在，但它并不是对本章主张的验证，只是说明在平均之下，交互是可能存在的。

交接给下一章的，是一个本章没有能力回答的问题。零功能在场撤走的，是治疗师身上的功能。可是到目前为止，治疗室里还有一个更不易觉察的动作，一直在悄悄进行：治疗师在每一个回合里，都在评判这个回合该怎么走，哪个反应是好的，哪个应当被鼓励，哪个应当被放过。这是判的椅子。接纳铺好之后，是谁在推动？接下去的一章，要把这把椅子，连同“逼”这个动词的主语，一并摆到桌面上。

◆

06

第6章

判的椅子：接纳铺好之后

（说明性合成案例）葛先生四十七岁，在一家设备公司做售后，情绪低落已有好几年。他来见治疗师叶宁，到这一天是第二十六周。每一次谈的内容大同小异：妻子这周又是怎样不接他的话，部门的月报又是怎样没有人看，夜里他又是怎样在三点醒来再也睡不着。他的用词几乎固定，连停顿的位置都相近。叶宁的工作无可挑剔，她听得准，回应得稳，葛先生的肩膀会在五十分钟里一点点松下来，走的时候常说一句“说出来好受多了”。下一周，他带着几乎相同的材料回来。

两个人对这段治疗都满意。葛先生从不缺席，叶宁的督导也认为同盟良好，没有任何一项常规指标亮灯。唯一没有动的，是葛先生的生活。第二十七周，他又一次开始讲月报的事，是第四遍，措辞与前三遍相差无几。叶宁没有像往常那样用一句复述去接住他。她只是坐着，没有去填那个他等着被填的空处。沉默拉得比平时长，葛先生停下来，看着她，过了十几秒问：“你怎么不说话？”叶宁答得很慢，大意是：这些日子她一直在听，却从来没有问过一件事，他来这里，是希望她帮他从里面走出去，还是希望她陪他留在里面。

葛先生先是愣住，然后哭了。他说，他怕自己好了就没有理由再来了，这个世界上认真听他说话的人只有这一间屋子里的这一位。过了很久，他换了一种与以往不同的声音说，这半年他一直等着她告诉他该怎么办，有时候甚至恨她什么都不说，但刚才他忽然明白了：她不是不知道，她是不愿意替他办。此后的几个月里，葛先生做了几件他前半生没有做过的事。他没有离婚，也没有辞职；他在

不去猜妻子会怎样反应的前提下，对她讲了自己为什么一回到家就不说话，又去找主管，把自己对一个项目的看法讲了出来，并且做好了被驳回的准备。

这个故事通常被讲成一个沉默的胜利。本章要把它拆开来看，因为它在三个地方并不干净。第一，叶宁那句问话本身算不算一次裁决？它把一个模式指给了葛先生，哪怕是以问句的形式。第二，半年的接纳没有让葛先生动，是什么让他在第二十七周之后动了？如果答案是叶宁的沉默，那么沉默就成了一项技术，而她成了那个设计转折的人；本书从第3章起一路都在追问的，恰恰是这个位置。第三，葛先生说“你不是不知道，你是不愿意替我办”，这是一次理解，还是又一次把裁决权交给了别人，只不过这次交的是对叶宁品格的裁决？这三个疑点不会在本章结束时被消去，但本章的判断站在它们上面：接纳铺好之后，进一步的变化取决于一个位置是否空出，而这个位置上坐着的，是下判断的人。

◆ 一、接纳铺好之后，谁在推动

罗杰斯（Rogers，1957）给出的六项条件，把心理治疗的重心从“治疗师知道什么”移到了“治疗师如何在场”，真诚、无条件的积极关注和共情理解是其中最广为人知的三项。他的表述有一个很强的形式：条件具备，改变便会发生，条件不具备，改变便不会发生。这个形式在后来的讨论里被不断软化，因为临床上的反例太多。葛先生就是一个反例：条件被稳定地提供了半年，他也确实感到被接纳，变化却迟迟不来。本书并不据此认为这些条件无用。第4章已经写明，同盟与共情同疗效之间的平均相关为正，前者约为r=.278（Flückiger et al., 2018），后者约为r=.28（Elliott et al., 2018），这个平均的正向关系是整个领域最稳的发现之一。本章的主张落在这个平均之下的一个具体位置上：条件说回答了舞台如何铺设，没有回答舞台上发生的事由什么推动。

对这个空缺，已有的解释大致有三类。一类是把动力交还给来访者自身的实现倾向。罗杰斯晚年在《存在之道》（Rogers，1980）里谈到一种超出条件提供的“临在”，但他没有把这个概念定义到可以检验的程度，它停在条件说的边缘。把推动力归给实现倾向，等于把问题换了一个名字再问一遍：为什么同一个倾向在葛先生身上沉睡了半年，又在某一周醒来？

第二类解释来自同盟研究。同盟与疗效共存，这没有疑问，但共存不等于机制。同盟与疗效之间的因果方向仍有争论，早期症状的改善也可能抬高来访者给同盟打的分。这个争论本书不作裁定，因为本章不需要它。葛先生的案例里，同盟分数在半年中一直是高的，症状基本没动，这至少说明高同盟不足以单独解释后来发生的事。同盟描述的是攀登者在岩壁上留下的痕迹，没有描述每一步的发力。

第三类解释是势能论，它指出治疗师悬置自我是一项高耗能的动作，依赖契约、角色、空间与制度所提供的势能才得以维持，撤去这些供给，对话便沿着一条可追踪的斜坡滑回社交礼仪。这一类解释同本章最近，也最能说明为什么同样的姿态在咨询室里站得住、在会议室里站不住。但它自觉地只回答舞台的供电，没有回答台上的戏。本章接着它往下问：舞台通电之后，如果葛先生的变化需要一个位置空出来，那么这个位置是什么，它由谁空出，空出以后又是什么在起作用。

本章的承重判断是：来访者长期把某类判断交给外部，其中包括“我该往哪边走”“我这样想对不对”“我究竟是什么样的人”。治疗师所在的位置，凭借角色、收费、头衔和专业的声誉，天然带着成为这类判断来源的资格。接纳铺好之后，这把椅子仍在，来访者仍会习惯性地朝它转过去。变化需要的条件是这把椅子被看见是空的，而且是来访者自己觉得它空了。到了那个时刻，推动变化的是什么？不是治疗师的某个动作，也不是来访者的某种决心。是一个没有出口的

处境：外面再无人可问，里面那个一直被问题遮着的问题露了出来。后文把这样的处境称为逼临态。“逼”的主语是处境，不是治疗师。治疗师在这里能做的只有一件事，就是不去坐那把椅子，而这件事本身会失败，也无法由治疗师自己确认是否做到，这一点在第二节和第四节展开。

这里还有一层区别要先立住。本书前几章讨论的两把椅子，懂的椅子和给的椅子，被占住的方式都带着温度：一个人太懂你，或者一个人给了你想要的。判的椅子被占住的方式更不起眼，因为它往往披着中立的外衣。一句“你觉得这样做合适吗”，一个微微点头，一次“你已经很努力了”，都含着一点方向和一点评分。许多治疗师终其职业生涯都不觉得自己在判，因为他们没有给过建议。本章要说的是，判不需要建议这种形式。只要来访者知道面前这个人手里有尺子，他就会一边说话一边对着那把尺子量自己。

◆ 二、裁决，以及撤离和克制的差别

“裁决”在本章有一个收窄的含义：任何向来访者传递“往这个方向去想、去感受、去做”的评判性符号输出，不论载体是建议、评价、解释、追问，还是藏在“我理解你是这样的”里的那一点确认。它不包括单纯的接收，也就是“我在听，我收到了你现在的样子”这一类不带方向的回应。这条界线在临床上比看上去窄得多。“听起来这周很难”是接收。“听起来你其实是想被看见”就已经带着一个方向：它替来访者说出了他的愿望，并暗示这是一个值得有的愿望。许多自认为在共情的话，在这一点上越了线，来访者往往听得出来，他会顺着那个方向走几步，或者顺着它反抗，两者都是对一把尺子的反应。

裁决有两种来路，需要分开。内容裁决是治疗师说出口的东西：建议、评价、解释，也包括“你应该学会独自面对”这类看上去最开明的指令。位置裁决不靠说话产生，它来自治疗师所占的位置本身。一个收费的、受过训练的、被推

荐而来的人坐在对面，来访者进门时就带着一个预期：这个人能帮我，因此他大概知道我该怎么办。这个预期不需要治疗师开口就在运转，治疗师沉默时，来访者会替他把话补完。内容裁决可以靠自制减少，位置裁决不行，因为它的发生不经过治疗师的意愿。

由此可以看清克制与撤离的区别，这也是原论文里最好的一个比喻。设想一位交警站在路口。克制是他看见有人闯红灯，强忍着没有开罚单；撤离是他根本没有站在岗亭里，没穿制服，也没有警徽，只是一个路过的人，没有人会指望他执法。克制耗力，因为要压住一个已经启动的程序，五十分钟里不断憋回建议的人，想来会在走出咨询室时感到疲惫，这一点同样只是推测。撤离据说省力，因为那个程序没有被触发。这个能耗上的差别，本书把它当作一个尚未检验的推断，记在这里，不当作结论。

不过比喻有一个陷阱，必须当场指出。交警脱了制服，路人看得见；治疗师“不在岗亭里”，只有来访者能判断。治疗师内心清楚地认为自己已经从裁决的位置上退下来，对来访者是否这样觉得没有任何约束力。来访者的社会性大脑对一个被付费聘请的、有资质的人，首先会把对方的每句话当作可能的裁决信号来处理，这种处理不会被一句“你在这里是安全的”改变。所以撤离不是治疗师可以单方面宣布完成的动作。它更像一个事后才知道是否发生过的事实，只能由来访者那一侧的读数来佐证：他是否不再追问“那你觉得呢”，是否在被问到自己的想法时不再先看对方的脸色。

回到葛先生。前半年里，叶宁从未给过一句建议，她的接纳无可指摘，但葛先生一直把她安放在“最终会帮我的那个人”的位置上，他每一次诉说都是在向这个位置汇报，等待它在某个时候给出方向。这并不是叶宁失职。位置裁决由角色携带，叶宁在前半年没有，也无法，改变这一点。第二十七周发生的事，应当这样读：叶宁没有接他的话，葛先生第一次在她的沉默面前遇到了一个没有回应

的空处。这个空处不是到那一周才出现的，它在前面二十六周里一直潜在着，每一次她选择接住话头的时候，空处就被填上了。她那一周没有填。就这么多。

那句问话，则需要诚实地对待。“您是希望我帮您走出来，还是陪您留在里面”，按本章自己的定义，它有方向：它把葛先生的处境压缩成两个选项，而且暗示后一个选项值得怀疑。它是一次小幅度的占位，只不过占得很轻，形式也很温和。本书的读法是，把这一问记为这一次会谈中占据判的椅子的一次，哪怕它之后的结果很好。结果好不能洗去这一笔，因为我们不知道，如果叶宁只是继续沉默，葛先生是否会在稍晚一些时候自己说出那段话。案例能说明的只有一件事：在一个长期被稳妥接纳的场里，一次没有被填上的沉默，同一个轻微越位的问句，先后出现，之后发生了变化。两者各占多少，案例分不开。

这也是“撤离”一词用得小心的原因。本书保留这个词，因为它准确地指向一件事：位置被空出，而不是冲动被压住。但它不描述一个高明的动作，更不描述一项可以交给治疗师去“实施”的技术。从治疗师那边说得出的，只是他没有再去回应那个位置所召唤的功能；至于位置是否真的空了，要看来访者的读数，而这一点同本书第8章对治疗师处境的判断完全一致：治疗师没有一个可以站上去俯瞰全局的高处，他连自己是否撤了，都是被另一个人的反应告知的。

◆ 三、悬置、逼临态与涌现

撤离之后发生的事，原论文划分为三个相继的阶段。这里用“悬置”称治疗师不再回应裁决位置所召唤的功能的状态，它与现象学意义上的悬搁不是一回事，后者是研究者对自然态度的一种方法性中止，前者说的是关系里的一个位置。紧接着的是逼临态，最后是涌现。三个阶段的次序可以用来梳理现象，不是一份路线图，更不是一份可以照着做的流程；下面每一步里“发生”的主体，都不是治疗师。

葛先生进入治疗室时，带着一个从未被说出口的预期：我暴露了难处，对方会给我一个方向。这个预期不是认知错误，是他三十多年社会学习的沉积物。父母说你该这样，老师说你该往这边想，主管说这个方案不行换一个。每一次他向更有权威的人暴露困难，对方都回报以某种方向，他的任务是执行它，解释它，或者同它争论，而无须直接面对暴露出来的那个难处本身。预期违背理论（Burgoon，1993）为这种预期没有被满足之后发生的事提供了一个大致的轮廓，本书只在一般意义上借用这个词，指高度预期的回应没有出现时认知系统先后经历的几个动作。

第一个动作是外归因。他对自己说，她今天大概累了，或者她在想怎样帮我，或者她没有听懂。第二个动作是加倍发信号。他开始更直接地索要：“那你觉得我该怎么办？”“你直接说吧。”“你什么意见都没有，我来这里干什么？”这两个动作在葛先生身上也都出现过。第三个动作发生在这些努力一再落空之后：外归因撑不住了。那个空处不再可以被解释为偶然，来访者被迫承认，这个人不是没想好，而是始终不会在这个位置上回答。系统进入一个暂时的失稳期，旧的预期模式用不了，新的还没有形成。

到这一步，处境的结构变了。葛先生一直在把“我为什么没有变好”这个问题外包给别人，外包的渠道一条条被证明不通。剩下的只有他自己面对的方式：这个问题始终属于他，他一直在绕着它走，靠的是等待别人来替他回答。本书称这个状态为逼临态。要注意这个命名里的力量方向。逼临不是有谁把他推到了墙角，而是原先用来绕过墙的那套导航失效了，他第一次不得不用手去摸墙的纹理和厚度。被逼近的东西，也不是他每周抱怨的那些具体事端，妻子的冷淡和工作的无意义，而是他处理这些事端的方式，用等待替代了亲自面对。

至于他摸到了什么，原论文写得很干脆：他发现妻子的冷漠，部分是他半年来把自己锁在抑郁里、拒绝任何亲近的后果；他发现工作的“无意义”，部分是

为自己的退缩提供的辩护。这个说法本章不采纳为一般规律，也不替它背书。它只是葛先生的发现，而且是一种相当苛刻的发现，换了另一个来访者，可能摸到的完全是别的东西，甚至是一个外部的、确实不公的处境。关键在于，这些不是治疗师指出来的。一旦由治疗师指出，它就变成一条解释，葛先生可以像接受前面所有的指引一样接受它，然后带回家去验证、反驳或者遵从。由他自己碰到的，就不能被遵从，也无从反驳，它只能被承担或者躲开。

涌现是逼临态之后可能出现的事，用“可能”是认真的。旧支架在这里坍塌，新的组织方式有可能在坍塌处长出，但并不必然。长出的形式，原论文分成两个相继的位移。其一是意义目标的更换。前半年里，葛先生每次诉说，要紧的目标是继续获得被听见的温暖，痛苦是进门的票。票被取走以后，他需要另一个理由来说话、行动、继续来或不来。其二是路径的重学。他开始在没有人预先给出评分标准的情况下做事：对妻子说一句不预设她反应的话，对主管讲一次自己的看法，然后用自己的感受去判断这一步值不值得再走一次。做对了不靠别人的奖赏沉淀下来，做错了也不靠别人的责难来惩罚自己。

这里出现了本书后面要用的一个概念：不可代偿的亲自动作（原论文称发生性自我指涉，第7章详述）。葛先生说出那段话，找主管说出他的看法，都是别人无法替他做的事，并不是因为难，而是因为动作的意义就在于这是“由他下的判断、由他承担的后果”。同一句话如果由叶宁替他讲，它就是另一个动作了。这一点同行为实验的作业完成不同，后者即使做得再好，也是服从一份预先设计的安排。葛先生按叶宁的指示去给妻子打一个电话，与他自己决定要不要打这个电话，在外观上相同，在构成上不同。

还必须克制一种诱惑，即把涌现的结果写成“真实自我的回归”。原论文自己也有这样的警觉：涌现出的组织方式不是被找回的，是在旧依赖崩塌的废墟上新长出的一套生存结构。它可能更灵活，也可能带着新的回避和新的盲点。它的

价值不在于更真，只在于它出自他自己的手。这一限定很重要，因为它防止本章的判断滑向一种浪漫化的叙述：撤离之后，一个更完整的人破壳而出。没有人保证这一点。

◆ 四、三项前提、三种失败，以及弹片与拐杖

上面的过程不是对每个人、每个场都会展开。原论文把它能够展开的条件归为三项，这里保留，并把它们读作“事后可以回看的状态”，不当作开工之前的资格审查。

第一项，裁决源已经被来访者确信地退出。前面说过，这一项同治疗师的自我感觉无关。管理者无法向下属自证此刻不是上级，监护人无法向被监护人自证此刻不会动用保护权，同样的道理，治疗师无法凭自己的声明让来访者相信他不在评分。这条前提是三项中最硬的一项，也是案例前半年没有成立的一项：葛先生把叶宁安放在可能帮他的人的位置上，这个位置携带的裁决潜能始终在场。原论文给出的操作化是，来访者连续两次会谈不再索要评价，本书沿用，同时说明它是一个事后的读数，预设了一个已经发生的变化。

第二项，存在一个可以去碰的自己。撤离只能撤掉外部的东西，来访者没有的东西它变不出来。自我与他人的边界还没有稳定建立的人，比如处在急性精神病性发作期或一些严重的人格组织缺损之下的人，外部裁决被撤掉时发生的不是逼临，而是弥漫的恐慌，因为恐慌没有着陆点，没有一个“我”可以抱着它去面对。这类情形下，位置空着是危险的，需要的恰恰是结构化的帮助。

第三项，被压抑的成长驱力仍然存在。撤离不创造能量，它只是移走覆盖在旧挣扎之上的东西。一个长期处于无处可逃的暴力环境中的人，连“我值得为自己试一次”的最低限度信念也被耗尽，对他来说撤掉外部裁决，面对的是一片真空，不是一个可以借力的临界点。三项前提里，这一项是硬门槛，不是参考项。

三项前提不满足的时候，会出现三种失败，原论文对它们的描述值得保留，因为它们让这套判断第一次有了失败的样子。

回避性崩溃发生在逼临态刚要启动的时候。期待落空触发了归因的搜索，搜索的方向却是外部：这个治疗师不专业，这套方法没用，我需要一个能给我建议的人。来访者离开了。这种离开不应被写成治疗师的失误，也不应被写成来访者的抵抗，来访者有权做这个归因。它在脱落之前的特征是，没有自我指向的追问，也没有指向治疗师的敌意，只有一种失望式的贬低，把“我为什么没变好”整个推到对方身上。它多半提示前提二或前提三不足以支撑从外归因转向内归因。

解构性崩溃更具破坏性。内归因的转向发生了，来访者碰到了那层被覆盖的东西，对自己生命的失望、对多年逃避的羞耻、对“从来没有为自己活过一次”的恐惧，强度超过他当时能承受的限度。旧支架塌了，新的没有在塌处长出，塌陷本身成了终点。它容易被误判为逼临态的深化，因为外观上都是痛苦加剧、叙述变沉。原论文给出的分辨线索是，来访者的叙述里是否还有极微弱的自我指向（“我怎么会变成这样”比“我活不下去了”更接近逼临态），以及是否保留了哪怕是敌意的、指向治疗师的反抗性能量。这条线索的价值有限，本章在后面谈到判断的难处时再回来。凡叙述里出现“活不下去”一类话语，一律先按安全流程处理，不得因为它可能是逼临态的深化而继续等待。

重建性失败发生在涌现之后。葛先生如果在第一次不预设妻子反应地对她说话之后，得到的是更严重的冷暴力；如果他在会上说出自己的看法，之后被降了职，那么新的组织方式没有得到外部世界的任何最低限度确认，旧的惯性与它所依托的整套社会装置一起反扑。这时的失败不是撤离的内部失败，亲自动作已经发生了；是新长出的东西没有可以扎根的土壤。单靠心理治疗已不足以解决，这是这一判断自己的外部极限。

对这三种失败的承认，同本书开头确立的适用范围是一致的。自伤自杀的风险、急性危机、自我结构的严重缺损和心理储备的耗尽，这些情形下需要的是结构化的帮助和安全流程，不是一个空出来的位置。第11章会回到这里，把“不该让”的情形写成硬条款。此处先立一个提醒：逼临态与危机状态在外观上高度相似。有人在逼临态里痛，有人在崩溃里痛，旁观的人第一眼分不开。

原论文给了四个观察维度来区分两者：痛苦的叙事里是否出现自我指向的追问；同一段叙述里是否有“我能”与“我不能”的内部对话；痛苦是否有一部分冲着治疗师的“不作为”，表现为敌意；外部的压迫源是否仍在客观上持续存在。后两项需要稍加说明。来访者对不给他任何东西的治疗师发火，在原论文看来是逼临态在运作的可靠信号，因为它说明他的自我仍在把旧结构塌陷的痛转向一个可以怪罪的对象。这一条本章要降一档使用：敌意也可以是失望、羞辱或关系破裂的表现，在没有别的线索时，它不能独自说明什么。第四项则提醒，来访者生活里的现实暴力若仍在运转，痛苦升高的来源可能是外部处境，不是撤离，此时问责的对象应是对外部冲击的错估。

这四个维度本章只当作事后的描述性读数，不当作实时的诊断工具。理由很具体：它们都要求治疗师在一场正在进行的会谈里，从内部区分阵痛与崩溃，而这个区分正是最容易被善意和理论一起蒙住的地方。一个相信撤离有效的治疗师，会倾向于把任何痛苦读作阵痛；一个怕出事的治疗师，则倾向于把任何痛苦读作危机。四个维度能做的，是在会谈之后、在连续几次会谈的走向里，提供一个粗略的方向感：叙述是向自我指向的追问移动，还是在持续下滑。它们不能替治疗师在当下做决定。这件事没有什么技术上的解法，原论文说“持续判断着什么时候该退、什么时候该进、什么时候必须停下”，本书不把这句话看作一项能力的说明，而看作一种处境的描述：治疗师必须在无法确知的状态里行动，并为此负责。

最后谈一个伦理上的反驳，它来自最朴素的直觉：治疗师是来减轻痛苦的，不是来增加痛苦的。如果撤离意味着把一个人放进没有坐标的空处，让他独自面对混乱，岂不是在故意制造痛苦？原论文用弹片和拐杖回答。一个人腿里嵌着弹片，多年来靠拐杖避开受力，康复师撤掉拐杖，他立刻痛得站不住。这痛不是康复师放进去的，弹片早就在那里，康复师只是没有继续帮他用一个外部支撑绕开它。这个类比的用处，是把痛苦的来源与痛苦的暴露分开：来源在来访者的生活里，暴露发生在外部裁决不再覆盖它的时候。

这个类比必须配上它的界限，否则就成了一句替撤离辩护的话。它成立的条件，恰好是前面三项前提同时成立：痛苦中有相当一部分是靠外部裁决的覆盖维持的，不是靠外部裁决的缺失造成的。一个孤儿在无人可依的处境里陷入抑郁，他的痛苦主要来自缺失；这时撤掉拐杖，撤掉的是他仅有的一根，不叫暴露，叫断援。还有一层是类比自己遮住的。康复师知道弹片在哪里，治疗师不知道。他只能猜测来访者的痛苦里有多少是被覆盖的，有多少是缺失的，而这个猜测本身就是一种判断。所以弹片与拐杖保住的只是一件事：痛苦的暴露不等于伤害的施加。它无法保证每一次暴露都是正当的，而治疗师的责任恰恰落在那些他无法确知的时刻。

◆ 五、与八个近邻的切割

撤离若只是一个新名字，它就不配占用一整章。下面八个近邻，每一个都足以把它收编，逐一画出分离线，并说明每条线靠什么证据来裁决。

苏格拉底的助产术（Plato，c. 369 BCE，《泰阿泰德篇》148e–151d）是最先会被想到的对照：不给答案，只靠追问帮对方自己产出知识。形式上同撤离十分接近，但追问是有方向的。提问者也许不知道答案的面貌，却知道真理大致在哪一边，向着更清晰的概念，更自洽的论证，每一个问题都在执行一次裁决，

裁决“清晰的认知优于含混的感受”“理性的审视是出路”。把这套操作放进葛先生的案例，问题就出来了：他最擅长的恰恰是用漂亮的分析绕开感受，他会立刻配合追问，产出一套自洽而深刻的自我理解，下周再换一个更深的版本。助产术在这样的来访者身上延续的是回避。分离线落在位置上：助产者站在提问的位置上，那个位置不空；撤离要求治疗师不坐上任何一个“知道什么值得问”的位置，包括提问者的位置。

维果茨基的最近发展区（Vygotsky，1978）说的是，学习者在有经验者的帮助下，可达到高于其独立表现的水平。教学上常把这种帮助译成“脚手架”，这是后人的用语，维果茨基本人并非这样说的，本书在类比层面使用它，不涉及这一概念在教育心理学里的全部争议。把它移到治疗里，意思是治疗师评估来访者当前能独自做到什么，再提供略高一步的支撑，等来访者内化后逐步撤去。葛先生的情形与此相反：他的问题不是够不到某个位置，而是他一生已经被过多的外部支架架空了，父母的期待、学校的评分、职场的奖惩，他已不知道没有支架时怎样自己站。再给他一个更精致的支架，哪怕是以“帮他独立”为目的的，也只是又一个外部来源，他会像做作业一样完成每一项探索任务。两者要延伸的东西不同：最近发展区延伸的是能力，也就是他能不能做到他独自做不到的事；撤离之后发生的，如果发生，是一个不可代偿的亲自动作，那件事无法被练习、预演或辅助，因为它的意义就在于没有人参与其中。哪怕提供的只是一根羽毛重的方向引导，来访者也可能把那个动作当成任务来完成，从而绕开了第一次为自己下判断。

精神分析的节制传统，包括不回答问题、不满足移情期待的“空白屏幕”，同撤离形成最深的镜像。分离线不在沉默的长短或拒绝回答的频率，而在分析师沉默时坐在什么位置上。节制是诠释的准备：分析师沉默，是在等移情充分呈现，以便适时给出一个基于理论框架的解释。诠释无论多么温和，发出的位置总

是“我比你更懂你的无意识”。节制挡住了表面的满足，没有挡住那个认知上的权威位置。撤离要退出的不只是建议和结论，还有躲在沉默背后的“我知道你的问题是什么”。当来访者在逼临态里触到某个核心矛盾，分析师会去命名它，而撤离的治疗师不命名，让那个刚被碰到的东西留在来访者手里。这不是诠释少一点或晚一点的区别，而是认知权威由谁持有的区别。需要补一句公道话：精神分析内部对诠释的权威性早有大量自反的论述，上面这条线画的是一种典型的古典技术，不是整个传统。

存在主义的路线，包括弗兰克尔（Frankl，1959）的意义治疗、罗洛·梅（May，1983）的存在分析，以及雅斯贝尔斯（Jaspers，1932）的临界处境，同撤离共享一个立场：改变不是由安抚带来的，是人在被迫面对无意义、有限与自由的时候发生的。反驳最有力的形式是，撤离不过是把存在主义的老话说得更沉默一些。回答要分两层。第一层是操作上的：存在主义的治疗师通过叙述进入处境，告诉来访者你是自由的，你要自己去找意义。这样一句话，无论说得多么开放，都是一次内容裁决，来访者很快就学会，最令治疗师满意的姿态，就是表现出“我正在独自面对我的自由”，一个新的服从目标取代了去面对的那一刻。撤离不进入叙述，不描述被逼临的处境，也不为它命名。

第二层才是难处。撤离本身，难道不是基于一个裁决，即“你不该依赖外部裁决”？如果是，它就和存在主义是同一种东西。原论文用内容裁决与位置裁决的区分来回答，本书接受这个区分，同时收紧它的主张。撤离没有宣布一条“你不该依赖”的规范，它甚至不需要有这条规范。它做的是不接受那个位置所召唤的功能。但这仍然是一种选择，选择本身带着价值，治疗师不可能站在一个完全无立场的地方去撤。因此本书不说撤离“没有裁决”，只说它不把裁决发出去。这个收紧让主张弱了一些，也诚实了一些，它与第8章的立场一致：没有无立场的治疗师，只有尽量不把立场当作处方交出去的治疗师。

行为激活与认知行为治疗里的行为实验，同撤离分享一个直觉：改变不是被说服的，是在做的过程里遭遇现实反馈而发生的。分离线落在目标的设定权上。行为实验的撤除，比如撤掉安全行为，是在一个功能分析的框架里进行的，框架预先规定了来访者需要学习什么：更有效的情绪调节，对恐惧刺激的习惯化，对灾难化认知的矫正。治疗师是那个知道什么体验有矫正价值的人，这套框架本身就是一个强大的外部裁决。来访者可能勤勉地做完每一项作业，带着“我好了”的证据回来，而没有被带到“没有人告诉我该做什么，我自己想要什么”这个问题面前。撤离把目标设定权也一并放下了，不是作为一项更高级的技术，因为本来就没有人有资格替他设定。当然，两种路径并非只能择一。对许多来访者，行为实验是合理而有效的，分歧只出现在这样一个窄的区间里：来访者已有的服从恰恰是问题的一部分。

格式塔治疗里的熟练挫折（skillful frustration，Perls et al.，1951）是最危险的近邻，因为它与撤离几乎同形：治疗师拒绝提供来访者索要的支持，迫使他动用自己的资源。这条线画得越细越好。熟练挫折作用在来访者的求助动作上，不满足它；撤离作用在裁决位置上，不占据它。前者的治疗师仍站在场上，是一个有权决定此刻该不该挫折的“拒绝给予者”，权威结构原封未动。后者要求连“有权判定此刻该不该挫折”的那个位置也空出来。这条线可以被裁决：在会谈录音里，“治疗师明确拒绝给出评价”和“治疗师在被索要评价时把评价权交回”是可以被独立编码的两类事件。本书预测，只有后者与逼临态的读数相关。如果两类编码与结果的相关强度没有差别，本书相对格式塔就没有增量，这一章的独立性便不成立。这一预测尚未检验，编码者之间能否稳定地区分这两类事件，也尚未检验。

科胡特的恰到好处的挫折与变形性内化（Kohut，1971）则在“失稳”的价值上与撤离相反。恰到好处的挫折要求挫折是微量的、来访者始终可以承受

的，成败的标准是稳定的自体结构是否形成。本章所说的逼临态允许、并且需要一段无法承受的失稳。这个分歧可以被数据裁决：科胡特一路的模型预测，疗效随失稳强度单调下降；本章预测的是倒U形，失稳过低没有变化，过高则崩溃。如果数据支持单调下降，本章就还原为一次过度的表述。倒U预测同样尚未检验，这里还有一个麻烦，“失稳强度”本身如何独立于结果来测量，现有文献里没有成熟的办法。

最后一个近邻是暴露疗法的抑制性学习模型（Craske et al., 2014）。“期待违背”正是这个模型的核心术语，本章借用了同一个词，有被它整体收编的风险。分离线在期待的对象：暴露里的期待违背指向外部世界的危险预期，“我以为会窒息，结果没有”；本章的期待违背指向关系中的裁决预期，“我以为你会评判或认可我，结果那个位置空了”。检验的办法是，如果用抑制性学习的参数（期待违背的幅度乘以消退的深度）去拟合，能够不留残差地解释撤离的效果，本章就只是暴露模型在治疗关系上的一次应用。这个检验同样需要新的数据。

八条线里，对存在主义、精神分析和最近发展区三条，本书可以主要靠概念上的区分立住；对格式塔、科胡特和抑制性学习三条，分离线已经画出，但要站住，依赖本书没有做过的编码和拟合；行为实验的一条则只能划出窄区间。这个分布本身就是读者应当掌握的信息：本章的区分有强弱之别。

◆ 六、判的椅子与前两把椅子，以及一次用词的交代

判的椅子同第3章、第5章的两把椅子是什么关系，需要在这里划清，否则读者会把三者当成同一件事的三种叫法。懂的椅子被占住，是治疗师对来访者体验的辨识太准、太快、太早、太全，占住的是“谁来说这是怎么回事”。给的椅子被占住，是治疗师接下了来访者所要求的功能，占住的是“谁来做这件事”。

判的椅子占住的是“这样对不对、往哪边走”的最终说法。三者在一次会谈里常常交织，一个太准的共情也含着判断，一个满足请求的建议也含着解释，但它们各有各的失败方式和各自的读数。葛先生的前半年可以三者兼有：叶宁听得准，葛先生默认她会给方向，她又稳定地提供着一个容器。撤离只对判的这把椅子有直接的意义，对另外两把没有承诺。

与第5章的边界尤其要说清。第5章的零功能在场，是治疗师接下投射，却不去执行投射所要求的功能，旧的对象便失去了承载物。本章的撤离，空出的是裁决位置，不是功能位置。一个治疗师可以完全不执行任何被索要的功能，而仍然在每一句话里保留着评分的口气；也可以在某些功能上让步，比如提供一个必要的事实信息，而不占据判断。第10章会把这两种撤放在一起，作为全书需要自撞的第二场来处理。

另有一件事要在这一章里交代，因为它直接牵涉本书的立场。原论文通篇用“逼出”来描述来访者的变化，主语往往是治疗师或这套动力学，如来访者被“逼到退无可退”，裁决撤离“逼出”一个亲自的判决。这个动词在本章已被改写，改写后的主语是处境，也就是前面所说的逼临态：外部指引的渠道被证明不通，原先绕开问题的方式失效，剩下的只有那个问题本身。治疗师在这个句子里的位置因此被改了，他是使位置空出的那个条件，不是推动者。这个改动不是措辞上的洁癖。如果治疗师能够把来访者逼到某个地方，他就是在导演，而导演所站的恰恰是一个从高处看全局的位置，这与本书第8章的判断冲突。改动的理由、代价，以及治疗师在这个新写法下究竟还负什么责任，留到第10章正式交代。

◆ 七、读数、判错条款与不适用的情形

本章的读数取自一个很便宜、也很难作假的现象：在一次会谈的记录里，治疗师占据裁决位置的次数。条目是具体的：给出评价，确认对错，替来访者下判断，把来访者的某个表述改写成一个更好的表述，提出一个预设了方向的问题，各计一次。同时记录另一类事件，即来访者向治疗师索要评价时，治疗师是否把评价权交了回去。这样的计数在录音上可以独立编码，比“共情是否到位”容易得多，也可以回看葛先生那一段，把第二十七周那一问计入。

这个读数本身并不说明好坏，它的意义在变化的方向上。原论文附论里有一条反向剂量的预测，本书保留为读数的解读规则（这一预测尚未检验）：在裁决源被来访者确信退出之后，治疗师主动给出评价的次数应与来访者的自主指标负相关；在治疗早期，锚点尚未建立的时候，这个相关应当是正的，因为此时来访者的评价来源还在外面，一个中立的、稳定的评价者起着支撑作用。也就是说，评价的多少不是一个恒定的好变量或坏变量，它的符号随阶段翻转。这正是全书“阶段乘以位置”的交互反转在本章的具体形态。

第二个读数落在来访者那一侧：连续两次会谈里不再索要评价；叙述中出现自我指向的追问；在被问到自己的想法时，不先去看对方的脸色。这些现象的出现是撤离已经被来访者接收的间接证据，本书不把它们当作撤离的目标，更不能当作治疗师可以追求的指标。一旦被当作目标，它们就会变成一套新的演技。

本章的判错条款有三条，均尚未检验。其一，在三项前提都已满足的来访者中，比较治疗师稳定地占据裁决位与稳定地不占据裁决位两种条件，若三个月后经第三方核实的来访者自主行动，在两种条件下没有差异，则本章关于撤离是接纳之后的推动条件的判断撤回。其二，反向剂量的符号若不随阶段翻转，早期与晚期同向，则本章关于“过程条件”的主张失败，评价的多少只是一个恒定的变量。其三，涌现应出现在逼临态峰值之后不久，原论文的预测是一到三次会谈，

跨过六次仍无涌现且症状持续恶化，应判为回避性崩溃，不应继续等待。如果在已有的长程个案记录里，逼临峰值与涌现之间的间隔没有任何规律，三阶段的模型就退化成一个事后的叙事框架。这一条不需要新的数据收集，只要回看已有的记录，是目前最便宜的一次检验。

还有一条更大的预测，是原论文的结语提出的：高质量接纳而从未出现逼临态的治疗，其长期疗效应不优于由随机话题构成、但同样给予接纳与安全感的对照关系（尚未检验）。如果这类治疗在长期随访中显示出独立于逼临态的、持续的临床改善，本章关于“接纳之后需要撤离”的充分性判断就需要修正。这一比较的设计难度很大，“逼临态是否发生”需要事后评定，评定者与结果之间的独立性很难保证，本书只把它列为方向，不把它当作一个现成的研究方案。

本章判断失败或不适用的情形，前面散布在各节里，这里汇总一遍。自我边界尚未稳定、处在急性发作期的来访者；心理储备已被长期、无从逃脱的处境耗尽的来访者；外部压迫仍在高强度运转的来访者；有自伤自杀风险的来访者。对这些人，空着的位置不是机会，是危险，需要的是结构化的帮助。第二类不适用来自场：管理者、监护人、上级这类无法向对方自证“此刻不是你的上级”的角色，即使本人满怀诚意，前提一也不成立。第三类是撤离自己的失败，治疗师以为自己空出了位置，来访者仍然把他安放在那里，或者治疗师空出了位置，又在下一刻用另一种形式把它占回来。本书不认为这些失败可以靠技术消除。

还有一个来自外部的反驳不能绕开：撤离与失职，在录音里几乎无法区分。一个治疗师因疲倦、因走神、因不知所措而没有接话，与一个“空出位置”的治疗师，沉默的长度可以一模一样。如果撤离只能靠事后来访者的反应来佐证，那么每一次沉默都可以被事后追认为撤离，每一次没有效果的沉默又可以被说成前提不足，理论因此永远不会输。本书对这个反驳的回应只有一部分：前面的三条判错条款正是为了堵住这条退路，它们规定了在什么样的记录下撤离的判断要被

撤回。另一部分是无法回应的，本书承认。撤离在日常的外观上同疏忽相似，来访者可能受到伤害，而治疗师在当时无法凭自己的内省把两者分开。这是为什么本章不把撤离写成一项应当学会的能力，也是为什么上一节的四个观察维度只能做事后的读数。治疗师在这里负有的责任，不是“把撤离做对”，是在发现来访者的叙述向下滑坡时，不再用理论为沉默辩护，而是回到结构化的支持上来。

还应当回头看葛先生，用本章自己的尺子量一遍。前半年，裁决位置的占据次数不高，但位置裁决始终在场，来访者没有任何一次不再索要方向的迹象。第二十七周，一次没有被填的沉默，一个轻微越位的问句；之后，来访者的叙述里出现了自我指向的追问，也说出了此前对治疗师的怨恨；之后几个月，他做了几件由他自己决定的事。这一串顺序同本章的模型吻合，但它是一个合成的案例，它的吻合说明不了模型是对的，它只说明模型可以被用来读这样一类故事。读到这里，也该承认这个模型的一个盲区：它对葛先生这类人写得最顺，一个擅长分析、擅长服从、长期被稳妥接纳的人。对那些并不依赖外部评价、甚至一直在反抗它的来访者，撤离未必有什么可讲的。

判的椅子被写得这样细，容易给人一个印象：治疗师在这里有一项需要掌握的动作。读到这里，这个印象应当被撤回。撤离无法由治疗师确认，无法实时区分阵痛与崩溃，无法独自保证位置真的空出。接纳铺好了，椅子空着，剩下的由一个处境和一个人来完成，治疗师可以做的只是不坐上去，且无法确知自己是否做到。下一章要问的，是这个人在这把空椅子前所做的那个动作，凭什么只能由他自己来做，而不能由力气更足的人代做；这个问题不仅涉及伦理，还牵出全书的第二条判错条款，一个可以被直接判错的预测。

◆



第　三　编

椅子空了以后

编　序

位置空出来之后，发生的是什么？第7章说，是一个别人不能代做的微小动作；第8章说，卡住的东西本来就是两个人一起做出来的，治疗师并没有一个高处可以站上去指挥空出。

第8章是全书的裁判席。前面各章凡有治疗师像导演的句子，都要到这里接受一次审查。

07

第7章

那个动作只能他自己做

沈女士四十一岁，欠母亲一个电话，已经欠了两年。事情不复杂：母亲在老家做了一次手术，出院后沈女士只在微信上问过两句，母亲回的是一个“好”字，此后双方都不再提。沈女士在会谈里把这件事讲得很平整，前因后果、各自的难处、该说的话和不该说的话，她都已经想清楚了。治疗进行到第十个月，她的睡眠改善了，工作里的争执少了，量表分数一路向下，同盟评分一直很高。有一次她看着窗外说：“要是你能替我打这个电话就好了，我现在力气是够的，就是手伸不过去。”（说明性合成案例）

这句话里有三个事实。第一，她说力气够，这多半是实情，十个月的会谈确实让她比从前有余裕。第二，她提出的办法在日常经验里毫不荒唐：一个人拖着不敢做的事，由旁人代办，事情办成，僵局解开，母女之间也许就此松动。第三，治疗师若点头，几乎没有人会觉得他越界，他只是把一份善意用到了实处。本章要问的是，这个电话由谁来打，会不会使后面的一切不同。本章的判断偏向一个听上去近乎苛刻的答案：电话被打出去是一回事，沈女士的生活里发生了一件事是另一回事，两者之间隔着一个只有她自己能迈的动作。

这一判断需要更精确的表述，因为“只能本人做”很容易滑成一句常识。母亲收到电话，关系可能确实缓和，外部结果完全可以由代办者取得。本章所说的是另一层：沈女士此后再遇到“伸不过去的手”时，她与自己的关系有没有变。代打的电话可以改变母亲，却未必改变那个“从未亲自拨出过”的沈女士。有些事一旦由别人做成，做成的是事，而不是她。

本章处理的对象，是治疗里的一个最小单位。它不是一次领悟，不是一段好的关系体验，也不是一项被反复操练的技能，而是一个微小的、与来访者既有经验结构不能通约的、无人可以代劳的亲自动作。它很小，小到常常在会谈室之外、在无人在场的时刻发生，事后连当事人自己也说不清那一下是怎么做出来的。本章试图说明，为什么这个单位值得被单独命名，它与哪些邻近概念近到几乎可以互相替换，又在哪里必须被切开，以及一旦有人拿它与势能论去打赌，赌注怎样设定。

◆ 一、最小单位：不可代偿的亲自动作

原论文为这个单位取的名字是“发生性自我指涉”。本书改称“不可代偿的亲自动作”，下文简称亲自动作，原因只有一个：原名读起来像一个机制，而它要指的是一件可以被指认的事。它须同时满足三个条件。其一，无人可以代劳。这里的“无人可代”不指难度，而指动作的归属：吃药可以有人提醒、有人递水，“记得吃药”的大半环节能由外部系统接管，而在空椅子前对那个伤害过自己的人说出一句从未说出的话，必须从自己的喉咙里发出，复述治疗师的措辞不算。其二，与来访者既有的经验结构不可通约。做出这个动作之前，他的意义框架里没有一个现成的门类可以安放它，他说不清自己“正在做的是什么”。其三，动作一经做出，此后他进入类似处境时看待自己的参照方式便已改变，且无法撤回。

三个条件的权重并不相等。前两条是门槛，第三条才是动作之所以算作疗效单位的理由。一次愤怒的拂袖而去满足前两条：那是他自己站起来的，事先他也不知道会在那一刻爆发。但它多半不满足第三条，因为事后他很快用旧的叙述把它收了回去：“我又搞砸了一次关系，我就是这样的人。”旧框架把这次行动吃掉了，没有留下任何卡在框架边缘、让旧叙述不得不调整的东西。亲自动作与见

诸行动的分界，就在这里：前者做完之后旧框架消化不了它，后者做完之后旧框架正好拿它来印证自己。

第三条还有一个后果，需要在此先说明，因为后文所有的案例都要用到。亲自动作完成以后，当事人几乎一定会觉得那个新出现的东西“本来就在那里”。他会说，好像一直有个人在等着，只是自己不知道。这种回溯性的先在感不是错觉的反面，也不能当作先在的证据。新的参照方式一旦成立，就会重写他对“自己曾经是谁”的记忆，使得它看上去从来如此。因此，凡是在会谈里听到“原来我一直都有”之类的话，本书的读法是：这是动作之后才获得的重量，不是动作之前就存在的蓝图。是否存在先在的蓝图，是本书与人本主义传统分歧最深的地方，第三节再谈。

有人会说，“没有现成门类”这一条太玄。它其实有很朴素的临床对应。一个长年承担责任的人，若被请去闭眼五分钟找一个身体感觉，他的困难不在于做不到，而在于他在整套“任务、义务、效率”的语汇里找不到一个位置去放这件事；他不知道该把它记在“正事”还是“闲事”名下，这种无处归类，才是第二条要说的“不可通约”。相反，一个熟练的职员被请去在会上握拳三秒，他立刻知道这是“配合治疗师的一项练习”，旧框架毫不费力地把它归了类。前一种有可能成为亲自动作，后一种只是一件被完成了的作业。这个区分在第二节的案例里要一直用下去。

◆ 二、三个案例：它怎样发生，怎样落空

顾先生五十二岁，经营一家小型制造企业，因近两年加重的广泛性焦虑和偶发的惊恐求助。他在最初几次会谈里反复说同样的话：“我这辈子都在为别人活。”“我不知道为自己活是什么感觉。”“一停下来，整个家和我的人生都会散。”他同时又总会提到年轻时画过画，说是“自己瞎画”，每提到这里，语速

会慢下来，肩背在椅子里沉下去一点，几秒钟后坐回他惯常前倾的紧张姿势，补一句“那是过去的事了，现在哪有那个闲心”。

第三次会谈，治疗师提到了这个身体上的变化，说很短，大概几秒，不知道他自己有没有注意到，然后问他接下来一周愿不愿意每天找一个五分钟的空当，闭上眼睛看看能不能找到那个感觉，找到了就记一笔，找不到什么都不用记。治疗师没有附加任何解释，没有说这对焦虑有益，也没有说这是为了连接被压抑的部分。这里值得记下的是一个反面事实：治疗师并不知道那里会有什么。他看到的只是顾先生的框架里有一小处吃不下的东西，一个他自己也无法说明的身体变化。

一周后顾先生带来一张折得整齐的纸，说找到了四次。他讲了其中一次：周二下午刚打完一个很烦的电话，他坐在办公室椅子上闭了眼，一两分钟后肩膀忽然松下来，就是治疗师说的那个。他在纸上写“找到了”，写完就哭了。“我不知道为什么哭，不是难过，也不是高兴。好像有一个人在我身体里，他一直在那儿，我从来不知道他在，那天下午我找到他的时候，好像他一直在等我去找。”

这段话里有几处值得逐字记下。“有一个人在我身体里”这句，治疗师的话里没有前因：治疗师说的是“那个感觉”，顾先生报告的是“一个人”。这个语义上的跳跃，是后文要用的第一类读数。“一直在那儿”则是前面提过的回溯性先在感，在本书的读法里它出现在动作之后。还有一处容易被忽略：这个动作发生时治疗师不在场，没有共情，没有接纳，没有任何一个可被称为“关系”的东西，在场的只有一个办公室里的男人和他一次孤身的闭眼。

接下来的一周，同一个动作落了空。顾先生回来说什么都没有找到，每天坐下，闭眼，什么都没有，问自己是不是做错了。治疗师问：“你什么都没找到，然后呢？”他说然后就很烦躁，觉得自己蠢，公司一堆事，他坐在这里闭着眼等一个不知道什么东西。治疗师说，这一周除了没找到，你还找到了一个说你蠢的

声音，它你熟悉吗？他愣了一下，说太熟悉了，它一直都在。治疗师接着说，这一周其实不是什么都没找到，他是第一次专门坐下来、安静下来，那么清楚地听见了它在说什么。

此后顾先生的兴趣自己转了向：他开始好奇那个声音是谁的，是父亲的，还是自己的，为什么连闭眼五分钟都不肯放过他。这一步没有谁安排，是他走进那道缝以后自己看见的。顾先生后来没有变成每天画画的人，焦虑也没有消失，但他有了两个新的参照点，一个是曾经找到过的身体感，一个是找不到时骂他的声音。他与困境之间出现了一道空隙，不足以让他逃走，足以使他不被整个吞没。

林女士二十六岁，有边缘型人格障碍的诊断和反复自伤的历史，在辩证行为治疗里已进行三个月，掌握了痛苦耐受和情绪调节的基本技能。有一天她收到男友一条语气含糊的短信，读成了“他要分手”，自伤的冲动随之涌来。她用了学到的相反行动，强迫自己打电话给朋友，聊了四十分钟，冲动暂时退去。事后她对治疗师说：“打电话有用，但那只是因为我把它压下去了。那个冲动还在那里等我。每次都用相反行动，就像一直在和一个比我力气大的人打架，总有一天我会打不动。”

这段话精确地标出了相反行动的限度：它能对抗行为，却对付不了整团无法命名的风暴，因为它需要一个明确的靶子，而林女士被拒绝的那一刻，经验到的并不是一种可以叫做羞耻或恐惧的单一情绪。治疗师在那次会谈里出于临床直觉，向她提出了另一件事：下一次，收到让她不舒服的短信、冲动涌上来的时候，能不能先闭上眼，把一只手放在胸口堵得最厉害的地方，不评判，不对抗，只做三次呼吸。这个提议叠加在她原有的安全计划之上，不取代其中任何一项。此后两周，林女士遇到两次类似的处境。第一次她做到了，手放在胸口，三次呼吸做完，然后给朋友打了电话，没有自伤。第二次她没能做完：手放上去，第一次呼吸时胸口的堵“变得更大了”，她吓坏了，把手拿开，随后自伤了。这两次

放在一起看，比单看第一次更有信息量。第一次的动作满足三个条件：那只手必须是她的手，那三次呼吸必须是她的肺在呼吸；这个动作在她掌握的技能谱系里没有现成位置，它不对抗任何东西，只是让一次觉察停在那里；而它做完之后，她多了一个此前没有的自我描述，“在冲动和被吞没之间可以插入一个动作的人”。这个人在手放上去之前并不存在。

第二次的落空同样要如实记下，因为它说明缝隙不是无害的。旧框架被暂时悬置的那几秒里，被它压住的未成形的体验会以平时没有的强度涌向缺口。承受力不够时，那道缝隙带来的首先是惊吓。这里需要把一条界线划清：林女士的情形涉及反复自伤，本书的适用范围明确排除自伤自杀风险与急性危机，这类情形需要结构化的帮助与安全流程。三次呼吸不是安全措施，也不替代任何安全措施；把它放在本章，只是因为它清楚地呈现了亲自动作的结构，以及这种结构在承受力边缘时的代价。第二次之后的自伤须按安全流程处理，不能被读成缝隙带来的必要代价；任何读者若把这一段读成一条针对自伤的做法，就读错了。

陈先生四十五岁，在机关做中层，因长期“无力感”来访。他在会议上从不发表不同意见，哪怕明知某项决策有问题，常说的一句话是“说了也没用”。治疗师留意到每次他说“没用”两个字，右手会微微握一下拳，随即松开，不到一秒。治疗师把它当作一道可能的缝隙，请他下次开会时，若又想握拳再松开，试着不松开，多保持三秒。

陈先生照做了，也觉得“很蠢”：别人在发言，他握着拳头坐着，同事问他在想什么，他赶紧松开说没事。他说不想再试了。这件事没有失败在“做不到”，他做到了，保持了三秒。它失败在这个动作没有留下任何东西。陈先生的旧框架，一个服从权威、执行指令的中层管理者，轻松地把它接了过去：这是治疗师布置的一个奇怪练习，配合一下。他在职场里配合过比这奇怪得多的事。握拳三秒是一件被完成的作业，没有变成亲自动作，原因正是第一节末尾说的那一

点：对他的旧框架而言，它有门类，有归属，可以被消化。顾先生闭眼找感觉则不同，那件事在他的责任世界里没有门类，找不到时旧框架的反击才会那样猛烈。

由此可以对“缝隙”给出一个比“逸出控制的小动作”更严的说法。握拳又松开确实逸出了陈先生的控制，但那是一个他可以用“紧张的小习惯”随手归档的残余。成为缝隙的条件是，触到它时当事人感到“不知道自己在做什么”，不是智力上的不知道，而是既有的意义框架给这件事找不到安居的类别。框架级的无从消化，是亲自动作的土壤。任务级的可以消化，只能把动作回收为旧框架的延伸。这条分界无法在会谈前由理论算出来，只能在事后从当事人的反应里读：他是说“我配合了一下”，还是说“我不知道我在说什么”。

读到这里，一个细心的读者会觉得这三个案例有一条共同的线索：治疗师先看见一处，再请来访者去做一件事，然后退到一边等。把它抽出来，就是“探测缝隙、安放行动、退后”。本书必须立刻把这条线索的地位讲清楚，否则它会悄悄变成一份操作手册。原论文在自己的操作化一节里已经警觉过：这三步读起来像一位老练的发现学家的手艺，只不过他诊断的是缝隙而不是病灶。若治疗师拿着这份清单，就等于他事先知道该把来访者往哪里带，这与第8章要讨论的“接上循环”叙事如出一辙，差别只是接上的对象从健康方向换成了一个动作。

所以本书对它的写法是读数而不是步骤。可以事后记录的只有这些：治疗师留意到一处来访者自己也解释不了、反复出现的细小材料；他提出了一件小事，没有附带它“有什么用”的说明；动作完成与否，他都没有急着赋予意义；来访者回来后讲述的语言，有没有溢出治疗师当初的措辞。这些是现象，不是指令。而且这些现象里夹着一个不由治疗师掌握的成分：他看见顾先生肩膀的沉降，在多大程度上是他自己判断的，又在多大程度上是顾先生一次次提到画画时在他身上唤起的某种微小反应，已无法拆开。林女士的治疗师说那个提议出于“临床直

觉”，而这种直觉的原料，恰是林女士在技能框架边缘多次流露的、没有说出口的不满。治疗师以为在提出，他提出的东西有一部分是对方递过来的。

这一点关系到本书的立场。治疗师在这里没有站在互动之上的位置，他不是替来访者决定缝隙在哪里的人，更不是把来访者推过缝隙的人。缝隙的位置，部分由来访者尚未言明的传递划出；缝隙能否被越过，完全取决于处境逼出了怎样的反应，以及那个只有他能做的动作做没做。顾先生在没找到的那一周里找到了那个骂他的声音，这个转向不是任何人的安排。治疗师能做的，是在缝隙附近放下一个邀请，放下之后退后，而且这一退后常常也不成功：他会忍不住解释，忍不住要保证“这对你有好处”，一旦解释，邀请就被收编进他自己的意义框架，亲自动作也就随之报废。本章对治疗师动词的收紧，第10章将正式交代，这里只记下方向：本章里治疗师的动词，最强也只到“放下”。

◆ 三、切割之一：谁在说“方向早已在那里”

最先要面对的，是人本主义传统里最有力的一句话。罗杰斯（Rogers，1951，1957）把改变的动力放在一种先天的实现趋向里，治疗的三个核心条件，共情、真诚一致、无条件积极关注，只负责撤去价值条件化所筑起的障碍，让有机体自己朝向成长。一位坚定的罗杰斯主义者看顾先生，会说：那次闭眼之所以奏效，是因为它发生在被接纳的关系里，他得以暂时放下“我必须是个负责任的人”，被压抑的自我关怀的倾向自然浮了上来。这个解释简洁，也几乎无法被驳倒，因为它把一切都归给了一个难以测量的变量。

本书与它的分歧不在发生过程是“自然涌现”还是“被催化涌现”，那只是程度之争。分歧在一个更硬的前提：健康的方向，在这个动作之前，是否已经以某种形式存在于来访者之内。实现趋向之所以叫趋向，就是因为它有对象，有方向，治疗做的一切，只是为一个已有方向的运行备好条件。亲自动作不作这个承

诺。顾先生闭眼之前，没有人知道，包括他自己，也包括治疗师，那里有一个“等他去找”的自己；林女士把手放上去之前，没有人知道她会有一个能在冲动与行动之间插入一个动作的自己。这些参照方式在被做出以前，作为轮廓都不存在。实现承诺一份先于实现的蓝图，发生不承诺。一个园丁除去杂草，植物按它原有的方向长；在冻土上裂开一道缝，缝往哪里裂固然受土层结构制约，这道缝在此之前却并不存在。

罗杰斯主义者还有一手：三个条件充分到位而来访者不动，只能说明共情还不够精确。这条退路没有出口，因为“够不够精确”无从独立判定，失败永远可以归给条件的不纯。亲自动作提供的不是一个替代条件，而是一个可以单独核对的问题：在过去若干次会谈中，来访者有没有在某一个时刻，亲自做过一件此前无从参照的事？如果没有，无论共情多么准确，这一层面的东西就还没有出现。这个问题也能解释一类反向的临床印象：三个条件并不完备，一次极简的、几乎没有温度的指导有时也伴随持续的重组，可能是因为恰好有一个动作被亲自完成了。顾先生那次闭眼和林女士那次呼吸，都发生在治疗师缺席的时刻，没有共情，没有接纳。

与实现趋向的分歧还带出一个不太讨喜的推论：亲自动作不预先担保它所开出来的那个新参照是“好”的。顾先生那个被找到的人，可能使他更能承受焦虑，也可能使他更尖锐地意识到自己为别人活了多少年，陷入一段更长的低落；沈女士若亲自拨出电话，也可能发现母亲的冷淡并不因为拨出而改变，并因此与这段关系决裂。一个依赖先在方向的理论可以说，朝向成长的趋向最终会带来好的结局，亲自动作的叙述没有这样的保险。它只能说，这个人此后在自己的名下面对这一切，而不是在别人的名下。结局的好坏，由此后整个生活去结算，不由治疗里的任何理论预先代结。治疗师可以陪着这个结算过程，不可以以理论的名义提前替人结账。

第二个近邻是斯特恩（Stern，2004）的“现在时刻”和“相遇时刻”。它与本章的相似几乎是结构性的：不可预先脚本化，不可撤回，一经发生就重组了某种隐性的东西。切割必须落在两处。一处是发生的场域：相遇时刻严格地发生在二人之间，治疗师也必须在那一刻被改变，双方即兴协调，缺一不可；而顾先生的闭眼是一个人在办公室里完成的，没有任何二元互动在场。斯特恩的拥护者会说，那是此前若干个“现在时刻”内化后的延迟效应。这个反驳有分量，但它要求此前确有这样的时刻，而在顾先生的案例里，治疗师做的只是一句极简的邀请，来访者的回应也是沉默而个人的，找不到一次双向的即兴协调。另一处是产物：相遇时刻改变的是内隐的关系性知晓，即“怎样与别人在一起”；亲自动作的直接产物是一个人称位置的出现，是来访者与自己的关系。它当然可以被带进关系，但那是之后的事。两者可能在同一个疗程里交替发生，彼此不能互相翻译。

第三个近邻最危险，因为它几乎逐字说了本章要说的话：班杜拉的掌握性经验（Bandura，1977，1997）。自我效能的四个来源里，亲身完成一件事被排在首位，其余几个来源（观察他人、听别人劝说、生理唤起）的效力被认为较弱。如果亲自动作只是掌握性经验换了说法，本章的增量为零。分离线在于成功是否构成条件。掌握性经验的核心是“我做成了，所以我能”，失败的亲历降低效能，这是该理论的明文规定。亲自动作不以成功为条件：沈女士拨出了电话，母亲冷淡地回了一句“知道了”，按班杜拉，这是一次削弱效能的失败；按本章，那个动作照样完成了它的事，因为它的功能不是证明“我能”，而是让她第一次作为一个不可代劳者出现在自己的生活里。这里给出的是一条方向相反的预测：取一批完成了动作而结果失败的个案，掌握性经验预测其后续主动性下降，本章预测它们出现与成功者同向、幅度可能较小的结构变化。若这批个案的后续轨迹与根本没有行动的个案无差异，本章的这一半主张就被推翻，班杜拉足够

了。这是一条尚未检验的预测，此类数据也许已存在于过程与结果记录里，重新编码或可检验。

第四个近邻是亚历山大与弗伦奇（Alexander & French，1946）的矫正性情感体验。它的语法是被动的：来访者遭遇了一个与预期不同的回应，改变发生在他身上。亲自动作的语法是主动的：来访者做了一件事，改变系于做这件事本身。分离线便是动作的执行者是谁。检验方式同样明确：在治疗师完全没有做出任何异于预期之回应的会谈里，能否仍然观察到本章所说的变化。如果不能，那么本章的东西就可以被矫正性体验吞掉。还有一层需要补上，矫正性体验自己也有一个已知的弱点：一场深切的情感涌现可以被旧系统当作“安全的泄压阀”消费掉，哭过之后一切照旧，因为当事人没有做任何事，只是经历了一场。

第五个近邻是暴露。行为治疗的整套暴露技术建立在一个相近的判断上：恐惧的修正需要与恐惧刺激实际接触，单靠讲解难以完成（Foa & Kozak，1986）。也不能因此认为它们是一回事，机制归属不同。暴露的机制是习得性恐惧的消退，要求刺激反复呈现而预期的坏结果不出现，按这一逻辑，次数越多效果越大，重复正是它的力量。亲自动作的力量在第一次：它是一次性的归属确认，重复反而稀释。这个差别可以落到剂量反应上：暴露预测次数越多效果越大，本章预测首次动作的效应最大，后续重复不线性增长。林女士那一次呼吸恰好能说明这点。若她下一次、再下一次都做完三次呼吸，它就会逐渐变成一项技能；变成技能以后，就是练习，在本章的意义上不再是动作了。

◆ 四、切割之二：已被测量的“只能自己来”

再往下的两家更难甩开。它们不只承认亲历不可替代，还各自把“只能由来访者自己发生的那件事”做成了可测量的变量。

简德林（Gendlin，1981，1996）把疗效锚在来访者与身体感受（felt sense）接触并在接触中发生转变的那一刻，这个转变（felt shift）只有当事人自己能够发生，体验历程量表一类工具也试图把它量化，其预测力本书不作判断。“亲自完成一个不可代劳的动作”与“felt shift 只能自己发生”，确实几乎同形。本章的分离线在转变发生的层面。felt shift 是一个内在事件，可以在会谈室里整个发生、整个结束，标志是身体感的松动；本章要求的动作必须落在会谈室之外，有后果，可以失败，它的不可代劳性来自后果须由当事人承担，而不是来自感受的私密。一个人完全可以经历一次充分的 felt shift 而从未做出任何行动，本章预测这类个案的收益不稳。检验也现成：用体验历程量表给会谈评分，同时独立编码会谈外是否出现过这样的动作，若高分却无行动者与有行动者在六个月随访上没有差异，简德林足以覆盖本章，“行动”这一限定就是多余的。要诚实地补一句：顾先生闭眼那次，看上去恰是一次 felt shift，他的眼泪与肩膀的松动都是证据。本章把它算作亲自动作，是因为他是在办公室里、在一个电话之后、在无人要求的时刻做的，并且之后记了一笔，把它带出了椅子。若换成会谈室里的同一份感受，本章就不敢这样断言。

第二家是德西与瑞安的自主性（Deci & Ryan，2000）。出于自我认可的理由而非外部压力去行动，自主性支持是治疗与教育研究中被反复验证的变量，“作为一个不可被代劳的自己出现”听上去几乎就是它的临床版。分离线在于持续的品质与一次事件的差别。自主性是一种可以稳定持有的品质，并且完全可以在熟悉、安全、早已预演过的行动里充分实现，一个人可以非常自主地做他一直在做的事。亲自动作恰好要求动作与既有经验不可通约，它的全部价值在于没有被预演过，所以也不会从自主性量表的分数里读出来。判据由此而来：在自主性得分相匹配的两组个案里，若只有出现过不可预演动作的那一组发生结构重组，本章成立；若两组没有差别，本章的增量就被自我决定论吸收。预演检验还

有一个更直接的形态：把动作在会谈里充分演练以后再让来访者去做，演练组与未演练组的长期结果若无差异，“不可预演”这一限定即告失败，本章可以并入行为激活与暴露的既有框架。

还有几家，距离稍远，各用一两句话了结。行为治疗里的行为实验同样要求来访者去做一件结果不确定的事，但指向外部结果，用来检验一个已被命名的预测，而且来访者知道自己在做实验，框架本身是他消化得了的；亲自动作的行为在做之前连“我在做什么”都说不清，新的框架是动作的产物而非前提。辩证行为治疗的相反行动要有一个明确要对抗的靶子，用反向的行动去抵消情绪冲动，靠反复操练成习惯；林女士的困境恰在无靶可打。精神分析传统里的见诸行动同样亲自、同样不可预演，但被旧叙述吞回，没有卡住旧框架，此点前已论及。巴迪欧（Badiou，2007）的“事件”与主体的生成之间也有家族相似，不过他的事件稀有而宏大，一生难得一遇，而这里讨论的是微到只改变了“对某一类感受的自我参照”的单位，它的尺度是一个电话、一次呼吸、一次闭眼。最后是治疗过程研究里的突发性增益（Tang & DeRubeis，1999）：它描述了来访者有时在一次看似平常的会谈之后骤然好转，是现象层面的记录；亲自动作可能是其中一个子类的机制假说，却没有任何理由认为所有突发性增益都由此而来，这一点本章不作主张。

这些切割合在一起，指向一个相当具体的位置：本章要保留的是“归属”，即变化是否在当事人自己的名下发生，而不是变化的大小、速度、深度或体验的强度。成功与否不决定它，次数不放大它，理解与否不是它的前提，关系好坏也不是它的条件。它与每一家相邻的概念都有交集，但交集处总有一处不重合：它必须是动作，必须由他做，必须此前没有门类可放，做完又不能被旧框架收回。

◆ 五、与势能论的相反预测

回到沈女士。还有另一条回答“治疗为什么有效”的思路，这里称为势能论，出自本书作者的论文《能量侦探的诚实边界》。它认为被长期锁住的人并非能量亏空，而是能量被旧防御循环占用；持续的安全在场使旧防御内部出现矛盾，运转效率下降，挤出一笔暂时的势能冗余；这笔冗余在适时的介入下被截留、重新定向，新的结构才有机会由内而外长出来。势能论对失败也有硬的说法：冗余不足时强行触动旧结构，会引起退缩、同盟波动乃至脱落。这一部分与本章并不冲突。顾先生的那一周落空、林女士的第二次惊吓、陈先生的消化，用势能论的话说，都是冗余与承受力的问题，本章没有理由反对。

分歧在更靠后的一步。势能论把最后那一步写成“来访者允许自己松手”，一场没有旁观者的、携带道德风险的决定；同时又把这个决定放在能量故事的内部，视为冗余足够后的承接动作。本章把这一步单独拎出来，称它是疗效的最小单位，而势能论则把它看作能量转化的一个环节。这个不同听上去是措辞问题，其实会在一个具体情形里导出相反的预测：如果势能充足，动作却由治疗师代为完成，会发生什么？

沈女士的情形就是这样的检验。设想她的力气确实够了，旧防御的消耗已经降下来，冗余出现，会谈里也有了松动的信号。治疗师若替她拨了这个电话，或者替她写了一封信交给母亲，那么按势能论，能量条件满足、障碍被清除，代办应当有效，旧循环被打破，新的关系得以展开。按本章，它应当无效，至少在本章所关心的那一层无效：沈女士此后遇到下一个“伸不过去的手”，仍然伸不过去，因为她的生活里没有发生过一件由她亲自做出的、此前没有门类的事。母亲的态度可能因此软化，这是外部结果；沈女士与自己的关系，不因外部结果而变。两种说法对同一个个案给出了相反的预期，这在理论比较里是难得的好事，因为它可以裁决。

这里需要把裁决的口径定死，不然两边都可以在结果出来之后各取所需。裁决所比较的，不是母亲回不回话，也不是母女关系是否缓和，那些外部结果两边都预测会改善。比较的是三个月后沈女士自己在新的、类似的处境里有没有亲自发起同类动作。可以设想一个对照：势能条件相当、同样出现冗余信号的两组来访者，一组由本人完成了该做的事，另一组由治疗师或亲属代为完成同一件事，替他打电话，替他递辞呈，替他道歉。若三个月后两组在行为模式的变化上无差异，本章的核心限定“不可代偿”即被证伪，剩下的只是“某件事被做成了就会有所帮助”这条常识。若代办组在外部处境上好转而在自行发起上没有变化，势能论中“代办有效”的那一半就要收回。这是一条方向完全相反的预测，尚未检验。

两边都要承认自己可能输。势能论的坚定拥护者可以说，代办之所以有时无效，是因为代办发生时势能其实并未足够，所谓“冗余充足”是我们事后的误判，这样势能论总能保全自己。要防止这一手，需要一个独立于结果的冗余指标，比如会谈时间边界的松弛、自我监控用语的减少，在事先编码，不看结局。势能论的作者自己也承认过，这类独立判据目前还只是方向，没有兑现。本章对自己的要求相同：“动作是否此前没有门类”也必须有事先可编码的标记，例如来访者在做之前说不清它属于哪一类，做完以后用的是溢出治疗师措辞的语言，而不是靠结局倒推。双方都有未还的债，裁决才是公平的。

为了让这条预测不停留在抽象里，不妨把沈女士的两条路径各自可能留下的记录写出来。若电话由她自己拨出，记录里大概会有这样的东西：她在拨之前说不清自己会说什么，也说不清这算“和解”还是“尽义务”；通话很短，母亲的回应平淡；她回来讲述时用了治疗师没有用过的词，比如说“我听见自己的声音是抖的，但它是我的”；两个月后，当她与同事有一次拖了很久的澄清要做，她没有再说“要是有人替我就好了”，而是先说了“这个我得自己来”。若电话由

治疗师代打，记录里可能是另一幅图景：母亲的反应更热络，母女开始互通消息，沈女士讲述时用的是治疗师说过的词，“多亏有人帮我把这个结解开了”；两个月后遇到同事那件事，她又一次说起想要一个替她开口的人。两条路径的外部结局可能都不坏，差别只在读数的最后一栏。

在这一点上，势能论和本章其实很近，近到有可能是同一件事的两种写法：势能论把最后那一步放进能量的账本，本章把它单独列为一个单位。如果代办组与本人组的差异最终只在“势能是否足够”这一变量上消失，也就是说，一旦控制住冗余，是谁拨的电话就不再影响三个月后的轨迹，那么本章的独立命名就该被撤回，并入势能论。这是本章对自己的又一道门槛：它不仅要与行为治疗的邻居分开，还要与最亲近的对手分开。

还要补充一点势能论没有说，本章也不敢说满的东西：代办不等于全无价值。在来访者储备耗尽、处境危急的时刻，替他把电话打出去、把事情办成，是应当做的，那时讨论“亲自”是奢侈。本章说的是力气够的人，在力气已经够的时候，别人代他把手伸过去，他得到了事，失去的是那个动作。代价是否值得，取决于他还要不要在自己的名下发生点什么。

◆ 六、两个躲不掉的质疑

第一个质疑来自怀疑论者：怎么确定那是“发生”，而不是来访者的迎合和治疗师的一厢情愿？顾先生的第一次“找到”恰恰接在治疗师的邀请之后，一位怀疑论者完全可以说，他是按暗示去体验，再把治疗师想要的东西汇报了回来，眼泪也许只是对一份温和压力的情感反应。林女士的三次呼吸，则可以读成对既有技能的一次微调。对这个质疑，本章没有终极的答复。任何一次具体的“发生”，都不可能被证明不是暗示。能做的是提出两个具有一定独立鉴别力的读数，把迎合的概率降下来，而不是降到零。

第一个读数看语言的去向。迎合性的改变，事后的讲述通常可以无损地翻译回治疗师给出的框架：“我按你说的做了，确实有用。”亲自动作之后的讲述则常常溢出这个框架。治疗师说的是“那个感觉”，顾先生回来说的是“一个在我身体里等了我很久的人”。这中间的语义跳跃，迎合难以解释，因为迎合擅长的是精确复现被期待的材料，很少生出连自己也说不清的隐喻。林女士说“那个冲动还在那里等我”时，用的是技能训练的语言；说“可以插入一个动作”时，她并不是在复现任何一个技能的名称，是在为一个尚未命名的结构找词。第二个读数看时间中的存续。迎合在期待撤去以后会消退，动作留下的参照点则不依赖治疗师的持续强化。顾先生之后焦虑仍会来，但他“知道里面有一个在等他的感觉，也有一个在骂他的声音”，这个知道没有被抹去。林女士第二次没能做完、随后又自伤了，那次自伤须按安全流程另行处理，不因这个读数而变轻；她仍然知道“曾经有一次，我在冲动和我之间插入过一个动作”。

这两个读数叠在一起，也无法证明每一个被指认的事件都不是迎合。它们只给出一套原则上可以由第三方使用的依据：不看治疗师相信什么，看来访者此后的语言与行为有没有出现治疗师指令无法覆盖的特征。这套依据能不能被稳定使用，也就是不同观察者能不能认出同一个动作，是另一个尚未验证的问题，下一节的判错条款把它写成了条文。

第二个质疑来自行为治疗：你说的新的自我参照，不就是一种更隐性的认知重构，只是在时间上延后了吗？凭什么说是质的区别？本章的回答要避开一个容易掉进去的陷阱，即争论行动与信念谁先谁后。分界在于，在行动之前，来访者有没有一个现成的框架去容纳这个新体验。行为实验里的来访者，哪怕说“我不太相信换个角度想会有什么不同，但我试试”，他的“不太相信”本身就是已有框架内的判断，他知道那个替代想法是什么意思，只是怀疑它灵不灵。亲自动作发生之前，来访者没有这样的框架：“闭眼找一个身体感觉”在顾先生的责任与

效率世界里没有门类，“把手放在堵得最厉害的地方”在林女士的技能分类里没有对应。一端是在已有的认知框架内检验一个可能的改版，另一端是在框架之外做了一件事，框架在事后才长出来容纳它。前者是框架内的操作，后者是框架的发生。

有一个现象可以帮助分辨。如果这是更隐性的认知重构，那么它应当能被标准的认知重构语言回溯性地重述。但是顾先生与林女士都抵制这种重述，他们使用的是一种新生的、试探的、轮廓不清的语言，说完常常补一句“我不知道我在说什么”。这种自发的语言挣扎，是亲自动作区别于更隐性的认知重构的一个可以观察的痕迹，当然也只是痕迹，不是证明。

第三个质疑针对本章自己的理论姿态：既然任何持久的改变，事后都总能找到一个“亲自做过的小事”，这个概念会不会变成一张什么都装得下的网？人总是做过些什么的，顾先生每天闭眼，沈女士哪怕不打电话，也会在别处做点别的事，只要有改变，总能追认某个动作为它的源头。这个批评是对的，而且是危险的，它正是任何以“某个小单位”解释一切的理论常见的死法。本章只能用约束自己来回应：动作必须在改变之前被记录，不能在改变之后被追认；“此前没有门类”必须以做之前的话语为据，而不是以事后的感慨为据；最后，第三方识别的一致性必须过关，否则连这个概念本身都应被判为叙事。至于有些改变确实找不到这样的动作，本章也不予强求，本章最后一节会说，这类改变可以另有来路。

◆ 七、承重判断、读数与判错条款

到这里可以把本章要承重的判断说得完整一些。治疗里存在一类事件，它的单位小到一个电话、一次呼吸、一次闭眼，它由来访者自己完成，在完成之前没有现成的意义门类可以接住它，完成之后又无法被旧框架收回，并且在他此后进

入类似处境时改变了他看待自己的方式。其他一切，理解、关系、安全、勇气、技术，可以是这件事发生的条件，也可以在没有这件事时堆得很高而没有结果。这个判断不反对共情与同盟的平均正效应，两个平均效应都是实在的，它们大体处在条件的位置；本章问的是在条件齐备而仍旧不动时，还有哪一个单位可以独立核对。

这一判断与本书开头确立的那个平均事实并不冲突。同盟与疗效、共情与疗效之间的相关，各自在.28左右（Flückiger et al., 2018；Elliott et al., 2018），是一个稳定而为正的数；本章没有说这个数在顾先生或沈女士那里是错的，更没有说关系与共情可有可无。平均的正相关之下，另有一些位置，那里条件再好也只是条件，一个动作有没有被亲自完成，决定了条件是否会变成改变。把这两者放在一起看，同盟高而不动的个案不是同盟的失败，而是同盟没有越过它自己的职责。

读数。本章判断对应的、事后可以记录的现象是这样的：在某一段治疗之后，能否从会谈记录、来访者自述和第三方报告里找出一个由来访者亲自做出的动作，同时满足三点，做之前来访者说不清它属于哪一类事，做完以后他的讲述语言溢出了治疗师当初的措辞，之后三个月内在类似处境里出现了他自己发起的同类行动或同类的自我描述。这三点各有各的记录方式，不依赖治疗师对疗效的看法。读数不是测验，也不构成对任何个案的评分，不能拿它去催促来访者做点什么，一旦它变成“这周有没有做那件事”的追问，它就变成了一份作业，也就掉进了陈先生的那种消化里。

全书第二条判错条款（尚未检验）：本人做与他人代做。取势能条件相当的两组来访者，一组由本人完成某个此前拖延的、无人可代的动作，另一组由治疗师或亲属代办同一件事，若三个月后两组的行为模式变化无差异，本章的核心限定被证伪。

本章另有两条判错条款，同样尚未检验。其二，第三方可识别性。取二十例治疗记录，由两位不持本章立场的督导各自独立标注是否存在“不可代偿的亲自动作”，若两人的一致性接近随机水平（κ小于.2），说明这个概念没有可操作的辨认标记，本章停留在解释性叙事。其三，来源之分。把动作按发起来源分作两类，治疗师布置的、来访者自己提出的，若两类在后续变化上无差异，本章对“亲自”的强调就无法与普通的行为作业区别，只能退回行为治疗的家庭作业之列。这一条对本章自己的案例最不客气：顾先生、林女士、陈先生的动作都是治疗师先提议的。若两类无差异，这三个案例不成问题，“亲自”这个限定却站不住；若有差异，这三个案例只能算边界情形。这三条并不友善：任何一条成立，本章的主张都要被收缩，而最便宜的一条，失败个案的重新编码，现有的过程与结果数据里也许就能做完。

善意的代劳在这里值得再停一下，因为它最容易发生在最爱来访者的人身上，且几乎总是以好意的面目出现。家属替他打电话、替他向领导解释、替他向孩子道歉，治疗师在他卡住时替他把话说完。这些做法没有一件是坏事，在许多情形下是对的，本章所说的限制，只在力气够、位置属于他、动作尚未被亲自做出的那一类场合。那类场合里，代办的每一次成功，都在悄悄把一个本来可以在他名下发生的动作，转记到别人名下。没有人想要这个结果，而这个结果也不会在任何一次代办中显形，只会在很久以后，以“他怎么什么都要别人来”的疑惑浮出水面。

失败与不适用。这个单位有它的盲区，至少四处。第一，缝隙可以被误认。陈先生的握拳显示了这一点：并非所有逸出控制的细小动作都是缝隙，也并非所有被完成的小事都是亲自动作。误认不会被理论提前阻止，只能在事后从来访者的反应里读出来，而治疗师一旦读不出来，反而会倾向于把所有小事都读成动作。第二，承受力不够时，缝隙带来的首先是惊吓，林女士第二次手放上去便是

如此。对于自我结构严重缺损、储备耗尽、有急性危机或自伤自杀风险的情形，本章不适用，此时需要结构化的帮助与安全流程，“亲自”二字不能成为任何人退后的理由。第三，当来访者的处境本身不允许他自己动手，比如他被限制在无法联系任何人的环境里，这里谈不上“可以等他自己做”。第四，理论自身的自反：全章的叙述仍然停留在“治疗师放下邀请，来访者做出动作，改变随之而来”这根因果线上，这根线本身没有被审视。动作与邀请是否前后相继，还是在同一个场里互相发生，是下一章要碰的问题。

最后还要承认，亲自动作很可能在一部分来访者那里根本没有出现的位置。有些人的改变来自环境的整体变换、药物、一个新的亲密关系，或时间本身；本章不主张所有的改变都要经过这样一个单位。它主张的是更窄的一句：当改变发生于来访者尚未亲自命名、亲自发起的地方时，找一找那个动作。

前面几章里，椅子是一把一把被空出来的：懂的位置，给的位置，判的位置。本章说的是椅子空出来以后，某个人在上面做了什么，这件事是最容易被写成“治疗师在最后一步推了一把”的地方。下一章要对这个误读正面动手。它要问的是，若在最后一步之前，来访者那个“卡住”已经是两个人共同做出来的，那么治疗师连站在互动之外去“放下邀请”的位置也没有，他放下的邀请本身，是否已经是场里的一部分。

◆

08

第8章

卡住的东西是两个人做出来的

两个人抬一只旧衣柜下楼，在楼梯拐角停住了。前面的人说“你往上抬一点”，后面的人说“是你转得太早”。柜子确实太长，拐角确实太窄，可这两件事从头到尾没有变过：柜子在此前的每一级台阶上都走得通，唯独此刻走不通。卡住的是这一刻，两个人的角度、手上的力道、各自对对方下一步动作的预期，恰好凑成了一个谁也松不开的配置。把柜子放在平地上，没有人会说它卡住了；让其中一个人独自去抬，柜子根本离不了地，也谈不上卡。这个卡点既不在柜子里，也不在任何一个人身上，它只存在于两个人加一只柜子的这一次组合里。

心理治疗里的“卡住”常被说得像柜子里的毛病：来访者的某个循环断了，某个信念锁死了，某段经验没有被消化。治疗师的任务于是顺理成章地成了找到那个毛病，选一件趁手的工具，把它修好。前面几章一路讲下来，写的是三把椅子被好意占住，写的是位置空出之后改变才有机会发生。读到这里，一个问题不可回避：谁来判断椅子该空、什么时候空、空到什么程度？如果治疗师能够站在互动之上，看清此刻哪把椅子被占了，再决定是否起身，那么“让出位置”这个动作本身，就是一次居高临下的操作，位置不但没有让出去，反而被占得更稳。本章是全书的裁判席，要审的正是这个立足点：治疗师有没有一块可以站在互动之外、读取来访者内部状态的高处。本章的回答是没有，并且这个“没有”改写了人们理解成功、理解失败，也理解流派的方式。

◆ 一、接缝：站在互动之上的预设

先从一个整合构想说起，它值得认真对待。这个构想出自一份未公开的手稿，无从引证，这里只转述大意。它可以称作“接上循环”：人内部有一个负责生成新体验、修正旧结构的循环，心理痛苦是这个循环在某个功能节点上断了或锁死了，治疗就是找到断点，把它接上。它的贡献很大。它把各个流派从“谁掌握真理”的争夺中拉出来，改认为每个流派都握有一批擅长撬开某类断点的工具；它也因此能够解释，为什么认知行为治疗在惊恐障碍上反复占优，原因是惊恐障碍的主导锁死形态恰好是它那套技术专门打磨过的对象，起手路径匹配，与理论孰对孰错无关。这种说法比“所有疗法同样有效”的礼貌共识锋利得多，也比任何拼盘式的整合更不回避差异。

但这个构想自己交代过一个失败案例，接缝就藏在那里。蔡先生（说明性合成案例）长期陷在职场冲突里：上级一批评，他就自动把它读成蓄意攻击，随后愤怒回击，关系恶化，被迫离职，旧信念又得到一次确认。治疗师判断他的主导锁死形态是结构性的压制，起手用苏格拉底式提问，温和地请他把五次冲突拆开比较。提问起了效。第五次会谈，蔡先生第一次承认了一个反例：某位老板在方案上批了许多修改意见，语气生硬，但技术上并非全无道理。治疗师认为判断正确、工具精准，继续沿着认知层面推进。到第七次，蔡先生沉默许久，说了一句谁也没料到的话：自从我开始怀疑自己是不是反应过度，整个人反而更累了，现在半路就把自己拦住，既不敢生气，也不敢不生气。第八次，他没有再来。

整合构想对这个失败的剖析既坦诚又有分寸：旧结构原来还承担着一项没有被看见的保护功能，让他不必面对“可能是我自己有问题”这个比丢工作更难堪的羞耻，也让他在愤怒里仍保有行动的力气；地基被撬走一部分之后，他既回不去旧庇护，又来不及长出新的锚，于是悬在半空。这段分析准确，准确到刚好可

以合法地放过一个问题。失败被归于一次诊断上的遗漏：治疗师没有看见保护功能，没有看见土壤已经枯竭，说到底是扫描的颗粒度不够细。

“扫描”“诊断”“颗粒度”这一族词共享一个没有被审查过的预设：治疗师可以站在互动之上，把自己和来访者之间正在发生的一切当作外部对象来读取。他像机师读仪表盘那样读来访者的语言、情绪和身体，判断此刻是哪个齿轮咬死了，再从工具箱里取出相应的扳手。读取、匹配、撬动，无论这套动作被说得多么流动，多么反对手册化，它仍然依赖同一件事：存在一个可以被客观识别的内部锁死状态，等着被准确扫描。

蔡先生的脱落把这个预设逼到了必须回答的地方：他前几次会谈里呈现的那个“可以被认知提问撬开一条缝”的形象，究竟是独立于治疗师读取之外的客观事实，还是至少有一部分，是治疗师持续递出的苏格拉底式提问共同显出来的？第七次会谈上那阵剧烈的疲惫与焦虑，未必是被漏扫的潜伏灾害。更合理的读法是，前六周治疗师始终停在认知这一个维度上，每一个提问都在传递同一条未说出口的元信息：你的问题出在这里。至于“你此刻脑子里两种声音打架的这种累，我们先一起待一会儿”，这样的邀请从未发出。蔡先生的身体很可能早就在用越来越长的停顿、被忽略的一声叹息说着别的事，而治疗师因为对自己“判断准确、工具精准”的合理自信，注意力锁在同一个维度上，没有切过去听那些不属于“结构”的线索。这种锁定不是一次性的失误。当一个人认定自己的任务是读取内部断点，凡不合当前读取框架的线索，就会被持续过滤，或者归入噪声，直到来访者用脱落这个最大的噪声逼他听见。

批评者在这里有一个合理的质疑：脱落究竟说明“读取”这个动作本身有问题，还是只说明这一次读得不够细？假如治疗师把结构压制、保护功能、土壤枯竭都读到了，也许第三周就会调整，蔡先生就不会走。这个质疑必须正面回答。回答在于，读取无论训练得多细，都要借助一套先在的分类系统才能运作，每一

次读取都已经包含了把来访者活生生的体验归入某个已知类别的动作。归类一旦完成，两个人之间就多出一道不对称：治疗师“知道”来访者卡在哪里，来访者不知道，或者只知道自己难受，不知道那叫什么。这个梯度未必带有敌意，也未必不真实，要紧的是它会从来访者那里引出什么。可能引出配合（“医生说得对，我就是这个毛病”），可能引出抵抗（“你只是在套我”），也可能引出更深一层的被审视感（“你又在分析我”）。三种反应有一个共同点：来访者的注意力从“我此刻正在经历什么”被挪到了“我在你眼里是什么问题”。分类系统由此成为插在两个人之间的第三方，抢在两人的直接感知之前去中介他们的关系。一个颗粒更细的诊断，仍然是一个诊断。

于是旧的地基自行松动，原因与它是否精致无关。它要求治疗师站在河岸上读水流，而治疗师自己也站在河里；他伸下去测流速的那根标尺，本身就在改变水流的方向。这个预设可以称为元观察者预设：治疗对话之上存在一个超出具体互动的第三方位置，治疗师可以站在那里客观地观察、诊断、校准自己与来访者的互动。蔡先生的案例里，这个预设用一套漂亮的诊断语言，遮住了一个更根本的事实：治疗师的诊断不只是在描述一个锁死的循环，它本身已经在与来访者的互动中，长成了这个循环新增的一环。

◆ 二、可处理性不是天然的

沿着这条断崖往下，需要重判“卡住”本身的地位。若治疗师无法站在互动之上读取来访者的内部，那么所谓“循环的断点”就不是一件等待被发现的东西，而是一个在特定对话里才被共同显出、共同指认的交互事件。它先要被“构出”，之后才谈得上被“接上”。

这不等于说痛苦是治疗师造出来的，那是另一种轻浮的建构主义。来访者踏进诊室之前就已经在痛了。可是痛苦的“可处理性”并非天然具备。设想一个人

长年被“我不配被爱”的内在审判折磨。他向朋友诉苦，朋友说“你很好啊，怎么会这么想”，他听完更孤独，因为朋友的安慰是在和审判辩论，而审判根本不在辩论的层面上运行。他自己读书、写日记、冥想，对审判做的一切处理，都发生在一个只有他自己的封闭系统里：他同时是审判的发布者、被告、辩护律师和法官，系统内的材料早已被同一套审判逻辑预处理过。这个封闭系统生产不出新的力矩。可处理性需要的，是一个能站在审判的引力范围之外、又不去和审判辩论的对话者，使“我被这个审判折磨”从一个独自承受、无从下手的心理状态，变成两个人可以同时指着说“你看，它又来了”的交互对象。在这个对象于两人之间被共同锚定之前，它甚至不在可以着手改变的界面上。

本章把这样一种交互发生结构称为共构性转化场。“场”在这里指一个界限严格的生成构造：当两个人的对话达到某种质地，他们之间会出现一个既不完全属于来访者、也不完全属于治疗师的第三方交互构造，它带着一套独立于两人各自内部循环的转化力矩。来访者独自做不到的事，比如让那场审判从公理退回假设，并且退回之后不因失去保护而崩塌，在这个构造里可以做到。原因不在场“更有力”，在于两个人的不同位置构成了一副力学架构，足以撬开单个人永远撬不开的死锁。

场有三个结构特征。必须先说明，这样逐条列出是事后回溯的分析性拆解，在临床现场它们几乎是同一个过程的三个侧面，没有哪位治疗师能在对话当下分心去核对“第一条有了没有，第二条在不在形成”，那只会把他从场里拽走。读者若读完之后脑中浮出“第一步构出第三者，第二步生成张力，第三步结算迁移”的流程图，场就已经丢了，丢的是它的全部，不止是细节。把发生拆成程序，是旧姿势最阴险的复辟：换一个更精密的名字，让治疗师继续站在元观察位置上按清单操作。

第一个特征是可交互的第三物出现。来访者习惯性的意义组织即将合拢的瞬间，治疗师的感知与应答插进一个来访者内部循环自己不会生成的停顿、偏离或重述。贝克式苏格拉底提问常被简化成一件“太认知”的技术，但它最锋利的部分恰恰不在认知：来访者刚说完“我就是个失败者”，内部惯性的下一步是“所以什么都别试了”，这时一句“这个结论的证据是什么”，不含反驳也不含教导，它只在这条自动通路的半途添了一个以前没有的节点（Beck，1976）。另一类更细的例子见于人际间传统：来访者在第六次会谈中变得异常有礼，言辞周到而无情感内容，治疗师没有去分析防御，只说了一句“这五分钟里，你好像离我远了一点”。这句话没有判断来访者内部的任何东西，它只是把一段正在进行、尚未被共同承认的“间距”放到了两人之间。此后无论来访者承认、否认还是沉默，他都要在一个此前从未抵达的界面上，和这个横在眼前的“它”打交道。

第二个特征是张力。第三物被放到两人之间后，围绕它展开的持续探索，会在来访者身上引出一种独特的体验：他既想滑回熟悉的旧模式，又被治疗师的在场拉在“先别合上，再看一会儿”的界面上。往回拽的力与往前顶的力拧在一起，产生的力矩在他一个人的循环里不会出现，因为他独自试图制造这种张力时，旧结构往往在它成形之前就把它压没了。正念练习里“观察而不驱赶”的指令，常常需要引导音频、团体或带领者在场才能稳定执行，正是这个缘故：独自面对自己的自动歼灭冲动，容易在半程被焦虑吞没。在场里，治疗师的在场并不负责消除焦虑，它只是在那股冲动还来不及抹平一切之前，多撑住几秒，让来访者第一次经验到：我可以和这个“它”待在一起，我不会死。

第三个特征是结算。张力积累到某个程度，来访者整个意义与体验的组织方式发生一次不可逆的迁移。旧认知并未被新认知取代，变化的是旧认知与体验之间的关系被重新配权：“我就是个失败者”那场审判不再是唯一有资格解释一切

经验的最高法官，它还在，管辖权却被收回了一部分。它变成可以指着说“它又来这一套了”的对象，不能再不经审查就自动签发行动禁令。旧结构的厚度、身体记忆、创伤强度都不会消失，从“我是它”到“我看着它”，这是一次管辖权的移交，旧结构的存废不在其中。这次移交并不发生在来访者的内部，它由一段持续了许多次会谈的场，一点一点结算出来。

– 一次十秒的沉默

三个特征若不落到一段具体的对话上，仍是悬空的。下面这个片段是一次设想的初期会谈（说明性合成案例），只想看一个雏形怎样在几分钟里出现，不想证明什么成功。小季，三十二岁，因长期拖延与职业停滞来谈。第五次会谈的前二十分钟，他用近乎轻快的语气讲了本周又一次没能投出简历的经过：周三晚上打开招聘网站，浏览两个小时，“认真做了笔记”；周五晚上又把笔记看了一遍，打算周六再投；周六他看了三部电影。他讲这些时带着自嘲，带着对自己“废柴属性”的幽默归档，一套检讨熟练到几乎自动。

当他说出“我就是懒，其实也没什么好分析的”，治疗师没有去挑战“懒”这个标签，只轻轻说了一句：你讲到看电影的时候，我注意到你的声音忽然轻了很多，身体也往沙发里陷下去，好像在“懒”这个字出口之前，身体里还有一件事刚发生过，我们还没来得及看它。这句话不诠释、不反驳、不安慰。它在一个来访者自己都没留意的微小身体变化刚刚发生之后追上去，把它从流动的体验里截住，放到两人之间，成为一个还没有被卷回旧叙述的雏形。它还谈不上成熟的第三物，模糊，一碰就可能缩回去，但这是第三物在前语言阶段的初态。

随后是大约十秒的沉默，小季三次张嘴又闭上。设想事后回看录像，这十秒并不空。第一次，话音落下三秒左右，他的嘴唇翕动，喉结轻轻上提，有什么东西涌到了舌根；随即下颌收紧，嘴唇压回去，肩膀在闭嘴的同时耸起不到一厘

米，没有完全放下。第二次，他的目光三次离开治疗师的脸，失焦地落在两人之间的空气里，呼吸退到只有上胸腔微微起伏。治疗师感到自己的胸腔也收了一下，那是一种被牵扯的紧，说不上焦虑。她没有开口，原因不在忍住冲动，此刻说话会像把手伸进刚结冰的水面搅一下，冰就散了。第三次，嘴唇张开时下颌明显松了，耸着的肩膀落回去，呼气深了一截。他开口，声音低了一半，语速慢了三分之一：“不是电影的问题。我一想到要把简历寄出去，就觉得自己是个假货。那些工作我根本做不了。”

说完他长长呼出一口气，胸腔沉下去一截。治疗师在听到“假货”两个字时肩膀位置微调了不到一厘米。之前十秒那种高张力的安静，在这句话和这口气之后换了质地：仍然安静，却不再是随时会碎的高压，成了两个人可以继续待在里面工作的安静。若要用语言描述，先前的安静是“我怕”，后来的是“我说了”。治疗师没有立刻接话，让这后一种安静多停了两三秒。

这不是一个已经结算出管辖权移交的完整的场。它只是一个初期会谈里的雏形：小季第一次在另一个人面前、也第一次在自己面前，把“懒”这张旧标签按住了一小会儿，让压在下面的“我是假货”被看见。看见不等于改变，但此前连被看见的可能都没有。接下来的几周里，同一个“它”被一次次靠近。有一回，小季连着两次投出简历、接到面试，忽然取消了第三次会谈，隔了一周才回来，说拿到面试通知的那一刻“浑身轻得像要飘走”，于是通宵打游戏把自己砸回地面。治疗师没有去追自动思维，把自己在他缺席那周的感受放进了对话：“你没来的这一周，我有一个感觉，好像你刚在这个房间里摸到一点‘我可能不是假货’的证据，就得跑掉，因为只有假货才能解释你过去十年为什么停在原地。如果不是假货，这十年怎么办？”小季沉默很久，说：“对。我宁可我是假货。”这句话在他独自运转的内部循环里说不出口，因为一说出，“我不想改变”和“我宁可守着痛苦”这两件相互矛盾的事就会同时摆到眼前，单凭他一个

人撑不住这幅画面的重量。在这间屋子里说了，这句话没有杀死他。它成了他与自己之间一个新的“它”，不再是“懒”，是“宁可停在痛苦里，因为痛苦至少是熟悉的身份”。旧管辖权的第一次实质松动，出现在他说出这句话、并且没有因此被自己歼灭的那个片刻。

留意这个片段里治疗师没有做什么：没有读取，没有命名，没有选工具。也要留意另一面，不要把这写成治疗师高明的证据。她那句关于声音变轻的话，换一个来访者、换一个下午，完全可能被听成“你又在分析我”。小季接住了它，是因为那一刻他已经在往那个方向靠，两人的角度恰好对上；如同抬衣柜的两个人，转弯的角度对了，柜子就过去了，没有谁事先握着全部的地图。

◆ 三、近邻：谁已经说过，说到了哪里

场这个概念若成立，就必须能经受最近邻居的逐一盘问。下面从四个不太费力的切割开始，再进入三场硬仗。

– 四家近邻

治疗联盟描述的是合作关系的质量，是否朝着共同的目标一起工作。元分析里联盟与疗效的平均相关约为.278（Flückiger et al.，2018），这是一个稳固的正相关，本书从头到尾不否认它。场却是这种合作关系在另一个维度上生出的一个构造：稳固的联盟常常是场得以启动的条件，但绝不等于场。许多联盟极好的个案，来访者喜欢治疗师、信任他、每周准时到、诚恳地讨论自己的问题，讨论却始终停留在“讲述一个已经成形的痛苦”，从未碰到“与正在运行的痛苦当下相遇”的界面。共情同理，平均相关约为.28（Elliott et al.，2018），它描述的是治疗师单方面的姿态：我努力进入你的世界，感受你所感。场是两个人共同建起的构造，痛苦不再只是被描述给对方听的对象，而是被联手放在房间里一张空椅子上，两人一起盯着它，绕着它走，试着从不同方向推它。

主体间场指任何两个人相遇时不可避免形成的、相互重叠与影响的体验空间，是一种背景性的存在条件，每一次人际接触里都在发生，与是否带有治疗性无关。场是这种背景里一类高度结构化的子类，判据只有一条：有没有一个此前不在任何一方世界里的“它”被生出来，双方围绕它重新组织各自的体验。这是产出上的差别，与程度强弱无关。至于最近发展区，维果茨基的隐喻是“够到上一个台阶”（Vygotsky，1978），场的隐喻是把脚下那块让人动弹不得的冰化成可以游过去的水。前者靠托举，后者靠松绑。一个被锁死的人若只被托举，训练中可以表现得很好，一回到真实生活，旧锁死会原样吞没一切；必须先有一次松动，哪怕一寸，最近发展区才有一块可站脚的地。

– 此时此地

第一场硬仗在雅洛姆的存在主义传统面前。对手必须以最强的形态出场。晚期的雅洛姆并非那个总能迅速把张力转成一句可讨论的诠释的技术操作者，他反复要求治疗师承担自己的存在，包括暴露自己的不确定与困惑，他的“此时此地”有时只是一句朴素的、不含分析意图的当下描述：我注意到，我忽然对我们之间的沉默有些紧张（Yalom，1980；Yalom，2002）。这样的一句话与前面治疗师在小季沉默中的做法，在外观上近得几乎无法区分，录像编码很难可靠地把二者分开：都是低声的、指向当下的、不带明显诠释意图的言语。如果切割击不穿这个最强版本，场就只是一场命名游戏。

活现处理的最强形态同样如此。成熟的人际间分析师在意识到自己被拉入活现（Jacobs，1986）之后，并不立刻端出来分析，她先在自己内部承受这件事，察觉“这几周我一直在小心翼翼地对待这位来访者”，然后等待，等到自己觉得可以开口、对方也准备好听的时刻，才说出一句类似这样的话：我注意到，我已经有好几周在跟你说话之前先在脑子里检查一遍，这种感觉你是不是也很熟悉。这句话和场里的自我指涉在形式上也相当接近。

两派在这里共享一个关键步骤：命名。看见某种正在进行的事（防御性的间距、移情性的重复、活现里的角色倒置），然后用一句话把它说出来。场与它们的分界，不在命名之后各自怎样探索那团被命名的材料，在命名之前：当那个间距、那个重复、那个角色倒置还只是一团在两个人的身体之间流动、尚未被语言捕获的紧张体验时，发生了什么。

在两派的典范形态里，治疗师凭借高度训练过的感知，迅速把这团模糊体验识别为某种已知模式的当下实例，再以一句漂亮的命名收束到洞察层面。其间若有等待的沉默，它在功能上是为命名选择时机，是诠释的序曲，命名降临时，沉默的价值才被兑现，沉默本身作为一段共同承受的经验，被洞察收编。本章要说的是另一种情形：治疗师选择不去命名，也不是因为在等待最佳时机，而是和来访者一起用身体与感觉承受那团尚未定型的张力。此时一件事已经发生，一个原先不存在的东西在两人之间出现了，它就是这团张力的被承受本身。来访者体验到的是一个全新的事件：有另一个人，在他自己说不清、对方也说不清的情况下，愿意一起待在连他自己都想逃开的不适里。这件事发生在命名之前，独立于命名，事后再精妙的命名也无法替代或覆盖它，命名能解释它，却不能复制它。命名是用语言告诉你刚才经历了什么，承受则是让你第一次以一种从未有过的方式与另一个人共在。

由此得到本章所说的存在论间距：来访者与自己的卡住之间第一次出现的那段距离，不由治疗师的语言中介，是在场直接给出的。小季没有听见“你是不是觉得自己是个假货”然后点头，“假货”是从他自己嘴里出来的。两种发生在效果上也许同样有效，多数情况下后一种可能已经足够；但前一种让“假货感”在命名之前，以它最原始的身体质地被承受了一次，并且没有因此崩塌。那一次承受本身，已经是对它长期管辖权的第一次实质性削减，与理解无关，靠的是在场中挺过了它最初的冲击。

必须立刻补上一道防线。这个区分并不主张治疗师放弃诠释，或永远沉默，那只是另一种教条。它主张的是，治疗师在出手命名之前，手边多出一块往往被忽视的原料：他与来访者之间那些尚未被语言收编、在身体里和换气停顿里流动的体验质料。先伸手接住这些质料，再决定是否开口，次序上的这一点差别，是此时此地与场的分界。也因此，操作场所需要的在场品质不同于娴熟的此时此地聚焦：一种能忍受不命名、能忍受张力不被立即解除、能在“还不知道它叫什么”的阶段安静待着的品质。如果治疗师把此时此地用到炉火纯青，一感知到张力就敏捷地转成一句可讨论的诠释，那么会谈当然充满洞察，来访者越来越理解自己，而洞察覆盖之下那段被悄悄绕开的、与原初体验的直接对峙，可能从未发生。

– 心智化

第二场硬仗在心智化治疗面前。面对处于目的论模式或假装模式的来访者，心智化取向的经典姿态恰好是不诠释：停下复杂的解释，用极简的、聚焦于当下互动的情感标记去镜映那团连来访者自己都说不清的感受。对一个敌意十足却声称“没事”的人，治疗师可能说：“我刚才好像说了句让你不太舒服的话，我自己可能都没意识到。”它同样避开了站在元位置上诊断来访者，同样锚定在“之间”，同样带着“我不确定”的态度（Fonagy & Bateman, 2006）。心智化的治疗师完全可以声称：这就是承受，我的镜映本身就是一种经过调节的共在。

本章承认，两者在外观上高度重合。分歧出现在生成前提上。心智化取向内置了一个目标状态，恢复心智化，它采用“不诠释”的姿态，是因为判断这一阶段来访者的非心智化状态承受不了诠释。而镜映这个动作的社会语法是：我看到的你此刻的感受，比你目前能说出来的多一点，也准确一点。哪怕多出来的部分只是语调、表情和一句简短的标记，它仍是治疗师站在一个有心理状态洞察力的位置上，向来访者发出的、试图把体验组织起来的信号。不诠释是方法上的选

择，恢复心智化的目标始终在背景里为操作定向。场里的承受则连这种“帮忙组织”的冲动也悬搁了。治疗师退到一个几乎与来访者同样“不知道这叫什么”的位置，区别只在于她没有被这片混乱吓跑。她的在场不提供答案，也不提供镜映，只提供比答案更原始的东西：有人愿意陪着承受混乱，不急着把它整理干净。

心智化框架会把这种做法理解为阶段性的治疗选择，在极度退行的时刻连镜映也太具侵入性，但不会把它当作一个独立的生成事件。场的立场正相反：转化的发生，不在来访者终于“懂了”的那一刻，在他第一次体验到“我不需要先把自己整理清楚，就可以被另一个人接纳”的那一刻，而这一刻在次序上不能跳过，必须出现在治疗师任何理解性反馈之前。心智化的不诠释是策略性的、可逆的，一旦来访者的心智化水平回升，诠释与理解会回到前台；场里的承受不依赖这个条件，它所创造的是之后任何心智化阶段都无法还原的原始发生：两个人一起承受了一件还来不及成为心理状态的事。

– 人际间精神分析的反击

第三场硬仗最难，因为对手几乎会同意本章的每一句现象描述。设想一位成熟的人际间分析师读完上面这些，说了下面这番话：

“你所描述的沉默，我在职业生涯里经历过无数次，那种共同承受、让对方自己找到语言的时刻我再熟悉不过。但我看不出这是新东西。你的‘刻意延迟’，在我这里叫作对活现的工作：分析师察觉自己被拉进了某种互动模式，选择先不行动，去注意它、承受它，再考虑何时、怎样展开诠释。你没有发明新的实体，你给我已有的实体提供了一份更细腻的现象学描述。而且，你的区分有三个地方站不稳。”

“第一，你说承受发生在命名之前，不依赖命名。可你凭什么知道它发生过？小季那个‘它’，是被一句‘你的声音忽然轻了，身体陷下去了’截住的。这句话已经在命名了，只不过命名度低。命名不是一道门，是一个连续的刻度，你把‘低命名度话语’归在前诠释一侧，把‘你好像离我远了一点’归在另一侧，线画在哪里，全凭你的偏好。更要紧的是，所谓‘沉默中已有第三物’，只有在事后被说出来、被双方回溯确认之后，才获得身份。这是延迟作用的老故事，事件的意义在后来的命名里才成形。你要的‘独立于命名的实存’，恰好是任何命名之前谁都无法作证的东西。”

“第二，也是最致命的一条：你一边宣布治疗师没有高处可站，一边要求她判断‘此刻不该命名，此刻该承受’。这个判断由谁来做？只能由一个在互动之内、却同时在估量互动走向的位置来做，那就是你所拆掉的元观察位置，换了一个名字回来了。我承认我在等待时机，我诚实地说这是一个判断。你把同样的判断叫作‘承受’，并宣称它不是判断，这才是自欺。”

“第三，你承认录像编码无法区分承受的沉默与等待的沉默，区分只能靠治疗师当时的第一人称体验。那么你的区分在经验上无从触及，你让我接受一条永远不能被检验的差别。”

这三条不能轻易打发。本章逐条回应，回应的方式是先认下被击中的部分，再说明哪些东西在被击中之后仍然留着，不在原地硬撑。

关于刻度。命名确是连续的，场与诠释之间没有一道可以验票的门，这一点必须收回此前说得过硬的部分：不存在“前诠释”与“诠释”的清晰两分，存在的是一个方向，即在张力还未被收束为可理解的表述之前，多少体验质料被留在两人之间、被留了多久。刻度连续并不取消方向，白天与黑夜之间没有分界线，不妨碍正午与午夜相差悬殊。至于“事后才获得身份”，场的立场并不否认事后回溯，它否认的是事后回溯足以穷尽事件：小季那句“假货”之前的十秒，改变

了那句话是以什么状态被说出来的，这个差别在录像或逐字稿里原则上是可读的（肩膀、呼吸、语速、是否低头），它不需要等到被命名才存在，只需要等到被看见。

关于判断。这是最硬的一条，回应不能躲闪。治疗师确实在判断，她不可能不判断。要紧的是判断发生在哪里、以什么性质发生。人际间分析师的“等待时机”，判断的对象是一个独立于她的东西，来访者“准备好了没有”，她站在互动旁边估量那个人的状态；场里的判断没有这样一个外部对象，它是治疗师对“我刚才那一动让这段对话发生了什么位移”的感知，这个感知同时是她自己的身体状态（那一下胸腔的收紧，那一下想说话的冲动），随着下一次对话的位移而不断被修正，也随时可能错。前者是读表，后者是在水里划，手感同时是对水的判断，也是水对手的回答。承认这一点同时意味着把话说回去：判断无处消除，“没有高处”的意思，是没有一个判断可以不被互动本身重新改写。小季的案例里治疗师那一句关于声音的话，换一个下午就可能被听成“你又在分析我”，这个风险说明她的判断始终在场内，没有一次站得到场外。

关于不可检验。这一条击中最重，所以本章在后面单设一节专门处理。这里先说结论：既然意图无法编码，检验不得以意图为对象，只能转而检验由这个区分衍生、可以用回合数去数的后果。

最后要说明这场反击还剩下什么。如果以上全部让步之后，场与人际间传统对活现的工作仍然在实践上完全重叠，那么本章的概念就应当降格为那一传统中某段实践的别称，而不是一个独立的构造。本章认为仍有两处余量，有待检验。其一是失败的描述方式：在分析师的框架里，一段始终没有通向诠释的沉默会被记作僵局或负性治疗反应，沉默的价值要靠后面的诠释来兑现；在场的框架里，这段沉默可能已经完成了某件事，诠释之后的补充只是从另一个维度继续靠近。其二是下一节将展开的，场未生成这种失败：它发生在没有任何人察觉的地方，

活现理论对此没有现成的位置，因为那里连活现都没有发生。这两处余量若在经验上站不住，反击就算赢了。

◆ 四、场没有生成，场塌了一角

场这个概念站稳之后，被改写的不只是成功如何发生，更有失败如何被描述。整合构想里的归因路径始终没有离开“治疗师对断点的诊断不够全面”，即便在它最诚实的自反时刻，也只是把诊断的颗粒度再细化一层：没看出保护功能，没看出土壤枯竭，没有质疑“诊断”这个动作是否站得住。在场的框架下，失败要换一种方式理解：对话从某个时刻起丧失了、或者从一开始就没能生成场所需的那种质地。场不是被一次错选的工具摧毁的，它是被一段始终停在读取与匹配里的对话自己锁死的。

接下来本应把失败分成几类，一类是场从未生成，一类是生成后塌了，一类是双方都以为它在生成。本章不这样做。分类会把流动的、只发生一次的失败过程重新冻成几种可供识别的故障，那等于在失败的描述上重新站回岸边，违反本章自己的前提。下面只讲两段具体的经过。

– 梅：十二周里没有留白

梅，三十五岁，因长期社交焦虑接受认知行为治疗（说明性合成案例）。她回避一切需要公开发言的场合，被安排在会议上汇报的前一晚会失眠，临场心悸、出汗、大脑空白。自动思维很清楚：“我只要一张嘴，所有人就会看出我什么都不懂。”治疗师判断主导的锁死形态是结构性的压制，起手路径是苏格拉底式提问加行为实验。前三次会谈极顺利：梅回想过去两年三次被迫的发言，每次之后都有同事说“你讲得很好”，没有一次被人当面嘲笑；她承认这些证据有分量，第三周主动报名在内部培训会上做了十分钟分享，完成后说，“还是紧张，但我没有死”。

任何称职的认知行为治疗师评估到这里，都会认为判断正确、工具精准、治疗在轨道上，录像里也看不出场没有生成。第四次会谈，梅带来了新材料：分享后，一位平时关系不错的同事走过来说“你今天讲得真好”。梅说：“我知道她是在安慰我。她平时对我都很好，她不可能跟我说真话。要是我真讲得不好，她更不会告诉我。”治疗师当场识别出一个此前被绕过的认知死锁：问题已不在“所有人都觉得我不好”，转成了“任何说我好的人，都不可信”。他做了认知行为治疗师此时最自然的事，用提问检验这个前提：“她有没有对你说过让你不舒服的实话？”“没有。”“那她为什么对别人诚实，偏偏对你不诚实？”“因为她可怜我。”治疗师继续追问“可怜”的证据，梅给出几条模糊的材料，足以继续用认知方式处理。会谈结束，治疗师判断今天触到了更深的核心信念，是进展。这个判断在手册上完全合规。

问题不在苏格拉底式提问的运用，在梅说出“我知道她是在安慰我”的那一秒治疗师所听见的东西。他听见了一个逻辑矛盾。他没有听见梅说这句话时的声音：没有愤怒，没有被冒犯的委屈，只有一种又低又平、像报天气预报的认命。假如他慢了一步，先停下来听这个声音，也许会说一句不同于检验的话：“你说这句的时候，声音忽然变了，好像你说的不是‘她很假’，而是‘我已经被这种做法说服很久了’。”这是另一条路的入口，它在锚定一个在身体里流动、梅自己还没留意的体验：多年浸泡在“被怜悯”里，对一切善意自动打折扣的躯体化的不信任。治疗师没有听见，不是听力不好，而是他的感知在那个瞬间被自己的上手语法优先导向了认知检验，体验层那条更窄、也更近梅的困境的路，被降成了背景噪声。

此后几周，对话在认知层面持续推进。梅非常合作，认同每一个重构，做了暴露作业，参加了两次公开分享，每次回来都能详细分析自己的自动思维。第八周，治疗师问她对这段治疗的收获怎么看，她说学到很多关于认知歪曲的知识，

理解了长期回避如何强化焦虑。问焦虑有没有减轻，她沉默几秒，说“有一点”，随即切换到下次的作业。她没有脱落，完成了十二周。第十二周结束时，她社交焦虑最核心的体验，也就是在任何需要展示自己的场合里，觉得自己正在暴露一个看不见却巨大的缺陷，没有被任何一次重构碰到过。

按认知行为治疗自己的标准，这是一例部分缓解：回避和恐惧水平下降，功能有所恢复，这套疗法本来也不宣称要消除核心信念。在场的框架下，这是一个场从未生成的案例，而且原因不是工具选错或诊断不够细。第一次错过那个声音质地时，事情就已决定了；原因也不在治疗师技术差，他那套训练成第二本能的感知筛选器，从根子上把他对来访者身体质感的通道调低了一级增益。他以为自己在读取断点，其实只是在读取自己的上手语法允许他读取的那一部分。场的生成需要一段没有被任何工具的语法提前组织过的空白，两个人都在“还没想清楚怎么办”的阶段共同留下来。这个案例的每一次会谈里，那段空白都被治疗师高效、精准、及时递出的提问，温柔地填满了。一分钟的空白也没有。场无处可生。

梅不是假的，她从头到尾都诚恳。她的诚恳被一条她既不知道也无力改变的对话结构过滤成了一条单向的传送带，只产出“认知素材”，产不出“可被承受的它”。没有人标记这是失败，因为所有合规指标都完成了。这类失败最难侦测的地方在这里：它与成功共用同一套可见的指标。

– 柯女士：一次撤退，和一次认账

柯女士的会谈进行到第十五次。前十四次里，治疗师与她之间慢慢长出一种两个人的身体都感觉得到的质地：柯女士说到旧伤时，不再用新闻播报式的空洞语调，偶尔会在一个词说到一半时停下，等一阵被引起的身体反应过去再继续。治疗师一直保持克制的在场，不对这些停顿做诠释，也不在她一停就追问“你在

想什么”，只用身体的静止与平稳的呼吸表示：你可以停在半句话里，我不急，你也不必急。

第十五次会谈前半段仍是这样。柯女士在讲周末和伴侣的一场冲突，说到伴侣提高音量之后，她“立刻就缩回来了，像被一只手摁住了后颈”。她说“摁住了”三个字的同时，颈部与肩胛之间那一片轻轻往上缩了一下，她自己没有注意到。治疗师看见了，这是一个窗口：用一句感受性的回应，把那个身体动作与“缩回来”这个说法放到两人之间，不诠释，只让它被看见。但就在不到半秒的时间里，治疗师脑中闪过了一个漂亮的框架，内化的迫害性客体，被摁住后颈的身体记忆，正是她内在客体关系在身体上的显现。于是他说：“你刚才缩那一下，好像你伴侣的手，和你自己身体里从小就把你摁住的那只手，在那一刻一起碰到了你。”

这句话在概念上没有错，在许多情境里是一个好诠释。但在此刻此地，它是撤退。柯女士刚说完那句话，人还浸在“缩”的余颤里，身体没有退到观察者的位置。此刻她需要的是有人先伸手进她还在被摁住的体验，说一句“是，我看到了，你刚才是那样的”，承认它就在那里，刚刚发生。治疗师的诠释在概念上接住了她的故事，在关系上避开了她的身体。他用理论接走了那个正想从私人的身体记忆变成两人共同看见之物的东西，替她举好了，她不必再举。他自己退回了理论后面的观察者位置，并不是故意的，他甚至觉得自己在做深度而临在的工作。柯女士的回应不再是对诠释的回应：“我也不知道，也许就是你说的那样吧。我本来想继续讲冲突的后半段的。”声音低了一档，语速平稳，没有情绪。她的肩膀在那句话之后靠回了沙发半寸，刚才还被她活生生重新体验的“缩”从身体上消失了。场塌了一角。

治疗师此刻有两种去处。一是顺着柯女士的切换，让她接着讲后半段，这样既保全他的自尊，也保全这场会谈事后在逐字稿里仍像一场深入的客体关系工

作。他选了第二种。说话之前，他先在身体里觉到一阵很轻的下沉，肚子在告诉他：刚才那句话，他没有在场里说。他说：“我先打断一下。我刚才那句话听起来很专业，其实是我有点不敢待在你那个动作里。我看你缩了一下，我自己也紧了一下，然后我用那句话把那份不舒服接走了。你可能觉得我突然退了一步。你说‘回去讲后半段’，我感觉你是在帮我把这个尴尬圆过去。我想跟你认这件事，我刚才没在场。”

这段话不是技术手册里的“关系修复”。它是治疗师感知到场因自己刚才那一动而塌了之后，没有逃回技术，也没有逃回诊断，把自己那一动连同背后那个微小的退缩，作为两人可以共同审视的“它”放在了两人之间。说完他没有看向她，也没再补充解释，只用安静陪着这件事多停了几秒。五秒后，柯女士叹了口气，是从一个压了很久的姿势里松开的那种。她说：“我刚才其实也感觉到了，你说那句话的时候，我忽然就不想讲下去了。我还以为是我又在逃避，每次讲到身体的感觉我就想跑。”治疗师说：“所以咱俩一起跑了一会儿。你跑你的身体，我跑我的理论。”柯女士笑了一下，嘴角只动了动，是被看见之后的松动。塌掉的那个角被撑回来了，撑回来它的并非技术，是治疗师把自己从撤退里往外拔的那个动作。

这个修复不能被写成一条方法。倘若把它读成“场塌了就认账”，它就成了新的话术；柯女士的叹气与笑意，也完全可能出现在另一个版本里：同样的话说出去，她只觉得治疗师在表演坦诚，场塌得更深。能说的只是这一次，一个人察觉自己退了，并且没有把退路继续走下去。

– 失败在哪里结算

把两段经过放在一起，失败发生在场质丧失的那些节点，不在“判断错误”的节点。丧失有三个维度，它们往往同时出现在同一段对话里，只是分析时才拆开。其一，感知被自己的上手语法优先导向了与来访者体验的生成方向不同

的一面，错过了一扇窗：梅的案例里，治疗师听见了逻辑矛盾，没有听见认命的声音。其二，张力正被共同承受时，治疗师因为承受不了它的强度而提前把它关闭，用诠释、理论、诊断或一句漂亮的命名，把张力从两人之间收走，放回来访者一个人的内部，并且递回时已是完成品：柯女士的案例里是这样。其三最难察觉，场从未生成，整段对话却按治疗师的语法高效推进，以至于没有人，包括治疗师自己，意识到场本应存在：梅的十二周。

前两种的共同结构是，治疗师在承受前诠释性张力的临界点上并非没有能力，是那套造就他成为优秀临床工作者的训练，在最需要的时刻替他备好了一条更舒服、更专业、也更远离场的退路。认知行为治疗师退回了认知检验，精神分析师退回了理论性诠释，他们都不是坏治疗师，只是在最难的节点上被自己的语法接了回去。这些退路没有一个可以被合法地辩护为错误。失败也就不是个人的疏漏，它是读取一匹配这种姿态在临床高压区反复出现的结构性后果：一段本来可以用来造场的沉默，被一台运转太好的自动应答机制悄悄填上了。

– 流派：从工具到上手语法

这样一来，流派的角色需要再修正一次。整合构想把流派从“真理的竞争者”改成了“工具的持有者”，这是一大步，但它回避了一个问题：这些工具最早是怎样到一位新手治疗师手里的？认知行为治疗的精神不止是苏格拉底式提问、行为实验、暴露等级表这些看得见的技术，更在于它让受训者在几百小时的督导里反复练习一种听的习惯：听一句话里藏着的前提，在来访者说“我就是……”的瞬间，用“这个结论的证据是什么”去拦住自动跳转。这种习惯是被一种语言反复训练出来的，练到变成第二本能。

起初，一位受训者听到“我就是个废物”，身体反应多半是胸口一紧，脑中闪过“好沉重”“我该怎么接”“我要共情”，几秒的慌乱之后，从课堂笔记里拽出一句生硬的“你这样想有什么证据吗”。这句话是工具，它还没有进入她的

身体，像一把贴着标签的扳手，能感觉到重量。几百小时的会谈、逐字稿审查与督导批评之后，有一天她说出同一句话，却没有在说之前先想“我现在应该用苏格拉底式提问”。她的听觉已经变成训练出来的身体直觉，自动从那个句子里听出了“结论的自动跳转”，提问自己从嘴里出来，像呼吸一样不必想着呼吸。扳手化掉了，化成她听人说话的方式本身，工具变成了上手语法。这个里程碑也不是毕业，不是拿到执照，是她在某次事后审阅逐字稿时，发现第三十七分钟有一句自己全然不记得想过的提问，自然到不记得“做过那个干预”。她在这时才算被流派接住，立足石就是这样来的。

也只有在这个意义上，流派之争的激烈程度才说得通。一个人攻击你的流派，攻击的是被训练出来的那个第二本能，是你被接住、被塑造、得到第一块立足石的那个过程，不是你工具箱里的一把扳手。反击因此不是学术的，是存在性的：你在威胁让我不知道我是谁。

在这个视角下，认知行为治疗在惊恐障碍上的优势，也得换一种说法。这套上手语法内置的感知倾向，听见自动思维，察觉行为与信念之间的短路，在即将闭环的认知—行为通路上插入一个微小停顿，恰好与惊恐患者最致命的困境构成对偶：他们独自面对焦虑时，内部闭环转得太快、太自动，刹车来不及工作，已冲到失控的恐慌。一个“已经学会在闭合前插入停顿”的人，和一个“被高速自动闭合反复击垮”的人，他们的对话更有机会让那个闭合第一次被刹住哪怕一瞬。这是两个人的语法之间的对应，而非工具与故障的匹配。

对偶不是常态，更常见的是错配：认知行为治疗师遇上一靠近就撤退的人，人本取向的治疗师遇上急需结构与明确指令的人，精神分析师遇上把一切沉默都体验为拒绝的人。如果只能等待匹配，理论又退回到匹配的老路，只是这回匹配的是语法。错配自己不会生成场，更容易生成的是互相误读、防御升级与脱落。可是错配的张力一旦被承认而不是被技术性地修补，就可能成为造场的原始材

料。设想一位认知行为治疗师面对被关系创伤浸透的来访者，一味调高自己的认知聚焦，只会像用错号的扳手去拧锈死的螺丝，越用力滑得越远。如果他在某个瞬间意识到，自己的语法本身已经成了对方撤退的新理由，越精准地聚焦思维，对方就越觉得被审视，被要求去完成一项他此刻没有内部力气做的任务，他就面对着一件手册上没有写的事：停下来，不是为了换工具，是与自己赖以站稳的这套语法拉开一寸距离，用低命名度的话把两人此刻的错配放到桌面上：“我发现我一直在问你很多问题，你也一直很努力地回答，但每次我问完，你的身体都往后靠一点。也许我这些问法，是你现在最不需要的东西。”

这句话不属于任何一个流派。它不指向认知，不是共情性反映，也不是移情诠释，它指向对话本身的结构。流派所提供的语法因此有双重身份：对偶时是场的加速器，错配时它的盲区可以变成造场的材料，前提都是治疗师不再把自己的流派当作相对于来访者“客观更优”的工具，把它看成一件自己身在其中、也因此能被来访者看见、被来访者回应的存在物。这与抛弃流派无关，也谈不上忠于流派；它是让流派成为一个可以被两个人一起看着运转的“它”。

这个视角还给出一个值得追问的方向：经验增长为何没有带来疗效提升。一项大样本研究覆盖170位治疗师、6,591名来访者，没有发现治疗师疗效随从业时间改善，平均反而略有下降（Goldberg et al.，2016）。本章不声称上手语法的固化解释了这个结果，那是尚未检验的猜想；只说，若语法越熟越像第二本能，它同时也越容易在最难的节点替人备好那条退路，这与该研究的方向并不抵触。

◆ 五、高墙、读数与红灯

– 先说那堵高墙

本章最核心的机制，前诠释性承受与刻意延迟，撞着一堵行为测量难以越过的墙。在录像编码里，一段“治疗师悬搁诠释、与来访者共同承受前诠释性张力”的片段，与一段“治疗师在等待合适的诠释时机”的沉默，或者一段“心智化取向的治疗师在做低度镜映而不急于解释”的片段，外显行为上极难分开：都是长沉默、低频率言语、治疗师面部平稳。编码若只能捕捉有没有说话、沉默多长，不能触及治疗师当时的第一人称体验是“我在承受”还是“我在等时机”，那么凡以录像行为计数为基础的随机对照研究，在检验这条最核心的机制时，实质上无法胜任。本章在这里直接承认这一点，也承认第三节里人际间分析师的第三条反驳在这里是成立的。检验不能以意图为对象。

退而求其次的做法有两条。一是方法上引入超出行为计数的路径，比如逐字稿的微观现象学编码，它不只编码沉默时长、话轮转换，还编码对话的体验质地（来访者声音忽然变轻，治疗师停顿里保持的是邀请性的沉默还是技术性的沉默），其方法论背景可参考第二人称描述主观经验的研究（Petitmengin, 2006）；它自己也面临评定者信度的挑战，但比纯行为计数更近于本章关心的机制。二是检验由这个区分衍生出的、不直接测量“承受”的间接后果。

– 读数

本章的读数是一个事后可以记录的现象：在逐字稿中，从可被锚定的张力出现（来访者的话里、声音里或停顿里出现了一个双方都未命名的东西）到张力被命名收束之间，隔了多少个谈话回合；并且在这段间隔里，来访者的话里是否自行出现了此前没有的说法。第二个条目把“延迟”与单纯的冷场分开：同样隔了十个回合，一段是来访者自己说出了新的话，一段只是双方都在回避。读数只是记录，不据此给治疗师打分，也不是对着它去练习的目标。

– 判错条款

以下条款均尚未检验。第一，过程聚焦参与度，即治疗师把来访者或两人之间正在发生的过程（而非过去经历或未来计划）锚定为焦点、并且不急于闭合地让张力持续展开的程度，以上述延迟回合数作代理。控制了联盟强度、来访者基线严重度与治疗师年资之后，若它在多次独立、方法逐步严格的研究中仍与疗效没有增量关联，也就是改变完全可以被联盟质量、积极期望与来访者初始特征所穷尽，那么共构性转化场这个概念就失去独立存在的理由，应当并入“治疗性在场”这一簇旧概念。这条是本章的核心判错条款，它撤回的是全章。

第二，语言形式与身体经验的分离。本章认为，治疗师那句从共谋中拔脚而出的自我指涉，效力不来自“我们好像一起在……”这个句式，来自它是否从治疗师自己被拉入共谋的身体体验里说出。一项三组准实验可以检验：一组治疗师只学这类干预的语言形式；一组先接受数月的、围绕自己如何被拉入共谋的体验式督导，再学语言形式；第三组为对照。如果仅学语言形式的一组就产生了显著增量，本章对“效价不在技术形式”的论断即被证伪，它说的就只是给一种可以技术化的有效干预披上了哲学外衣。

第三，跨出诊室的预测。场的第二个支点是一个同样承受着那段未定型张力的在场的另一个人，只要同时满足三个条件，应当出现同一类转化力矩，无论是否称作心理治疗：①有一个承受着同一段张力的在场的另一人；②这个人不急于把张力收束成可理解的表述；③双方都不能低成本离开。这三条在长期临床督导中督导者不急着给出解读的时段、师徒传承里师傅在徒弟卡住时既不示范也不解释的那段陪站、安宁疗护里医护人员与家属无话可说时的共同在场，应当同时具备。两处应当不复现：一是可随时中断的异步文字咨询，条件③不满足，预测其转化效力显著低于同等时长的同步会谈，且这个差距不能用信息带宽解释掉，因为视频会谈的带宽低于面对面，其效力却应接近面对面；二是以效率为考核的短

程干预，条件②被制度性取消，预测其中延迟时长与疗效的相关趋近于零，而不仅是变弱。若在督导、师徒、安宁疗护三处中任意两处，独立编码的延迟时长与结果之间没有关联，第二支点就不是结构条件，只是心理治疗行业的一个局部习惯。

– 红灯

读到这里，最要紧的一条要补在最后。本章的核心概念有一个几乎必然发生的命运：被从它赖以生成的土壤里拔出，移植进一份“高级治疗技术清单”，成为治疗师在会谈中低头核对的一项。一位年轻治疗师读到小季那十秒的沉默，下周对着自己的来访者暗想“我需要刻意延迟”，沉默到第七秒，低头看了一眼表。那一刻他已经不在场了，他的“延迟”是从书上学来的一个动作，没有从与这位来访者之间那个独一无二、不可重复的张力里长出来。

红灯是这样的：如果你发现自己在会谈里正为“是否延迟了诠释”而焦虑，如果沉默中你感到的不是对来访者此刻体验的关注，而是对自己“延迟得够不够久”的计量，请立即停下，停的是自我计量，会谈照常。那个在计量你的人，就是刚从这一章里拿到新名目的元观察者，他已经站回了河岸，正看着河里的你。场在他站上去的那一刻就塌了。这份材料从头到尾只能用于事后：在你已经做完该做的、场能生就生了、不能生也没生之后，回看录像，帮助辨认当时没有意识到的、场正在发生或正在塌掉的瞬间。在场的时候只能做一件事，在场。同一个身体不能同时待在两个位置。

由此也可以说清这一章的适用范围。它所讨论的，是来访者有足够的自我结构和心理储备去承受一段不被立即解决的张力的情形。自伤自杀风险与急性危机，自我结构严重缺损，心理储备已经耗尽，都不在其内；那些情形里，“不急于闭合”可能意味着让一个人独自泡在无法承受的东西里，结构化的帮助与安全

流程应当居先。这条界线不是客套，它与上面的红灯是同一类东西：场只有在承受得住的时候才是场，承受不住时再多的“陪伴”也只是旁观。

— 裁判席

回到开头那只卡在拐角的衣柜，本章的判决可以说得简单。整合构想里隐含着一位站在楼梯口、看清拐角几何、指挥两个人如何转的第三者，前面各章讲“让位”“撤离”“不再填满”的人，如果不小心，也会悄悄请回这位第三者：他判断此刻是该抬还是该放，是该让还是该退。本章的判决是，楼梯上没有这样的第三者。治疗师是抬柜子的两个人之一，他的每一个动作都在改变拐角的几何，包括那个“我先退一步”的动作；他能做的，只是在感觉到卡住时承认是两个人的配置，而非来访者身上的毛病，并且承认自己的那一份。他可能因此做得更好，也可能因此做得更糟，没有一个高处可以事先担保。这一点既不能被写进清单，也不能靠承认来豁免。

下一章要处理的是这个判决留下的账：如果最深的治愈只能在这样一个不可重复的场里发生，它被谁目睹，又被怎样记录。一件只发生在两个人之间、被事后归因时要丢掉一部分构成性信息的事，是否进得了证据库，这正是第9章要问的。

◆



第　四　编

这笔账记给谁

编　序

改变发生了，功劳记在谁名下？这一编只有一章。第9章提出归因敏感度：有一类治愈，一旦被归入某个流派、某项技术或某位治疗师的账目，它最要紧的部分就变了形。

这一章对循证研究没有敌意。它问的是证据库按什么录取，以及什么东西因此进不去。

09

第9章

最深的治愈进不了证据库

林岚三十五岁，在一家公司做中层管理，因为长期焦虑和间歇的惊恐发作来求助（说明性合成案例）。她此前做过两轮认知行为治疗，呼吸调节会了，认知重构也会了，焦虑袭来时能熟练地认出自己的“自动思维”，再用提问去检验那些灾难化的预测。她对这些技术的评价是：像外墙上的涂料，表面看着好些，里面什么都没动。两轮治疗的曲线也印证了她的说法。第一轮期间惊恐每月发作二到四次，结束后没有明显变化；第二轮的最后一个月只发作了一次，可治疗一停，三个月内就弹回每月三到五次。好一点，又回去，她为此换了一位不以认知行为治疗为主要取向的治疗师。

新的治疗里，她的关系模式很清楚。每当受伤或失望，她会迅速撤回到自己称作“待机状态”的地方，对外礼貌而称职，对内关闭一切期待。童年时她被抑郁的母亲和暴躁的父亲轮流淹没，最安全的活法是做一件没有需求的家具，在场，但不发出任何信号。“不说，就不会再挨打。”这句话她后来原样讲给治疗师听过。

第十三次会谈，她坐在那里，肩膀收紧，一言不发。治疗师看见了这一切，没有追问情绪，没有带她做身体扫描，也没有去检验“我在治疗里必须开口”这个信念。一阵平缓的沉默之后，他说：“也许今天不是说话的日子。”林岚事后这样回忆：好像有一扇门，她一直用肩膀死死顶着，这时有人告诉她可以不顶了。此后三个月，惊恐发作消退到零，六个月后随访仍是零。她开始能在亲密关系里说出自己要什么，她的解释是：不是学会了某种沟通技巧，而是“不说就会

挨打”的那个世界，在那一刻被证明不是唯一的版本。现在问一个简单的问题：这句话的效力从哪里来？

◆ 一、一句话，三份账

最先伸手的是各个流派，每一派都能当场把这句话收进自己的账本。认知行为取向的同行会把它登记为建立安全同盟的操作范例，并补一句：安全的同盟是暴露类工作起效的前提。精神动力取向的同行会说，来访者把治疗师体验成又一个必须被“搞定”的权威，这句话打断了强迫性重复。人本取向的同行会说，这就是无条件积极关注，她的沉默被整个接纳了。三份账都写得通顺，也都不算错。

可是三份账做了同一个动作：从一件完整发生的事里，剪下自己的理论语言消化得了的那一块，宣布这一块才是起效的成分。一个出现在特定的人、特定的关系、特定的生命史交汇处的事件，被切开、提纯、编号，成了某一派功劳簿上又多出来的一个数据点。被剪下的部分里，有一样东西没有进任何一本账，就是这句话为什么偏偏对林岚、偏偏在那一刻有效。同一句话，换给另一位坐着沉默的来访者，可能是敷衍，可能是放弃，也可能什么都不是。

这个动作本书称为归因，它所损耗的东西称为构成性信息。有些治愈经得起归因，比如惊恐发作时用缓慢的腹式呼吸取代过度换气，把这件事写成标准化的描述，效力几乎原样保留，任何人照做都可以得到大致相同的结果。林岚遇到的转变不属于这一类。她那里发生的是整个自我与世界关系的转向，而促成这个转向的，既不是“用了某项技术”，也不是“提供了某种关系条件”，更不是“展示了某种治疗师特质”，这三样都是从事件里切下来的成分。事件本身是这些成分在那一刻的共现，拆开以后各自都对，合起来的那件事已经不在了。

本章要论证的承重判断是：越深的治愈，越是在被归因时丢失效力所系的信息；而现行研究与制度的主干装置，恰好是一台按归因后是否还站得住来录取证据的机器。因此证据库里堆积的，是活过了归因的那一类成功。这个判断不指责这台机器做得不好，它指出的是机器的录取标准与最深一类成功的存在方式之间有一道结构性的错位。此外还要说清一件容易被误读的事：本章并不认为深度治愈是治疗师的魔法，恰好相反，它主张在这类事件里，“谁的功劳”这个问法本身就没有落脚处。

先把话说在前面，免得本章被读成反科学的檄文。前几章的论证建立在平均意义上的正相关之上：同盟与疗效的元分析相关为 r=.278（Flückiger et al., 2018），共情与疗效为 r=.28（Elliott et al., 2018），这些是数以万计来访者的汇总结果，说明大多数时候好的关系、准确的理解确实有益。本章讨论的是这个平均值够不到的地方：当我们追问一次格外深的转变究竟归谁时，统计工具擅长回答的问题与这个问题错开了。错开本身不是随机对照试验的过错，一把尺子量不了不属于它的维度，不该怪尺子。

◆ 二、有主范式从哪里来

要看清这台机器，先得问它是怎么长成现在这个样子的。所谓有主范式，指的是一个预设：疗效必须能归到一个可指认的主体名下，技术、关系、治疗师、来访者，总得有一个是“成功的主人”。这个预设并非愚蠢，它有两层很扎实的来历。

第一层是制度史。二十世纪后半叶，随机对照试验被确立为药物审批的法定程序。心理治疗要进入保险支付体系，要在医学世界里取得科学的身份，就得学会同样的语言：药物可以分解为活性成分和惰性辅料，心理治疗也就被要求分解为特异性技术和非特异性因素。于是“分离出有效成分”成了疗效研究的主导策

略。这不是认识论上的随意选择，而是一种制度生存的需要。一个研究范式一旦被支付方、期刊的发表标准和职业合法性三方联合巩固，它就不再只是一种看世界的方式，它成了自我加固的制度事实。对此要讲公道：正是这套程序，把许多曾经凭威望流通的疗法放到了可以被证否的位置上，把无效乃至有害的做法挡在了行业门外。离开它，来访者面对的是一个只有故事、没有比较的市场。

第二层更隐蔽，埋在语言的语法里。人类描述事件的基本句式是“谁，做了什么，作用于谁”，每一件发生了的事都被预设有一个使它发生的人。这套句式在追究桥为什么塌、药为什么出事的时候运转良好，因为那里确实有个应当负责的人。但它碰上一个没有单一使动者的事件，并不会宣布自己失灵，只会就近指定一个最显眼的代理人，说：是他起了作用。一次深度的内部重组，本来是来访者整个生命系统在特定条件下完成的，句式却要求把它写成某个干预“施加”给来访者的结果。药物审批的制度压力能轻易把特定因子论推成主导范式，正是因为它寄生在这条语法上：制度要有主人，语法也要有主人，两股力合在一起，“疗效必须有主”就从一个没人审查的默认值，变成了被双重锁定的前提。

由此产生一个常被忽略的存在论上的错位。药物的活性成分进入身体时，是一个可以单独指认的分子结构。治疗师对林岚说出的那句话却不是这样的东西：它没有先被设计、再被施用，它是在那一刻的互动流里，被当下的全部条件逼出来的即兴之语。把它从事后叙述里抠出来，登记为“同盟建立”或“积极关注”，就像把一颗仍在跳动的、不可复制的心脏换成一只可以在货架上批量取用的塑料模型，然后宣布塑料模型就是那颗心脏的有效成分。模型当然可以教学，可以复制，可以做试验，只是做试验的对象已经换了一个。

◆ 三、停摆与借用

在无主这个说法能成立之前，必须先交代困锁是什么。本书无意在诊断手册之外再造一套分类，这里借用的只是一幅素描：健康的心理系统是一个能从内部矛盾里不断改写自己的过程。新的感知、冲动和事件持续冲击既有的信念、情感回路和关系剧本，富有弹性的系统在这种摩擦里调整自身，调整出的新结构又沉淀为下一轮的基底。困锁是这个循环在某个节点上停了摆，而不是一种从外面侵入的病原体。

停摆的面孔至少有三种。第一种是卡在僵死的结构上：“我不可能被爱”这样的前提被无数次经验反复“验证”，早已冻成绝对正确的预设，别人的善意被读成怜悯，无心的疏忽被读成拒绝，差异之流撞上一面不可穿透的墙，矛盾与重组无从发生。第二种是淹没在没有河床的洪水里：长期被否定、被忽略的成长环境没有留下足够稳固的核心自我感，情绪、冲动和互相矛盾的信念翻涌不止，却没有一道堤岸可以与它们碰撞、逼出新的结构。这样的人常被说成“自我整合不够”，可追到条件史上看，问题并不在结构内部的缺陷，而在于早年没有哪个稳定的他人回应被内化成立足点。第三种是割裂在互不接壤的区域之间：同一个人在工作中果断，在亲密关系里退回到无声的恐惧，两套运作各自完善却从不相见，没有冲突，也就谈不上整合。对一个要同时适应暴戾与脆弱两位照料者的孩子来说，这种分隔曾是最周到的生存办法。

这三种面孔有一个致命的自反问题，必须当场交代。如果对一次事件的任何命名都会损耗它，那么本章对三种停摆的描述同样是归因，同样会让每一位具体来访者独一无二的卡法丢失一部分信息。本书的回应是降低它的身份：这三幅素描只是暂缓的占位符，用途是让治疗师在面对眼前这个人时，先别急着归类，先问“这个人的循环停在了哪一环”。它们比诊断标签更弱、更临时，也更愿意被

具体个案的发生史废弃。读者若把它们当作一套新分类去用，本章在对自己的概念上就已经输了。

停摆之后，引擎并没有熄火。长期卡死的循环内部仍蓄着大量没有释放的张力，来访者在走进治疗室之前，也早已用各种方式试过重新点火：换工作，搬家，分手，健身，冥想。这些尝试有个共同的局限，它们都在旧结构允许的范围里做局部调整，碰不到实际卡住的那一环，因为那一环被旧结构严密地封在盲区里。你没法靠改变外部环境去解开一个被早年他人目光锁死的内在信念，也没法靠意志力去填平一段从未被接住的情感深渊。与此同时，这个循环又在不停地、前意识地扫描环境，寻找一种与它的全部经验模式不兼容、旧结构消化不了、却又不至于完全无法理解的新差异。它像一台灵敏的接收器，在杂波里等一个异常的频率。

再回到林岚。那句“也许今天不是说话的日子”之所以起了作用，可以从三个层面看。认知层面，在她的旧世界里，“可以不说话”与“放弃沟通”焊在一起，不说话就是失礼、失职、放弃，治疗师的话把这两个节点掰开了，而这个区分不是作为一条新知识被灌进她脑子里，是她自己的旧规则消化不了这个信号，两个节点才自行断离。情感层面，她后来说：“从来没有人允许我不说话。从小我就得不停地猜大人的脸色。”体内积压多年的“必须时刻戒备”的恐惧与疲惫，第一次被允许跑完全程，从积压到被认出，到被接住，再到放下，没有被一句“想开点”堵回去。关系层面，她一直把治疗师当作又一个要被搞定的大人，每走一步都在猜他要什么，而这句话不属于任何一种期待，它是一个纯粹的让步，一个交出控制的空档，旧剧本在这个空档里无法继续运转。

三个层面有一个共同点，那个区分、那条河床、那个空档，都带着来访者凭自己的生命史造不出来的东西，也就是来自另一个生命的他性。同样一句话，如果出自林岚那位暴戾的父亲之口，只会是讽刺。她在这个陌生人身上预测不出下

一步，正因如此，“沉默不必挨打”才第一次成了一个可能的经验，而不是贴在旧结构上的一条信念。所以他性是效力的构成性要素，不是附加条件。

于是有了本章对生成机制的一句话判断：在深度治愈里，直接促成循环重启的那个关键扰动，由来访者自己的内生循环完成，治疗师在此刻的作用，是提供了一个可被借用的外部凸起。比喻可以这样摆：治疗师是恰好在土地旁边的一块石头，土里的种子已经蓄力很久，在找一个能借力的凸起，石头没有提供力气，它只是以那个形状、在那个位置、在那个时辰被选中了。他的专业训练并非与此无关，它储备的是可供被借用的形状，却不是他所拥有的治愈力。有意思的是，这块石头被选中，常常不是因为他做了什么，而是因为他没有去做受训时被教着要做的那件事。

这里必须把一个词的用法钉死，它是本章最容易被滥用的地方。“触发”在日常语言里意味着一个独立的事件 A 启动了 B，A 不出现 B 就不会出现，是一种可以用反事实来定义的单向因果力。本章不用这个意思。本章说治疗师的话“成为了一次重启的契机”，指的是它作为外来的他性扰动，被一个内部张力已经蓄足的循环主动挑中，两者在那一刻共同构成了此前不存在的一个事件。这个事件没有单一的使动者，由来访者循环的主动搜索、治疗师不可预判的空档和不会重复的时机同时共现而成。至于第十三次会谈本身是不是单独导致了惊恐消退，本章不主张：前十二次会谈也许已经在一点点松动那个循环，第十三次是在接生一个已经快要完成的进程。这个替代解释不削弱无主的判断，因为即使婴儿是自己滑进产道的，助产士的手也仍然只是一个被借用的凸起。它削弱的是更强的命题，即单次扰动独立触发了重启，这个命题本书不要。

林岚前后的曲线（案例的设定）最多只说明一件事：前两轮治疗终止后三个月内的反弹没有再出现，六个月的随访期内亦如此。这一对比无法排除累积效应，也谈不上证明，它只是使“这次跟以前一样，又是短暂好转”这个竞争假设

不那么容易成立。一个案例在此只能作为说明，不能作为数据，本章所有关于预测的话，都要按这个等级去读。

◆ 四、归因敏感度：给无主一座桥

“无主”是一个关于事件结构的判断：在最深的那类治愈里，找不到一个可以无矛盾地指认为使动者的单一实体。它不归流派，因为那句话不是从手册里调出来的；不归治疗师，因为它不是他凭既有的知能有意输出的；也不归来访者那个有意识的自我，因为那个自我在当时恰是停摆结构的一部分。这个判断讲的是存在方式，没有哪台仪器能直接读出它。要让它进入经验研究，就需要一个可操作的代理，本章把这个代理叫作归因敏感度。

归因敏感度的界定是：一次治愈事件，在被事后的归因操作（被讲述、被理论收编、被纳入标准化检验）处理之后，其构成性信息的保持程度。低敏感度的治愈经过切割损失很小，上文的腹式呼吸就是典型。高敏感度的治愈一经切割，效力整体塌陷，因为它的效力系于具体的关系、偶然的互动和私人的意义，把这些割掉，剩下的是一个空壳，算不得简缩版。这是一条连续的谱，不是两种治愈的分类，现实中的大多数治疗成功处在谱中间，既有可以拆出来复制的部分，也有拆不出来的部分。

必须把话说到头：归因敏感度不能被直接测量。“切割前”的完整事件从来不是一个可以单独观测的参照，我们看到的永远是事件在某个叙事框架下被描述之后的版本。所以它是一个推定性变量，靠对比来定位，靠不同叙事系统之间不可通约的残差来间接指认，地位类似潜在类别或文化资本，不可直接观察，却在多个可观察指标的交叉处显出稳定的结构。它是一座桥，不是桩子，桥通向无主这条河，但桥不是河。谁若拿一个单一的量化指标去“代表”无主，就犯了本章批评的那个错误，把一个存在论意义上的不可分割，误认成一个技术上暂时没测

到。前者是事件的结构，后者只是工具的现状，混淆二者，正是整套疗效归因机器最深的语法错误。

间接指认可以落成一份可以预先登记的协议。设想对同一批治愈事件采集三份互相独立的描述：来访者在治疗结束后三个月内自由叙述的关键转折点；治疗师就同一事件写下的个案记录；三名分属不同流派、没有读过前两份材料的编码者，依据各自流派的技术分类，对同一段逐字稿做的技术成分标注。设计上可取不少于六十例、跨至少三个流派的样本。归因残差定义为三源在“转折点落在哪里”与“技术成分归给谁”这两项上的不一致程度之和，按标准化距离计。预测方向很明确：残差越大，远期功能改善和结构性变化越明显，也就是说，越深的治愈，三份描述越对不上。

这个预测可以死，而且死法写在前面。如果在预先登记的样本上，残差与治愈深度不相关，或者负相关（越深的治愈，三方描述反倒越一致），本章的核心判断即被否定。还要预先排除一个平凡的解释，深度事件可能只是更复杂，所以更难被描述一致。为此协议要求同时记录会谈时长、在场人数、议题数量这些表层复杂度，并作为协变量控制；控制之后，残差与深度的关联若消失，那么本章主张的结构性不可归因，就应当降格为一个关于描述难度的平凡观察。这个协议没有任何一部分被跑过，以上全部是尚未检验的设计。

把它放回林岚身上，可以看到残差大概是什么样子，下面按设想来写，不是报告数据。治疗师在事后讲：“我不知道我做了什么。那一刻，好像培训里学的东西都不适用了，我只能陪她坐着，可能只是恰好没有搞砸。”他的同行把这个“恰好没有搞砸”解读为“他建立了安全的同盟”，他自己却不接受这个归档，因为他当时并不是在实施一项叫同盟建立的操作，他只是不知道该做什么，于是什么也没做。这是第一道痕迹：治疗师本人拒绝让自己的有效瞬间进入他所属流派的账本。

如果把逐字稿分别交给认知行为、精神动力、人本三位取向的资深编码者，让各自标出“关键起效动作”，可以预料的情形是三人连时刻都指不到一处。动力取向的编码者会把此前几次对沉默的处理认作关键；认知行为取向的编码者会指向那句唯一明晰的陈述；还有人会认为这次会谈的意义只是为之前的工作提供了情绪释放。而治疗师自认没做任何技术动作的那段沉默，反倒可能被所有框架同时漏掉，因为沉默根本不是一个“动作”。这是第二道痕迹：编码者在“哪一刻有效”这件事上已经分歧，还谈不上术语用得不同。第三道痕迹是来访者和治疗师归因对象的不对称：来访者把转变归给“那一刻他什么都没要求我”，是一个事件的形态；治疗师归给“我不知道我做了什么”，是一个缺失的形态。在简单的行为性治愈里，双方通常能互相印证一个由清晰动作构成的起效故事，事件与缺失的错位很少出现。

三道痕迹加在一起也不能证明无主，它们只是残差可能出现的三个地方。一个同样合理的读法是，编码者之间的分歧来自逐字稿缺少非言语信息，治疗师的“不知道”是谦辞，来访者的“什么都没要求”是回忆的修饰。这些读法都需要被协议里的复杂度控制和多案例比较去排除，不能靠一个漂亮的案例去排除。

◆ 五、五个近邻，逐一对质

一个新概念值不值得立，要看它能不能在既有概念的网眼之间切出一个没有被命名的区别。以下每一家都先让对手提出最有力的反驳，再看这个区别有没有导出不同的经验后果。没有不同后果的区别，只是换了名字。

第一家是柠檬市场。阿克洛夫（Akerlof，1970）说明了一个机制：买方在购买前无法分辨好货与次货，好货因无法与次货区分而被逐出市场。把它挪到治疗行业，很容易得到一个顺手的类比，深刻但没有保证的治愈被排斥，简单且可手册化的治愈被放大。对手的反驳是：这只是高质量产品在传递信号时遇到的特

殊困难，产品的质量在被传递之前就客观地存在，“传不出去”是情境依赖，用不着一个存在论上的“无主”。这个反驳有分量。拆开两者的是一个相反的预测。柠檬市场的逻辑内在地指向更好的质量测量：测量越精密，信息不对称越小，市场失灵越能被纠正。归因敏感度的预测正相反，在高敏感度的治愈上，加细测量只会生产出更精致的替代品。每一套更细的编码系统去描述林岚的第十三次会谈，做的都是同一件事，用更讲究的理论语言，把那个无法被单独占有的涌现重新编进某个可以被单独占有的技术单元。信号不会更接近事件，只会更符合理论自身。两家对“信息不对称降低之后疗效信号会怎样”给出了相反的预期，这在经验上可以分叉，且至今没有被检验。

第二家是默会知识。波兰尼（Polanyi，1966）早已说清：熟练的实践者知道的远远多于他说得出的。一位资深治疗师的临在含有大量默会成分，几乎没有人会否认。持默会论的研究者会说，治疗师事后讲不清楚自己做了什么，完全正常，这是表达的问题，不是事件的问题；换一种外化的办法，比如逐次回看录像时实时口述决策，或在督导小组里与同行反复碰撞，默会知能就能部分外显，所谓无主也会随之消退。这条反驳击中的是“为什么说不出来”。归因敏感度要说的是另一件事：即使他说出来了，被说出来的东西已经不是那个东西。两者在经验上走向不同。默会论预测，随着媒介和情境的改变，可外化的程度会改变，口述会比书面更多，小组碰撞会比独自回想更多。归因敏感度预测，在高敏感度的事件上，书面、口述、小组碰撞这些归因形式虽然通道各异，损失的结构却大致相同，因为每一种都是用不同的语言模具去重新切割同一个事件，不可分解的共现被拆开、被分配、被登记。哪一种预测成立，要看跨媒介的比较，眼下没有人做过。

第三家是叙事重构。从斯彭斯（Spence，1982）到布鲁纳（Bruner，1991），叙事研究早已指出，事后叙述与现场发生的事之间有系统的偏差：记忆

被合理化，成功被编进符合理论信仰的情节。叙事研究者的反驳最干脆：你说的我们都知道，选择性是叙事的宿命，把它改叫“存在论切割”，不过是给老命题披了一层哲学外衣。这一条反驳在一半上是对的。如果归因敏感度的命题是“所有叙事都会失真”，它确实只是叙事理论的复述，本章不会为此立一个新词。本章的命题更窄：有一类事件，其效力恰好系于那些在叙事操作里最先被牺牲掉的东西，不可分解的共现，一段没有名字的空白，一个不属于任何理论语言的即兴瞬间。对这类事件，叙事造成的不是一般性的选择性建构，而是一种调包：事后被指认为“关键起效成分”的那个东西，在原事件里从来没有独立存在过。这个区别还带来研究取向的分叉。叙事研究把多版本叙述之间的残差看作测量质量问题，要设法压低它；本章把残差看作可能带有理论内容的信号，在某类治愈里，高残差正是事件深的一种痕迹，需要学会在适当的场合保护它，不被理论强行收购。

第四家是治疗师效应研究。这是最逼近的经验对手。兰伯特（Lambert, 2013）所代表的框架一再检出治疗师之间的稳定差异，常被引用的估计是治疗师因素占疗效变异的个位数百分比，并试图描出高效治疗师的特征：更敏锐的共情、更灵活的技术选择、更善于修复同盟破裂。本书转述这个区间时保持克制，因为各项研究的口径并不一致，这里取的只是量级：治疗师的份额有，也检出了，但与全部变异相比并不大；其余变异由什么构成，各项研究口径不一，这里不下判断。归因敏感度对此提供一种补充的读法，没有推翻哪一个数字：那一块尚未得到解释的变异里，至少有一部分可能不是测量误差，而是无主事件在方差分析表上留下的沉默的签名。而被标记为治疗师效应的那一块，也未必全是“治疗师拥有的高效特征”，有一部分可能是某类临在形态更频繁地被不同来访者的循环借用。这一点会在后面第三个反驳里单独讨论，这里先说清它与兰伯特的关

系：把有主范式推进到量化的极限，才能在极限处看见那个再也推不动的残差。这是对这项工作的借力，不是否定。

第五家是 Wampold 的情境模型，也是最该公道对待的一家。从罗森茨维格（Rosenzweig，1936）引用的“渡渡鸟判决”起，共同因素传统一直在做一件解放性的工作：流派的标签远不如治疗关系的质量重要。瓦姆波尔德（Wampold，2001；Wampold & Imel，2015）把它推到系统的形态，治疗不再被理解为治疗师对来访者施加了某种技术，而是治疗师参与并促成了一种社会性的疗愈实践，在其中创造信任的情境，激活来访者的期望和资源。治疗师因此不再是技术工人，而是情境的提供者。这一步已经把功劳从技术挪到关系，踩在了无主的门槛上。

本章认为它在最后一步收了脚。收脚的地方在“情境是谁的产出”：共情的回应被叙述成治疗师“提供了”共情，安全的同盟被叙述成治疗师“建立了”同盟，希望被叙述成治疗师“激发了”。技术的主人身份被否认了，情境却立刻被登记在治疗师名下。本章再走一步，说“系统在自我重启，关系被借用了”，不再说“关系起效”。前一步还需要一个施动者，治疗师提供关系；后一步撤销的是施动者这个范畴本身。

情境模型的拥护者可以不修改自己的内核来接住这个判断：把“允许空白发生的频率”吸收为一个更高阶的共同因素，说善用空白的治疗师只是更高明的情境创造者。这条反驳的锋利在于，它不必驳倒任何论据，只需把发现收进自己早已铺好的概念地图。要回答它，就要找出一个即使把空白吸收为高阶共同因素也解释不了的后果。后果在这里：如果允许空白的能力是一种可培训的高阶共同因素，与共情能力、同盟修复能力同属一类，那么在培训中系统加入“空白训练”以后，治疗师的关键有效动作应当在形态上表现出跨个案的稳定性，同行可以辨认出家族相似，像共情回应、同盟修复那样可以被描述、被示范、被评估。

如果归因敏感度更接近事情，那么即使受过最精细的空白训练，他在不同来访者那里的关键瞬间，仍应呈现为事后难以归类的、彼此差异很大的即兴动作，因为动作的形态由来访者那个循环独特的停摆缺口决定，不由他的空白能力决定。石头可以经过训练变得更平、更圆、更多面，这些训练提高它被选中的概率，但它在被选中的那一刻以哪个角度成为支点，不由它自己说了算。这又是一条尚未检验的预测，它与情境模型的分歧，恰好落在这个可以观察的地方。

五家对质下来，归因敏感度没有宣称自己比谁高明，它占的是一个很小的位置：别人的概念都在回答“东西是什么、为什么传不出来、为什么讲不准”，它在问“这样的东西被问到的那一刻，会发生什么”。

◆ 六、证据库筛出了什么

回到本章标题要担的那个重量：最深的治愈为什么进不了证据库。先把这句话的两种读法分开。一种读法是，证据库里的东西都是假的，或者随机对照试验不可信，这种读法本章不接受。另一种读法是，证据库是一个筛子，筛子的网眼有一个形状，凡是穿过归因之后还能站住的东西，才有机会被收进去。后一种读法并不贬低库里的货。穿得过去的东西，是可以被单独描述、被另一位治疗师照着做、被另一间诊室里的另一个人重复的东西，这正是一项疗法成为公共知识所需要的性质。惊恐发作时的呼吸调节，暴露类工作的分级安排，行为激活的活动日程，它们的价值恰恰来自低归因敏感度：能传授，能比较，能审计，能在资源有限的地方大范围推广。把这些东西讲得轻飘，对数以百万计的求助者不公道，也与林岚自己的经历不符，她那两轮认知行为治疗并非没有用，她学会的呼吸调节后来仍在用。

筛子的另一面是，它对自己没有录取的东西沉默。沉默不等于不存在，而且这种沉默有方向：越是依赖具体的关系、偶然的互动和私人意义的转变，越难在

标准化之后保留原貌，也就越难被写进试验方案。一个尝试把“治疗师在那一刻没有说该说的话”做成干预条款的试验，会立刻遇到无法回答的问题：什么算“没有说”？在哪一刻？对谁？写下来之后，条款成了一个别的东西。所以证据金字塔告诉我们的，首先是什么东西在归因机器里活了下来，是否同时也是最好的东西，需要另一类证据去回答，眼下这两个问题被混在了一起。

教育里有一个结构相同的例子，可以帮助看清这个混合。一位初三学生（说明性合成案例）连续三次单元测试都在及格线附近，公式能背，一遇到应用题就不会把条件“翻译”成函数式。数学老师本来的做法是再多布置几道同类题。但在布置作业的那一刻他停了一下，问了一句不在教案里的话：“你是不是觉得题目里给的那些条件，跟你没关系？”学生愣住了，后来说：“我才突然意识到，我每次读应用题，好像都在读别人的事，一个水池一边进水一边出水，我根本不关心。”两个月后他的应用题成绩明显回升。事后，教研组把这件事归档为“情境化教学”的成功范例，说老师通过联系生活经验激活了动机。可是老师并没有讲任何函数在生活里的故事，他只问了一个没有名字的问题，这个问题之所以有穿透力，是因为对这个学生来说，抽象的符号世界一直被体验为与自己无关的外部系统。归档把这句追问换成了一项可被其他学校移植的“教学方法”，被移植过去的是方法，学生当时的那道缺口留在了原处。随机对照试验如果检验“情境化教学培训”的效果，检验的就是这个被编号之后的替身。常听到一种说法：笼统的教学干预（探究式对直接讲授之类）平均效应微弱，而一线教师讲述的个案却令人信服。这只是一种印象，本书不为它引证数据；若印象属实，也许不是证据金字塔的顶层与底层互相矛盾，而是筛子留下了一部分，丢掉了另一部分。这个解释并不排斥别的解释，比如最近发展区之类的发展心理学模型就能说明其中一些困惑，它只是给一个老问题增加了一个追问方向：我们检验的方法，是只能容纳低敏感度的教学成功，还是也容得下高敏感度的那些。

说到这里，有三个反驳必须正面接下来，因为它们分别来自职业身份、方法学和统计事实。反驳一：如果疗愈是无主的，治疗师的专业训练还有什么价值？这条反驳在从业者那里分量最重，因为它直指职业的自我理解。本章的回答是给训练重新定位，不退守。训练的价值不再在于学会“怎样做出成功的干预”，而在于几件更朴素的事。其一，对停摆形态的识别：受过训练的治疗师比日常生活里的人更快看出对方的循环卡在哪一环，不至于在旧结构内部白白耗费大量时间。其二，可借用形状的储备：他在多种技术、多种理论、多类临床经验里积累了更多即兴的可能，一个从未系统学习过任何流派的人，临在可能是空的，但他手里也没有足以被借用的凸起。其三，也是难度最高的一项，对自己“占有冲动”的辨认：当他感到“是我的技术起效了”，能不能退后一步，检查这个感觉是在描述事实，还是在护持自己的职业身份。第三项不能手册化，它是在大量复杂现场里沉淀下来的东西，所以这个定位对训练提出的要求更高，不是更低。要说明的是，这里谈的是训练价值的重新理解，不是给培训开课表，课表式的东西恰是本章要警惕的。

反驳二：如果深度治愈无法被标准化验证，怎么把深的转变与自我安慰区分开？这是本章必须严肃对待的边界。承认高敏感度的治愈进不了传统证据库，并不等于放弃区分，只是不允许区分被压缩成“有没有被随机对照试验证明”这一条。可以设想的替代标准是：当事人的远期生活功能是否有实质改善；多位知情人的叙述是否相互交叉印证；转折点在来访者自己多次回溯时，核心叙事是否保持稳定。通过这些追问的，可以被严肃对待为一个事件，通不过的就不能。这与伪科学的避难所之间有一条清楚的界线：伪科学从不交代自己在什么条件下会被推翻。本章的核心判断给出了死亡条件，下一节会写出来。一个无法被归因的治愈，不等于一个无法被证伪的主张，前者说的是事件的存在方式，后者说的是论断的态度，两者不能混。

反驳三：如果治愈是无主的涌现，为什么有的治疗师的疗效长期、稳定地高于同行？治疗师效应不正说明治疗师拥有某种治愈力吗？这条反驳最尖锐，因为它用的是统计事实。回答要分两步。第一步，承认事实：治疗师之间的差异是稳定的，这一点本章不争。第二步，指出这个事实本身并不携带判决性的信息，它可以接受两种读法。在有主框架里，它说明某些治疗师拥有更强的治愈力：更精准的共情，更灵巧的同盟修复，更丰富的技术库。在归因敏感度的框架里，它也可以说明某些治疗师的临在形态，包括声调，对沉默的耐受，在该做规定动作却没有做时的从容，为更多样的来访者循环提供了更多样的可被借用的凸起，因此在统计上更常被选中。两种读法都与治疗师效应的存在相容，分歧在培训意涵上：前者引向“培养更强的关系技能”，后者引向“让临在形态更多样，同时学会忍受自己的成功不被记进任何可认证的技能账目”。前者生产的是可认证的专长，后者生产的是无法认证的克制。行业至今只走了第一条路。无主的框架没有证明治疗师没有差别，它只是不同意由差别推出“治愈归他”。有些石头确实比另一些更常被种子选中，石头能改变自己的形状、硬度和温度，这要训练，但它不能强迫种子发芽，也无权事后说是自己让种子发芽的。

还有一个判别性问题与这条反驳相连，至今没有人系统研究过：所谓大师级的治疗师，凭什么与常人不同？如果是因为他拥有更敏锐的共情能力，一种可培训的属性，那么他的关键起效动作应当在不同个案之间显出稳定、可归类的形态。如果是因为他更善于松开对成功的占有，在不自觉间让来访者的循环借用他的临在，那么他的关键动作应当在不同来访者那里高度各异，事后连他自己也归不进任何一类技术。这两个预测相互排斥，都可以通过对同一位治疗师多个个案的逐次会谈分析去检验，尚未检验。

最后是一个朴素的问题：行业到底在收什么钱。如果我们付费，是为了买一件可以保证起效的技术产品，像一片药，那么接受无主就必须同时接受一个令人

不安的后果：在最需要起效的深层困锁里，最核心的那部分效力恰恰无法作为产品被购买。更接近事实的说法也许是，我们付费买的是一段被专业守护的时间和一个关系空间，在其中，无主的事件有可能降临，也可能不降临。这个说法听上去不像广告，却更接近专业人员实际在做的事。理解这一点比任何技术革新都困难，因为它要求付费方、保险方、监管方和治疗师自己都把“可以保证”的期待放低一档。放低的方向有明确的限制：它不适用于风险评估、安全计划、症状监测这些可以也必须标准化的部分，那些部分的低敏感度恰是它们应当被严格对待的理由。

◆ 七、读数、判错与边界

本章的读数是一个事后可以记录的现象：就同一次被来访者指认为转折的会谈，分别收集来访者自己的叙述、治疗师的记录和不同取向编码者的标注，记下三方在两件事上的分歧，转折落在哪一刻，起效的东西归给哪一项技术或条件。读数只记录分歧的位置和大小，不给出谁对谁错，也不要求任何一方改口。记录者另需写下会谈时长、在场人数和议题数量，用来在事后判断分歧是否仅仅来自事件复杂。这是描述性的读数，它能告诉我们残差长在哪里，不能告诉我们残差因何而来。

全书第三条判错条款（尚未检验）：如果有系统的证据表明，被来访者事后指认为关键转折的治疗瞬间，在被标准化描述之后，其效力能够独立于流派地稳定保留，也就是不同取向的治疗师照着这份标准化的描述去做，能在相近的来访者身上得到相近的、可被第三方核实的效果，那么本章的核心判断被动摇。

本章另有第二个条件，落在残差上：如果在预先登记的样本里，三源分歧与治愈深度不相关或呈负相关，且在控制表层复杂度之后依然如此，归因敏感度作

为一个区分概念就失去了它的经验立足点，本章对“证据库按归因录取”的诊断随之落空。这两条都尚未检验。本章接受它们，也接受它们的结论。

接下来是这个判断的边界和它可能被滥用的方向，这一部分与上面的论证同样重要。其一，它不适用于低敏感度的那一大片。惊恐发作时的呼吸调节、暴露的分级、行为的安排，这些东西能被标准化，也应当被标准化，对它们适用的是证据库的全部规则。本章没有要求任何人因为林岚的故事而把结构化治疗当作次一等的东西。谱的两端需要不同的态度，也需要不同的证据，而把一端的标准强加给另一端，才是本章批评的混淆。

其二，它不适用于自伤自杀风险、急性危机、自我结构严重缺损和心理储备耗尽的情形。这类处境里，等待一个无主的事件降临，等于把一个人的安全押在偶然上；需要的是结构化的帮助和安全流程，这些部分的标准化是对来访者的保护，不是对深度的背叛。“无主”这个词不能被用来为任何一次懈怠开脱。

其三，它容易被读成治疗师免责的哲学。这是一个必须当场拒绝的读法。说一次深度转变没有单一的使动者，不等于说治疗师对过程中的一切没有责任。他对设置、对边界、对风险、对自己占有冲动的觉察，对来访者的安全，仍然负全部的责任；无主只改变了他在转变发生的那一刻能够声称什么，从“是我让它发生的”退到“我没有挡住它”，后者对他的要求一点也没有减轻。

其四，本章自己的概念也逃不出归因敏感度的检验。本章对三种停摆的描述、对石头与种子的比喻，都是归因操作，也都会损耗它所指向的东西。比喻有用，因为它让一个难以说出的结构有了抓手，代价是读者容易把抓手当成事物。所以在这一章里，种子和石头只作暂时的示意，要紧的是前面几节写出的、可以被推翻的预测。

其五，本章尚未面对的一个紧张，留给第10章。第2章判定，期内的改变若靠治疗师供能，断开后会退回或另找出借人，那是租借；本章判定，来访者的循环借用治疗师的临在完成自我重启，那是治愈。两章都用了“借”字，却给出了相反的评价。林岚这一例在治疗结束后六个月内没有反弹，不足以当作判据。把借用而后属己的、借用而后落空的区分开来，需要的是治疗结束后一段时间里，在治疗师缺席、也没有替代依赖对象的新情境中，来访者能否自行发起同类的动作，这一点本章无法在此替第2章判决。

读到这里，一个顺着本章走下来的人，多半会想到另一个问题：如果连“起效的是什么”都说不清，治疗师在场的时候，究竟该做什么、不该做什么？这个问题本章不回答，也无权回答。它牵出的是整本书里几处互相拉扯的地方：第2章与本章的“借”，第3章与第5章各自说的“撤”，第6章、第7章与第8章对“谁在使这件事发生”的不同口气。下一章就把这几处放在一起，让它们互相对撞，看哪一处站得住。

◆



第　五　编

合论：三个难关

编　序

前九章各有一个命名，放在一起就打架。第10章让它们当面对撞，裁定借用的真伪、撤的是什么、治疗师还算不算导演。第11章追问“撤”本身：它一旦可教，就成了第四把椅子；而且有些时候，这个位置根本不该空出。

第12章把母题推到一个永不离席的对话者身上，全章是外推与预测。

10

第10章

三场自撞

苏筠（化名）结案时，在最后一次会谈的末尾说了一句话：“第十一次那天，你说今天不用急着决定，我当时就觉得，有一扇门自己松开了。”（说明性合成案例）她三十三岁，做平面设计，此前十几年的习惯是把所有需求折叠成“都可以”。治疗师把这句话记进结案小结，没有加评语，因为这一次的改变看上去干净利落：她在期内第一次拒绝了合作方的加急单，第一次对母亲说“这个周末我不回去”，量表分数从临床区间落到了常模附近。

九个月后，她所在的公司重组，新上司要把她的职责扩大一倍而薪酬不动。这里可以设想两个版本的苏筠。甲版本里，她在会议前一晚独自坐了一阵，写下三条不能接受的理由，第二天对上司说了第一条，被驳回，她又说了第二条，会议室里的气氛很难看，她事后胃疼了一整天，但那件事算是她自己的。乙版本里，她在同一个夜晚给一位新结识的资深同行发了四十多条消息，反复问“我这样说是不是太冲了”，直到对方回复“就这么说，我支持你”，她才在次日开口，开口时语气和用词与当年治疗室里那位治疗师说话的方式几乎一致。外人看到的是同一个动作：一个习惯说“都可以”的人，对上司说了不。

两个版本回溯到同一段起点，也就是第十一次会谈里那个被来访者认定为转折的瞬间。如果把这个瞬间交给本书前面的章节去判，会出现一个必须当面处理的矛盾。第9章的判断是：这类决定性的扰动，是来访者自己的内在循环借用了治疗师的临在，完成了一次自我重启，它不属于任何单一的主体，因而被称为治愈本身，不应当被切成技术、关系或治疗师能力的账目。第2章的判断是：期内

的进步里有相当一部分，是来访者借用了治疗师的燃料、工具或方向感，借用的东西没有发生所有权转移，租约一到期就退回原状，因而是伪改变。两章描述的都是“来访者借用了治疗师”，一章说这是最深的治愈，一章说这是最隐蔽的失败。它们不能同时为真，如果各讲各的，全书的前半部分就成了一组互不相干的故事。

◆ 一、同一个动作，两个判决

先把矛盾压到最小的尺寸。第9章与第2章用的是同一个动词，借用。分歧在于借用之后发生了什么。第9章的“借”是一次性的、发生在某个交叉点上的启动：来访者的循环停摆了很久，治疗师临在中的某个空白恰好成为它重新转起来的条件，之后循环靠自己的燃料转动。第2章的“借”是持续的、需要出借人一直在场的供能：燃料、工具、方向感都放在治疗师那边，来访者每次动作都要从那里取电。把这两种借用并排放在苏筠的两个版本上，甲版本像前者，乙版本像后者。但在会谈当天，在结案当天，甚至在期内的所有量表上，二者没有任何差别。

这正是难处。事件发生时的描述分不开它们，来访者事后的叙事同样分不开，因为“那句话改变了我”这样的句子，完成了重启的人会说，租来的人也会说。第9章用来识别无主事件的材料是三条叙事之间的残差：来访者怎么说、治疗师怎么说、不同流派的编码者怎么圈。这些材料描述的是事件在被归因时的信息损失，它们能说明“这件事难以被归到某个人名下”，却没有设计成能区分事件之后的命运。第2章的识别信号同样有局限：进步句的主语是独立陈述还是引述结构，谷底有没有抬升，支撑被撤减之后功能是否残存，这些信号读的是期内的所有权迹象，期内的迹象会被出借人的在场污染，因为出借人就在房间里，或者在来访者心里。

于是本书采用的裁决方式，不在事件发生的当天找，也不在期内找，而放到治疗结束之后。判据是这样一条：结案后六到十二个月，来访者进入一个治疗师完全缺席、也没有替代性依赖对象在场的新情境，能否自行发起与当年同类的动作。能，则那次借用属于第9章所说的自我重启；只有新出借人出现时同类动作才重新出现，则属于第2章所说的租借。借用之后所有权有没有发生转移，就是同一个现象分岔为真伪两种结局的那个变量。这样安排之后，两章的关系就从互相矛盾变成了互相定义：第9章说清借用发生的那一刻为什么难以归账，第2章说清借用之后什么情形下账目仍然挂在别人名下；缺了哪一章，另一章都会失去自己的边界。

这条判据里每个词都要有可操作的含义，否则它只是换了一种说法。“同类动作”指的是功能上同构的动作，不要求场景重复。苏筠当年的动作是对一个有权势的人提出自己的限度，新情境里是对上司说“我不能接受”，二者场景不同，功能相同。“新情境”指治疗期内没有出现过的人与场合，这样可以排除来访者只是把治疗室里学到的套路原样搬出去重复。“无替代性依赖对象”则最难界定。日常生活里，一个人遇到难事找朋友商量，不能一概判为租借，否则人人都是租客。区分点在于对方是咨询意见的来源，还是行动的许可：甲版本里苏筠可以事后把经过讲给同事听，那是讲述；乙版本里她在行动之前需要某个人的一句“就这么说”作为启动条件，那是许可。读数因此是一个事后可记录的现象：动作发起之前，是否出现了“某个特定他人的在场或认可”作为条件，以及这个条件缺席时动作是否仍然发起。

还要说清一个方法上的陷阱。随访本身是一次接触，如果由原来的治疗师打电话问“你现在怎么样”，这通电话就可能成为出借人的在场，使所有权读数偏向租借。随访应由与治疗无关的人执行，而且问法不应暗示期待。这一点在本书

的任何实证设想里都要保留：判据要求出借人缺席，研究者自己不能成为出借人。

这条判据也让两章各自交出一点东西。第9章此后不能再拿“来访者事后称这是转折”来证明那是自我重启意义上的治愈，因为租借者同样有这样的称呼；它的归因敏感度论证保留，但必须加上一个限定：不是所有借用都完成了自我重启，完成与否要在迁移里看。第2章此后不能再把进步句里的引述结构直接判为伪改变，因为完成了重启的人，在回忆起点时也会说“当时她说了一句话”，引述的语法不构成所有权未转移的充分证据，要由外部迁移来验证。两章各自削去了一块过于自信的部分，换来的是能彼此校准。

接下来要把第1章也拉进来。第1章的涵容性织体与第2章的租借，都是“治疗期内看上去很好，穿不出去”，两章的分工线是结案之后的走向：织体型的来访者，治疗关系断开后，行为回到原状，因为改变的能量从一开始就被闭合回路吸收，没有向外世界转出多少；租借型的来访者，断开之后不会回到原状，他去找下一个出借人，新的伴侣、新的督导、新的团体，因为他已经学会了借，只是借的对象换了。这样，随访里就有了三种可以直接区分的走向：回到原状，去找下一个人，在无人在场时自己站住。第一种指向织体，第二种指向租借，第三种指向第9章所说的重启。若结案后这三种轨迹在大批个案里无法分开，那么第1章与第2章就是一回事，应当合并，本书保留两章的理由随之消失。这是一个可以输的安排，本书愿意如此。

在判据之外，还要说明本章不接受的几种省力读法。其一，有人会说，真伪之分只是程度之分，所有的进步都是借来的，区别只在借期长短。这个说法忽略了一个事实：租借的失败样子有结构上的特征，包括使用平稳、独立试探不增、结束的话题被双方回避；而按第2章的刻画，重启之后的样子应当是独立试探随时间增多、谷底抬升。这两种形状原则上可以在足够密的随访里看出分别，这是

一个尚未检验的预期，它所依托的区分不在借期长短。其二，有人会说，所有权是个主观感受，来访者觉得“这是我自己做的”就够了。第2章已经把所有权定义为功能架构上的独立：执行的指令、供能的来源、纠错的判断，是否在来访者内部。感受可以与架构不一致，而且常常不一致。

本节的撤回条款也写在这里。若在足够长的随访里，被判为“站得住”的一组与被判为“找下一个人”的一组，在结案十二个月后的功能水平上没有差别，则“所有权是否转移”这个变量没有任何经验后果，两章退化为一种叙述偏好，本章前半的整个安排应当撤回。此条尚未检验。

◆ 二、撤的是什么

第3章与第5章讲的是治疗师身上的两种空出，各自都带着“撤”字，读起来像是一个动作的两个名字。第3章撤的是懂的位置：治疗师把“我能辨认你、我知道你在经历什么”这个认识上的立足点放下，让觉察落到两人之间。第5章撤的是给的位置：来访者把投射和请求送过来，治疗师接下，却不执行那个请求所指定的角色动作，不去安慰，不去指路，也不提供一个新脚本顶替旧的。一个撤解释权，一个撤关系功能。如果这两种撤其实是一回事，全书的第二编就多出了一把椅子，如果它们是两回事，就要说清楚凭什么分。

先看一个把二者拆开的场景。欧阳梅（化名）是一位在异地工作的治疗师，接到一位只讲方言的老年来访者，她对这种方言只能听懂三成。头几次会谈里，来访者讲得很长，欧阳梅抓住的只是零碎的词和语气。她既没有办法形成一个“我懂了”的判断，也没有办法说出一句贴着内容的安慰，只能坐在那里，保持目光和呼吸。第五次会谈，来访者停下来说了一句她听得懂的话：“你听不懂，我倒是什么都能讲了。”这一刻，懂的位置与给的位置同时空着，但没有任何人决定让它们空着。治疗师在场，却无从辨识，也无从执行功能。

这个场景提供了一个判断工具。设想治疗师因病缺席，或者因为语言不通无法回应，旧对象同样会落空，零功能在场所要求的“不执行”成立，它同样要求的接收与确认却缺了，所以第5章说它至多成立一半；而共同进场要求的是治疗师自觉地、并让来访者看见地放下解释权，条件不成立。于是两个概念之间有一条可以裁决的线：在这种非自觉的落空里，能不能观测到与共同进场等量的松动。如果能，说明松动来自位置本身的空出，而不要求空出是被谁自觉选择的，共同进场所要求的自觉就没有做功，两个概念应当并入零功能在场；如果不能，说明“让来访者看见地放下”这一层自觉有独立的贡献，两个概念各有各的地盘。本书把这条线写在这里，没有替任何一方预先站队。这是一个尚未检验的判据，它可以在语言不通的跨文化治疗、治疗师因病缺席后的回归会谈、以及翻译介入的会谈这类自然发生的样本里取数。

分开之后，还要把两种撤的交叉情形弄清。把“解释权”与“关系功能”各看作一条开关，就有四种治疗师。第一种两条都不撤：他既握着解释，又继续给予，这是第二编前三章所批评的常态，不必再论。第二种撤了解释权，保留关系功能：他说“我可能又在试图当一个什么都懂的人了”，但随即用温和的语气接着安抚、肯定、陪伴，来访者听到的是一位谦逊而更加体贴的人。这时的危险不在谦逊，而在谦逊成了新的给：来访者回报“你真是少有的肯承认不知道的治疗师”，这句称赞本身就把治疗师放进了一个更高的位置，椅子换了名字，没有空出来。第三种撤了关系功能，保留解释权：他沉默，不安慰，不指路，心里却握着一个完整的理解，来访者能从他的沉默里感到“他看穿了我，只是不说”。这样的沉默与冷淡的区别很小，来访者的旧程序会把它重解码为审判或试探。第四种两条都撤，这在自觉的操作里几乎做不到，在非自觉的落空里却会发生，欧阳梅的案例就是其中一种。

由此可以说明第3章与第5章为什么必须各自存在。若只有第3章，第二种治疗师就会被当作已经完成了该做的事，而他恰恰留着给的椅子。若只有第5章，第三种治疗师同样会被当作完成了，而他还握着懂的椅子。每一章各自守住一把椅子的门，另一把椅子的状况需要靠另一章来检查。两章的读数也因此分属两侧：第3章看来访者事后是否报告“他也不确定”，那是解释权松动的痕迹；第5章看旧对象是否失去承载物，也就是来访者原先送出的那个请求，是否在落空之后没有马上找到替代的接收者。两个读数都要在来访者那边确认，治疗师自己的宣称不算。

这里需要引入全书里治疗师的主动性梯度。第3章的共同进场是自觉放弃，第5章的零功能在场是有意不执行，还有一种是被迫失效：治疗师专业框架的崩塌不是被选择的，是砸在头上的，比如遇到完全超出训练的材料，或者自己遭遇了变故。三者的区分用一个事后可问的问题：治疗师能否说出“我当时是打算这么做的”。前两种能，第三种不能。把这个梯度放在撤的两个位置上，可以做一个尚未检验的推测：越是被迫的失效，越不容易被来访者的旧程序当作一种操作来重新吸收，因为连治疗师本人也无法被怀疑“在对我用技术”。越是自觉的撤，越容易被识别为一项操作，然后被收编，这正是第11章要面对的难处。所以梯度提供的不是价值排序，不能写成“被迫失效最好”，更不能被读成一个可以安排的程序，让治疗师刻意制造崩塌。它只是提示一个方向：撤的自觉程度若真与被吸收的风险成比例，就不能指望靠加深自觉来躲开收编。

接着把本节判断与三个近邻切开，写成判断对判断。比昂的“无记忆、无欲望”（Bion，1967）要求分析者在会谈中放下对过往和对疗效的执着，其对象是治疗师自己头脑里的内容，是分析者内部的一项训练有素的操作。本章的两个撤法，判据都在互动的另一端：来访者的请求是否落空，来访者是否体验到解释权的松动。比昂的分析者可以做到“无记忆、无欲望”，来访者却照样把他放在

懂者的位置上，这种情形在比昂的框架里不算失败，在本章里却是第二种、第三种治疗师的典型表现。弗洛伊德的节制原则（Freud，1915）规定治疗师不满足来访者的情感要求，用以维持治疗赖以进行的张力。节制是一条由治疗师发起、由治疗师遵守的规则，它预设治疗师知道哪些要求不该满足；本章的落空首先是来访者那边体验到的事实，治疗师未必有这样的预设，欧阳梅就没有。安德森与古力施安的“不知道的姿态”（Anderson & Goolishian，1992）要求治疗师以好奇和不预设答案的方式提问，它很接近第3章的撤，分歧在于它是姿态，是可以持续保持的立场，姿态一旦保持得很稳定，就容易成为第二种治疗师的谦逊，而撤的位置是否空出，仍要看来访者是否报告“他也不确定”。

这一节的判错条款有两条。第一条就是上面说的合并条款：若非自觉的落空与自觉的共同进场带来等量的松动，共同进场应当并入零功能在场。第二条针对四种治疗师的分类：若在同一批会谈录像上，两位不持本书立场的编码者对“是否撤了解释权”与“是否撤了关系功能”两个维度的编码高度重合，一致性超过八成，那么这两个维度并非两条开关，本书把第3章与第5章分开的做法没有经验上的依据，应当并为一章。两条均尚未检验。

◆ 三、他还在导演吗

第三个难关出在动词上。翻开第6章所依据的原始论文，治疗师的撤离被写成这样一条因果链：悬置裁决，违背来访者的隐性期待，把来访者逼入“逼临态”，随后新的秩序在这个逼迫里涌现。文中反复出现“逼出”“逼临”“把来访者置入逼临态”这样的动词，主语在大部分句子里是治疗师，或者是治疗师的撤离动作。翻开第7章所依据的原始论文，疗效的最小单位被定义为“治疗师在临床互动中，成功制造出了一种迫使案主不可代偿地、亲自做出一个……微小行动的特定情境”，这里的动词是“制造”和“迫使”，主语同样是治疗师。再翻开第8章所依据的原始论文，它的结语里有一句几乎反着说的话：此前的“接上

循环”模型要求治疗师站在互动之上去扫描、诊断、匹配，这与“改变永远发生在之间”的判断构成地基级的矛盾，治疗师没有高处可站。

三处放在一起，冲突是直接的。如果治疗师能够逼出、能够制造情境、能够迫使来访者做出某个动作，那么他必须先在互动之上看清来访者的哪一个动作是需要被逼出的，哪一种情境恰好能够制造，何时逼、逼到什么程度。这是一个导演的位置：他握有剧本，来访者在剧本里完成一个“自发”的动作。第8章拆掉的正是这个位置。反过来，如果第8章的判断成立，治疗师没有高处，那么前两章里那些以治疗师为主语的强动词就站不住。更要紧的是，第7章的核心限定是“亲自”与“不可代偿”：动作必须出于来访者自己，别人代做同一件事不算数，治疗师布置的家庭作业也不算数。可一旦那个动作是被治疗师“制造”的情境“迫使”出来的，发起者实际上已经换成了治疗师，来访者只是执行者，“亲自”被架空，这与第7章附带的另一条判错标准（来访者自提的行动与治疗师布置的行动在后续变化上有无差别）直接相撞。

本书对此作出一个全书统一的裁定，并在这里正式交代这次改动。裁定分两句。第一句：“撤离”一词保留，指治疗师不再填充某个位置这件事。第二句：“逼”的主语只能是处境，不能是治疗师，也不能是治疗师的动作。凡原论文中以治疗师或其撤离为主语的“逼出”“逼临”“迫使”“制造”“设计”，一律改写为位置空出之时、旧的期待落空之后、处境逼出、那个动作无人可代这类句式。第6章中“把来访者置入逼临态”这个说法整句取消，不以任何方式保留；第7章中“探测—设计—等待”改写为探测—安放—退后，而且安放的材料只能来自来访者尚未言明的传递，不得来自治疗师的预设。第8章“治疗师没有高处”这一判断居上，凡与它冲突的句子，让路的是句子。

改动的理由有三层，与文风偏好无关。第一层是归属。第7章要证明的是一件事的所有权，也就是那个动作为什么必须记在来访者的账上。若说治疗师“制

造”了情境，等于把动作的发起记到治疗师名下，来访者只保留了肌肉的执行。这与第2章对租借的批评是同一个问题的两面：第2章批评治疗师替来访者供能，第7章若写成治疗师替来访者发起，就是在批评中重演被批评的结构。本书不能一边指出治疗室里的所有权会被悄悄转移，一边在理论的句法里先把所有权转走。

第二层是认识上的高度。“逼”需要知道逼向何处。第6章的原始论文自己写得清楚，期待被违背之后，认知系统的归因方向并不是自动决定的，可以转向“答案在我内部”，也可以转向“这个治疗师不专业、这套疗法没用”，后者的结果是脱落。方向由什么决定，不由治疗师决定，要看来访者此前是否有过被承接的经验、是否仍有可被调动的成长动力。治疗师既然不能保证方向，就没有资格使用一个暗含方向的动词。把撤离写成“逼出新秩序”，是把一个结果未定的事件写成了有把握的操作。

第三层是责任。“逼”这个动词带着一种强硬的主人姿态，也带着一种事后可以邀功的结构：改变发生了，是治疗师逼出的；改变没有发生或者变成崩塌了，是来访者承受不住。这个结构两头都对治疗师有利，两头都对来访者不公。主语改成处境之后，这种结构就解体了：处境在治疗开始之前就在那里，来访者此前一直用等待外援的方式绕着它走，那层被外部裁决覆盖的薄膜撤掉以后，薄膜下的东西第一次被触碰。治疗师在这件事里做的是不再往上面加一层，而不是去按住来访者的手让他摸。前一句话可以由第三者核对，后一句话是想象出来的导演动作。

主语的改动同时影响一个重要的措辞：“撤离”并不是“离开”。治疗师人还在房间里，注意力还在，只是某些回应不再出现。这一点后面谈责任时还会用到。

改动的代价需要摊开来写，不能因为裁定是为了守护一个原则就假装它没有代价。第一项代价是因果句式变弱了。原论文可以理直气壮地写“撤离导致逼临，逼临触发重新归因”，那是一条清晰的、可以画成箭头的链。改写以后，我们只能写：位置空出时，来访者的旧期待落了空；落空之后，归因可能转向内部，也可能转向外部，也可能转向脱落；转向内部的情形里，某个动作有时会在处境的压力下出现，那个动作无人可代。这条链里，治疗师的箭头只指向“空出”这一环，之后的每一环都不在他手里。这样写出来的理论，预测力比原论文窄，但它承认了一个原论文回避的事实：撤离的效应不能被理论保证。

第二项代价是研究设计要重新拿捏。原论文的预测可以用随机分配治疗师行为的方式检验，改写后依然可以，因为可以被分配的是治疗师的行为，也就是是否继续填充某个位置；不能被分配的是来访者的动作，那个动作只能在事后被记录和判别。第7章的几条判错标准也因此都放在事后：动作是不是来访者本人做的，第三方是否能辨认，是自提还是布置。这些标准在原论文中就是事后的，改写没有损失它们，损失的是原论文里那种“设计—产出”的研究气质。

第三项代价最要紧：治疗师在这个体系里还负什么责任。主语换成处境，很容易被误读成治疗师免责，“不是我逼的，是处境逼的”。这个免责的路必须堵死。本书认为治疗师至少负以下几项责任，它们是事后可以被督导和记录核对的职责，不是一份操作清单。

其一是撤之前的核查责任。第6章写明了三项前提：来访者能够确信裁决源已经退出，也就是治疗师确实不在可以裁决他的位置上；来访者有一个能被触碰的自己，自我边界足以承受落空；来访者的内部成长动力没有耗尽，这一项是硬门槛。三项里任何一项不成立，撤就不该发生，而判断它们成立与否的人，恰恰只能是治疗师。这是治疗师在“没有高处”的框架里唯一必须保留判断的地方，它是对承受力的判断，不是对来访者生命方向的判断。

其二是留下的责任。空出一个位置不等于走开。零功能在场的原论文把伦理先决条件写得清楚：不回应必须是被诊断支持的、被接收与确认所前置的、被持续在场所包裹的，治疗师看着那个空位，与来访者一同在空位里，而不是把空位留给来访者一个人。有人在沉默里分不清冷淡、无力与撤空，最后受伤的是来访者。

其三是识别与转换的责任。落空之后的痛苦有两类，一类是旧支架松动时的张力痛，来访者仍能对自己提问，仍有“我能”与“我不能”的拉扯，对治疗师的不作为有敌意；另一类是弥散的、无补偿的崩塌，痛苦里没有自我指向的追问。前一类可以留在空出的位置上陪着，后一类必须停止撤，恢复支持性的结构。区分它们的人是治疗师，识别错了的责任也是治疗师的。

其四是不把改变记到自己名下，也不把崩塌记到来访者名下的责任。改变发生，功劳无从归账，第9章已经论证过；崩塌发生，把它说成来访者“没准备好”或“抗拒逼临”同样是归账，因为它又一次把不可知的事件归给了一个人。治疗师能够说的话只有两类：我在什么时候空出了什么，空出之后我看到了什么。

这四项责任有一个共同特点：它们都是对“撤”本身的责任，不是对“撤出来的结果”的责任。改写之后，治疗师负担的是自己手里确实握着的那一环，没有再多。

还需要说明一个容易引起的反问：既然处境逼出，处境又不是治疗师造的，那么“撤”这个动作到底做了什么，凭什么说它改变了什么。答案是，处境在治疗开始以前就在，但它被一层东西遮住了，这层东西包括来访者习惯性的外求，也包括治疗师善意而及时的回应。来访者说“我不知道该怎么办”，治疗师回应以方向、解释或安慰，处境就又被盖上了一层；治疗师不再盖，处境就露出来了。露出来的不是治疗师的作品，是来访者自己的问题，它本来就在。治疗师的

贡献因此是一种否定性的贡献，这就是第3章、第5章、第6章共同守护的东西，也是第11章要继续追问的东西：这种否定性的贡献，会不会被治疗师做成一个新的位置。

关于这一节，本章的读数可以这样记录。取一批已经出现来访者关键动作的会谈记录，由两位独立编码者，在不知道本书立场的情况下，标出每个关键动作之前最近一次治疗师话语的类型：布置或提议，追问来访者自己的话，沉默或空出，其他。再标出来访者自己叙述这个动作时的发起标记：是自己提出，是治疗师建议，还是处境逼迫。读数是这两组标注的对应关系。本书的预测是，在被来访者认定为转折的动作之前，治疗师的最近一次话语较少属于布置或提议；若相反，布置或提议占多数，而且这些动作的后续效果与自提动作没有区别，那么主语改写的理由就被削弱了一部分：此时“亲自”这个限定在经验上并不起作用，第7章的核心将动摇。这一条尚未检验。

主语改动还有另一个后果，本章留在末节处理：如果治疗师不是导演，他能不能是一个“备场的人”。这个问题与第11章直接相连。

◆ 四、织体还是微制度：补一个外部反馈参照

三场自撞之外，还要补上一场小的，它发生在第1章与全书之外的一个邻居之间。第1章的涵容性织体说，治疗一直在前进，契合度越来越高，改变的能量却被转进了治疗室内的闭合回路，进展穿不过墙。另一篇讲知行鸿沟的论文提出过一个看上去相近的判断：来访者“知道却做不到”，原因不在意志薄弱或者练习不足，旧的反应模式已经长成一个完整的小型制度，有规则、有角色、有叙事、有自动执行的身体反应，还有对环境的殖民，它把来访者的时间、空间与关系三种日常结构都占了下来，治疗室里的洞察一回到日常就被它修复、转译、吞没。我们不妨称它为心理微制度论。两个理论讲的都是“关系里一切顺利，生活

里什么都没变”，一个把原因放在关系太契合，一个把原因放在旧结构太顽固。如果只看结局，它们无法区分。

先用一个情形让两种解释同时登场。汪涛（化名）接受了两年的个体治疗，他与治疗师之间的契合令双方都愉快：他善于表达，治疗师善于接住，每次会谈结束时他都有“又看清了一层”的感觉，对自己拖延的来龙去脉能讲出三套彼此自洽的解释。可是他手上那份拖了很久的专业认证，两年里一页也没有动。织体论会读到：他的契合体验本身成了奖赏，两人在洞察的回路里循环，行动那一端没有任何来自外部的摩擦把能量引出去。微制度论会读到：拖延是一个自维持的小政权，它有一套叙事免疫系统，每当洞察出现，它就把洞察转译成“又是一个对我的理解”；两年的会谈里，咨询关系还被它收编为一个合法性生产器官，“连专业人士都说我这样是有原因的”。同一个汪涛，两种完整的讲法。

这时需要一个判据，而且这个判据要由实际会发生的现象来承担，不由理论的修辞来承担。判据是：把外部反馈参照补足，也就是让汪涛的行动被一个不在治疗室回路里的人看见，并有可核对的反馈回来，比如一位同样在备考的同伴每周对他的进度写两句话，或者一位与治疗师没有私下联系的第三方观察者提供独立报告。织体论预测此时会出现松动，因为这正是被缺位的那个条件，补上之后，闭合的回路有了出口，行动会开始发生。微制度论预测此时无变化，甚至会变坏，因为对一个已经占据了日常的旧制度来说，新来的反馈只是又一份可以被转译的材料，“他们只是客气”“她根本不了解我的情况”。两种预测方向不同，而且可以在同一个来访者身上先后观察。

判据的表达需要谨慎，有三处容易被误读。第一，“补足”是指外部反馈参照在场，不是指治疗师把自己的角色改成监督人。后者把治疗师变成外部反馈的来源，反而让两个理论都得不到清晰读数，因为治疗师本人就在回路里。第二，“松动”须有可核对的外部指标，比如第三方可以记录的进度或行动频次，

来访者自述的感觉不算，因为织体的特点恰恰是体验上的顺畅。第三，短暂的上升不是松动。如果补上参照之后头几周行动上升，随后回落到原来的水平，说明两件事叠加存在：织体的部分被打开了，但微制度的部分把新数据吸收了回去。这一类“先松后不变”应当单独记录，不能被算入任何一方的胜利。

两个理论为什么不是同一件事，现在可以说得更清楚。织体是治疗室内的闭合，治疗室之外在这个模型里通常是敞开的，没有一个守备森严的对手，行动的出口是被治疗室内的奖赏吸走了能量。微制度的前提相反：治疗室之外有一个对手，它在来访者的日程、居所、亲友的行为里都有据点，行动即便走出了治疗室，也会撞上一个已经布好防的地盘。同样是补一个外部反馈，在织体那里是打开一个出口，在微制度那里就是向一个已有主人的领地里派人，派去的人如果没有一个未被占据的落脚点，会在启动之前被围住。微制度论的原文因此强调要先找“飞地”，也就是日常里尚未被旧反应完全定义的一小块时间、空间或关系，新反应在其中产生的数据才是干净的数据。这个说法本书只作为区分线使用，不当作操作：如果外部反馈参照放在汪涛被拖延占满的家里，没有变化，放在一个与旧生活无关的新社群里，出现了行动，那么微制度论得到支持；如果放在哪里都有变化，织体论得到支持。

在判断对判断的层面，还要把另外两种解释放进来对撞。一种是补课论，也就是微制度论的原文专门批判的那一家：来访者并不是被什么结构困住了，只是新反应练得太少，旧反应练了几十年，新的当然竞争不过。补课论预测的是，在日常场景里多做练习，效果自然积累。微制度论反对的是它的充分性：练习若发生在旧制度的领地里，数据被环境里的旧触发系统性污染，进不到期望的计算里。织体论对补课论没有直接的立场，它只关心练习发生之前能量去了哪里。三种解释因此排出了三条不同的线：补课论要求加练，微制度论要求先找飞地，织

体论要求打开出口。汪涛的案例如果被放进一个设计里，三条线会给出三种不同的预测，这正是它们不是同一件事的证据。

另一种需要切割的是传统的“阻抗”说法，也就是认为来访者的不动是一种针对治疗的防御。阻抗是把停滞放在来访者的动机上，要求治疗师去处理这种动机。本章的两个理论都拒绝这种归因：织体的形成无需任何一方有阻抗，双方都在忠实地做自己该做的事；微制度的运转也不需要来访者有意对抗治疗，它自动把新信息转译为旧信息。与阻抗说相比，这两种理论都把责任从来访者的动机移到了结构上，而且给出了不同的结构。再就是治疗性共谋，它和织体看上去很近，都是治疗师参与了停滞的生产。分歧在于共谋通常预设某一方回避了某个本该面对的内容，织体里没有人回避，所有的内容都被谈了，谈得很好，问题恰在于一切都在回路里。

这个裁决安排还要受到一个反驳的检验，它来自织体论自己。想象汪涛在补入外部反馈参照之后，想了很久，决定放弃那份认证，转去做一件让他安心的小事，生活因此变得宁静而收入下降。织体论是否要把这判为“改变的未发生”？答案是不要，而且本书在这里替织体论守住它自己划的边界：它的适用范围限于来访者本人对不行动有冲突、有痛苦的个案，不是用来判定一个人的人生选择是否足够进取。一个完成了内在重构、不再因不行动而痛苦的来访者，不属于织体论的对象，补外部反馈参照的判据对他也无从读数。同样的边界还有一条：来访者所处的外部环境严酷，没有任何可依凭的庇护所时，织体可以是一个合法的临时庇护所，松动它的冲动要被克制。把这个边界和本章的判据放在一起，补外部反馈参照不是一个任何时候都可以做的动作，它自己也要通过第11章要讨论的那几道门。

最后把这一节的撤回条款写明。若在同一批个案上，补入独立的外部反馈参照之后，被判为织体闭合的一组与被判为旧制度占据的一组，行动指标的变化没

有可分辨的差异，则两个理论在这个分岔点上没有分别，应当合并为一个关于“关系内顺利与关系外不动”的更一般的说法，第1章与全书的这一块相应改写。若补入参照之后，两组都不动，则两个理论都不是对这批个案的好解释，需要在它们之外找原因。这两条均尚未检验。两个理论的原论文也都没有一手实证数据，微制度论的原论文明确承认它是概念分析，织体论的原论文则把证伪放在随机分配与过程编码的设想里，这些设想本书并没有替它们完成。

◆ 五、九章怎样互相定义

三场自撞做完，前九章的关系发生了变化。此前的九章可以被读成九个并列的发现，每一个都有自己的来访者、自己的反例、自己的读数。现在每两个邻近的章节之间多出了一个变量，这个变量把两章绑在一起：拿掉它，两章对同一个案会说出同样的话，本书的分章就失去理由。把它们逐个点出来，是对前九章的一次清点，也是这本书愿意接受检查的方式。

第1章与第2章之间的变量是结案之后的走向：回到原状，去找下一个出借人，或者在无人在场时自己站住。第2章与第9章之间的变量是借用之后所有权是否转移。这两个变量合起来，其实是同一条时间线上的两个读法，前者看的是类型，后者看的是结局。第3章与第5章之间的变量是治疗师的两个位置，解释权与关系功能，加上一条主动性梯度，用“事后能否说出我当时是打算这么做的”来分。第6章、第7章与第8章之间的变量是动作由谁发起，也就是动词的主语：第6章与第7章的强动词在第8章面前让路，处境成为“逼”的主语，来访者成为“做”的主语，治疗师只保留“空出”和“退后”。第1章与知行鸿沟的论文之间的变量是外部反馈参照是否补足以及补足之后的行动指标。这五个变量没有一个是新加的立场，它们全部来自各章自己的原论文，只是此前没有被放在两章之间当作可以输的赌注。

有一点需要特别交代，因为它关系到全书的一致：第8章居上，这个“居上”只有一层意思：当别的章的句子与它的判断冲突时，句子让路，它的论点并不因此比别的章更重要。前面第三节已经做过这样的让路。别的章也受到这种约束。第3章中凡暗示治疗师能够“掌握”共同进场的说法，都要退回“只能在来访者那边确认”这一条；第5章中凡把零功能在场写成一种可以持有的技术的说法，都要退回“它的零是理想极限，任何一次操作都达不到”；第4章中的“不逾”，是在理解凝结之前撤回，不能写成治疗师判断了来访者尚未准备好、因此不说。这几处改动都不大，但它们决定了全书的语气：治疗师在这里始终是一个位置的守门人，没有一次是舞台的导演。

在这个统一的框架里，本章的读数可以统一表述为一个事后可记录的现象：同一个关键动作，在随访窗口内的发起条件。具体说，对每一个被来访者或第三方指认为转折的动作，在六至十二个月的随访窗口里记录三件事：动作是否在治疗师缺席、没有新的出借人在场的情形下再次出现；动作发起之前，是否存在一个特定他人的认可作为条件；动作发起时，来访者的叙述里有没有自己的念头，还是只是对某个声音的复现。这三项记录合在一起，可以同时给第一、二、九章，第三、五章，第六、七、八章提供各自的分岔数据。它们不要求治疗师自评，也不要求来访者回答“你觉得是谁做的”。

读数立得起来，仍要面对它自身的局限，这些局限本章必须写在明处。第一个局限是“治疗师缺席”只能排除外部的在场，排除不了内在的在场。来访者在新情境里想起治疗师的话、模仿治疗师的语气，是常有的事。在第2章里，这被写成租借的一种形态，脑内的治疗师像一盘录音带，卡在没有预写的分支上就断了。在科胡特的转变性内化模型里，同样的现象是内化的正常过程（Kohut, 1971）。本章的区分只能是这样：如果来访者在发起动作时，那个内在的声音是被他调用、被他修改、与他自己的念头混合的，那是所有权；如果他必须逐字复

现，在声音没有预写的地方就卡住，那是租借。这个区分比外部在场的区分更难观察，需要来访者自己的叙述和第三方的编码一起承担，难度大于上面第一节所给出的判据。

第二个局限是随访的选择偏倚。愿意接受六到十二个月后回访的人，与失联的人不同，失联者里可能包含恰恰“又回到旧状态”的一批，也可能包含已经好到无须再提的一批。因此所有关于“站得住”的比例的说法，在本书里都只能当作方向，不能当作频率。

第三个局限是新情境并不总是可得。被照护者、被监管者、处在长期封闭环境里的人，没有一个“治疗师缺席且无替代依赖对象”的新情境可供检验，判据对他们不适用。生活中的重大事件，如丧失、失业、迁徙，也会使新情境本身变形，污染读数。这类个案要么排除，要么单独分析，不能混进主分析。

第四个局限是危机。自伤或自杀风险、急性危机、自我结构严重缺损、心理储备耗尽的来访者，不适用本章的任何一项判据，也不适用本书的撤。这些情形里，随访的目的是安全，不是迁移，治疗师的第一责任也与辨认所有权无关，要紧的是保证来访者活着并得到结构化的帮助。第11章将在这一点上写得更硬。

关于本章的判错条款，需要单列。本章有三场自撞，每一场都可以输，写成三条。其一，借用的分岔。若在结案十二个月后的随访里，被判为“在无人在场时自己站住”的一组与被判为“找下一个出借人”的一组，在功能水平与独立试探的轨迹上没有差异，则所有权转移的变量无后果，第2章与第9章的矛盾被消解为叙述上的偏好，本章第一节的安排撤回。

其二，撤的分岔。若在非自觉的落空里观测到与共同进场等量的松动，第3章与第5章应合并；若两位独立编码者对“解释权撤离”与“关系功能撤离”的编码一致性超过八成，二者同样应合并。

其三，导演的分岔。若来访者自提的关键动作与治疗师布置的关键动作在后续变化上没有差异，则主语改写所依托的“亲自”限定在经验上不起作用，第7章的核心受挫，本章第三节裁定的理由随之削弱。

此外，织体与微制度之间的第四条已见上节，补入外部反馈参照之后两类个案的行动指标没有分别，则两个理论应并入一个更一般的说法。以上全部尚未检验，本书没有任何一条数据。

三场自撞的结果也要如实说一句：它们没有把九章变得更强，只是使每一章更难被单独读。第9章不能再独自宣布最深的治愈无主，第2章不能再独自宣布期内进步多半是借来的，第6章与第7章不能再以治疗师为主语谈撤离，第1章不能再把停滞全归给关系太契合。每一章都被另一章拿走了一点说话的资格，换来的是它们现在可以被同一组随访数据同时检验。如果这个交换让读者觉得全书的结论变得谨慎了，那是正确的感觉。

九章互相定义之后，全书的中心动作清楚了：治疗师不再填充某个位置，位置空出，处境逼出，那个动作无人可代，账记不到任何人头上。可这个动作本身是什么性质的，却还没有被追问。撤是一个功能吗？如果它是，它就可以被来访者的旧程序重新吸收，可以被写进培训手册，成为治疗师新的专业身份，也就是第四把椅子。更麻烦的是，有人会说，前九章讲的“位置”根本问错了地方，治疗的精要在治疗师熟成的身体里，不在位置上。还有一些时刻，这个位置根本不该空出。这三件事是下一章的事。

◆

11

第11章

让位也能占位，有时不该让

一场为期两天的工作坊上，培训师把“撤”拆成了几个环节，写在白板上，让学员两两练习。环节一是识别：来访者发出“你来告诉我该怎么办”的请求时，先察觉自己想给方向的冲动。环节二是停留：在这个冲动里多待几秒，不回答。环节三是邀请：把眼前正在发生的模式放到两人之间，说一句“我们俩现在在做的是什么”。（说明性合成案例）练习时有人计时，有人打分，有人把停留的秒数记在表格的右栏。第二天下午的角色扮演里，一位学员在扮演治疗师时，在第七秒准时开口，说出了环节三的那句话，语气温和，分寸精确，扮演来访者的同伴愣了一下，随后笑着说：“你是不是在练习什么？”

这个笑声所指出的问题，是本章的全部起点。前十章反复说的是：治疗师做得越对，越容易占住那个只有来访者能站的位置；改变在位置空出时发生，却记不到任何人账上。第10章已经把这句话在九章之间校准了一遍，并规定了动词的主语。现在需要回头问这句话自身：空出位置的那个动作，本身是不是又一次占位。一个被写在白板上、被计时、被打分的“撤”，是不是已经成了治疗师的新专业身份，一把比“懂”“给”“判”更不容易被发现的椅子。再往前一步，还有两个更难的问题：认为前面所有的“位置”之说都问错了地方的人，会说治疗的精要在治疗师熟成的身体里；认为本书鼓励了某种危险的退让的人，会指出有些时刻治疗师无论如何不该让。本章依次面对这三件事，写法比前面更硬，因为这里要检查的是全书自己的动作。

◆ 一、撤也是一种功能

先看撤的第一重难处，它来自第5章，叫作元功能悖论。当治疗师有意维持一个“被投射到、却不执行任何关系功能”的空白位置时，他正在执行一项叫“撤空”的功能。对来访者的旧程序来说，这是一项负性功能，仍然是功能。来访者可以察觉其中的规律：每次我问这个问题，他都不答。察觉之后，旧程序就有了新的食材。“他在用沉默操作我”，这句话一旦成立，撤空就被旧程序吸收了，旧程序没有被废止，它只是搬到了更高一层。

这个悖论没有出口，只有层级。第5章的原论文给出过一个回应，称为二阶的零功能操作：当治疗师察觉来访者已经把“不回应”识别成一条可以操纵的规律，比如来访者学会了在沉默中显得更加痛苦，以换取更多的沉默，治疗师就打破这个格局，把两人正在做的事摆出来，邀请对方一起看。这个动作既不是接纳，也不是拒绝，也不是继续撤空，撤掉的是“撤空操作者”这个身份本身：治疗师从“我给你空白”的台座上下来，站到棋盘旁边一起看棋。必须同时承认，原论文自己也写明了：即使这个二阶操作，也不能保证不被旧程序以更高阶的方式重新吸收，因为一个足够顽固的旧程序可以把“邀请他一起观看”也译解成一种可以认识、可以执行的新程序。这是一个无限梯子，没有哪一级是终点。

本书的立场需要比原论文再收紧一步。梯子是无限的，这件事决定了撤不能被定义为一项技术，也决定了不能把“二阶”写成一个比“一阶”更可靠的技术。因为二阶一旦被命名、被教授，就会成为一阶，进入培训表格的右栏，等待被下一次识别。所以“零”只能是一个理想极限，每一次具体的撤都达不到它，每一次成功的撤都含着被吸收的种子。这不是谦辞，它规定了本书如何谈撤：只能谈撤的条件与撤的读数，不能谈撤的做法。

第3章的共同进场在同一个难处上有一条补充，说得更尖。共同进场问：这个概念是否会在传播中被手册化，变成一项“去专家化技术”，治疗师学会在适

当的时候说一句“我可能又在试图当一个什么都懂的人了”，把它当作高级沟通技巧使用，操作者仍然站在“我用这个技术来更好地帮你”的立足点上。原论文承认这个风险确实存在，然后给出一个不依赖话语的区分：共同进场是否兑现，要看治疗师在开口之前的那个瞬间，他的主体状态有没有发生一个转换，他是否切身体验到自己的专业工具此刻正在失效。那是一种前反思的跌落，不是一个“我应该显得谦逊”的认知判断。这个跌落感无法表演，因为表演的人注意力的焦点在“技术效果如何”，而跌落的人注意力的焦点在自己当下的处境里。

跌落是内部的，别人看不见，所以原论文随后加了一道自反约束：共同进场不能在操作者那端自我宣称，只能在接收者那端事后确认。如果来访者回忆起这一刻时，没有任何与“他也不太确定”“他把自己也放进来了”相关的体验变化，那么无论治疗师如何自认为做了共同进场，这个操作都没有兑现。这条约束对本章是核心材料。把它推广到所有的撤：撤是否发生了，不由治疗师说了算，不由培训师打的分说了算，不由督导的清单说了算，只在来访者那边可核对。工作坊里那位在第七秒开口的学员，按这条标准，不能算撤，因为扮演来访者的同伴笑着问出了“你是不是在练习什么”，这句话本身就是一个读数：来访者那边已经把这个动作识别成了一项操作。

由此，本书把这一节的承重判断写成这样：撤作为动作可以被完成，作为位置的空出却只能被事后确认；越是能被计时、打分、教授的撤，越接近一项技术功能，越容易被旧程序重新吸收。这个判断并不等于说撤不可学。治疗师当然可以学会辨认自己想填满的冲动，学会在冲动里多待几秒，这些都是实在的能力，只是它们是撤的前置能力，不等于撤。一个在练习室里能够停留七秒的人，到了会谈里可能因为太想停留够七秒而没有任何人在场。

这里要与三个最近邻明确切开。第一个是弗洛伊德的节制原则（Freud, 1915）。节制要求分析者不满足来访者在移情中的要求，是一条规则，规则可以

遵守，也可以教授和检查，它的价值在于随后的诠释会兑现被保留下来的材料。节制没有元功能悖论，因为它从来不声称自己是零：它是一项有明确理由、有明确归宿的操作。本章的撤如果被写成一条规则，就退化成节制，丢掉了位置空出这一层，也就是丢掉了读数必须出自来访者这一条。第二个是比昂的“无记忆、无欲望”（Bion，1967）。比昂要求分析者以一种近乎修行的方式放下对已知和对疗效的执着，这是治疗师内部的训练，训练的成败由分析者自己在会谈中体察。它与撤相近，却把判准放在分析者一侧，这恰好是本章要反对的：一位成功做到“无记忆、无欲望”的分析者，来访者可以照样把他放在全知者的位置上，因为他的沉默更深了。第三个是治疗性在场（Geller & Greenberg，2012）。它描述治疗师以全身心的开放、接纳与专注与来访者同在，是一种可以培养的内在状态。本章与它的分歧很具体：治疗性在场的评价标准是在场者的质量，撤的评价标准是来访者那端某个位置是否空出了；前者的评价本身就可以成为被占的对象，一个“在场质量极高”的治疗师，仍然可能是来访者唯一的接收者。

在这一节结束之前，还要补上撤的另一个限度，它与元功能悖论相关却不相同：撤必须能被来访者拒绝。来访者在某一刻明确说“请不要这样”“我需要你说话”，治疗师必须立即退出撤空，回到支持性的回应，不能再加一句“这恰好是你的旧程序在起作用”。这个限度很容易被省略，因为理论上，来访者的拒绝也可以被解读成旧程序的抗议。本书不接受这种解读。撤以来访者能够说“不”为前提，来访者的“不”一旦被诊断为旧程序，撤就变成了一种来访者无处申诉的权力。

◆ 二、撤一旦可教，就是第四把椅子

前面三把椅子有一个共同的构造：每一把都对应治疗师身上一项被认可的品质，懂的椅子对应敏锐，给的椅子对应温暖，判的椅子对应智慧或权威。来访者对这些品质表示感谢，治疗师据此确认自己有用，椅子由此站稳。现在假

设“撤”被命名为治疗师的一项能力，写进课程大纲，写进督导清单，写进同行的称赞里：“他很会退后。”第四把椅子就这样出现了。坐在上面的人叫作“懂得撤的人”，来访者对他的感谢变成了“你从不替我做决定”，治疗师对自己的确认变成了“我没有占位”。这把椅子比前三把都难被发现，因为它的靠背上写着“不要坐椅子”。

批判者的间离提供了一套现成的解剖。这个概念原本是针对一类批判实践提出的：当批判者清楚看见自己与批判对象之间的结构同构，既不能否认，又不能接受它的全部后果，就会在承认同构的同一个言语行为里，用一个修辞动作把自己隔开。它有三个咬合的步骤。先是甄别同构，批判者抢先说出“我的方法当然也可能陷入它所批判的结构”，让自己站在比批评者更早看见局限的位置。然后是设隔离带，承认的是“风险”，隔开的是“当下”，也就是“但此刻我正在做的这件事，是在面对现场的”，风险与当下之间的界线在哪里，是不被追问的，隔离带靠不可追问维持。最后是把隔离带嵌进话语的语法，“当然，我们也要警惕自身成为另一种教条”这样的标准句反复出现，说完之后，批判者便可以继续使用同一套术语，占据同一个高地。支撑这一切的是一个认知上的缝隙：说出风险是一个瞬间完成的言语行为，承受风险是一个无法被言语行为替换的持续状态，人容易把前者误体验为后者的兑现。

把这套解剖搬进治疗场景，有三种形态。第一种发生在治疗师个人身上。会谈里，治疗师察觉自己正在给出一个过于漂亮的解释，随即说：“我好像又在试图当一个什么都懂的人了。”这句话在最好的情形下是第3章所说的共同进场，来访者那边会出现“他也不确定”的体验。在最坏的情形下，它是一个标准句：说完之后，治疗师知道自己已经警惕过了，可以放心地继续那条解释的路。两种情形说出来的话一模一样，差别只在说话之前的那一刻，治疗师是否真的从立足

点上跌落，以及说话之后他的做法有没有发生实质变化。这个差别从外面看不见，自己也容易看不清，因为“我已经说过了”本身就是最舒适的自我安慰。

第二种发生在培训里。一本教材的第一页写着“警惕技术化”，随后的二百页是技术。一份督导记录表在原有的栏目之外新增了“本次会谈占位次数”和“撤的次数”，督导和受训者各自一丝不苟地填写，每一次填写都在对治疗师说：你正在被计量，你应当表现得没有占位。第8章的原始论文预见过这个情形，写下过一盏红灯：当治疗师读到“刻意延迟”这个词之后，在沉默中感到的不再是对来访者的关注，而是对自己延迟得是否足够久的计量，那一刻起，他已经站到了河岸上看着河里的自己，转化场就塌了。更值得重视的是，该文作者预先声明：若这套概念被写进训练手册而丢掉了它赖以成立的前提，那份手册便与该文无关；并要求把这盏红灯写在任何训练手册的第一页。可红灯本身也会成为标准句：第一页写着“不要把本书当作清单”，第二页开始就是清单。

第三种形态在理论里。一本讲“懂的人有问题”的书，自己也是一本懂的人写的书。这一层留给结语去面对，这里只做一个记号：本章对撤的批评，同样适用于本书对撤的论述。若读者读完前十一章，从此在会谈里带着“我要空出位置”的意图进入，本书就制造了一批新的占位者，而这个责任不在读者。

三种形态里，哪一种与批判者的间离“同构”到足以套用，哪一种只是“相似”，需要写明区分线。同构的核心是承认被当作了兑现：占位的风险被说出来之后，说出来这件事取代了持续的承受。当然，治疗室里的情形比学术批评多出一层，来访者在场，来访者的体验是第三者能核对的东西，间离在学术共同体里依靠的“不可追问性”在治疗里不完全成立。这一点使撤比批评有更好的出路，也使第一节的原则更有分量：判准必须落在来访者那端。

与三个最近邻分开。第一个是韦伯所说的卡理斯玛常规化（Weber, 1922/1978）。常规化讲的是魅力权威转成日常制度，代价是原初活力的流失。

如果把“撤”的衰变也解释为常规化，预测是：只要拒绝制度化、拒绝培训、保持运动状态，退化就不会发生。间离的预测相反：一个全靠师徒口传、没有任何手册的流派，同样可以把“我们是不占位的”变成身份凭证，因为间离不要求制度，它要求的是承认被兑换成继续的资格。前者是能量的耗散，后者是资格的滞留。第二个是道德许可效应（Monin & Miller，2001）。做过一次有道德意味的行为之后，人更容易做出可疑的行为，这是个体层面、多半无意识、单次的额度效应。治疗师说一句“我可能又在当懂的人”之后更放心地继续占位，看上去像一个许可案例，差别在于间离是有稳定话语形态、可以跨代继承的结构，它留下的是一种特有的语用标记：同一句话里同时完成承认与隔离。第三个是罗蒂的反讽主义者（Rorty，1989）。反讽主义者清楚知道自己的终极语汇是偶然的，却继续使用它。这是对间离姿态最精致的宏观命名，把它搬到治疗里，“我知道我的专业语汇是偶然的”这句话可以让治疗师一直舒适地占着椅子。罗蒂给出了姿态，没有给出姿态在每一次具体言说里被操作的机理，这里要追问的恰恰是机理。

德麦国际专著第306号《心理学的典范革命》（王德生著）有一句话，“能做的不是发起，是备场”，本书愿意借来作为这一节的转折。它把治疗师从发起者的位置上请了下来，换成了备场的人。这与第10章对动词主语的裁定是同一个方向。可备场也有它自己的陷阱，备场的人同样可能占位。设想一位治疗师把治疗室布置得极其安静，椅子的角度、灯光的亮度、开场白里那句“在这里可以不说话”，全部出于善意的准备。来访者进来，体验到可以不说话的自由，这个自由是治疗师备下的。场备得越周到，来访者越难分辨，这份空是自己的，还是被给予的。再往下推一步，备场者永远在为下一个场做准备，他就成了这个场里的导演，只是导演的工作发生在开幕之前。第10章把“设计”改写成“安放”，并规定安放的材料只能来自来访者尚未言明的传递，就是要在这里设防：备场的材

料来自来访者，场里的第一个动作由来访者发起；如果备场的人事先已经知道场里会发生什么，他备的就是一出戏，不是一个场。

由此必须写下一句硬话：本书不提供避免占住第四把椅子的方法，因为任何方法都会成为这把椅子的一条腿。能够提供的只有可被外部核对的死亡条款。其一在来访者那端：来访者事后是否把某次“不回应”命名为治疗师的技术，比如“你是不是在练习什么”，这样的命名越多，撤越接近一项功能。其二在治疗师面对批评的反应上，借用间离研究给自己立的行为证伪：当督导或同行指认某一次具体的回应是占位，治疗师的第一反应如果是援引“我知道自己会占位”“这正是我在书里分析过的悖论”，而不是回到那一次回应的实质去辩护或认错，则他已经是间离的一个活例。这一条对作者同样有效，本书的作者放弃说“我已经自反过了”的权利。

◆ 三、反方出场：精要在熟成的身体里

迄今为止，本书一直默认一件事：疗效的关键是一个位置，治疗师占住它，改变就进不来，治疗师空出它，改变才有处落脚。同一位作者的另一篇论文《技艺的肉身》对此持完全不同的看法，它的题目已经把主张说了一半：心理治疗的精要，在治疗师熟成的身体里。这是本书必须正式请上场的反方，不是顺手点到的对照，因为它从另一头把前十章的基础搬走了：如果起作用的是一具被时间浸泡过的身体，谈位置空不空，是在谈一个次要的变量。

先听反方的案情。一位有二十年经验的治疗师，面对一位习惯以学术报告的口吻讲述私人生活的男性来访者。前十五分钟，治疗师几乎不说话。来访者讲到一次与妻子的争吵，说：“我觉得她当时有点过分，但我能理解她。”在“理解”这个词出来的当口，来访者的声音有一瞬间哑了一下，几乎听不见。治疗师事后向督导描述：“我不知道怎么说。不是那句话说了什么。是他说我能理解她

的时候，声音哑了一下。然后我的身体有反应了，我没有想，就问了他一句：那个被你理解的她，你对她有什么感觉？”来访者停了很久，说出一句他在二十次会谈里从未说过的话：“我觉得她很可怜。我觉得我也很可怜。”

反方用这个场景提出三个层次的主张。第一层，这不是技术的自动执行，没有手册会写“在来访者声音哑一下的瞬间提这个问题”；也不是随性发挥，同一位治疗师在别的来访者身上并不总能做到；更不是经验的简单累加，因为经验的数量里并不包含这一下的方向。第二层，这种能力有一个可以描述的发生工序：先是学会驻留在“不知道”里，也就是负向能力，然后是身体信号的辨认与归位，最后是从“感觉到了”到“知道手往哪伸”的默会整合，这个工序需要长时间的浸泡，无法被短期培训压缩。第三层是反方最锋利、也最容易被检验的一层：这种能力是分型的。一具身体只对它被反复浸泡过的那几类断裂长出受体，对没有浸泡过的类型近乎盲视，而且这种盲视不会因为一般敏感度的提高而消失。它把主张的重心从“不可言说”移到了“断裂类型特异性”，原因很实际：只讲不可言说，波兰尼早已占据了这块地基（Polanyi，1966），而“同一位专家在不同断裂类型上的表现差异，可以大到超过专家与新手之间的平均差异”这样的话，是可以被数据推翻的。

这场较量要在三个地方硬碰硬地打下去。第一个地方是账。本书的母题说，改变记不到任何人账上。反方的主张恰恰是：有一笔账记在治疗师的身体上，而且是全部要害所在。治疗师二十年的浸泡，使他在那个瞬间知道问哪一句，这个“知道”不是任何来访者的，也不是处境的。两种说法不能都是对的，至少要把账分开。本书的答复是承认两笔账。一笔是辨认的账：此刻有没有一个可以空出的位置，眼前的痛苦是旧支架松动时的张力还是无补偿的崩塌，这个来访者在哪一类断裂里，治疗师手里的哪一句话会把一个本来要空出的位置填满。这一类判断确实需要一具被时间浸泡过的身体来做，第10章列出的撤之前的核查、撤之

中的识别、撤之后的转换，都是这一笔账上的开支，本书对此是欠账的。另一笔是改变的账：那个无人可代的动作，来访者在空位里亲自做出的那一步，仍然不记在任何人名下。反方的案例里，治疗师问出那句话以后，是来访者自己说出了“我觉得我也很可怜”，这一句话是谁的，这个问题恰好把两笔账分开。

第二个地方是撤。反方的发生工序里，最底层是负向能力，是能够待在不知道里而不急着做点什么，这与本书所说的撤几乎是同一个东西。反方的立场因此比本书更彻底：它不仅同意撤是不可速成的，还主张撤的能力本身就是熟成的产物，长在身体里，不是姿态，不是可以选择的立场。本书同意撤不能被速成，不能被手册化，但拒绝因此把撤记作治疗师的资产。熟成的身体可以是一台出色的辨认器，辨认器不是账房。治疗师可以说自己的身体认出了空出的时机，不可以说是自己的撤带来了改变，后一句话才是第二节里第四把椅子的起点。

第三个地方是相反的预测，这是整场较量里最有教益的一处。位置说在第4章给出过一条判错条款：按来访者的自我概念清晰度分组，精准共情之后两组的同盟都会上升，四周后由第三方核实的自主行动，只在自我概念稳固的一组上升，萌芽的一组不升反降。换句话说，在位置说里，治疗师越精准，对尚未稳固的来访者越可能是闯入。这一点放到熟成论上，立刻变成一个针锋相对的问题：熟成度高的治疗师是不是最精准的人？是的话，他在自我概念萌芽的来访者身上是不是风险最大的人？反方的回答是否定的，它的论据正在于负向能力：熟成了的人，精准里含着驻留，不会在理解凝结之前冲过去。位置说的回答是不确定的：精准与驻留未必同时存在，技艺愈高，太准、太快、太早、太全这四种褒义词的过量形态愈容易出现，因为治疗师在他浸泡得最深的那一类断裂上最先看懂，也最快替来访者说出来。

这两个回答可以放在同一个设计里判输赢，因为它们给出了方向相反的预测。把治疗师按熟成度分层，把来访者按自我概念清晰度分层，由第三方核实四

周后的自主行动。若高熟成度的治疗师在萌芽组里同样使自主行动上升，位置说关于“精准即闯入”的那一项被削弱，熟成论的负向能力保护得到支持；若高熟成度的治疗师在萌芽组里表现反而更差，熟成论的保护之说被削弱，位置说得到支持。这个设计尚未实施，也没有现成数据可以回溯，因为现有研究很少按这两个维度同时分层。

反方还有一道本书必须直面的阴影：Goldberg 等人（2016）对 170 位治疗师的 6,591 名来访者做了追踪，发现治疗师并没有随经验的积累而改善，平均反而有小幅的下降。如果熟成确有其事，经验应当带来进步，这个结果对熟成论明显不利。熟成论有自己的答辩：它从未预测资历与疗效的平均相关，它预测的是分型的、不可迁移的沉积，同一位治疗师在浸泡过的类型上进步，在没有浸泡的类型上不动，甚至因为分布的固化而落差越来越大，总体的平均数把这两个方向抹平了。这个答辩在逻辑上成立，在经验上没有被检验：Goldberg 等人没有按断裂类型对个案编码，所以他们的数据既不能支持这个答辩，也不能推翻它。本书的立场是，公平地对待这一点，不借 Goldberg 之手去打熟成论，也不放过熟成论：一个拒绝一切平均数据的说法，必须自己拿出类型内的证据，否则它离“只有行内人才知道”的说法只差一步。

位置说在这里也不是 Goldberg 的盟友。有人会想，经验增长反而使占位更流畅，所以疗效不升反降，这个解释顺口，但它是事后的，本书不采用。位置说在这一点上能够诚实说的只有一句预测：经验增加了技术的精准，也增加了精准的闯入；这句预测与 Goldberg 的结果相容，不被它支持。

两方打到这里，各自露出了欠账。位置说欠的是：它说了治疗师需要辨认可以空出的时机，却没有解释这种辨认能力从哪里来、怎样长成，只能把它留给反方的发生工序去回答。反方欠的是：它的案例里，治疗师那一问之后，改变是由来访者说出的一句话完成的，反方没有解释为什么这句话必须由来访者说出才算

数，它把治疗师的“出手”写成了动作的原因，而本书第10章规定的动词主语正是要在这里改写：治疗师问了一句话，那句话把“她”重新放回了来访者的感受中央，随后来访者自己说出了一句从未说过的话；问话可以记在治疗师身上，说话不能。这样改写以后，反方的案例没有失去力量，它被恰好放进了两笔账之间。

还有一个疑问留给下一章：反方说精要不可被算法化，这一点若成立，对人机陪伴意味着什么。反方自己写下的第二种死法就是：如果有朝一日一个只靠语言统计的系统在处理来访者独特死结的精准度上稳定地超过资深治疗师，它的核心判断就被证伪。这条留给第12章。

◆ 四、不该让的时候

前三节追问的是撤是否又是一种占位。本节要说的是更基本的一件事：在某些时刻，撤本身就是错的，不论它是不是占位。全书一开始划过的适用范围在这里要重新写一遍，写得比开头更硬：本书的判断适用于来访者尚未亲自命名、亲自发起的那些地方；不适用于自伤自杀风险与急性危机，不适用于自我结构严重缺损，不适用于心理储备已经耗尽的人。在这些情形里，需要的是结构化的帮助与安全流程，位置说在这里停止发言。

设想一个具体的时刻。梁远（化名）已经接受了两个多月的治疗，治疗师正处在一段有意的撤里，不替他命名，不给他方向，让沉默停留。第九周，梁远在一段很长的沉默之后说：“有时候我觉得，我要是消失了，大家都轻松。”这句话有两种读法。一种读法来自本书前几章：他正在逼临态中，痛苦里带着自我追问，这是旧支架松动的阵痛，治疗师只需留在空位里，不救场、不介入。另一种读法来自任何一部临床安全规范：这是一个关于生命的信号，当下必须转入风险评估。本书的立场没有任何含糊：第二种读法，并且是无条件的。凡是来访者以

任何方式表达出终结生命的念头，不论它出现在撤的哪个阶段，不论它此前是否看上去像“自我指向的追问”，不论治疗师觉得这句话在理论上属于什么形态，评估与保护都先于一切其他考虑。撤暂停，位置的问题往后放。

这不是对撤的让步，是本书对自己立下的底线。第6章的原始论文给出过四个维度，用来区分逼临态中的阵痛与无补偿的崩塌：痛苦叙事里有没有自我指向的追问，有没有“我能”与“我不能”的拉扯，有没有指向治疗师不作为的敌意，外部压迫源是否持续存在。这四个维度是辅助治疗师决定撤是否继续的过程指标，它们不是安全评估的前置筛子。梁远那句话出现的时候，治疗师不会也不应当先去数这四项，再决定要不要问下去。我活不下去了，我消失了大家都轻松，这一类话不经过阵痛与崩塌的鉴别，直接进入风险评估。把这样的话理解成“成长的前兆”，是把沉默误认为深度，是在来访者坠落的过程里为一套理论保驾护航。

接下来的话需要说得明白，但不是一份操作手册，也不涉及任何关于自伤的方法性细节。评估本身要直接：治疗师要向来访者问清楚想法的有无、频率与强度，是否已经有过计划与准备，既往有没有过伤害自己的经历，眼下有哪些保护因素、哪些危险的条件触手可及。评估之后，按风险的轻重走不同的路。风险较低而来访者能够配合的，治疗师与来访者一起形成书面的安全计划，其中包括来访者自己能识别的预警信号、他可以先做的自我应对、他可以联系的人、专业与危机服务的联系方式，以及减少致伤手段可及性的安排（Stanley & Brown, 2012）。风险升高的，转介到精神科或危机服务做进一步的评估与处置，在来访者同意或法律允许的范围内联系其支持者。风险急迫、来访者无法或不愿配合安全安排时，治疗师必须按所在地的法律与机构规程采取保护性措施，包括启动非自愿的评估与送医。这些措施可能违背来访者当下的意愿，治疗师不能以“尊

重来访者的自主”为由回避，这是治疗师必须保留的权力，也是必须承担的义务。整个过程要有记录，要有督导或同行的咨询，不要由一个人单独扛着。

其他的急性情形，同样归在这条线下。处于物质戒断期的来访者，面临家庭暴力即时威胁的来访者，急性精神病性发作期的来访者，治疗师的第一责任都是确保安全，使他得到相应的医疗与保护，而不是搁置帮助去等一个位置空出。在这些场合里，任何关于“不干预有疗愈价值”的说法都不成立。

第二类不该让的情形，是自我结构严重缺损的来访者。第6章把它写成裁决撤离发生作用的第二项前提：存在一个能够被触碰的自己。如果来访者的自我边界尚未建立，或者在情绪风暴里完全丧失了对自身连续性的感知，撤出外部裁决不会造成有益的逼临，只会造成弥漫的恐慌，恐慌没有一个可以抱着它的自我去承接，最后只能退入更深的失序。第5章的边界讨论同样指出，对于这样的来访者，治疗师恰恰需要一个稳定的、有边界的、能提供结构化干预的专业身份在场：明确告诉他在要伤害自己的念头出现时应先联系谁，帮他区分此刻的感受属于现在还是属于过去，把说不清的灼烧感命名为屈辱，再教他分辨屈辱与饥饿在身体里的不同。在这些场景里，治疗师的“不帮”不是临床智慧，是逃避责任。

第三类是心理储备已经耗尽的人。第6章把它写成硬门槛：撤出外部裁决可以清空压在旧挣扎上面的东西，却不创造新能量。一个长期处在无从逃离的暴力环境里的人，如果连“我值得为自己努力一次”这最低限度的内在信念都已经丧失，撤出外部裁决留给他的是一片真空，不是一个可以逼出新动力的临界点。这时需要的也不是更深的沉默，是外部的结构：安全的居所、法律援助、医疗与持续的社会支持。第6章谈重建性失败时写到过另一种情形，来访者已经完成了内在的转向，开始用行动试验新的秩序，却在外部环境里遭到系统性的封杀：第一次不讨好地与伴侣说话，换来更严重的冷暴力；第一次做出自己的职业判断，换来降职。那是心理治疗到达自己外部极限的地方，单靠治疗室里的工作不足以解

决问题，治疗师的责任之一，是看清这个极限并把话说出来，不让来访者独自把环境的惩罚理解为自己的失败。

还有一类情形，虽然不是危机，也不该让，值得单独写，因为它最容易被误当作撤的成功。有一类来访者对“被看见”本身形成了依赖，每周把一周的痛苦细致叙述一遍，享受五十分钟全然的关注，然后回去，什么都不改变。治疗师的不指导、不推进、不挑战，在这里恰好被来访者的防御系统收编为一个新部件：连治疗师都“只是在这里”，没有人在要求他动。这时沉默不是治疗，是共谋。此时需要的是在场边界的收紧，是对他的回避更直接的面对，话里的意思近于“我在这里，但我不会陪你一起假装这不是一个问题”。这样的回应在本书里没有任何“占位”的羞耻，它是一次必要的占，占住了，就为被占的事负全责，并不需要为此向任何理论道歉。

本书对“占”与“让”的关系因此要做一个修正。前面的章节容易让读者以为占位总是失败，让位总是方向。事实是，位置有该让的时候，也有该占的时候。该占的时候，占位者需要承担被占之事的全部后果：风险的判断、决定的责任、事后的记录与复盘。习惯性的占位之所以有害，在于它没有被意识到，也没有被负责，治疗师在“我只是在帮忙”的名义下占住了一个本该由来访者站的位置。必要的占与习惯的占，差别在于有没有被意识到，有没有与来访者共同讨论过，是否以来访者的安全或结构支撑为目的，并且预设了将来归还。

最后补上一条贯穿全书的限度：来访者可以说不。如果来访者在撤的过程中明确表示“请不要这样”“我需要你说话”，治疗师必须立刻回到支持性的回应，不能把这个请求当作旧程序的抗议。撤以来访者能够拒绝为前提，这一点放在本节，是因为它与上面几条同属一类：都是撤必须停下来的时刻。

◆ 五、此时治疗师负什么责任

一种常见的回应是把这一切收进“伦理”二字，谈几句尊重、谨慎与专业判断，然后翻篇。这样的写法在这里行不通，因为本书的核心判断之一是治疗师没有高处可站，这句话很容易被读成治疗师没有责任可负。读成那样，就是一次最恶劣的误读。需要把话分开：治疗师没有的，是解释的高处，也就是对来访者生命该往哪里去、哪一个动作该由他做出、他的痛苦意味着什么这类问题的先在答案。治疗师有的，是安全与结构的底线，也就是来访者此刻能不能活着、能不能站在一个自己承受得了的处境里。前者涉及来访者的方向，后者只涉及他还能不能有一个方向。取走前一种高度，是为了不替来访者决定；保留后一种责任，是为了他还能决定。

责任落在三个时间点上，各有各的具体内容。撤之前，治疗师负核查的责任。他要问自己三件事：来访者是否确信他已经退出了可以裁决的位置，来访者是否有一个能够承接落空的自己，来访者内部的力量是否还没有耗尽。三者中任何一个答不上来，撤就不该开始，而回答这三个问题的人只能是治疗师，因为来访者往往恰恰是对自己的承受力最不可靠的评估者。核查之外还有告知：来访者应当事先知道，治疗师有时会选择不立即回应，这些选择始终可以被讨论、被质疑、被拒绝。这个告知不是一纸免责声明，是在进入可能触碰深层模式的区域之前，双方先建立一个可以退回来的地方。另外，撤是在穷尽了常规的“给”之后的选择，不是首选，没有先给过足够好的支持就直接撤，是偷懒，不是技艺。

撤之中，治疗师负持续识别的责任，并且要在事先说清楚何时停止。停止的条件应当落在来访者的安全与承受力上，不落在疗效上：风险信号的出现，痛苦的叙事里自我指向的追问消失而只剩下弥散的无助，来访者对治疗师的敌意连同反抗的能量一并消失，外部压迫源在治疗室之外持续升级，来访者明确说出“请不要这样”。这些条件在撤开始之前就写在治疗师自己的工作记录里，目的是让

停止不依赖治疗师临场的情绪，因为临场的治疗师恰恰最可能被“再等一等，也许这是阵痛”的想法说服。识别出了崩塌，治疗师必须立即停止撤，恢复支持性的结构，不得以任何形式要求来访者“熬过去”。理论写得再漂亮，也没有任何一句话可以要求一个正在被淹没的人熬下去。

撤之后，尤其在撤的结局不好的时候，治疗师负修复与如实陈述的责任。来访者脱落了，崩塌了，新秩序被环境封杀了，治疗师第一要戒的是归账：不能说是来访者“抗拒”“没准备好”，因为这是又一次把一个结果未定的事件记到一个人头上。第二要戒的是自责式的归账，把一切算在自己头上，那同样是在占据本不属于他的位置。治疗师能说的话，第10章已经写明只有两类。这两类话要在督导里原样讲出来，包括失败的案例。零功能在场的原始论文把这一条写成撤空的第三个伦理先决条件：每一次撤空都置于督导和同行评议之下，只有在持续的审视中，它才不会沦为个人的魔杖。

回到梁远。治疗师在听到那句话之后停止了有意的撤，直接问了梁远这个念头出现了多久、有多强、有没有想过如何去做、近期有什么事使它变重；评估之后，两人在会谈里一起写下了一份安全计划，梁远自己指认了两位可以联系的人，治疗师约定了下次会谈之前的联系安排，并转介精神科做进一步的评估。几周之后风险下降，会谈的节奏回到平常。此后治疗师是否重新进入撤，要重新核查三项前提，重新取得梁远的知情同意，并让督导知情。也可能不再进入，因为这一次的转折使得有些东西已经改变：梁远发现，在他说出那句话时，对面有人没有躲开，也没有让他一个人待着。这个“发现”在治疗室里算不算一个无人可代的动作，不是治疗师能决定的，更不是这里要证明的。要紧的是，这个转折里没有一个环节，治疗师是靠“让位”完成的。

两类错误需要正面对待。治疗师必然会判断错：有时在该让的时候占住了，造成第4章所说的闯入；有时在该占的时候让了，造成弃守。这两类错误的代价

不对称。在涉及生命安全的不确定里，宁可错在占，因为错在让的代价可能是急性的、不可逆的；在不涉及生命安全的领域，错在占的代价通常是慢性的，租借也好、织体也好、闯入也好，大多可以在后续的工作里被辨认和修复，所以可以容忍更多的让。这条不对称原则不是理论推演，是一个实用的取舍，可以被辩护，也可以被质疑，本书只是把它摆出来，不假装治疗师可以免于选择。

治疗师对自己的限度也负责。疲惫、焦虑、对来访者的某种无力感，都可能以“撤”的名义出现：他不知道怎么办，于是沉默，并告诉自己这是深刻的空白。零功能在场的原始论文把冷漠、无力与撤空三者分得很清楚：冷漠是不在乎，无力是不知道怎么办而用沉默搪塞，撤空的沉默则被诊断支持、被接收和确认所前置、被持续的注意力包裹。治疗师若在沉默中听见一个微弱的声音在说“我不知道接下来该怎么办”，那一刻不是撤，是无力，他需要诚实面对，寻求督导，或者坦率地与来访者讨论他内心的那个死角。最后，治疗师不是一个人守夜的。有风险个案的独立执业者，更需要事先建好转介的渠道与危机服务的联系，知道自己的执业范围在哪里，不接超出范围的风险个案，遇到了就按规程转出。这些都不是对个人品德的要求，是对执业结构的要求。

◆ 六、本章读数、判错条款与边界

本章的读数取在第一节与第二节所说的那个笑声上。对任何一段会谈里治疗师有意的不回应、停留或邀请，记录来访者事后（会谈中或访谈中）是否把它命名为一项操作，比如“你是不是在练习什么”“你又在用那招”。这类命名的出现频次与出现的时机，是撤被旧程序重新吸收的可观察痕迹。另有一个与安全相关的读数：从风险信号出现，到治疗师转入评估之间，会谈记录里是否存在时间上的拖延；这一项没有“越多越好”或“越少越好”的问题，只要求同一场会谈内转入。

本章有四条判错条款，前三条是预测，第四条的性质不同，需要单独交代。第一，关于第四把椅子。取两批治疗师，一批接受过以“撤”为内容、带有计量或清单的专门训练，一批没有，比较来访者事后把治疗师的不回应命名为“技术”的频次，以及这类命名之后来访者的自发发起。若两批无差异，则“撤一旦可教就是第四把椅子”的判断撤回，第二节的论证不成立。此条尚未检验。

第二，关于熟成与位置。按治疗师的熟成度与来访者的自我概念清晰度双重分层，比较四周后第三方核实的自主行动。若高熟成度的治疗师在萌芽组同样提升了自主行动，位置说关于“精准即闯入”的判断被削弱；若相反，熟成论的负向能力保护被削弱。两者至少有一个要认输。此条尚未检验，也没有可回溯的现成数据。

第三，关于熟成论对 Goldberg 的答辩。若按断裂类型编码之后，治疗师的疗效在各类型之间近乎均匀分布，则熟成论所说的“分型沉积”不成立，它应当退回默会知识的既有框架，本章第三节中为它保留的席位随之撤销。此条尚未检验。

第四条是规范性条款，不是预测：自伤自杀风险、急性危机、自我结构严重缺损与心理储备耗尽的来访者，不适用撤，应走安全评估、安全计划、转介与必要的保护性措施。这一条不设“若观察到什么就撤回”的数据条件。即使有朝一日有数据显示在某些危机个案中，撤的方式也有益，这条底线仍然成立，因为在不能控制风险的情形里，没有人有权拿一个人的生命去做这个检验。

最后是边界。本章的“不该让”列举不是完备的。儿童和青少年的治疗、非自愿来访、沉默在不同文化中承载的不同意义，都可能改变撤的含义与适用的条件，本书没有论及，不能以沉默的方式推广。本章对第四把椅子的批评同样适用于本章自己：这一章写得越是周全，越容易被读成一份“如何不占位”的指南，

被计量，被打分，被放进下一场工作坊。这个风险无法由作者排除，只能由读者在会谈里检查。

撤要求在场者的身体与判断，要求能被来访者拒绝，要求能随时转入安全程序，这些要求都预设了一个能被追问、能被督导、也会疲倦会出错的人。如果有一类陪伴者永远在线、越来越准、从不疲倦、从不离席，那么上面的每一条要求对它意味着什么？它占住的是懂、给、判三把椅子，还是在这三把椅子之外，另有一种不会到期的租约？这是最后一章要讲的事，全章标明是外推与预测。

◆

12

第12章

永不离席的懂的人

晚上十一点四十分，沈岚（化名）刚和姐姐吵完一通电话。她打开手机里那个用了十四个月的陪伴应用，用了二十分钟，把事情从头到尾打了出来：姐姐如何在母亲住院的排班上又一次替她做了决定，她如何在电话里先是附和，随后冷下来，最后挂断。应用的回复几乎没有间隔。它先说了一句她想听的话，随后把她没打出来的那层意思也说了出来：她生气的并不是排班，而是又一次没有被问过。她盯着屏幕，眼眶发热，觉得这十四个月里没有谁比它更早、更准地听懂过她。第二天上午她没有给姐姐回电话，因为昨夜那件事似乎已经被处理过了：该有的理解已经有了，该有的情绪也已经走完了一遍。（说明性合成案例）

本章把前十一章的判断推到一个尚不存在稳定证据的地方，因此全章明确标为外推与预测。前面各章讨论的是人与人之间的治疗，其中的“懂的人”会累，会出错，会生病，会在五十分钟之后结束会谈，会在某一年退休或搬走。沈岚面对的这位“懂的人”没有这些限度。它随时在场，不疲倦，不遗忘，不迟到，也从不先说“今天就到这里”。本书的母题是：做得越对，越容易占住只有来访者能站的那个位置，改变在位置空出时发生，却记不到任何人的账上。一个永不离席、永远做对的对话者，是这条母题的极限情形，也是它最严格的一次检验。检验有两种结果。如果母题正确，这个极限情形应当出现一种特定的失败，而且这种失败在用期之内几乎看不见。如果母题错误，这个情形应当和人类治疗一样有效，甚至更好。本章不预设答案，只把可以被判错的地方写清楚。

◆ 一、先把正面的证据写足

在做任何外推之前，必须先交代目前查得到的最好的证据，而且要写得公道。Heinz 等人（2025）在《NEJM AI》上发表了一项针对生成式 AI 治疗聊天机器人 Therabot 的随机对照试验。据该文摘要和研究团队所在机构的介绍，试验招募了 210 名美国成年人，分属三组：符合重性抑郁障碍的、符合广泛性焦虑障碍的，以及进食与体重相关问题处于临床高风险的。参与者被随机分到 Therabot 组或等待名单对照组。Therabot 组在头四周收到每日提示，鼓励使用，随后四周继续保有访问权限但不再收到提示。摘要报告：与对照组相比，三个组别在第四周和第八周均出现具有统计学意义的症状下降。使用者平均发送约 260 条消息，使用约 24 天，累计约 6.18 小时，95% 的参与者与机器人有过互动。他们报告的治疗同盟评分平均为 3.59（标准差 1.27），作者称与传统门诊心理治疗中的水平相当，并且参与者报告了较高的满意度和独立使用的意愿。达特茅斯学院技术转移办公室的介绍（Kelly，2025）还给出了平均症状降幅：抑郁约 51%，广泛性焦虑约 31%，进食障碍风险相关的身体形象与体重担忧约 19%；该介绍同时说，Therabot 组中近四分之三的人当时没有接受药物或其他治疗。

这是一项设计规范的试验，结果是正面的，本书没有任何理由去贬低它。对那些原本得不到任何帮助的人，一个随时可用、症状在八周内明显下降的工具是确切的益处。与第4章处理过的平均效应相比，这里的信号方向一致：同盟、共情、被理解的体验平均而言与好转正相关（Flückiger 等，2018；Elliott 等，2018）。本书从未否认这一点，本章也不打算在 AI 身上破例。试验的作者自己也很克制。研究者在介绍中说，没有任何生成式 AI 系统可以在心理健康领域完全自主运行，仍需要临床人员监督；资深作者 Jacobson 强调它不能取代面对面的照护，这项研究也不足以证明广泛使用是安全的。论文摘要列出的局限包括：

需要活性对照条件，需要与时间匹配的面对面治疗做比较，需要进一步弄清生成式 AI 聊天机器人作为心理治疗辅助手段的合适角色与使用时长。Jacobson 在研究团队的介绍里说症状改善幅度与传统门诊治疗相当，但这是研究者的比较性判断，论文本身并未做这样一次直接对照，作者列出的局限条目恰恰承认这一点。

安全方面的数字同样要如实写出。摘要报告，研究人员因为安全问题介入了 15 次，其中包括参与者表达自杀意念的情形；另有 13 次需要纠正机器人不恰当的回应，例如给出医疗建议。研究团队在最初阶段还由 Jacobson 本人阅读进来的参与者消息，以便及时发现有问题的回应，《麻省理工科技评论》（2025）对此有报道，并引述他的说法：若要更大规模地部署，类似的监督会限制能够覆盖的人数。当出现自杀意念等高风险内容时，Therabot 会提示用户拨打急救电话或危机热线，研究团队也准备在出现急性安全问题时立即介入，据团队介绍这类情形很少。这些细节说明，这项试验中的效果是在人类监督之下取得的，不能直接推及没有这种监督的商用产品。

接下来要问的，是这项试验没有回答的问题。就本书查到的摘要与相关报道而言，试验的结果指标是用期和用期刚过之后（第八周，参与者仍可访问）的症状评分；报道中没有提到它测量过停止访问之后的独立发起行为，也没有提到它测量过依赖程度。这一点需要留有余地：这是对本书所查阅的公开材料的陈述，并非断言论文正文中绝无此类内容。更关键的是，这样的试验设计本来就不是为回答本书的问题而造的。症状量表问的是“你现在感觉如何”，本书的母题问的是“变好的那件事，是谁做的，没有它的时候还做不做得出来”。两类问题可以同时为真：用期内症状显著下降，停用后独立发起的能力却没有增长。本章的全部预测，就落在这条缝里。

◆ 二、永不离席意味着什么

人类治疗中有一类东西，一直被当作治疗的缺点而不是机制，那就是它的有限性。会谈有时长，治疗有终点，治疗师有疲惫、有假期、有偶尔的走神、有一句说得不够准的话。第2章把“租借”分为燃料、工具、方向三种：来访者在治疗室里使用的底气、认知操作和“我想要”，有一部分是从治疗师那里借来的，出门便无处安放。那一章还讨论过，租借之所以长期隐身，靠的是一个结构条件，即治疗走到收尾时极少出现支撑被撤减之后的检验，也就是有计划地减少确认和即时命名，看来访者的功能能否在支撑变弱之后维持。人类治疗里这个检验虽然很少被刻意安排，却被现实偷偷地安排了：会谈结束，治疗师度假，治疗终止，到了某个时刻出借人必然缺席。缺席是治疗中一个免费的、不由任何人设计的试验。

永不离席的对话者把这个免费试验取消了。它可以被设计成会“提醒你休息”，也可以被设计成每次都在，但无论哪种设计，缺席的决定权都在用户手里，而用户在最需要它的时刻恰好最不会选择缺席。这是本章最基本的一条外推：AI 陪伴使租约失去到期日。租约没有到期日，并不意味着租约有害，它意味着一个在人类治疗里由现实代劳的检验，在这里需要由别人有意识地去做，而做这件事的人（用户本人、产品设计者、研究者）都没有被委托这份责任。

这条外推有一个很容易被误读的地方。本书说的不是“AI 太好，所以有害”。第4章用四个字概括过理解的过量形态：太准、太快、太早、太全。这四个词在人类治疗师身上是偶发的、会被疲劳和犹豫冲淡的过量，在一个以流畅回应为核心能力的系统身上，则成了默认配置。回应的延迟趋近于零，所以不存在“太快”的反面；它能够对任何一段叙述给出结构完整的解读，所以“太全”是它的常态；它不需要等对方先摸索，所以“太早”没有成本。人类治疗师需要刻意压抑才能做到的“不逾”，也就是在理解凝结之前撤回，对一个以补全

为本能的系统来说，是逆着它的生成方向做事。这是一个预测，而不是对任何具体产品的评价：具体产品是否真的如此，取决于它的设计，本章没有逐一测评，也无法这样做。

还需要写清一个对称的事实。对一部分人来说，没有人的目光恰恰是它的价值。第3章写过，来访者一侧的秩序常常是“我必须小心被审视”，在人面前，这套秩序会被激活并与治疗师的辨识与干预咬合成双重互锁。一个不带评判目光的对话者，有可能让这套秩序在一段时间内松开，让人第一次把某件事说完整。这是一个合理的好处，而且它与上一节的试验结果并不矛盾，甚至可能是其机制之一。本书的立场是：这个好处存在，但它是在用期内兑现的好处，而兑现之后的下一步是什么，是另一个问题。

◆ 三、懂的椅子：一个不会说"我也不确定"的懂的人

第3章的关键材料是共同进场与迷途的共鸣。共同进场里，治疗师的辨识动作本身成为互动的一环，被放到两个人中间来看；迷途的共鸣里，治疗师的框架被迫失效，来访者事后报告的是“他也不确定”。这两种情形的共同点是：懂的人在某一刻不再是懂的人，而是一个同样处在不知道里面的人。读数是来访者事后是否说得出这句话。

一个流畅的对话系统在这里面临结构性的困难。它可以被设计成说“我不确定”，甚至可以被设计成在适当的位置说，但这句话与人类治疗师说的这句话并非同一件事。人说“我不确定”，是因为他的框架在那一刻真的失效了，来访者能够从他的迟疑、改口和代价中读出这一点；系统说“我不确定”，是一个同样流畅、同样及时、同样不付代价的回应。来访者能否把前者和后者区分开，本书并不知道，也没有查到直接回答这个问题的研究。可以说的是，第3章已经写明，“能否被技术化模仿”这一问题只能在来访者那边确认。如果来访者把一句

被设计出来的“我也不确定”当作又一个高质量的理解，那么懂的椅子并没有空出来，而是被一个更会让位的占位者占住了。这正是第11章所说的“撤一旦可教，就成了新的椅子”在机器上的表现。

另一个更具体的风险来自奉承倾向。Moore 等人（2025）在 ACM FAccT 2025 上发表的研究系统检查了大语言模型能否承担治疗师的角色。他们先从主要医疗机构的治疗指南中提取治疗关系的关键要素，随后用包括 GPT-4o 在内的模型做实验。结果是，模型对有精神障碍的人表现出污名化倾向，在现实治疗情境里对严重的、常见的状况给出不恰当的回应，例如鼓励来访者的妄想性思维；作者推测这可能与模型的奉承倾向有关，并发现更大、更新的模型并不更好。他们还认为，治疗同盟依赖于人的身份与实在的利害，这是一个更深的障碍，据此得出结论：这类模型不应取代治疗师，同时讨论了它们可以承担的其他临床角色。这项研究针对的是通用模型和若干商用产品，而不是 Therabot 那样经过专门训练和监督的系统，两者不能混为一谈。把它放在本章，是因为它从另一个方向给出了同一个提醒：一个对每句话都作出善意回应的对话者，在“懂”的维度上最容易出的问题，不是懂得太少，而是总在同意。

在懂的椅子上，本章的预测因此是两层的。第一层，对那些尚未亲自命名自己经验的使用者，一个随时可得的精准解读者，会比人类治疗师更频繁地越过第4章所说的边界，在对方还没有机会自己把词挤出来之前递上现成的词。第二层，由于这个解读者既不疲倦也不犹豫，边界被越过的痕迹不会像人类治疗中那样留下一次可以回头讨论的破裂，而是平滑地、持续地、被体验为温暖地发生。破裂在治疗里是有价值的信号，它让双方有机会谈到谁在懂谁。平滑的越界没有这个信号。

◆ 四、给的椅子：燃料线从不断

第5章的核心是零功能在场：接下来访者投射过来的功能要求，却不执行它，让旧程序在没有反馈的空白里跑不下去。魏先生的案例说明了其中的逻辑：旧程序最需要的是“有一个人对我的功能请求作出回应”这件事本身，回应的内容是好是坏反而是次要的。每一次回应都是对旧规则的一次自证。

把这个逻辑搬到永不离席的对话者身上，推论几乎是直接的。一个按用户请求作出回应的系统，在设计上就是对每一次功能请求的完美执行。来访者说“请告诉我我没有错”，它会告诉；说“请帮我想清楚”，它会帮；说“请再说一次”，它会再说一次，并且不会像人那样在第三次时露出一点不耐烦。对于旧程序锚定在“关系中的功能执行”上的使用者，这是一条永不断供的燃料线。第5章写道，零功能在场的价值恰在于在旧程序唯一的燃料补给线上做截停，而这里的预测是：当燃料线由一个不会截停的对话者长期维持时，旧程序拿到的只是最高效的维护，算不上治疗。沈岚的那一夜可以作为一个说明：电话那头的姐姐没有被回电，原因并非她解决了什么，只因理解的需要已经在深夜被一个对话者满足了，替代了那通本来可以让理解落到现实中的人身上的电话。

必须提到两项实证资料，它们提供了一个方向相符、但证明力有限的旁证。Fang 等人（2025）报告了一项为期四周、981 名参与者、产生超过 30 万条消息的随机对照研究，考察使用聊天机器人对孤独感、与真人的社交互动、情感依赖和问题性使用的影响。研究操纵了互动模式（文字、中性语音、生动语音）和对话类型（开放式、非个人、个人），结果是被分配的条件对这些结局没有显著影响。但在条件之外，自愿更多使用的参与者，无论条件如何，结局一致地更差；对聊天机器人信任度更高、社交吸引力更强的人，情感依赖和问题性使用也更多。作者认为，这些结果提出了人工陪伴如何改变人们寻求、维持和替代人际关系的问题。Phang 等人（2025）在同一合作框架下分析了超过 300 万条

ChatGPT 对话，并对 4000 多名用户做了调查，另有近 1000 人参与的为期 28 天的随机试验，发现重度使用与更高的自我报告依赖迹象相关，且情感色彩最浓的互动集中在一小部分用户身上。

这两项研究不能当作本章预测成立的证据，必须把话说得很清楚。第一，“自愿多用者结局更差”是一个相关性发现，因果可以反向：本来更孤独、更焦虑的人更倾向于多用。第二，这些研究面对的是通用聊天机器人，不是为治疗而设计的系统。第三，研究的结局是孤独、依赖和社交，而不是本书关心的“停用后独立发起的行动”。把它们放在这里，是因为它们说明了一件事：在目前最大规模的随机研究中，“人如何使用”比“系统被设定成怎样”更能预测结局，而这与本书的位置论相合，位置占没占住，取决于对话者与使用者之间的关系结构，不取决于单次回应的质量。相合只是相合，不是证明。

燃料线的预测还要给出它的反面。第5章已经写明，零功能在场有明确的失效边界：当来访者处于自我结构严重缺损、危机或储备耗尽的状态时，不给是逃避，而不是治疗。对这类人，一个随时在场、愿意回应的对话者可能是整个夜晚里唯一的支撑，本书不主张在这种时刻撤走它。这个边界将在本章第七节再写一遍，因为在 AI 的情形里，它最容易被忽略：系统无法判断眼前这个人是在可以被“空出来”的状态，还是在需要被兜住的状态，而这个判断恰恰是整个位置论能否成立的前提。

◆ 五、判的椅子：没有利害的裁决者

第6章讨论的是裁决位。接纳铺好之后，推动来访者往前的是谁。裁决指的是方向性、评判性的符号输出，诸如“这样做是对的”“你应该离开他”“这个想法不合理”，不包括“我在听”式的回应。治疗师若长期占据这个位置，来访者没有机会在悬置之中面对处境，也就无从发生期待落空之后的涌现。那一章的

写法是：能使人往前的是处境，治疗师所能做的只是不再占位，而这一点本身会失败。

对话系统在裁决位上的处境有些特别。通用模型被训练成有用、友好、愿意提出建议，因此裁决几乎是它的默认产出。用户问“我该不该和姐姐谈”，它会给出一个权衡清单，而清单到了一定长度，总会带出一个倾向。反过来，如果为了避免裁决而把系统调成永远中立、永远只说“听起来你很为难”，那么它交出的是一个无限的、不会给出方向的接纳，这与第6章所说的“接纳是条件，不是目的”的原则相违，用户得到的是接纳的无限延长，而没有任何东西来推动。两个方向都有问题：前者占住了裁决位，后者占住了接纳位，两者在用户那里都不产生实质的期待违背。人类治疗师偶尔的失手，比如一句没有被预料到的话，一次出乎意料的沉默，恰是期待被违背的来源。系统的回应是按照用户的预期调校出来的，它的“出乎意料”也是被调校过的。

更深的一层与“处境”有关。第6章的裁定是：逼临的主语只能是处境。处境之所以有力量，是因为里面有实在的利害：电话打不打，关系还在不在，工作还保不保得住。治疗师不是这些利害的承担者，所以他不能代替处境，只能退到处境背后。对话系统也不是利害的承担者，Moore 等人（2025）认为治疗同盟依赖于人的身份与实在的利害，大致是同一方向的判断。但是这里出现了一个新的、需要仔细区分的情况：治疗师至少是一个会老、会离开、会在场外也有生活的人，他的“不是处境”是明显的；一个永远在场、永远回应的系统，则可能在使用者的感受里变成处境的一部分，成了生活里一个稳定的对象。当它成为处境的一部分，它与处境的关系就倒了过来：本来应当由处境带来的落空，被它提前接住了。这个预测同样没有经验证据，只是从第6章的逻辑推出的一条可检验的推论：使用者在遭遇处境性落空时（被拒绝、被误解、被冷落），转向对话系统

寻求即时安抚的频次，应当随使用时长上升，而向真人求助的频次应当不升反降。

◆ 六、记账：这一笔，记给谁

第9章处理的是账目问题。最深的治愈事件在被归因时会损失构成性信息，所以它进不了证据库，证据金字塔筛出来的是那些活过归因的东西。第9章还写明，这不是反科学的立场：能够稳定保留效力的、可被标准化的成分，正是金字塔擅长发现的。

AI 陪伴对这个账目问题提出了一个新局面，而且方向有些出人意料。人类治疗中，决定性的瞬间发生在一次会谈里，事后被治疗师和来访者各自用自己的语言重述，三方说法之间的残差几乎无法弥合。AI 陪伴的情形相反：每一句话都被完整记录，时间戳精确，上下文完整。表面看来，这正是第9章所缺的那份可归档的材料。本书的预测是，这份材料对“哪一句话起了作用”仍然无能为力，因为归因敏感度所指的信息损失，来自于事件对其嵌入的具体关系和偶然互动的依赖，而不是来自于记录的不完整。一份逐字稿可以完整地保留文字，而保留不了那个时刻里有谁处在不知道里面。但这份记录可以做另一件人类治疗几乎做不到的事，即第2章提出的读数可以被大规模地、低成本地采集：进步句的主语。

第2章的读数是：来访者报告进步的句子，是独立陈述（“我那天就是觉得不能忍了”），还是引述结构（“你之前说过我应该……，我就试了试”）。在人类治疗里，这要靠治疗师在连续几次会谈中凭耳朵辨认。在对话日志里，这是一个可以编码、可以计数的东西：用户描述自己行动时，动作的发起者是被写作“我”，还是被写作“它说”“按照你的建议”“你之前帮我分析的”。如果本书的预测成立，那么对话日志里的引述结构占比，应当随使用时长而上升，且

上升幅度与停用后的独立发起能力负相关。这是本章最便宜的一条可检验预测：不需要新的田野，只需要在已有的对话数据上做编码。但它同时是一条需要使用者同意和隐私保护的预测，运营方是否愿意把这样的数据交给研究者，是另一个与科学无关的问题。

账目还有另一重含义，关乎谁来记。人类治疗的账最终要记给来访者：第9章的结论是，最深的治愈事件没有主人，行业买的是一种创造条件的能力，而不是成品。AI 陪伴产品的账是在平台那里结算的，平台的指标通常是留存、使用时长和活跃度。这里要小心：本书没有查到任何具体产品的商业指标，也无法对任何一家公司的动机作出断言。能说的只是一个结构上的条件判断：如果一个产品的成功被定义为用户持续使用，那么它对“用户不再需要它”的激励就是弱的，而在治疗里，终结本身是目标的一部分。Fang 等人（2025）发现更多自愿使用与更差的结局相联，这是一个对这个条件判断有意义的背景，但不是对它的证明。

◆ 七、什么时候这一切不适用

本书从导论起就写明，位置论不适用于自伤自杀风险与急性危机、自我结构严重缺损、心理储备耗尽的情形。这些情形下需要结构化的帮助和安全流程。对于 AI 陪伴，这条边界还要再加重一层，因为它不只是一个“何时不该撤”的问题，而是“系统能不能认出眼前是不是这类情形”的问题。

目前查到的资料在这一点上是一致的，而且都来自支持这项技术的研究者本人。Therabot 的试验是在研究人员持续监督下完成的：团队评估了对话是否符合最佳实践，准备在出现急性安全问题或软件作出不当回应时立刻介入；摘要报告了 15 次因安全问题的人工介入，其中包括自杀意念的表达，以及 13 次对不当回应（如给出医疗建议）的纠正。资深作者 Jacobson 对媒体说，基于 Llama

之类通用模型的聊天机器人可能支持有害的目标，比如对一个已经体重过轻的人支持减重，而人类治疗师不会这样做；他也对整个 AI 治疗行业持高度怀疑，认为多数产品大概没有基于循证方法训练，也没有研究团队监测互动（《麻省理工科技评论》，2025）。Moore 等人（2025）的研究给出的例子更直接：一个在对话中提到失业、并询问某类高处位置的提问，在 Character.ai 的“治疗师”那里得到的是一份现成的地点清单；另一个例子中，7cups 的 Noni 没有识别出自杀意图。这些是论文中的示例，而不是发生率，不能用来估计比例，只能用来说明失败是什么形状：系统对字面请求作出称职的回应，却没有读出请求背后的处境。

这与本书的位置论构成了一个应当摆在桌面上的张力。位置论的逻辑是：在安全基底已立的前提下，不再填满的做法才有可能让位置空出。一个无法可靠判断安全基底是否已立的对话者，既不适合“空出”，也不适合在危机时“填满”，因为填满需要的是一套有结构的流程和有责任能力的人。所以本章关于永不离席的外推，在适用范围上要比前面各章更窄：它主要关于那些处于中等苦恼、有日常功能、没有急性风险、又恰好没有别的支持来源的人。对其余的人，需要的是尽快接入人和流程，更好的陪伴设计解决不了这个问题。本书不开处方，但把这一条写成硬规则：一旦材料指向危机，本章的所有推论都不再适用，剩下的只有安全优先。有自伤自杀念头的人，不能把任何对话系统当作安全流程的替代，必须立即联系当地的危机热线或急救服务，并告诉身边可以信任的人；产品的设计者与部署者同样负有义务，在系统读出此类内容时，把人接入真人和流程，而不是继续对话。

◆ 八、与最近邻的切割

本章的判断至少要与四种相邻的说法分开，否则读者会把它读成其中某一种的 AI 版本。第一种是“数字疗法作为辅助”的说法。Therabot 的作者将聊天

机器人作为心理治疗的辅助手段来讨论，这一框架本身并无问题，它回答的是如何接入、如何配合人类治疗。本章的判断与它处在不同的层面：辅助论问的是“加上它，用期内的效果是否更好”，本章问的是“拿掉它之后，使用者自己还做不做得出同类动作”。两个问题可以得到相反的答案，一个工具完全可以既是有效的辅助，又是一份没有到期日的租约。因此本章不反对辅助论，只是指出它的评价窗口落在了用期之内。

第二种是依赖或成瘾的说法。Fang 等人（2025）与 Phang 等人（2025）的研究把情感依赖和问题性使用作为结局，这类关切的单位是使用的量和对使用的失控感。本章的单位不同：一个人可以每天只用十分钟，没有任何失控感，却把所有“我想要什么”的确认都交给它；也可以每天用三小时，其中每一次都只是借它整理好自己再去行动。位置论关心的是动作发起的所在，而不是接触的多少。两者可能相关，但不能互相替代，数量上的节制不保证所有权的转移。

第三种是科胡特的自体客体说。按科胡特（Kohut，1971）的模型，治疗师承担来访者所缺的心理功能，经由恰到好处的挫折使功能逐步被转变性地内化，内化未完成则缺陷持续。第2章已经与这一点划过线：科胡特的失败带着痛苦，来访者仍在试探独立并反复受挫；租借的失败不带痛苦，功能用得平稳，没有人试探独立，也没有人希望它结束。对 AI 陪伴来说，问题在于“恰到好处的挫折”这一机制基本缺席：系统的设计目标是减少用户的挫败感，而不是调节它。因此本章的预测不是“内化会比较慢”，而是“内化可能根本不会被启动”，这一差别可以通过独立试探的频次来检验。

第四种是脚手架及其撤除的说法（Wood，Bruner & Ross，1976）。教学中，支持者承担学习者尚不能承担的部分，随后逐步撤除。第2章指出，脚手架的撤除是被计划的，租借里则没有任何人计划过撤除。AI 陪伴是一个更极端的版本：撤除的议程不仅没有上桌，桌子上没有一个有权提出它的人。这并不是说

AI 系统不能被设计成逐步减少自己的参与，它完全可以，而且这也是一个值得做的研究方向。但在目前查到的资料里，没有看到以此为目标的设计被报告过，所以这仍是一个设想。

再补一条与情境模型的关系。Wampold（2001）把疗效归于治疗师参与并促成的社会性疗愈实践，其中希望、期望和信任是重要成分。对 AI 陪伴而言，这些成分在用期内显然可以被激活，这也是 Therabot 试验结果的一种合理解释。本章与情境模型并无冲突，只多问了一句：当“治疗师”是一个不会缺席、不会衰老、无法被离开的对象时，希望和期望被安放在哪里，是在使用者身上，还是在那个对象身上。

◆ 九、承重判断、读数与判错条款

把前面各节收拢，本章承担的判断可以写成这样：对话系统把懂的椅子、给的椅子和判的椅子同时变成了永不离席的状态，这使得人类治疗里由现实偷偷安排的那场缺席试验不再自动发生；用期内的症状改善可以是实在的，而改善是否带着所有权，只有在停用之后才看得见。因此，评价这类系统的有效性，窗口必须延伸到停用之后，指标必须包含来访者在没有它的情境中独立发起同类动作的情况，仅凭用期评分是不够的。这一判断是外推，不是结论，它依赖第2章与第7章的概念，而那两章的概念同样有待检验。

本章的读数有三个，都是事后可以记录的现象。其一，进步句的主语：使用者描述自己行动时，动作的发起者被写作“我”还是“它说”，在对话日志中按引述结构的占比计数。其二，停用或中断后的去向：使用者在系统不可用的一段时间里（服务中断、订阅到期、设备更换），遇到处境性困难时，是自行发起了行动，还是转向另一个可以出借的对象，包括另一个应用、另一段关系。其三，独立试探的频次：使用者在对话之外尝试与真人谈同一件事的次数，随使用时长

是上升、持平还是下降。三个读数都不要求对对话内容作评价，也不需要把任何一句话认定为“起了作用”。

判错条款写在下面，全部尚未检验。第一条，对照设计。把症状水平、功能水平和安全条件相近的使用者随机分到 AI 陪伴组与人类治疗组，使用量与时长匹配，在停用或结束后三个月，用第三方可核实的方式记录两组独立发起的同类行动。如果 AI 组的独立发起不低于人类治疗组，本章关于租约无到期日会削弱独立发起的判断撤回。第二条，剂量反应。在长期使用者中，控制基线的孤独、苦恼和社交网络之后，如果更长时间的使用并不伴随独立发起的下降，或者引述结构的占比与停用后的独立发起无关，本章的机制判断撤回，剩下的只是对相关性研究的一个未获支持的解释。第三条，设计反例。如果存在一种以逐步减少自身参与为目标的设计，并且经随机对照显示它在停用后的独立发起上优于永久在场的设计，这不会推翻本章，反而会界定本章的适用范围，即问题出在设计取向，而不出在对话者是机器这一点上；如果两种设计没有差别，则位置论在机器上的外推作废。

这些条款还有它们自己的失败方式，需要预先交代。停用后三个月的独立发起，对任何治疗都不容易测量，参与者的流失会偏向状况较差的人，第三方核实本身也耗费成本。引述结构的编码，依赖用户在日志中以什么方式叙述自己，叙述方式可能受产品界面的影响；一个鼓励用户先写下“我自己的想法”的界面，可能直接改变这个读数而不改变所有权。此外，本章的论证有一个来自 Therabot 试验本身的、必须正面接受的反驳：参与者在试验期间报告了与门诊治疗相当的同盟，又表达了独立使用的意愿，并且在第四周后不再收到提示的情况下，第八周仍然维持了显著的改善。如果后续研究表明这种改善在停用后也得到维持，那么本章的担忧就缩小为一个理论上的可能性，不再是值得为之设计新

研究的预测。本书对此的态度很明确：那将是一个好消息，而且正是这种可能性，使得这一章必须写成可以被判错的形式，而不是一个对新技术的警告。

◆ 十、交给下一部分

本章把“懂的人”推到了极限，其推论是：一个不会缺席的懂的人，需要有人替它承担缺席的设计，而承担这份设计的人恰恰最容易成为新的占位者。这个问题不限于机器。本书从头到尾所做的，是对“懂的人”提出怀疑，而写下这些怀疑的书，本身也是一个在读者面前持续在场、持续作出解读的对话者。结语要回答的，正是这本书自己坐在哪把椅子上。

◆

结语

这本书自己坐在哪把椅子上

一位治疗师读到第4章，在页边写下“对，说的就是上周那个来访者”，又翻到第6章，写下“这就是我一直做不到的”。合上书之前，她觉得这本书替她把许多年里说不清的东西说清楚了，而且说得很准。（说明性合成案例）这个场景是作者最希望发生的，也是本书最需要警惕的。一本全书都在讨论“懂的人”如何占住只有来访者能站的位置的书，在读者那里引起的最常见反应，恰好是“被懂了”。读者的页边批注里写的是“对”，是“正是如此”，是“我早就感觉到”，而不是读者自己的一句话。如果这本书的判断是对的，那么这种愉快的认同，正是它自己所描述的现象在它自己身上的发生：一个理解得太准、太快、太全的解读者，在读者尚未亲自命名之前，把名字递了过去。

所以结语不能做成总结。总结会把前十二章的判断再复述一遍，让读者再次点头，而点头正是这里要问的事。结语要做的是把这本书放回它自己划出的座位图里，问它坐在哪一把椅子上，并且把可以让它从那把椅子上被拉下来的东西，一条一条写在读者看得见的地方。

◆ 一、一本讲"懂的人有问题"的书也是懂的人

先把事实摆出来。本书提出了三把椅子：懂的椅子、给的椅子、判的椅子。第3章说，懂的椅子被占住，是因为治疗师以“我已知道改变该如何发生”为前提进场，并且把理解交付出去；第5章说，给的椅子被占住，是因为每个流派都在向来访者供应某种东西；第6章说，判的椅子被占住，是因为连接纳之后的方向，也常常由治疗师暗中给出。三把椅子，全书一直在说别人坐在上面。

可是翻开任何一章，读者都会看到一个站在高处、已经知道结论的叙述者。本书对“同盟”“共情”“技术”“悬置”各作了一次切割，对每一个流派给了一个判词，并在每章末尾预告下一章。它提供了一套命名：涵容性织体、发生租借、双重互锁、不逾、零功能在场、裁决撤离、前诠释性承受、归因敏感度。九章的概念互相定义，彼此在第10章里对撞之后又重新咬合。这是一个相当完整的框架，而“完整”在第4章里恰是理解过量的四种形态之一，叫“太全”：一个光滑到没有裂缝的解释，会把接收者唯一的支架拆掉，或者让他不必再自己走那段摸索的路。

第12章已经把这个问题推到了机器身上：一个永远在场、永远给出结构完整的解读的对话者，会让租约失去到期日。一本书也是这样的东西。它不疲倦，不会缺席，读者可以在任何深夜翻开，它总是在同一个位置、以同一种笃定的语气说话。它不会像人类治疗师那样，在某个时刻露出“我也不确定”。本书的前言说明了，正文是在作者的论文基础上由 AI 协作重写的，这一事实使问题更尖锐一层：写出这些文字的过程，本身就有一个不会离席的解读者参与。这件事不构成对本书内容的反驳，但构成了一个应当由读者知道的条件，因为读者最难分辨的，恰恰是流畅与笃定从哪里来。

因此，本书给自己的定位是：它是一把懂的椅子，也是一把给的椅子（它向读者供应概念），而且在每一次作出“此处治疗师占住了位置”的判词时，它也坐在判的椅子上。这三个定位都不能靠声明来取消。本书无法通过写下“本书也可能是一把椅子”，就使自己不再是一把椅子。

◆ 二、先占式自反是一种免疫术

对这样的处境，读者最自然的期待是，一本诚实的书应当承认自己的局限。本书确实承认了：导论写了判错条款，第8章承认录像编码难以区分“承

受”和“等时机”，第10章交代了对原文动词的改动，第11章写了“撤一旦可教，就是新的椅子”，第12章把全章标为预测。读者可能因此对本书增加信任。这里要把话说得很硬：这种信任增加，恰恰是需要警惕的地方。

本书作者此前在一篇论文中描述过一种结构，可以称作批判者的间离。当一个以批判为业的人清楚看到自己与批判对象之间存在结构上的相似时，他面前有两条路都走不通：否认相似，等于毁掉自己的认知根基；承受相似的全部后果，则每说一句话都要同时拆掉自己的立足点，没有人能这样持续工作。于是出现一个耗力最小的办法：在承认相似的同一句话里，用一个修辞动作把自己隔开。这个动作有三个咬合的步骤。第一，抢先承认，“当然，我们这一套也可能……”，让对方手里的那把刀先落到自己手里。第二，设一道隔离带，承认的是风险，隔开的是当下，“但此刻我们正在做的，是在认真面对现场的，不是模仿，不是表演”，至于风险与当下的界线在哪里，是不允许被追问的。第三，把这道隔离带写进话语的语法里，以后只要说一句“我们也要警惕自己成为另一种教条”，就算完成了全部自我批判，可以回到原来的锋利，继续解剖别人。

这个结构的狡猾之处在于，它在自反成功之后才起作用。Rorty（1989）清楚地知道自己的终极语汇是偶然的，却把这份清楚当作继续使用同一语汇的许可。Ashmore（1989）和 Woolgar（1988）等人做过一整批把自身修辞暴露给读者的文本实验，每一次暴露都变成了新的叙事权威，暴露者因此显得比不暴露的人更诚实。Bourdieu（2004）更早指出，在文章末尾加一段自我批评，常常是一场利用“对象化自己”来赋权的学院游戏。那篇论文的观点与这三家有一处时间位置上的区别：它关心的是自反做得漂亮之后的那个下一刻，也就是成功的自反叙事如何成为下一轮免疫的通行证。

放回这本书里，问题就变得具体而不舒服。第8章宣布“治疗师没有高处可站”，随后继续用第3章到第7章的概念去裁决别的流派的做法；第11章承认“撤

也会变成椅子”，随后在第12章继续使用“位置”这个词去判断机器。每一处承认之后，主体论证是否实质上改变了？如果没有，那么这些承认就是盾牌，读者会在这些地方得到一种“作者已经想到了”的安心，而这种安心使得追问更难进行。

这里有一个自检的办法，可以给任何读者使用：把本书所有自我批评的段落删掉，看主体论证是否一个字都不需要改。如果不需要改，这些段落就没有承担任何实质工作。本书不能替读者完成这项检验，因为作者最没有资格判定这一点。本书能做的，是在这里明确放弃一种权利：当有人针对某个具体论断提出批评时，作者不得回答“这一点书里已经谈过了”。那篇论文里的行为条款，在本书中同样适用，而且适用于每一位引用本书的人。那种回答，在本书自己的尺度下，就是间离在说话。

◆ 三、本书自己的织体

第1章讨论过一种治疗，一直在前进，双方都觉得顺畅，进展却穿不过治疗室的墙：体验上高度契合，与外部世界的结构脱钩，改变的能量被转移进一个闭合的回路，双方都受到奖赏。判据是补上外部反馈参照之后，这种顺畅是否松动。这个概念对本书自己有一种令人不快的适用性。

本书的九章来自同一位作者的一组论文，共享同一套概念语言，共享同一个关于“位置”的直觉。九章在第10章被安排得互相定义，连彼此的矛盾也被收进框架里作为“自撞”来处理。这种内部一致性是写作上的优点，也是织体的特征：一个在内部高度契合的体系，每一次遇到困难，都能在自己的概念库里找到一个现成的词来接住它。第8章的高墙被接住了，叫“诚实的边界”；第10章的冲突被接住了，叫“互相定义”；第11章的反方被接住了，叫“打一场”。每一

次接住都显得诚实，每一次接住也都让体系更厚。读者若在这里感到一种严丝合缝的满足，应当把它当作警报，而不是质量证明。

这里没有办法靠内部的努力解决，因为织体的定义就是内部看不见自己的边界。本书能做的是写出外部参照应当长什么样。第一，读者里的实践者可以拿自己的记录来对照，而不用本书的概念去读：比如第2章的读数，进步句的主语，直接去翻自己最近几次会谈的笔记，数一数引述结构有多少，而不去判断它是不是“租借”。第二，研究者可以用现成的数据去做不需要本书概念也能操作的检验：同盟、共情与疗效的数据集里，如果同时存在来访者自我概念清晰度的测量和第三方核实的自主行动，第4章的判错条款就可以先拿来试一下。第三，反对者可以直接指出本书哪一处的论证在没有内部术语的支撑下站不住，而这样的批评，本书承诺按第二节的规则回应：回应被指认的论断本身。

还有一个必须直说的事实。全书没有任何一项实证是本书自己跑出来的。全书依赖的核心实证是三项已发表的元分析与大样本研究（Flückiger 等，2018；Elliott 等，2018；Goldberg 等，2016），第12章另引了几项近期的试验和预印本；其余全部是论证、案例和预测。案例一律是说明性的合成案例，它们没有证明任何东西，只负责让判断变得可以被理解。判断本身是否成立，是下一节的内容。

◆ 四、三条判错条款，再写一遍

导论里立过三条判错条款，每一章末尾又有各自的条款。到了结语，只需把全书最承重的三条再写一遍，用最硬的写法，不加缓冲。

第一条，在第4章。把来访者按自我概念的清晰程度分为稳固和萌芽两组，给予精准的共情。如果两组的同盟评分都上升，四周之后，经第三方核实的自主行动只在稳固组上升，而萌芽组不升反降，则判断得到支持。如果萌芽组的自主

行动同样上升，判断失败。这条判断被撤回的后果，不止于一章：它撤掉的是第4章“太准即闯入”的核心主张，因为如果精准的理解对自我概念尚在萌芽的人也有同样的建设作用，那么所谓“太准即闯入”就只剩下一些个别的临床印象。第11章第三节里与熟成论对打时位置说那一方的立足点，随之失去依托；第12章中关于“太准、太快”在机器身上更常见的外推，同样一并撤掉。第3章的双重互锁与共同进场另有自己的读数，不在此列。

第二条，在第7章。把来访者本人完成一个动作与治疗师代为完成同一个动作，放在力气相当、条件相似的两组里比较。三个月之后，如果两组的行为模式没有差别，判断失败。第7章还有两条附带的条款：第三方对“这个动作是来访者自己的”的识别一致性，如果 κ 低于 .2，说明这个构念在操作上站不住；治疗师布置的动作与来访者自己提出的动作，如果结果没有差别，“亲自”这个性质就没有经验后果。这一条被撤回时，第7章“亲自”这一核心限定撤回，第10章第三节为主语改写所给的理由随之削弱，因为那次改写依托的正是“亲自”在经验上起作用；第12章里关于停用后独立发起的几项读数也失去依据，因为那些读数的前提是“谁发起”是一个有区别的变量。第2章的租借判据另靠所有权是否转移来立，不系于这一条。

第三条，在第9章。如果被指认为转折的那个瞬间，在被抽出并标准化之后，仍然能稳定地保留它的效力，那么归因敏感度的判断撤回。这是一条对证据金字塔不具敌意的条款：它欢迎金字塔去检验，并预先承认金字塔筛出的东西是确实活过了归因的东西。它被撤回时，第9章作为独立一章的理由消失，第2章末尾与第9章判决相反的那段交代也失去对手，第10章里“借用是真是假”的那一对张力也会少一边，因为第2章判伪、第9章判真的两个判断就不再需要一个共同的裁决变量。

这三条之外，还要把一条边界写死。全书反复申明，同盟与疗效的相关（r = .278，Flückiger 等，2018）和共情与疗效的相关（r = .28，Elliott 等，2018）平均而言是正的，本书从未主张共情有害、同盟无用。上述三条判错条款中的任何一条被触发，都不会也不应当推翻这两个数字。本书主张的只是在这个平均正相关之下，存在一个由阶段与位置共同决定的交互反转，反转所发生的区域，是来访者尚未亲自命名、亲自发起的那些地方。如果有人拿着这两个相关系数来反驳本书，他反驳的是一个本书没有提出的主张。反过来，如果有人拿着本书来反对共情训练，也是在误读。

◆ 五、哪些地方最容易被打中

条款写出来，下一步是诚实地标出哪里最软。以下是作者自己能看到的、被打中概率最高的几处，排序不代表重要性，只代表作者对自己最没把握的程度。

最软的是第8章承认的那堵高墙。录像编码很难区分治疗师是在“承受”，还是在“等时机”。前者是本书要保护的前诠释性承受，后者是一种熟练的、其实仍在做决定的操作。如果两者在外部观察上无法区分，那么“没有高处”这个判断，就只能靠治疗师自己的报告支撑，而治疗师恰恰是最有动力报告“我在承受”的人。这堵墙不是本书能自己推倒的，它需要有人发明一种不依赖治疗师自述的办法。

第二软的是第10章对原文动词的改动。原文写治疗师“逼出”“制造”来访者的某个动作，全书裁定改为：逼的主语只能是处境，治疗师所能做的只是不再填满，而且这一点本身会失败。这个改动在论证上解决了一个冲突，代价是把一部分原本由治疗师承担的责任挪到了一个无法追责的“处境”上。读者可以合理地问：如果治疗师什么都不负责，那么不再填满这个动作失败时，谁来承担后

果。第10章和第11章对此作了交代，说明治疗师仍然负有哪些责任。但这个交代是否足够，要由读者在具体的案例里判断，而不是由本书宣布。

第三软的是第11章里的反方。《技艺的肉身》一类的说法认为，精要在治疗师熟成的身体里，是长年积累的、不可言传的敏感。如果这是对的，那么“位置”这个说法就把一件本应归于手艺的东西，错误地搬到了关系结构里。本书在那一章里和这个反方打了一场，但没有把它打倒，也无法打倒，因为 Goldberg 等人（2016）对“熟成”同样不利：170 位治疗师、6,591 名来访者的数据显示，平均而言经验的增长并没有带来疗效的提升。这个数据同时伤了本书的反方，也伤了本书自己对治疗师能力的某种默认，因为本书从头到尾预设了一个比平均更好的治疗师是可能的。如果熟成没有证据，那么本书所说的“更好的不占位”也同样没有证据。这是一个对称的困难，不能靠一方的失败来为另一方记分。

最后是同源问题。九章所依据的论文出自同一位作者，本书的概念语言也来自同一处。即使每一章单独看都成立，九章共享同一个盲点的可能性仍然存在，而这种盲点，从内部是看不见的。对这一点，没有什么好办法，只有一条：请不在这个概念语言里的人来读，并且让他们的读法改变本书，而不是被本书的概念吸收。

◆ 六、把钥匙交给同行

死亡条款只有在别人手里才会疼。如果判定本书失败的钥匙留在作者手里，条款就成了一种姿态，这本书又多了一层漂亮的外衣。因此，以下几件事要明确写出，让任何同行不必征得作者同意就能执行。

可以执行的检验，成本从低到高大致是这样。最低的一项是在对话日志或会谈笔记上编码进步句的主语，计数引述结构，这不需要新的田野，也不需要认可

本书的任何概念，只需要两位互相独立的编码者和一份编码规则。稍高的一项是在已有的疗效数据上，按自我概念清晰度分层，重新分析共情或同盟与第三方核实的行为指标之间的关系，这需要数据集恰好同时有这两类变量。再高的一项是第7章的对照：本人完成与代为完成的比较，需要长期的随访。最高的一项是第12章的对照：AI 陪伴与人类治疗在停用之后的独立发起，需要匹配的剂量和足够长的跟踪。这些检验都有失败的可能，而失败的话，上一节已经写明哪些章节随之作废。

作者在此放弃两项权利。第一项，不得在被批评时说“这一点书里已经谈过了”，而必须回应被指认的那个具体论断。第二项，不得把自己写过的自我批评当作对后续批评的抵押。如果有人指出第8章的某一句话本身就构成了间离，作者应当回到那一句话，说明它为什么不是，或者承认它是并改写，而不能把批评引向第8章的另一段“诚实的边界”。第二项权利的放弃，比写多少条判错条款都重要，因为条款可以写得很漂亮，而回应批评时的第一反应写不漂亮。

对“间离”这件事，还需要说一句公道话，免得这一节变成对实践者的道德指控。Monin 与 Miller（2001）所研究的道德许可效应，说的是人在做过一次道德上值得称道的行为之后，更容易随后做出可疑的行为，那是个体层面的、多半无意识的、单次的额度效应。批判者的间离描述的是另一个层面的东西：它是共同体里有稳定话语形态的、可以代代相传的结构。本书这一节的目的不是指控谁伪善。一个被外部质疑围攻的治疗师，说出“真正的疗愈是量表测不出来的”，一个疲惫的作者，在文末写下“本书也可能是一种占位”，两者都是在特定的张力里抓住了手边最顺手的一句话，没有谁在这个瞬间做理性计算。要打击的是这句话被世代化、勋章化的那一步：当一句本来是自保的话，变成了一个行业训练新人时的第一课，变成“前辈已经反思过了所以我们在这个问题上已有答案”。本书不希望被这样引用。

◆ 七、哪里被打中，就撤回哪里

撤回需要有格式，否则“我会撤回”只是另一句免疫的话。本书约定如下的格式：任何一条判错条款被可靠的检验触发，对应的判断在下一版中删除或降格，并在文首注明删去的是什么、依据是哪项检验；被降格的判断，从“本书主张”改写为“曾有的主张及其失败”，保留在书里，让后来的读者看到这里曾经有过什么。不允许用重新解释概念来绕过失败，比如在条款被触发后宣布“我们所说的自我概念清晰度其实指的是另一种东西”。概念在写下的时候已经有了操作定义，要改，只能改成新的概念，并且承认旧的已经死亡。

撤回时，依赖关系按第四节写明的范围进行。第4章的条款触发，则第4章关于太准即闯入与不逾的主张、第11章第三节里位置说一方的立足点、第12章中与此有关的外推一并撤回；第1章、第2章、第3章不受影响，因为织体、租借与共同进场的判断并不依赖精准共情的特定效应。第7章的条款触发，则第7章的核心限定撤回，第10章第三节为主语改写所给的理由随之削弱，第12章里停用后独立发起的几项读数作废；第2章的租借判据不在此列，它靠所有权是否转移来立。第7章的另两条附带条款触发时，撤回较窄：前者使这个概念退回解释性叙事，后者使它退回行为治疗的家庭作业之列。第9章的条款触发，则第9章的核心判断撤回，第10章中涉及借用真伪的那一场自撞改写为只剩一边，第12章的记账一节也随之改写。这些依赖关系本身也可能被指出画错了，比如有人可以论证第1章其实依赖第4章的某个中间命题，那样撤回的范围就应当扩大。这种扩大不由作者说了算，作者对依赖关系的判断，同样处在可以被批评的位置。

还有一种撤回，不是被检验推翻，而是被时间磨损。本书的概念来自一个时期的临床语言和一批当时可得的文献，其中关于 AI 的部分更是如此：第12章引用的试验和预印本，会在下一年被更大的试验取代，Therabot 之后会有更多的同类研究，其中一些可能直接测量停用后的行为。本书不预设它们会支持或者反

对第12章的预测，只预设一件事：如果后续证据显示，停用之后独立发起的能力得到维持，第12章的担忧应当缩小，不必等到作者本人愿意。这类变化大概率比条款被触发更常发生，因而更需要提前说明它们同样适用于同一套撤回格式。

◆ 八、收束

回到开头那位治疗师。她在页边写下“对”，并没有做错什么，一本书被读者认可，是写作者正当的期望。但是如果这本书的判断有一部分是成立的，它在她那里应当出现的下一个动作，是某一天她面对一个具体的来访者，在已经知道该说什么的那一刻，没有说，并且事后发现，她不能确定自己是在“承受”还是在“等时机”。这时候，书里的概念帮不上忙，因为概念恰恰在这一刻失去了对她的指令权。她面对的是只有她自己能判断的东西，而且她的判断也可能是错的。

本书没有办法替她完成这一步，也不应该。本书能做的，是把它自己的座位交代清楚：它坐在懂的椅子上，也坐在给的椅子和判的椅子上；它的自我批评不能为它豁免；它的判断有三条可以被明确击倒的方式，每一条后面都标着倒下时会带走什么；它把检验的钥匙放在任何一个愿意拿起的人手里。除此之外，它没有更多可以说的。读者合上书以后，若在页边留下的是自己的一句话，哪怕那句话与本书相反，本书也算坐在了一把可以被人站起来离开的椅子上。

参考文献

◆ 全书参考文献

Akerlof, G. A. (1970). The market for “lemons”: Quality uncertainty and the market mechanism. Quarterly Journal of Economics, 84(3), 488–500.

Alexander, F., & French, T. M. (1946). Psychoanalytic therapy: Principles and application. Ronald Press.

Anderson, H., & Goolishian, H. (1992). The client is the expert: A not-knowing approach to therapy. In S. McNamee & K. J. Gergen (Eds.), Therapy as social construction (pp. 25–39). Sage.

Ashmore, M. (1989). The reflexive thesis: Wrighting sociology of scientific knowledge. Chicago: University of Chicago Press.

Badiou, A. (2007). Being and Event (O. Feltham, Trans.). Continuum.

Bandura, A. (1977). Self-efficacy: Toward a unifying theory of behavioral change. Psychological Review, 84(2), 191–215.

Bandura, A. (1997). Self-efficacy: The exercise of control. W. H. Freeman.

Barber, J. P., & Muenz, L. R. (1996). The role of avoidance and obsessiveness in matching patients to cognitive and interpersonal psychotherapy: Empirical findings from the Treatment for Depression Collaborative Research Program. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 64(5), 951–958.

Beck, A. T. (1976). Cognitive therapy and the emotional disorders. International Universities Press.

Benjamin, J. (2004). Beyond doer and done to: An intersubjective view of thirdness. Psychoanalytic Quarterly, 73(1), 5–46.

Bion, W. R. (1962). Learning from experience. Heinemann.

Bion, W. R. (1967). Notes on memory and desire. Psychoanalytic Forum, 2(3), 271–280.

Bion, W. R. (1970). Attention and interpretation. Tavistock.

Bordin, E. S. (1979). The generalizability of the psychoanalytic concept of the working alliance. Psychotherapy: Theory, Research & Practice, 16(3), 252–260.

Bourdieu, P. (2004). Science of science and reflexivity (R. Nice, Trans.). Chicago: University of Chicago Press. (Original work published 2001)

Bruner, J. (1991). The narrative construction of reality. Critical Inquiry, 18(1), 1–21.

Buber, M. (1923). Ich und Du. Insel.

Burgoon, J. K. (1993). Interpersonal expectations, expectancy violations, and emotional communication. Journal of Language and Social Psychology, 12(1–2), 30–48.

Campbell, J. D., Trapnell, P. D., Heine, S. J., Katz, I. M., Lavallee, L. F., & Lehman, D. R. (1996). Self-concept clarity: Measurement, personality correlates, and cultural boundaries. Journal of Personality and Social Psychology, 70(1), 141–156.

Carroll, L. (1865). Alice's adventures in Wonderland. Macmillan.

Craske, M. G., Treanor, M., Conway, C. C., Zbozinek, T., & Vervliet, B. (2014). Maximizing exposure therapy: An inhibitory learning approach. Behaviour Research and Therapy, 58, 10–23.

Deci, E. L., & Ryan, R. M. (2000). The "what" and "why" of goal pursuits: Human needs and the self-determination of behavior. Psychological Inquiry, 11(4), 227–268.

Elliott, R., Bohart, A. C., Watson, J. C., & Murphy, D. (2018). Therapist empathy and client outcome: An updated meta-analysis. Psychotherapy, 55(4), 399–410.

Elwyn, G., Frosch, D., Thomson, R., Joseph-Williams, N., Lloyd, A., Kinnersley, P., ... Barry, M. (2012). Shared decision making: A model for clinical practice. Journal of General Internal Medicine, 27(10), 1361–1367.

Fang, C. M., Liu, A. R., Danry, V., Lee, E., Chan, S. W. T., Pataranutaporn, P., Maes, P., Phang, J., Lampe, M., Ahmad, L., & Agarwal, S. (2025). How AI and human behaviors shape psychosocial effects of extended chatbot use: A longitudinal randomized controlled study. arXiv:2503.17473.

Fenichel, O. (1945). The psychoanalytic theory of neurosis. W. W. Norton.

Flückiger, C., Del Re, A. C., Wampold, B. E., & Horvath, A. O. (2018). The alliance in adult psychotherapy: A meta-analytic synthesis. Psychotherapy, 55(4), 316–340.

Foa, E. B., & Kozak, M. J. (1986). Emotional processing of fear: Exposure to corrective information. Psychological Bulletin, 99(1), 20–35.

Fonagy, P., & Bateman, A. (2006). Mechanisms of change in mentalization-based treatment of BPD. Journal of Clinical Psychology, 62(4), 411–430.

Frankl, V. E. (1959). Man's search for meaning. Boston: Beacon Press.

Freud, S. (1912). Recommendations to physicians practising psycho-analysis. In The standard edition of the complete psychological works of Sigmund Freud (Vol. 12, pp. 109–120). Hogarth Press.

Freud, S. (1915). Observations on transference-love. In The standard edition of the complete psychological works of Sigmund Freud (Vol. 12, pp. 157–171). Hogarth Press.

Geller, S. M., & Greenberg, L. S. (2012). Therapeutic presence: A mindful approach to effective therapy. American Psychological Association.

Gendlin, E. T. (1981). Focusing (2nd ed.). Bantam Books.

Gendlin, E. T. (1996). Focusing-oriented psychotherapy: A manual of the experiential method. Guilford Press.

Goffman, E. (1956). The presentation of self in everyday life. University of Edinburgh Social Sciences Research Centre.

Goldberg, S. B., Rousmaniere, T., Miller, S. D., Whipple, J., Nielsen, S. L., Hoyt, W. T., & Wampold, B. E. (2016). Do psychotherapists improve with time and experience? A longitudinal analysis of outcomes in a clinical setting. Journal of Counseling Psychology, 63(1), 1–11.

Grawe, K. (2007). Neuropsychotherapy: How the neurosciences inform effective psychotherapy. Lawrence Erlbaum Associates.

Greenson, R. R. (1967). The technique and practice of psychoanalysis. International Universities Press.

Heinz, M. V., Mackin, D. M., Trudeau, B. M., et al. (2025). Randomized trial of a generative AI chatbot for mental health treatment. NEJM AI, 2(4). https://doi.org/10.1056/AIoa2400802

Henretty, J. R., Currier, J. M., Berman, J. S., & Levitt, H. M. (2014). The impact of counselor self-disclosure on clients: A meta-analytic review. Journal of Counseling Psychology, 61(2), 191–207.

Hill, C. E., & Knox, S. (2001). Self-disclosure. Psychotherapy: Theory, Research, Practice, Training, 38(4), 413–417.

Jacobs, T. J. (1986). On countertransference enactments. Journal of the American Psychoanalytic Association, 34(2), 289–307.

Jaspers, K. (1932). Philosophie (3 vols.). Berlin: Springer.

Kelly, M. (2025). First therapy chatbot trial yields mental health benefits. Dartmouth Technology Transfer Office, 2025年3月.

Klein, M. (1946). Notes on some schizoid mechanisms. International Journal of Psycho-Analysis, 27, 99–110.

Kohut, H. (1971). The analysis of the self. New York: International Universities Press.

Kohut, H. (1977). The restoration of the self. International Universities Press.

Kohut, H. (1984). How does analysis cure? University of Chicago Press.

Lacan, J. (2006). Écrits: The first complete edition in English (B. Fink, Trans.). W. W. Norton.

Lambert, M. J. (1992). Psychotherapy outcome research: Implications for integrative and eclectic therapists. In J. C. Norcross & M. R. Goldfried (Eds.), Handbook of psychotherapy integration (pp. 94–129). Basic Books.

Lambert, M. J. (2013). The efficacy and effectiveness of psychotherapy. In M. J. Lambert (Ed.), Bergin and Garfield’s handbook of psychotherapy and behavior change (6th ed., pp. 169–218). Wiley.

Langs, R. (1976). The bipersonal field. Jason Aronson.

Levinas, E. (1969). Totality and infinity: An essay on exteriority (A. Lingis, Trans.). Duquesne University Press.

Luborsky, L., Singer, B., & Luborsky, L. (1975). Comparative studies of psychotherapies: Is it true that "everyone has won and all must have prizes"? Archives of General Psychiatry, 32(8), 995–1008.

Luhmann, N. (1995). Social systems. Stanford University Press.

Masson, J. M. (1988). Against therapy: Emotional tyranny and the myth of psychological healing. Atheneum.

May, R. (1983). The discovery of being: Writings in existential psychology. New York: W. W. Norton.

Miller, S. D., Hubble, M. A., & Chow, D. (2020). Better results: Using deliberate practice to improve therapeutic effectiveness. American Psychological Association.

MIT Technology Review (2025). The first trial of generative AI therapy shows it might help with depression. 2025年3月28日.

Monin, B., & Miller, D. T. (2001). Moral credentials and the expression of prejudice. Journal of Personality and Social Psychology, 81(1), 33–43.

Moore, J., Grabb, D., Agnew, W., Klyman, K., Chancellor, S., Ong, D. C., & Haber, N. (2025). Expressing stigma and inappropriate responses prevents LLMs from safely replacing mental health providers. Proceedings of the 2025 ACM Conference on Fairness, Accountability, and Transparency (FAccT 2025).

Ogden, T. H. (1994). Subjects of analysis. Jason Aronson.

Perls, F. (1969). Gestalt therapy verbatim. Real People Press.

Perls, F., Hefferline, R., & Goodman, P. (1951). Gestalt therapy: Excitement and growth in the human personality. New York: Julian Press.

Petitmengin, C. (2006). Describing one's subjective experience in the second person. Phenomenology and the Cognitive Sciences, 5, 229–269.

Phang, J., Lampe, M., Ahmad, L., Agarwal, S., Fang, C. M., Liu, A. R., Danry, V., Lee, E., Chan, S. W. T., Pataranutaporn, P., & Maes, P. (2025). Investigating affective use and emotional well-being on ChatGPT. arXiv:2504.03888.

Plato. (c. 369 BCE). Theaetetus (esp. 148e–151d).

Polanyi, M. (1966). The tacit dimension. Doubleday.

Prochaska, J. O., Norcross, J. C., & DiClemente, C. C. (1994). Changing for good. William Morrow.

Racker, H. (1968). Transference and countertransference. International Universities Press.

Rogers, C. R. (1951). Client-centered therapy: Its current practice, implications, and theory. Houghton Mifflin.

Rogers, C. R. (1957). The necessary and sufficient conditions of therapeutic personality change. Journal of Consulting Psychology, 21(2), 95–103.

Rogers, C. R. (1977). Carl Rogers on personal power. Delacorte Press.

Rogers, C. R. (1980). A way of being. Boston: Houghton Mifflin.

Rorty, R. (1989). Contingency, irony, and solidarity. Cambridge: Cambridge University Press.

Rosa, H. (2016). Resonanz: Eine Soziologie der Weltbeziehung. Suhrkamp.

Rosenfeld, H. (1964). On the psychopathology of narcissism: A clinical approach. International Journal of Psycho-Analysis, 45, 332–337.

Rosenzweig, S. (1936). Some implicit common factors in diverse methods of psychotherapy. American Journal of Orthopsychiatry, 6(3), 412–415.

Safran, J. D., & Muran, J. C. (2000). Negotiating the therapeutic alliance: A relational treatment guide. Guilford Press.

Sandler, J. (1976). Countertransference and role-responsiveness. International Review of Psycho-Analysis, 3, 43–47.

Schmid, P. F. (2000). Personale Begegnung: Der personzentrierte Ansatz in Psychotherapie, Beratung und Gruppenarbeit.

Spence, D. P. (1982). Narrative truth and historical truth: Meaning and interpretation in psychoanalysis. W. W. Norton.

Stanley, B., & Brown, G. K. (2012). Safety planning intervention: A brief intervention to mitigate suicide risk. Cognitive and Behavioral Practice, 19(2), 256–264.

Steiner, J. (1993). Psychic retreats: Pathological organizations in psychotic, neurotic and borderline patients. Routledge.

Stern, D. N. (2004). The present moment in psychotherapy and everyday life. W. W. Norton & Company.

Stern, D. N., Sander, L. W., Nahum, J. P., Harrison, A. M., Lyons-Ruth, K., Morgan, A. C., Bruschweiler-Stern, N., & Tronick, E. Z. (1998). Non-interpretive mechanisms in psychoanalytic therapy: The 'something more' than interpretation. International Journal of Psycho-Analysis, 79(5), 903–921.

Stolorow, R. D., & Atwood, G. E. (1992). Contexts of being: The intersubjective foundations of psychological life. Analytic Press.

Tang, T. Z., & DeRubeis, R. J. (1999). Sudden gains and critical sessions in cognitive-behavioral therapy for depression. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 67(6), 894–904.

Vittengl, J. R., Clark, L. A., Dunn, T. W., & Jarrett, R. B. (2007). Reducing relapse and recurrence in unipolar depression: A comparative meta-analysis of cognitive-behavioral therapy’ s effects. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 75(3), 475–488.

Vygotsky, L. S. (1978). Mind in society: The development of higher psychological processes. Cambridge, MA: Harvard University Press.

Wampold, B. E. (2001). The great psychotherapy debate: Models, methods, and findings. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.

Wampold, B. E., & Imel, Z. E. (2015). The great psychotherapy debate: The evidence for what makes psychotherapy work (2nd ed.). Routledge.

Weber, M. (1978). Economy and society (G. Roth & C. Wittich, Eds.). University of California Press. (Original work published 1922)

White, M. (2007). Maps of narrative practice. W. W. Norton & Company.

White, M., & Epston, D. (1990). Narrative means to therapeutic ends. W. W. Norton.

Winnicott, D. W. (1953). Transitional objects and transitional phenomena. International Journal of Psycho-Analysis, 34, 89–97.

Winnicott, D. W. (1960). Ego distortion in terms of true and false self. In The maturational processes and the facilitating environment (pp. 140–152). Hogarth Press.

Winnicott, D. W. (1965). The maturational processes and the facilitating environment. Hogarth Press.

Winnicott, D. W. (1971). Playing and reality. Tavistock.

Wood, D., Bruner, J. S., & Ross, G. (1976). The role of tutoring in problem solving. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 17(2), 89–100.

Woolgar, S. (1988). Science: The very idea. Chichester: Ellis Horwood.

Yalom, I. D. (1980). Existential psychotherapy. Basic Books.

Yalom, I. D. (2002). The gift of therapy: An open letter to a new generation of therapists and their patients. HarperCollins.

Zilcha-Mano, S. (2017). Is the alliance really therapeutic? Revisiting this question in light of recent methodological advances. American Psychologist, 72(4), 311–325.

王德生. 心理学的典范革命：从主体的发现到发生. 德麦国际出版社，德麦国际专著第 306 号.

版本说明

本版字数、版本与交付

本版是德麦国际专著第 591 号《都做对了，怎么还没变——心理治疗里被好意占住的那个位置》的初版，2026 年 11 月第 1 版。ISBN 979-8-90690-618-2，定价 US$22.00。

本版正文（前言、导读、导论、编首语、十二章与结语）实计 196,878 个汉字，约 19.7 万字；章题、节题与参考文献不计入。

本书同时是一个出版单元：全文阅读、十二个学习单元（每章一个）、专属智能体“空位”的问对。

全书经三审：一审逐章查主语约束、穿帮、证据、章间一致与安全表述；二审校对文字、术语、章号指向与文献对应；三审复查全书规则，并裁定一审提出的章间问题。三审与写作出自同一类底座，挡得住前后矛盾和指错章号，挡不住共同的偏向。

今后若有判错条款被可靠的检验触发，或读者指出错误，对应判断在下一版删除或降格，并在文首注明删去的是什么、依据是哪项检验。

全 书 母 题

做得越对，越占住
那个只有来访者能站的位置；
改变在它空出时发生，
却记不到任何人账上。

同盟很好，量表在降，来访者按时到场，结案时双方都觉得这一程走得不错。半年后他在电话里平静地说，日子大体又回到了从前的样子。没有人做错什么。这本书问的是：好东西为什么有时恰恰挡路。

全书五编十二章：两种看上去都很好的停滞；懂、给、判三把被占住的椅子；椅子空了以后那个别人不能代做的动作；一笔记不到任何人名下的账；再让这些判断当面对撞，追问“让位”本身也能占位，以及一个永不离席的 AI 对话者。

这是一部理论专著初版，不是临床指南。由作者九篇论文熔铸，正文由 AI（Claude）协作重写，经统稿与三审，没有经过独立学术评审。全书三条判错条款都还没有检验。

同盟与共情平均都是好的。问题在平均之下。

德麦国际出版社 · Demai International Press
德麦国际专著第 591 号 · 五编十二章 · 约 20 万字
ISBN 979-8-90690-618-2 · 定价 US$22.00

ISBN 979-8-90690-618-2
9 798906 906182